



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN OKTOBER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi.....	2
2.2 Misi.....	2
2.3 Motto.....	2
2.4 7 Nilai Budi Utama.....	2
2.5 Struktur Organisasi.....	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI).....	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO.....	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO.....	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut.....	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan.....	6
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada.....	7
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan.....	20
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik.....	20
3.3.2 Rawat Inap.....	22
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU).....	31
3.3.4 High Care Unit (HCU).....	32
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	33
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO).....	34
3.4 Kinerja Bidang Penunjang.....	35
3.4.1 Instalasi Farmasi.....	35
3.4.2 Laboratorium.....	53
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran.....	56
3.4.4 Radiologi.....	62
3.4.5 Gizi.....	67
3.4.6 CSSD - Laundry.....	78
3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan.....	84
3.5.1 SDM.....	84
3.5.2 IPSRS.....	93
3.5.3 Security.....	101
3.5.4 Parkir.....	104
3.5.5 Humas Marketing.....	105
3.5.6 Penjaminan.....	112
3.5.7 PIPP – MOD – MPP.....	113
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	122
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum.....	123
3.5.10 IT - SIMRS.....	124
3.5.11 Driver.....	125
3.6 Komite dan Tim.....	126
3.6.1 Komite Mutu.....	127
3.6.2 Komite PPI.....	193
3.6.3 Tim PKRS.....	208
3.6.4 Tim Prognas.....	209
3.6.5 Tim PPRA.....	248
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT.....	254
3.7 Permasalahan Rumah Sakit.....	257
3.8 Profil SDM.....	266
Bab IV Kesimpulan dan Saran	270
Bab V Penutup	271
Lampiran	272

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Oktober Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



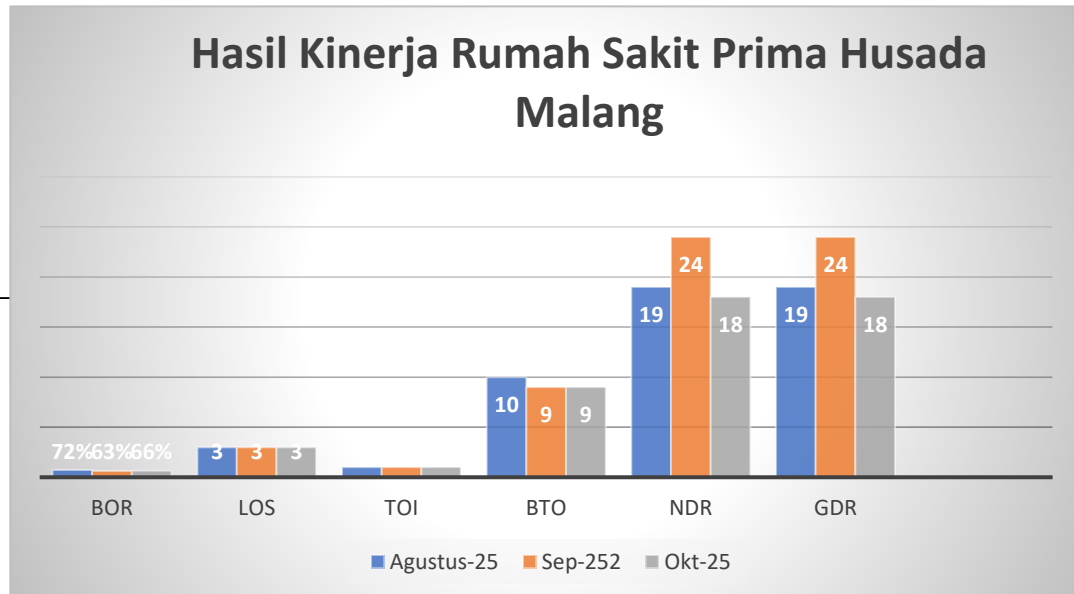
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
BOR	72%	63%	66%
LOS	3 hari	3 hari	3 hari
TOI	1 hari	1 hari	1 hari
BTO	10 kali	9 kali	9 kali

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Masalah :

- LOS terlalu rendah (3 hari)** → indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:
 - Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
 - Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
 - Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.
- BTO tinggi** → mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.
- BOR fluktuatif** walaupun masih dalam batas ideal → perlu perhatian agar tetap stabil dan tidak menurun di bawah standar.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Untuk BOR:

Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.

2. Untuk LOS:

- a) Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
- b) Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.

3. Untuk TOI:

Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.

4. Untuk BTO:

- a) Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
- b) Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
- c) Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

Analisa

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

- a) 72% → 63 % → 66%
- b) Utilisasi (BOR) menurun secara signifikan pada Oktober dibandingkan bulan sebelumnya (~3 poin persentase)

2. LOS (Length of Stay)

Karena LOS dan TOI tetap konstan, penurunan BOR & BTO sangat mungkin disebabkan oleh **penurunan jumlah pasien yang masuk / rawat inap**, bukan karena inefisiensi internal

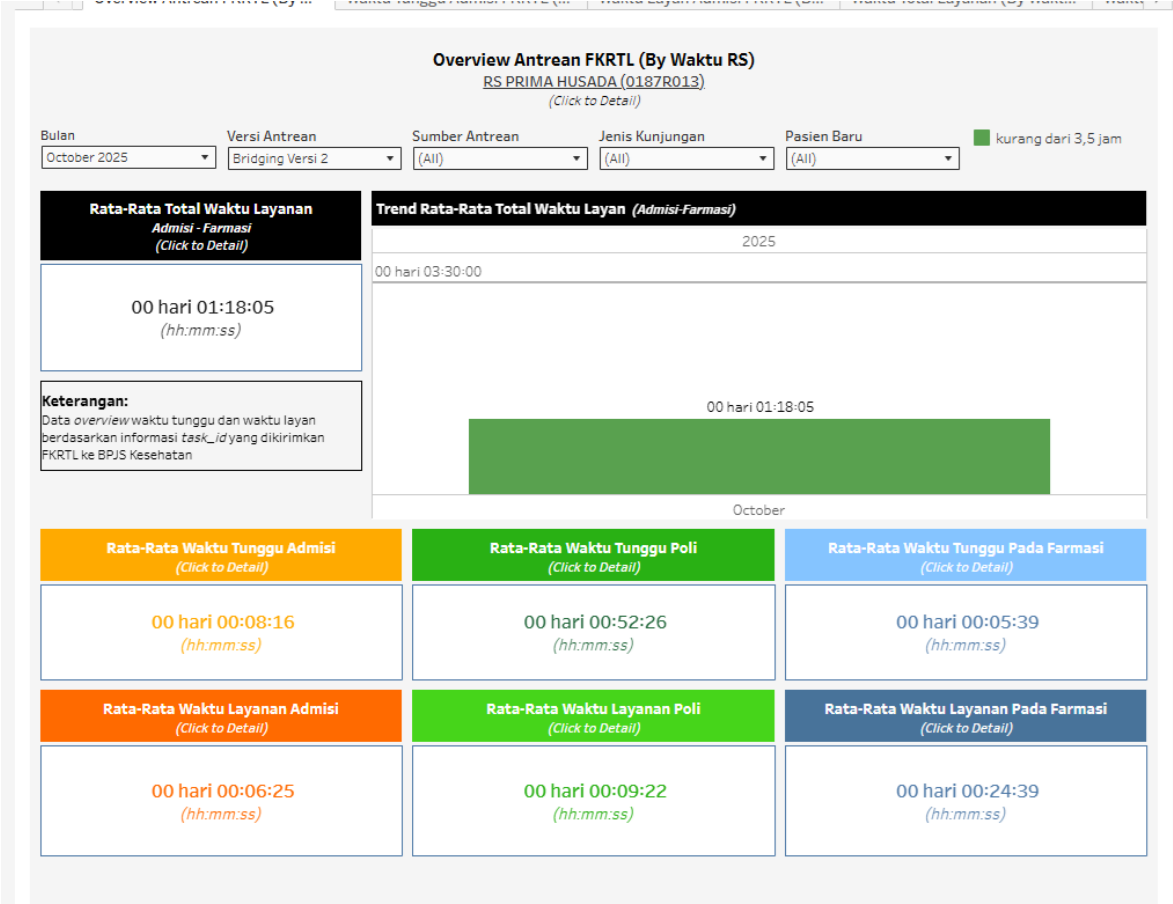
3. TOI (Turn Over Interval)

- a) Tetap 1 hari
- b) Kapasitas terpakai jauh lebih rendah di September sehingga banyak tempat tidur “menganggur”

4. BTO (Bed Turn Over)

- a) 10 kali → 10 kali → 9 kali
- b) Penurunan BTO juga mencerminkan bahwa frekuensi penggunaan tiap tempat tidur menurun
- c) Efisiensi internal relatif stabil (LOS dan TOI) — artinya sistem operasional internal tidak memburuk secara mendadak

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	Jenis	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	46,43%	47.64%	49.61%	50.19%	48.42%	48.20%	
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	95.11%	94.28%	92.04%	94.61%	94.20%	94.36%	

Analisis :
Pemanfaatan antrian online data juli 2025 belum mendapat dari BPJS

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.1 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Implementasi resume keperawatan di ERM	1. Implementasi E-rekam medis rawat inap khusus untuk form bendelan OB hampir 80% sudah memakai ERM 2. Resume keperawatan selalu dikerjakan unruk setiap pasien rawat inap	1. Ditemukan kendala pilihan diagnosis keperawatan belum muncul 2. Cetakan resume keperawatan belum muncul 3. TTD perawat ada yang masih belum muncul di ERM 4. Untuk kendala-kendala yang ada sudah di tindaklanjuti oleh IT dan

				programmer
2	IRNA	Implementasi ERM pemberian informasi SC, curettage dan persalinan sudah bisa diakses di ERM	1. Implementasi ERM pemberian informasi SC, curettage dan persalinan tidak perlu mengetik manual karena sudah ada template yang bisa diakses di SIMRS 2. Kendala yang muncul adalah TTD pasien yang tidak muncul 3. Sudah dilaporkan ke programmer	- TTD pasien tidak muncul saat akan dimintakan ke keluarga pasien - Lapor IT untuk mengecek settingan tanda tangan di komputer - Untuk pengisian form pemberian informasi SC, curettage dan persalinan belum ada kendala sampai saat ini
3	IRJA	Poli Harmoni STIFIn	1. Ruangan tersedia di poli lantai 4 sakura 2. Ruangan dilengkapi dengan bed , sofa , meja, TV, dan PC untuk mendukung pelayanan poli harmoni 3. Koordinasi dengan PKRS, untuk share ke medsos	Untuk saat ini masih belum ada pasien yang reservasi ke poli harmoni
		Re- Upload dan sharing Poli Sunday Clinic	1. Karena poli Sunday clinic jarang diupload, dan hanya di share di WA channel, beberapa orang tidak tahu kalau poli minggu ready termasuk melayani pasien dengan BPJS kesehatan 2. Pelayanan Sunday clinic meliputi poli anak, saraf, dan peny dalam	Untuk poli sunday clinic khusus pasien bpjs tetap mengikuti prosedur, karena masin-masing dokter mempunyai kuota masing-masing sesuai HFIS
		ODC pasien Umum dan Asuransi Non BPJS Kesehatan	1. Buat SPO Alur ODC pasien Umum dan Asuransi Non BPJS Kesehatan 2. Sosialisasi pada unit terkait untuk pelaksanaan dan monitoring di lapangan 3. Kriteria pasien ODC ini diluar tindakan phaco dan curettage karena tarif nya berbeda	1. Untuk ringkasan pulang tidak bisa diakses menggunakan billing rawat jalan 2. Solusi untuk kelengkapan klaim (khusus pasien asuransi) bisa ditarik melalui simrs fitur resume medis rawat jalan

4	IGD	Sharing Ilmu kegawatan pada Dokter IGD , Dokter ruangan dan perawat IGD	Untuk meningkatkan skill dan pengetahuan dokter IGD, dokter spesialis bisa memberikan sharing ilmu terkait kegawatan melalui materi zoom maupun offline	Bulan Oktober 2025, ada sharing ilmu kegawatan abdomen untuk dokter IGD dan karu IGD, dan karu ranap oleh dr. Andi Abdillah, SpB
5	IKO	Pengajuan alat bor craniotomy di IKO	Ada demo dari vendor untuk pemakaian alat bor craniotomy di IKO	Dari hasil demo, apabila dengan harga yang ditawarkan, saran tidak diambil, dan dicari merk yang lebih bagus. Karena penggunaan nya tidak maksimal dan pertimbangan cari merk yang sesuai dan terjangkau

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 155 e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	Dalam antrian progamer
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada

		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .
		5. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	a. Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.

			b. Belum ada penanda resep obat siap dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap di SIMRS. c. Perubahan alur pendaftaran primantara oleh farmasi. a. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	
		6. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		7. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		8. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat	Pengajuan fitur ke progamer.

			yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	
		9. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat"	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat" untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
		11. Ruang handrub	a. Penambahan ruang handrub pada tanggal	Monitoring dan Evaluasi.

			28 mei 2025 untuk pengisian botol cairan handrub yang habis di ruangan agar meminimalkan mikroorganisme. b. Pengisian handrub dilakukan oleh apoteker. c. Sudah dilakukan sosialisasi pengisian botol handrub oleh komite PPI.	
		12. Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik	Alur pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik : a. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasien) b. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. c. Order vaksin ke gudang farmasi. d. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. e. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan berdasarkan kwitansi manual sebelumnya. d. Pasien melakukan suntik di poli vaksin.	Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah	Rencana trial menunggu Programmer PT

			tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaiki sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaikan alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO.	Monitoring dan Evaluasi.

			- Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan	
--	--	--	---	--

			selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan	
--	--	--	--	--

			dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi” bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan	
--	--	--	---	--

			permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih disistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada didepo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat.	
--	--	--	--	--

			f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Poli gizi dan kia belum menjalankan ERM	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM.
		3. Kirim ke Satu Sehat	Pengiriman data ke satu	2. Beberapa kendala teknis dan keterbatasan SDM dalam penggunaan sistem. Monitoring dan Evaluasi.

		untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	
		4. Formulir rekapitulasi kegiatan pelayanan laboratorium pada SIMRS	Rekapitulasi jumlah pemeriksaan lab dengan kriteria jenis kelamin dan hasil nilai rata-rata pemeriksaan lab	Keterlambatan pengisian pada web SIRS online → Follow up ke Programmer untuk update fitur di SIMRS

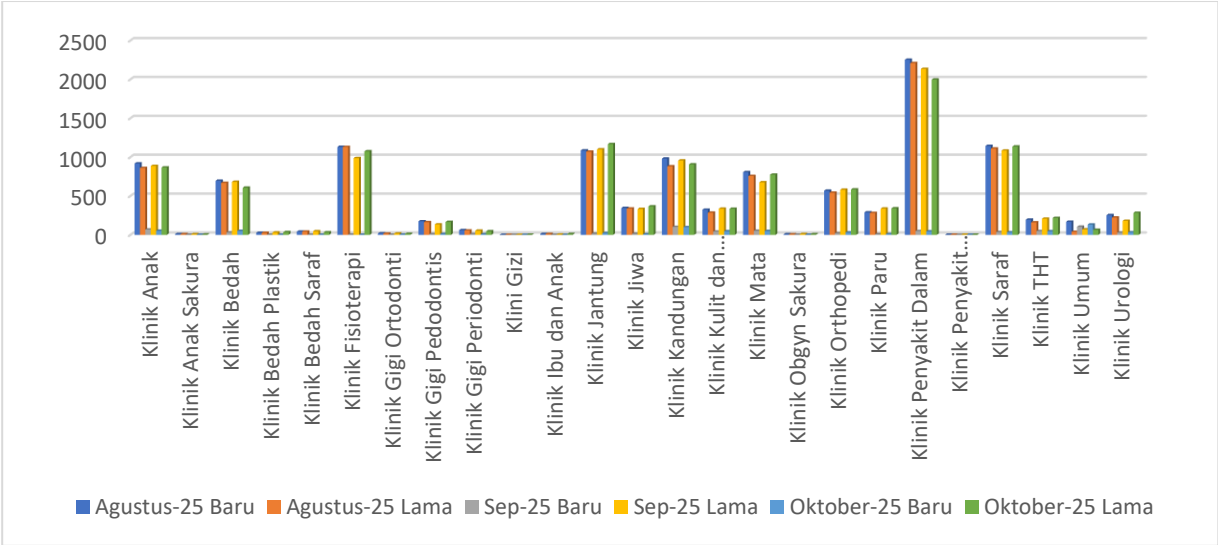
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

No	Nama Unit	Agustus			September			Oktober		
		Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total
1	Klinik Anak	918	860	1778	68	886	954	52	866	918
2	Klinik Anak Sakura	10	9	19	1	8	9	1	4	5
3	Klinik Bedah	696	667	1363	31	681	712	51	606	657
4	Klinik Bedah Plastik	26	26	52	1	30	31	1	35	36
5	Klinik Bedah Saraf	42	42	84	1	46	47	2	33	35
6	Klinik Fisioterapi	1131	1130	2261	3	987	990	1	1074	1075
7	Klinik Gigi Ortodonti	19	16	35	2	17	19	3	13	16
8	Klinik Gigi Pedodontis	174	163	337	9	134	143	11	166	177
9	Klinik Gigi Periodonti	60	56	116	10	54	64	8	46	54
10	Klini Gizi	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	Klinik Ibu dan Anak	11	11	22	0	3	3	0	11	11
12	Klinik Jantung	1085	1070	2155	15	1099	1114	23	1167	1190
13	Klinik Jiwa	345	337	682	14	333	347	8	366	374
14	Klinik Kandungan	980	881	1861	102	956	1058	99	905	1004
15	Klinik Kulit dan Kelamin	323	285	608	42	336	378	46	335	381
16	Klinik Mata	806	756	1562	52	675	727	49	773	822
17	Klinik Obgyn Sakura	7	6	13	2	9	11	1	8	9
18	Klinik Orthopedi	568	542	1110	20	580	600	31	584	615
19	Klinik Paru	288	281	569	8	337	345	10	340	350

20	Klinik Penyakit Dalam	2252	2208	4460	48	2134	2182	44	1996	2040
21	Klinik Penyakit Dalam Sakura	1	1	2	0	1	1	1	2	3
22	Klinik Saraf	1143	1109	2252	35	1084	1119	33	1135	1168
23	Klinik THT	195	160	355	48	208	256	46	217	263
24	Klinik Umum	168	39	207	104	70	174	132	64	196
25	Klinik Urologi	253	222	475	29	180	209	33	283	316



Analisis :

1. **Kunjungan pasien rawat jalan** September ke Oktober 2025 mengalami kenaikan secara keseluruhan sebesar 2%
2. **Kunjungan tertinggi** : Poli Penyakit Dalam dengan kunjungan 2040 pasien
3. **Kenaikan tertinggi** : Poli Urologi dengan persentase 51%
4. **Penurunan tertinggi** : Poli Anak sakura dengan persentase 44%

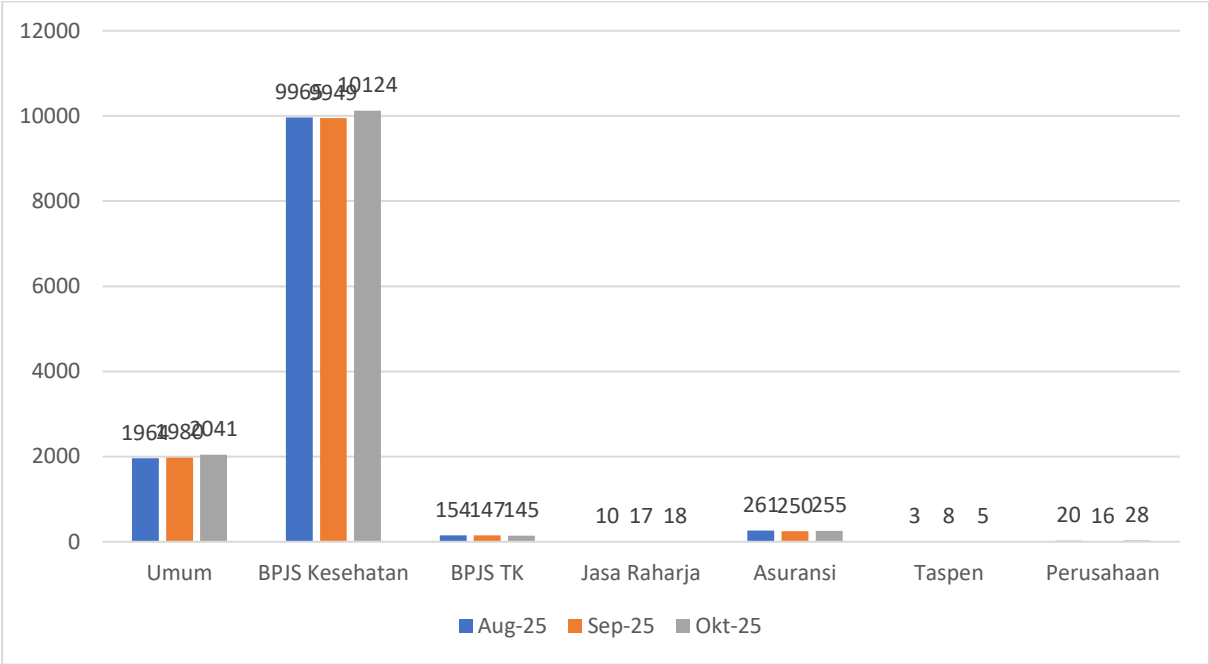
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli Sakura
3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	AUG-25	%	SEP-25	%	OKT-25	%
1	Umum	1964	15,87%	1980	16,01%	2041	16,18%
2	BPJS Kesehatan	9965	80,51%	9949	80,45%	10124	80,25%
3	JKK	154	1,24%	147	1,19%	145	1,15%
4	Jasa raharja	10	0,08%	17	0,14%	18	0,14%
5	Asuransi swasta	261	2,11%	250	2,02%	255	2,02%
6	Perusahaan	3	0,02%	8	0,06%	5	0,04%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	20	0,16%	16	0,13%	28	0,22%
	Total	12377	100%	12367	100%	12616	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



- Analisis :**
- 1. Kunjungan dengan cara bayar umum mengalami kenaikan 2,99 %
 - 2. Kunjungan dengan cara bayar BPJS mengalami penurunan 1,73 %
 - 3. Kunjungan dengan cara bayar BPJS KETENAGAKERJAAN mengalami penurunan 1,35%

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

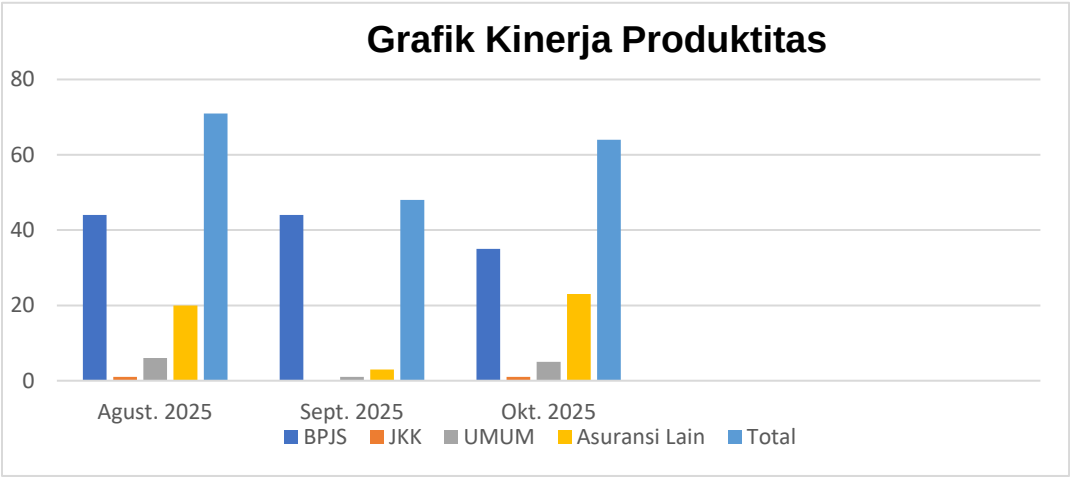
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2025)

NO	HAL	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	44	44	35	↓ 20,45%
2	JKK	1	0	1	↑ 100%
3	Umum	6	1	5	↑ 400%
4	Asuransi Lain	20	3	23	↑ 666,66%
Total Pasien		71	48	64	↑ 7,68%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Agustus - Oktober 2025)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Bulan	RAWAT INAP				Total Pasien
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Agust. 2025	44	6	1	20	71
	Analisa	Bulan Agustus pasien BPJS naik signifikan dari 38 menjadi 44	Pasien umum bulan Agustus turun menjadi 6 dari 11	Pasien JKK ada 1 karena naik ke VIP	Untuk pasien asuransi juga mengalami kenaikan drastis dari 10 px menjadi 20 pasien di bulan Agustus	Total bulan Agustus mengalami kenaikan yang signifikan dari 59 menjadi 71
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Septe mber 2025	44	1	0	3	48
	Analisa	Bulan september pasien BPJS bertahan di angka 44	Bulan september pasien umum turun menjadi 1	Pasien JKK tdk ada yg naik kelas	Untuk pasien asuransi menurun drastic dari 20 menjadi 3 dikarenakan banyak pasien yg menggunakan BPJS dan COB dengan asuransi	Total bulan September jumlah pasien emnurun drastic dari 71 menjadi 48 dikarenakan banyak yg sesuai kelas dan memilih dikelas 3 atau 2
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan				

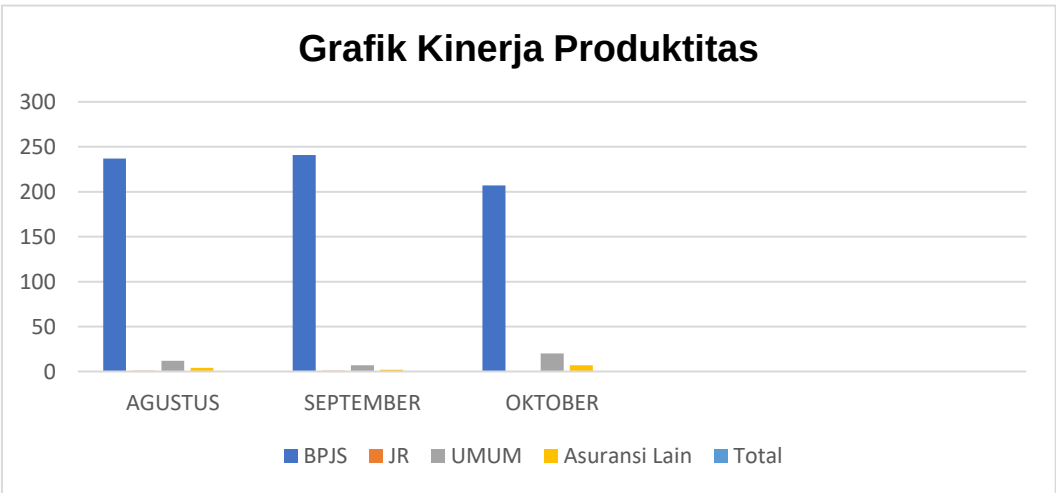
		perawatan pasca rawat inap				
3	OKTO BER 2025	35	5	1	23	64
	Analisa	Bulan Oktober pasien BPJS mengalami penurunan dari 44 menjadi 35	Bulan Oktober pasien Umum naik dari 1 menjadi 5	Pasien JKK bulan Oktober ada 1 karena pasien naik VIP	Untuk pasien asuransi di bulan Oktober naik drastic dari 3 menjadi 23	Total bulan Oktober jumlah pasien mengalami kenaikan lagi dari 48 menjadi 64
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Agustus - Oktober 2025)

NO	HAL	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	237	241	207	↓16,4%
2	JR	1	1	0	↓100%
3	Umum	12	7	20	↑65%
4	Asuransi Lain	4	2	7	↑71,4%
Total Pasien		254	251	234	↓7,2%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR	Asuransi	
	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS ada penurunan selama 3 bulan terakhir	Pasien Umum mengalami peningkkata n di bulan	Pasien JR dari 3 bulan terakhir tetap Dikarenaka	Pasien Asuransi mengalami kenaikan 71,4% di bulan	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak terjadi

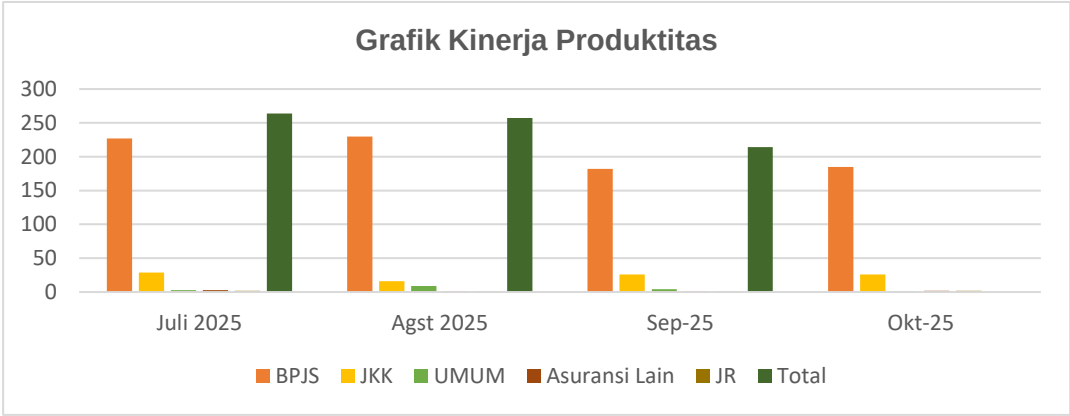
		pada bulan oktober 2025 Sebesar 16,4%	Oktober sebanyak65 % Dikarenaka n pasien sudah memiliki BPJS semua	KLL kebanyakan tunggal dan jatuh sendiri	Oktober Karena rata-rata pasien menggunakan penjamin BPJS+ asuransi	di bulan juli peningkatan di setiap bulannya yaitu 291 dan mengalami penurunan dui bulan agustus sebanyak 15% yaitu 254 Serta mengalami seddikit penurunan lagi di bulan September sebanyak 1,2% Dan mengalami penurunan di bulan oktober sebanyak 7,2%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)

NO	HAL	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	230	182	185	↑ 1,65 %
2	JKK	16	26	26	0% %
3	Umum	9	4	1	↓ 75 %
4	Asuransi Lain	1	1	2	100 %
5	JR	1	1	2	100 %
Total Pasien		257	214	216	↑ 0,93 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian	Pasien BPJS mengalami	Pasien Umum	Jumlah Pasien JKK	Jumlah Pasien JR	Peningkata n jumlah

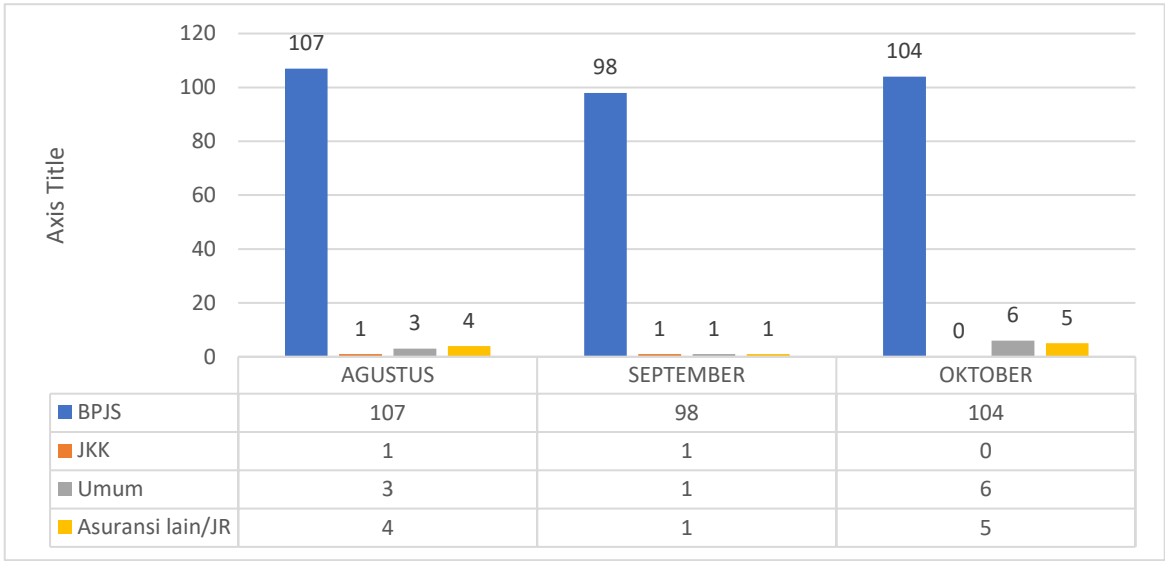
	Oktober 2025	peningkatan pada bulan Oktober 2025 sebesar 1,65%	pada bulan Oktober 2025 mengalami penurunan yaitu sebanyak 75%	pada bulan Oktober sama dengan bulan September yaitu sebanyak 1 pada. (0%)	pada bulan Oktober mengalami kenaikan sebanyak 100%	pasien di bulan Oktober 2025 dengan jumlah pasien sebanyak 0,93 %
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A sehingga pasien menurun				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2025)

NO	HAL	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	107	98	104	↑6%
2	JKK	1	1	0	↓100%
3	Umum	3	1	6	↑83%
4	Asuransi Lain	4	1	5	↑80%
Total Pasien		115	101	115	↑12%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Agustus 2025	Total Pasien BPJS mengalami kenaikan	Total Pasien Umum mengalami penurunan	Pasien JKK tidak mengalami penurunan maupun	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak	Pada bulan Agustus untuk total kunjungan pasien mengalami

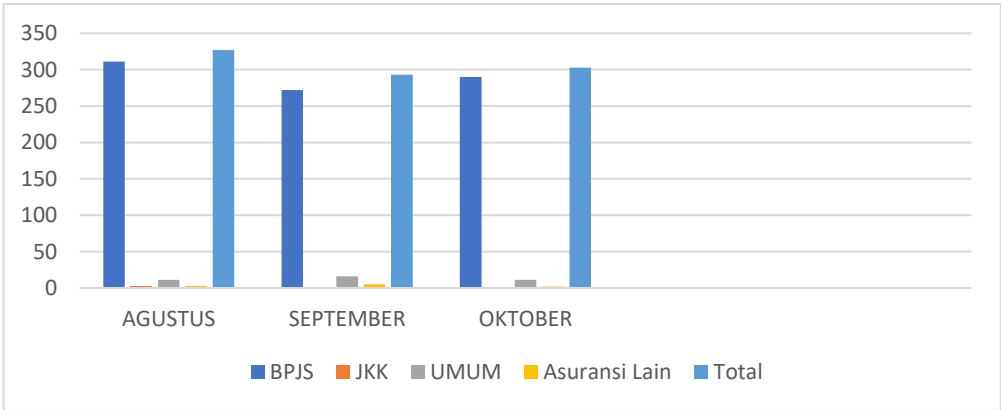
		sebanyak ↑0,01% dari bulan sebelumnya	↓50% dari kunjungan bulan sebelumnya	peningkatan ↓100% dari bulan sebelumnya.	↑25% dari bulan sebelumnya	Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑0.86%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
2	Analisis capaian Septembe r 2025	Total Pasien BPJS mengalami penurunan sebanyak ↓9% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum sama dengan kunjungan bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓67% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓21% dari bulan sebelumnya	Pada bulan September untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↓27%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian Oktober 2025	Total Pasien BPJS mengalami peningkata n sebanyak ↑6% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑83% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓100% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↑80% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Oktober untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑12%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2025)

NO	PENJAMIN	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	311	272	290	↑6,6%
2	JKK	2	0	0	Tidak ada perubahan
3	Umum	11	16	11	↓ 31,25%
4	Asuransi Lain	3	5	2	↓ 60%
Total Pasien		327	293	303	↑ 4,3%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

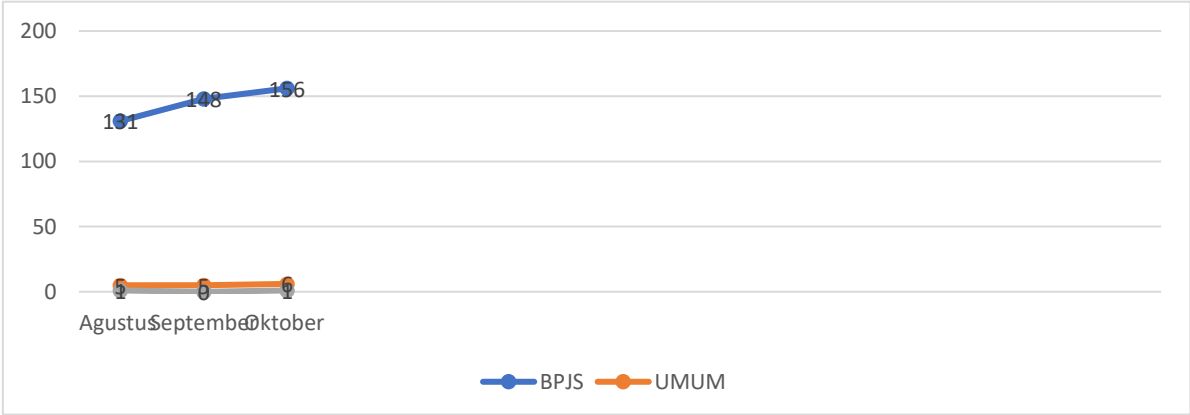
No	Bulan	Rawat Inap				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
	Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 311 pasien	Pasien Umum mengalami penurunan pada bulan September 2025 yaitu sebanyak 16 pasien	Tidak ada pasien JKK pada bulan Oktober 2025	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan pada bulan September 2025	Penurunan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan Agustus dengan jumlah pasien sebanyak 327 pasien.
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2025)

NO	HAL	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	131	148	156	↑5,12%
2	Umum	5	5	6	↑16,66%
3	Asuransi	1	0	1	↑0,01%
Total Pasien		137	153	163	↑0,06%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP			Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR/Asuransi	
	Analisis capaian Bulan Agustus-Oktober	Pasien BPJS pada bulan Oktober mengalami kenaikan 5,12%	Pasien umum pada bulan Oktober Mengalami kenaikan 16,66%	Terdapat 1 Pasien Asuransi pada bulan Oktober	Kunjungan naik dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya

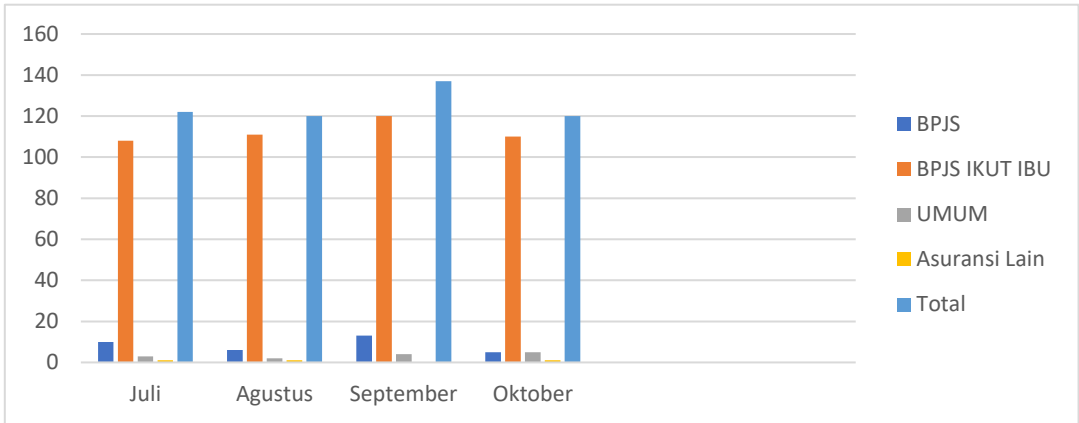
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
--	-----	--	--	--	--

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	6	13	5	↓6,6%
2	Umum	2	2	4	5	↑3,3%
3	Asuransi Lain	1	1	0	1	↑0,8%
4	BPJS IKUT IBU	100	111	120	109	↓8,3%
Total Pasien		110	120	137	120	↓14,16%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Agustus - Oktober 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	Rawat Inap				Total Pasien
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	
1	Agustus	6	2	1	111	120
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,33%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,83%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 2,5%	
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk	

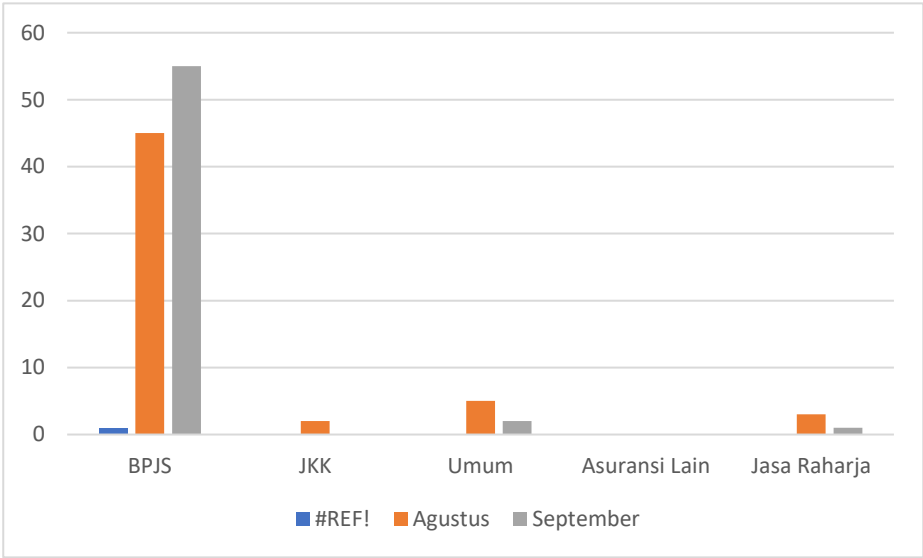
					promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
2	September	13	4	0	120	137
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 9,5%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,9%	Tidakada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 87,6%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
3	Oktober	5	5	1	109	120
		Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6,8%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,3%	Ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 14,16%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)

NO	PENJAMIN	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	45	55	34	↓0,38%
2	JKK	2	0	0	Tetap
3	Umum	5	2	2	Tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	1	1	0	↓100%
Total Pasien		55	58	36	↓0,38 %

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

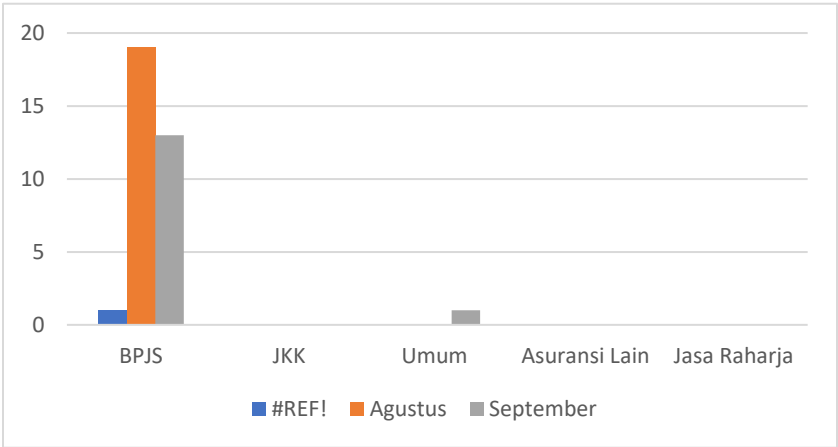
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Oktober 2025 mengalami penurunan 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan bulan Oktober dibandingkan dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan September 2025 ada 1 kunjungan,	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibandingkan dari bulan sebelumnya karena pasien yang perawatan di ruang ICU adalah sebagian pasien jantung
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)

NO	HAL	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	19	13	11	↓0,15%
2	JKK	0	0	1	↑100%
3	Umum	0	1	0	↓100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	0	0	Tetap
Total Pasien		19	14	12	↓0,14%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

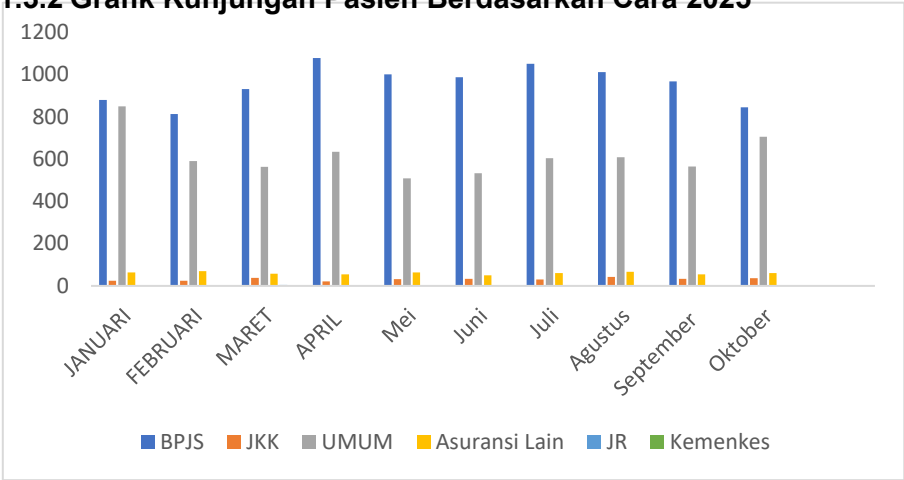
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan Oktober 2025 mengalami penurunan di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Oktober 2025 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi bulan Oktober 2025 tidak ada pasien	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada tetap dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2025)

NO	HAL	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1010	967	844	↓ 12,7%
2	JKK	608	565	705	↑ 19,8 %
3	Umum	42	34	36	↑ 5,5%
4	Asuransi Lain	67	54	60	↑ 6,6%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		1727	1602	1645	↑ 2,6 %

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara 2025



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	September	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasien BPJS di IGD menurun dibandingkan bulan Oktober 2025 banyaknya rujukan dari luar yang di tolak terkait fasilitas dan untuk kunjungan menurun,pe nurunan ini juga di sebabkan banyaknya pendingan pasien TF sehingga	Kunjungan pasien UMUM di IGD mengalami penurunan paling tajam .7%	JKK mencatat penurunan paling tajam (masing-masing sekitar 19%), menunjukkan kemungkinan penurunan rujukan dari perusahaan/i nstansi atau masalah administratif/ asuransi.	Asuransi Lain mencatat penurunan paling tajam (masing-masing sekitar 19%), menunjukkan kemungkinan penurunan rujukan dari perusahaan/i nstansi atau masalah administratif/ asuransi.	Tidak ada pasien dari jenis ini selama tiga bulan berturut-turut → perlu dikaji apakah layanan ini masih aktif atau kurang diketahui oleh pasien.	□ Terjadi kenaikan total kunjungan pasien sebesar 2,6 % dari September.ke Oktober □ Penurunan ini bisa mencerminkan faktor musiman, perubahan kebijakan, atau faktor eksternal lain seperti cuaca, libur panjang, atau isu kepercayaan pasien. 0,9 %

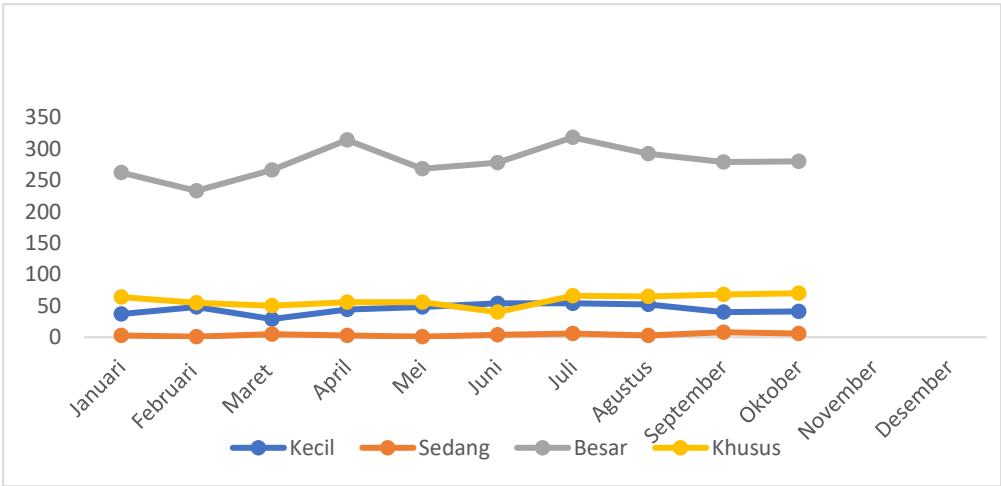
		membatasi pasien terkait TF					
	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Agustus - Oktober 2025)

NO	HAL	AGUSTUS 2025				SEPTEMBER 2025				OKTOBER 2025			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	49	3	278	29	40	8	269	31	39	3	264	43
2	JR	0	0	1	5	0	0	1	3	0	0	3	6
3	Umum	1	0	5	6	0	0	5	9	1	2	11	16
4	Asuransi Lain	2	0	6	3	0	0	2	2	1	1	3	4
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPJS TK	0	0	2	22	0	0	2	23	0	0	0	22
	Total Pasien	412				395				397			

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin 2025



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	BULAN	Instalasi Kamar Operasi			
1	Septe mber	Kecil	Sedang	Besar	Khusus
	Analisis	Jumlah pasien mata dibagi setiap bulannya jadi jika tidak ada kendala jumlah pasien operasi kecil relative tetap namun di bulan September DPJP sempat sakit sehingga pasien operasi kecil ditunda	Pasien Iridectomy meningkat	Pasien cito dari IGD tidak sebanyak bulan sebelumnya, jumlah pasien loadingan dari poli juga menurun	Jumlah pasien urologi dan jkk meningkat.
	RTL	Tingkatkan capaian dengan mengawal pasien-pasien yang menunda dilakukan tindakan	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Memilah pasien-pasien di IGD yang benar-benar bisa dilakukan tindakan di sini agar dikerjakan di sini dan tidak dirujuk	Pertahankan capaian dengan memberikan pelayanan kepada pasien agar pasien-pasien kecelakaan kerja tetap dibawa ke RSPHM.

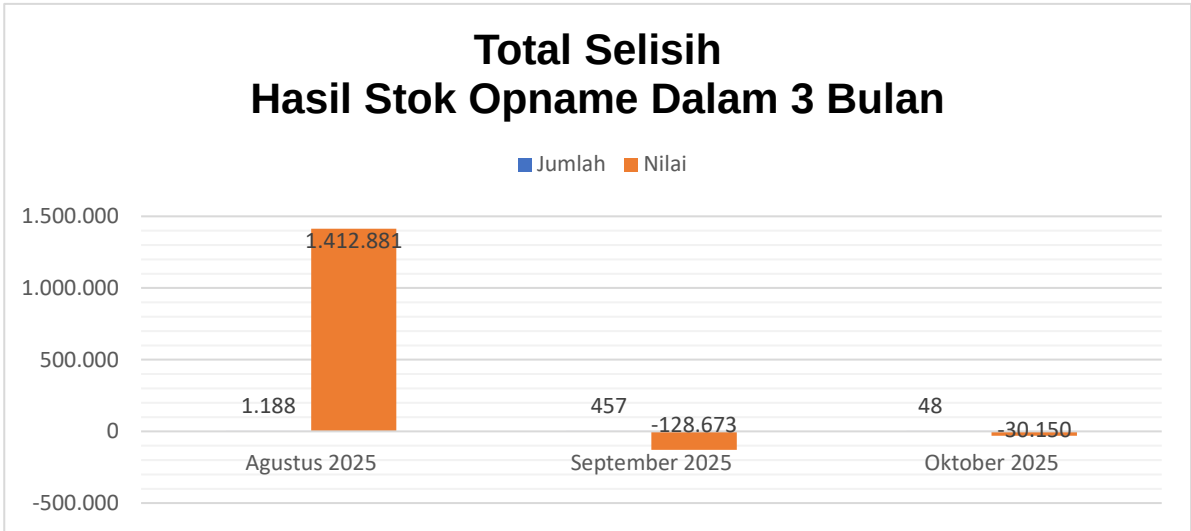
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Agustus – Oktober 2025

Unit	Stok	Agustus 2025		September 2025		Oktober 2025	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
GUDANG	Fisik	804.320	1.583.025.196	752.721	1.527.749.098	843.653	1.625.961.714
	Sistem	804.620	1.583.511.196	752.621	1.527.722.972	843.553	1.625.961.714
	Selisih	-300	-486.000	+100	+26.126	+100	0
DEPO FARMASI	Fisik	225.591	610.008.889	288.883	680.780.122	252.706	603.601.797
	Sistem	224.104	608.110.008	288.526	680.934.921	252.758	603.631.947
	Selisih	+1.488	+1.898.881	+357	-154.799	-52	-30.150
IKO	Fisik	2.624	100.070.771	2.548	93.388.930	2.427	89.711.385
	Sistem	2.624	100.070.771	2.548	93.388.930	2.427	89.711.385
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		+1.188	+1.412.881	+457	-128.673	+48	-30.150

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Agustus - Oktober 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

No	Analisis	Rencana Tindak Lanjut
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp 0 namun jumlah yang selisih 100 , hal ini disebabkan karena :		
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
2	Kode barang F04379 Oat Anak 2 Fdc Dosis Harian (Hibah) selisih lebih 52 tablet dan F00556 Oat Dewasa 4 Fdc Dosis Harian (Hibah) dikarenakan depo farmasi salah input satuan terkecil dalam 1 box dan di release oleh gudang farmasi.	1. Penggunaan scan barcode atau RFID dalam proses serah terima barang → follow up ke programmer terkait dengan program scan. 2. Pelaksanaan double check oleh petugas gudang dan unit. 3. Dilakukan retur barang unit jika tidak diambil oleh unit.
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp -30.150 , hal ini disebabkan karena :		
1	Ketidaksesuaian dalam proses INPUT dan SIAP menyebabkan kesalahan dalam jumlah obat yang di input dan disiapkan, yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan double check.	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan. 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
2	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS, seperti : F00996 blood transfusi set – otsuka = +2 F04724 dermafix s iv 6x7cm – onemed = +3 F01475 infusion set dewasa y set – otsuka = +1 F01481 iv cannula plus no 20 – hospitech = +1	1. Penegasan kembali kepada perawat IGD terkait kewajiban penulisan resep yang sesuai → kolaborasi dengan Karu IGD. 2. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan dan supervisi oleh kains farmasi. 3. Perbaiki alur resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.
3	Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS oleh perawat IRNA sementara pasien sudah KRS).	1. Dilakukan pemahaman kembali proses return sesuai alur dan dilakukan supervisi berkala oleh Karu IRNA dan PJ Shift ruangan untuk mengontrol terkait proses return ke farmasi sesuai dengan alur yang sudah di sepakati 2. Melakukan double crosscheck oleh petugas farmasi saat akan melakukan return di supervisi setiap hari oleh kains farmasi 3. Melakukan audit dan evaluasi berkala oleh Kabid keperawatan dan Kabid penunjang terkait obat-obatan yang belum tereturn sesuai dengan alur
4	Kesalahan dalam perhitungan buffer stok tidak sesuai: F00304 fenofibrat tab 300 mg - hexpharm jaya = +419 F03214 vitamin b kompleks tab – pim = +173	1. Perbaiki penataan ulang buffer stok sesuai rak di ruang buffer stok (sesuai alfabetis dan penggolongan obat). 2. Penambahan lemari buffer stok di ruang buffer agar buffer tidak di tumpuk di dalam kardus.

IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :		
1	Perawat patuh melakukan input resep; retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan; tidak ada anomali data di SIMRS	Supervisi secara berkala

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan Oktober 2025 - April 2026)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Mar 24 - Okt 25
							Agt	Sept	Okt		
1.	F01390	Foley cath no 20 - rusch	Pcs	20.570	30/11/2025	P20L04	22	22	20	411.400	18
2.	F00893	Aquacel silver 10cmx10cm (420676) - convatec	Pcs	191.250	30/01/2026	4A03853	0	2	2	382.500	0
3.	F00176	Cendo pantocain 2% - cendo	Flash	13.250	30/01/2026	3p30117	4	4	4	39.750	16
4.	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/01/2025	76122095132	10	10	6	1.680.000	21
5.	F01395	Foley cath silicon no 12 - rusch	Pcs	77.000	30/01/2026	KME21B1823	19	19	19	1.463.000	3
6.	F00558	Obat suntik kb 1 - harsen (hibah)	Vial	0	30/01/2026	3A020100	38	28	28	0	146
7.	F04476	Susu dancow full cream 780 g (hibah) - nestle	Box	0	01/01/2026	12578064	33	21	7	0	113
8.	F00812	Vaksin vaxigrip tetra - sanofi	Vial	179.550	31/01/2026	5DA67D1	5	3	5	508.725	183
9.	F00514	Nebacetin powder 5 g - pharos	Btl	23.000	28/02/2026	Y3B054A	4	4	4	92.000	3
10.	F00823	Velcasma xr tab 250 mg - novell	Tab	1.800	28/02/2026	26B194	215	207	173	311.400	799
11.	F00968	Benang t-vio 2-0 v9 - triton	Pcs	83.000	01/03/2026	23030460	13	13	13	996.000	61
12.	F00115	Cairan inf kaen mg3 500 ml - otsuka	Flash	13.656	01/03/2026	G87C54A	28	27	27	355.056	53
13.	F01382	Foley cath 3 way no 20 - rusch	Pcs	83.625	01/03/2026	183430	22	10	10	836.250	31
14.	F00517	Neostigmine inj 05 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/03/2026	E23C0063A	10	10	10	109.010	7
15.	F04488	Norepinephrine inj 1 mg/ml - bernofarm	Amp	14.680	30/03/2026	26B114	5	5	5	73.400	2.494
16.	F00450	Lixiana tab 30 mg - kalbe	Tab	25.000	30/03/2026	353698	75	75	75	134.750	0
17.	F00701	Sequest susp 40 g - novell	Sach	19.250	30/04/2026	256269	33	31	27	519.750	42
18.	F00944	Benang t-mono 6-0 m54 - triton	Pcs	144.000	30/04/2026	230405CF	23	23	21	3.024.000	30
TOTAL										10.936.991	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Oktober 2025 - April 2026)

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Oktober 2025 - April 2026 karena obat dan alkes slow moving: 1. Foley cath no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/09/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 2. Aquacel silver 10cmx10cm (420676) - convatec untuk mencegah pembentukan kembali biofilm pada dasar luka, diperlukan perlindungan antimikroba yang efektif dan tahan lama. Faktur pembelian terakhir tanggal 30/09/2025 dari distributor sejumlah 2 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 3. Cendo pantocain 2% - cendo digunakan sebagai anestesi untuk meredakan nyeri pada mata selama operasi atau pemeriksaan mata. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/07/2023 dari distributor sejumlah 16 flash. 4. Dj stent 6 fr close end – medika dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs. 5. Foley cath silicon no 12 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs. 6. Obat suntik kb 1 - harsen (hibah) sebagai obat KB. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari BKKBN dengan ed < 1 tahun pada tanggal 22/08/2025 sejumlah 40 vial. 7. Susu dancow full cream 780 g (hibah) – nestle. Penggunaan susu slow moving diberikan untuk pasien anak yang mengkonsumsi obat TB. Penerimaan hibah dari Dinkes Kabupaten Malang dengan ed < 1 tahun pada tanggal 16/10/2024 sejumlah 120 box. 8. Vaksin vaxigrip tetra – sanofi untuk mencegah penyakit Influenza yang disebabkan oleh 4 tipe virus influenza yaitu 2 tipe A dan 2 tipe B yang sangat mudah menular melalui air liur (droplet). Pembelian terakhir tanggal 23/08/2025 dari distributor sejumlah 11 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor karena adanya program harga promo dari PT. Sanofi dan penyediaan stok di RS untuk paket vaksin dengan harga promo. 9. Nebacetin powder 5 g – pharos digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi kulit superfisial (permukaan) yang disebabkan oleh bakteri. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 16/06/2023 dari distributor sejumlah 5 botol.	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. 6. Floorstok IKO yang slow moving di tukar dengan ED jauh.

10. Velcasma xr tab 250 mg – novel untuk mengatasi gejala mengi dan sesak napas pada penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis, termasuk bronkitis kronis dan emfisema. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 29/04/2024 dari distributor sejumlah 450 tablet. 11. Benang t-vio 2-0 v9 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/03/2023 dari distributor sejumlah 48 pcs. 12. Cairan inf kaen mg3 500 ml – otsuka digunakan untuk membantu pengobatan ketidakseimbangan karbohidrat dan elektrolit pada keadaan insufisiensi asupan makanan per oral, prosedur pembedahan, neonatologi, dan asidosis diabetikum. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 13/01/2025 dari distributor sejumlah 20 flash. 13. Foley cath 3 way no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/06/2024 dari distributor sejumlah 20 pcs. 14. Neostigmine inj 0.5 mg/ml – ethica meringankan gejala myasthenia gravis, ileus paralitik, atau retensi urine pascaoperasi, serta menghilangkan efek obat bius pascaoperasi. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/11/2024 dari distributor sejumlah 10 amp. 15. Norepinephrine inj 1 mg/ml – bernofarm untuk mengatasi hipotensi yang mengancam nyawa dan menangani kondisi henti jantung dan syok septik. Terdapat obat slow moving di IKO. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/02/2025 dari distributor sejumlah 300 amp. 16. Lixiana tab 30 mg – kalbe untuk gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah, penyumbatan pada paru-paru, serta mencegah stroke. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/09/2021 dari distributor sejumlah 84 tablet. 17. Sequest susp 40 g – novell untuk terapi tambahan utk menurunkan kadar kolesterol serum pada pasien dengan hiperkolesterolemia primer yang tidak menunjukkan respon terhadap kontrol makanan, menurunkan kadar kolesterol pada pasien dengan hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia, mengurangi pruritus pada obstruksi parsial pada saluran empedu, terapi tambahan dengan terapi rehidrasi pada diare karena malabsorpsi asam empedu, reseksi usus, penyakit Chron, vagotomi, dan neuropati vagal diabetikum Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/06/2024 dari distributor sejumlah 40 sachet. 18. Benang t-mono 6-0 m54 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 07/08/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor.	
--	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

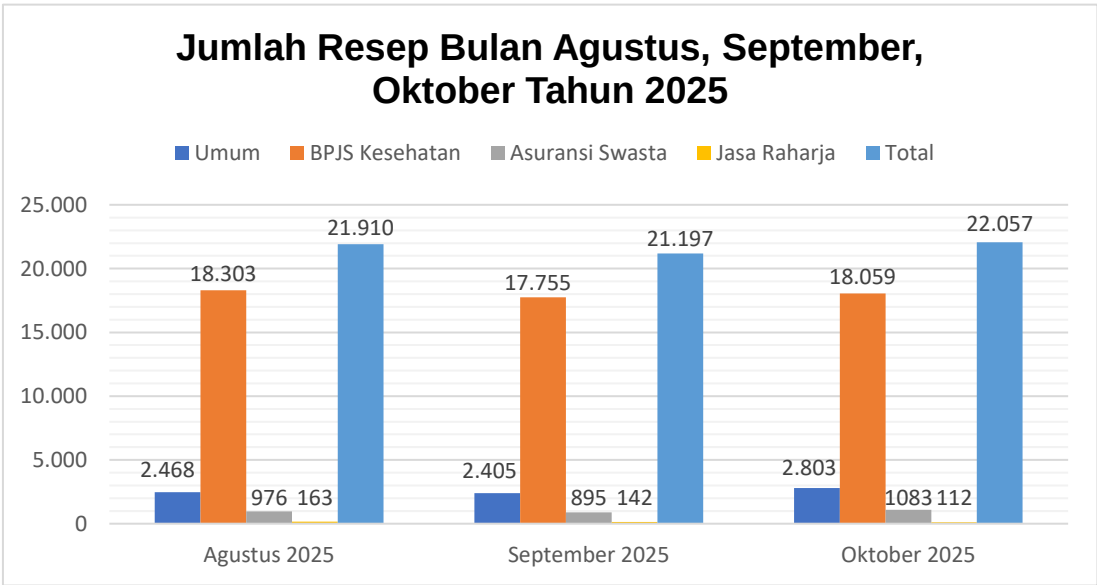
No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah Tenaga Vokasi Farmasi/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

5	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
9	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Oktober 2025

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asurans i Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	18	254	0	0	1	273
	Jumlah Resep Obat Jadi	411	7.040	0	529	43	8.023
	Jumlah Resep Obat	429	7.294	0	529	44	8.296
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	71	36	0	0	0	107
	Jumlah Resep Obat Jadi	905	1.558	1	158	38	2.660
	Jumlah Resep Obat	976	1.594	1	158	38	2.767
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	295	1.566	0	0	0	1.861
	Jumlah Resep Obat Jadi	1.054	6.726	0	300	4	8.084
	Jumlah Resep Obat	1.349	8.292	0	300	4	9.945
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	49	879	0	95	26	1.049
	Jumlah Resep Obat	49	879	0	95	26	1.049
TOTAL		2.803	18.059	1	1.082	112	22.057

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Agustus - Oktober 2025



Analisis :

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan Oktober 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan September 2025, dengan total resep yaitu : bulan September 2025 sebanyak 2.405 resep umum dan bulan Oktober 2025 sebanyak 2.803 resep umum.

- Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan Oktober 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan September 2025, dengan total resep yaitu : bulan September 2025 sebanyak 17.755 resep BPJS Kesehatan dan bulan Oktober 2025 sebanyak 18.059 resep BPJS Kesehatan.
- Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan Oktober 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan September 2025 dengan total resep yaitu : bulan September 2025 sebanyak 1.037 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan Oktober 2025 sebanyak 1.195 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja
- Secara keseluruhan total resep pada bulan September 2025 mengalami peningkatan :
 - Adanya pembatasan kunjungan pasien per poli untuk pasien rawat jalan,
 - Adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil di poli,
 - Retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien di poli,
 - Kurangnya promo tarif vaksin di poli,
 - Kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain,
 - DPJP tidak praktek karena cuti,
 - Adanya batasan diagnosa yang tidak bisa di layani di FKRTL untuk pasien IGD,
 - Adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat untuk pasien rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

- Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
- Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
- Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
- Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
- Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus - Oktober 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Ags 25	Sept 25	Okt 25	
1	Pengkajian resep	100%	99,01%	99,29%	99,53%	Jumlah pengkajian resep yaitu Agustus 2025 = 21.912 September 2025 = 21.197 Oktober 2025 = 22.057 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu Agustus 2025 = 218 September 2025 = 151 Oktober 2025 = 103
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO

						diletakkan dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ada kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	17	15	9	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

3.2.1.10 Tabel Analisa dan Tindaklanjuti Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Juli - September 2025

KINERJA	ANALISA	TINDAKLANJUT
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan Oktober 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan September 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan September 2025 sebanyak 99,29% dan bulan Oktober 2025 sebanyak 99,53%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : 1. Dari segi telaah administrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. 2. Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 103 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. 3. Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.	1. Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi. 2. Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). 3. Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

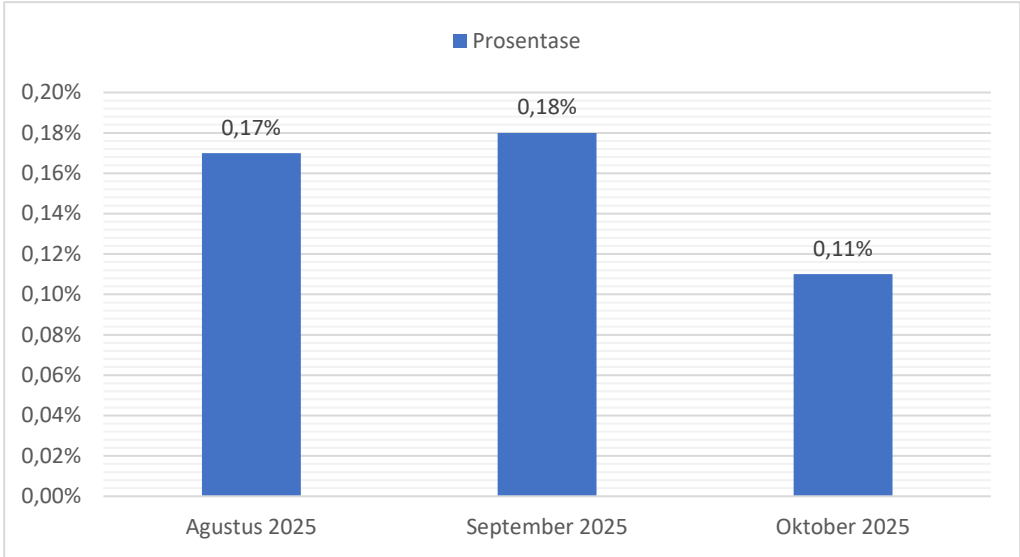
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Oktober 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. - Menganalisa laporan ESO. - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat megakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien Oktober 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan September 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan September 2025 sebanyak 15 dan bulan Oktober 2025 sebanyak 9. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.	- Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

1.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Agustus - Oktober 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/8/2025-31/8/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/8/2025-31/8/2025	Methylelgometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Agustus 2025 = 0.17%					

1	1/9/2025-30/9/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/9/2025-30/9/2025	Methylethergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase September 2025 = 0.18%					
1	1/10/2025-31/9/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
2	1/10/2025-31/10/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Oktober 2025 = 0.11%					

1.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Agustus - Oktober 2025



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Oktober 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak ada pemusnahan
2	BMHP/ Alat Kesehatan Rusak	Spuit 50 cc Lubang Pinggir	Onemed (No. Batch: 02072588)	1. Bocor, spuit seret, mudah lepas dorongannya, kaku,	Form keluhan alat kesehatan substandard dari DPJP Paru dilaporkan

	(Substandar)			sehingga jika ditarik lebih kuat cairan langsung muncrat. Karena dorongan spuitnya seret dan harus ditarik kuat, bisa menyebabkan posisi jarum bergeser, dan jika sudah bergeser berpotensi cairan pungsi pleuranya macet dan tidak terambil.	tanggal 24/09/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT dan tindak lanjut untuk mengganti dnegan spuit 50 cc LP - Terumo.
		Three way stopcock - Onemed	9 pcs	Three way patah (cacat produk) No. Batch : 02092488 dan 01102488	Form keluhan alat kesehatan substandar dari ruang IGD dilaporkan tanggal 07/10/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT untuk diganti sejumlah yang patah.
		Dermafix S IV 6x7 cm (IV dressing) - Onemed	5 pcs	Dermafix rusak ketika di buka dari bungkusnya. No. Batch : 01092588	Form keluhan alat kesehatan substandar dari ruang IGD dilaporkan tanggal 14/10/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT untuk diganti sejumlah yang rusak.
		Spuit 3 CC	Stera medical (No. batch : 01092588)	Ruang Irna 2 3 4 A : Jika di buat ngoplos obat tarikannya berat. Gampang lepas jika dibuat injeksi	Form keluhan alat kesehatan substandar dari unit rawat inap dilaporkan pada bulan oktober diajukan ke Pengadaan PT untuk ditindaklanjuti dengan penggantian merk sebelumnya (Spuit - Gidcare dan IV Canul - Prodevice).
		Spuit 10 CC	Stera medical (No. batch : 10102588)	Ruang Irna 6 7 8 A : 1. Tarikan dan dorongan spuit berat 2. Jarum kurang tajam 3. Jarum mudah tersumbat Ruang Irna 5C : 1. Susah di dorong di Tarik. 2. Saat nyedot obat tarikan sulit ICU : 1. Jarum kurang tajam/ terasa tumpul 2. Jarum gampang mleyot 3. Beberapa spuit bocor saat dibuat mengambil obat	
		IV Cannul No. 20	Hospitech (No. Batch : 3389224N)	Ruang Irna 2 3 4 A : 1. Waktu pasang infus sudah masuk ke pembuluh darah pada saat jarum ditarik (ujung selang) kanul keriting	
		IV Cannul No. 24	Hospitech (No. Batch : 3189523G)	Ruang Irna 6 7 8 A : 1. Saat ditusuk jarum terasa tidak tajam 2. Plastik abocath terlalu tebal, jadi sering terjadi pecah pembuluh darah Ruang Irna 2C : 1. Selalu mrembes darah dari bekas tusukannya. Sehingga mengakibatkan untuk	

				dilakukan infus ulang (2X) 2. Saat tersenggol ganti baju dari sela - sela merembes darah. Ruang Irna 5C : Sambungan canul bocor dan insersi lambat Maternitas : 1. Jika di pakai nusuk tidak tajam. 2. Darah ngrembes di selangnya iv Ruang 3C : sering membelah jadi 2 dan keriting	
3	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Oktober 2025

No	Masalah	Tindak Lanjut			
1.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname		
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan		
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0		
		A	- Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. - Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. - Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. - Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. - Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan		
2.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Agustus 2025 = +1.412.881 September 2025 = -	P	Perencanaan scan barcode.		
		D	1. Sudah dilakukan pengajuan proposal scan barcode dan pengadaan alat yang menunjang pelayanan. 2. Sudah dilakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.		

	128.673 Oktober 2025 = -30.150	S	Selisih stok opname di gudang farmasi dan depo farmasi
		A	1. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien. 2. Scan barcode menunggu antrian di progamer PT.
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 19,25% dan waktu tunggu obat racikan 8,27%	P	Perencanaan elektronik KPO dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur elektronik KPO di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	1. Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. 2. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Elektronik KPO menunggu antrian di progamer PT. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 155 KPO.
4.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaikan kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	1. Obat tertinggal bulan September mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Farmasi sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
5.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
6.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan VVM (Vaksin Vial Monitor) untuk vaksin pemerintah warna segiempat lebih gelap dari warna lingkaran sehingga tidak layak digunakan.	P	Pengadaaan VR (Vaccine Refrigerator) di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.

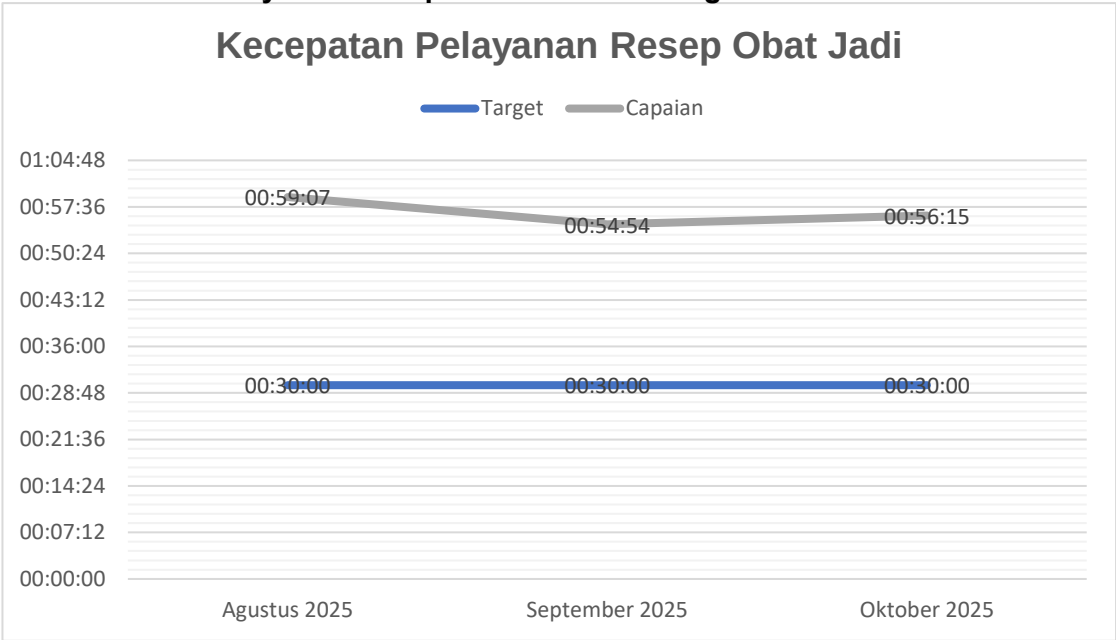
	(Data vaksin pada Tabel 9.10)		3. Koordinasi dengan PJ Vaksin Pemerintah untuk permintaan vaksin baru ke Puskesmas.
7.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). Agustus 2025 = 19 resep September 2025 = 36 resep Oktober 2025 = 21	P	Koordinasi dengan Karu poli
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol. 2. Koordinasi dengan Karu poli untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" : a. Input resep IU di apol b. Copy no apol c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Farmasi konfirmasi ke perawat poli untuk hapus surkon di SIMRS. c. Farmasi konfirmasi ke CSO untuk hapus di V-Claim pada grup whatsapp Pelayanan BPJS Kes jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format: Ganti Surat Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa d. Perawat input ulang surkon terbaru di SIMRS dan mengirimkan di grup WA. e. Pendaftaran mengubah di V-Claim f. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. g. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.
8.	Obat Rawat Inap di tandon di Nurse Station	P	Pengecekan obat tandonan di nurse station setelah dilakukan serah terima obat ODD
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi terkait pengecekan obat tandonan di nurse station
		S	Memaksimalkan jobdesk distribusi obat rawat inap oleh Tenaga Vokasi Farmasi dan Apoteker untuk mengecek obat yang ada di nurse station
		A	Pada saat distribusi obat rawat inap Tenaga Vokasi Farmasi wajib mengecek obat-obat yang ada di nurse station. Jika ada tandonan obat, Tenaga Vokasi Farmasi wajib menanyakan ke perawat jam pemberian obatnya. Jika sudah terlewat jam pemberiannya maka Tenaga Vokasi Farmasi wajib cek DPO obat yang ada di nurse station jika sudah lewat waktu pemberian harus di retur saat itu juga, serah terima obat dengan perawat dan perawat juga langsung input retur di simrs. Apoteker rawat inap saat visite pasien juga wajib double check obat yang ada di nurse

			station. Jika obat signa PRN / kp berkoordinasi dengan apoteker, apakah pasien masih membutuhkan terapi tersebut.
9.	Pelunasan resep non pasien	P	Koordinasi dengan keuangan PT. DPM, kasir dan farmasi
		D	Perbaikan alur pelayanan resep non pasien di SIMRS
		S	PT. DPM menemukan obat karyawan dan pembelian urinal/ pispot yang diinputkan non pasien belum dilunaskan di sistem sehingga banyak tagihan yang belum terbayarkan muncul di keuangan PT.
		A	Pembayaran obat non pasien wajib minta nota yang sudah terstempel LUNAS oleh kasir, setelah itu baru diberikan barangnya. Jika sudah terstempel lunas tetapi di billing belum dilunasi telfon kasir. Jika belum terselesaikan hingga akhir shift wajib ditulis dioperan unit farmasi. Jika pegawai RSPH yang membeli obat : tulis nama/unit
10.	Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan sehingga terjadi pendingan obat kronis.	P	Pengajuan bridging simrs dan apotek online BPJS Kesehatan
		D	1. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi terkait pendingan yang sering terjadi untuk memperbaiki ketelitian inputan obat di apotek online BPJS Kesehatan. 2. Pengecekan inputan obat kronis di apotek online BPJS dan e-resep oleh admin farmasi setiap hari
		S	1. Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan dan muncul di pendingan obat kronis yaitu velpraz tab 250 mg/ valproat 250 SK tab salut 250 mg (salah input valproat 250 SK tab lepas lambat 250 mg), berotec / fenoterol hbr 100 sk inh 100 mcg/puff (salah input fenoterol hbr 0,1 SK btl 50 ml), adalat oros 10 mg / aripriprazol 10 SK tab dispersible 10 mg (salah input aripriprazol 15 SK tab discmelt 15 mg). 2. Kesalahan centangan obat paket dan non paket di SIMRS.
		A	1. Jobdesk admin farmasi yaitu staff non tenaga vokasi farmasi. 2. Jadwal admin farmasi yaitu NS (jam 08.00-16.00). 3. Target admin : tidak ada masalah inputan apotek online dan pendingan.
11.	Rekonstitusi sediaan steril bentuk serbuk injeksi wajib dilakukan di LAF	P	Pelaksanaan rekonstitusi serbuk injeksi semuanya dilakukan di LAF
		D	Pengajuan proposal pelatihan penyiapan obat intravena dan teknik aseptik
		S	Perlu adanya pelaksanaan pengoplosan obat injeksi bentuk serbuk untuk setiap obat yang akan digunakan, sehingga perlunya farmasi untuk mengoplos obat setiap shiftnya di LAF namun terkendala dengan jumlah tenaga yang melakukan pengoplosan injeksi selama ini adalah apoteker.
		A	1. Tenaga vokasi farmasi sesuai regulasi PMK terbaru bisa diberikan kewenangan melakukan rekonstitusi sediaan steril dengan syarat sudah terlatih. 2. Dilakukan pelatihan dispensing sediaan steril. 3. Dilakukan trial dispensing sediaan steril setiap shift. 4. Dilakukan penjadwalan per shift untuk TVF dan Apoteker yang akan mengoplos.
12.	Input permintaan barang dari depo farmasi ke gudang farmasi	P	Pelaksanaan permintaan barang dari depo farmasi ke gudang farmasi dengan ROP (Re Order Point)
		D	Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi terkait ROP (Re Order Point)
		S	1. Permintaan ke gudang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu (tidak merata). 2. Fitur permintaan barang ROP tidak pernah dipakai lagi.
		A	1. Semua petugas harus bisa melakukan pengecekan barang menipis, harus bisa dan mau melakukan permintaan barang ke gudang.

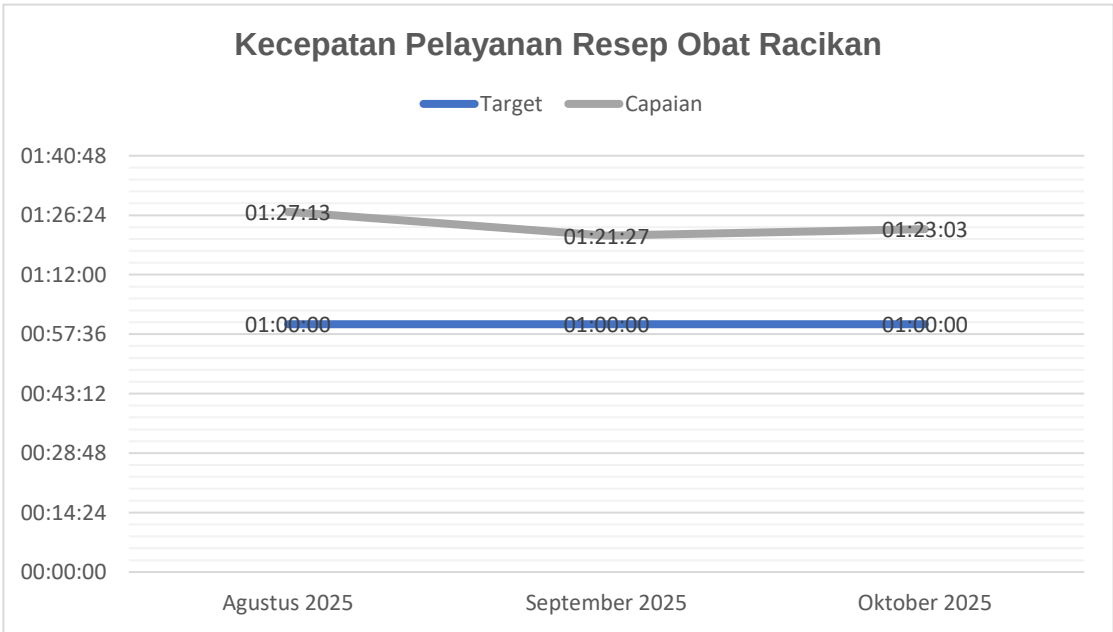
			2. Melakukan evaluasi dan melakukan permintaan dengan fitur ROP lagi. 3. Melakukan perbandingan permintaan ROP dan non ROP.
--	--	--	--

1.2.1.16 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Rawat Jalan Bulan Juli, Agustus, dan September 2025

Grafik Pelayanan Resep Obat Jadi Bulan Agustus – Oktober 2025



Grafik Pelayanan Resep Obat Racikan Bulan Agustus – Oktober 2025



Analisis :

- Kecepatan pelayanan resep obat jadi belum mencapai 100% dengan realisasi 00:56:15 dari target yang di tetapkan sebesar ≤ 30 menit.
- Kecepatan pelayanan resep obat racikan belum mencapai 100% dengan realisasi 01:23:03 dari target yang di tetapkan sebesar ≤ 60 menit.
- Waktu tunggu obat rawat jalan pada bulan Oktober 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan September 2025 dan belum mencapai target 100% dikarenakan:
 - DPJP tidak praktek karena cuti sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari berikutnya ketika DPJP praktek,

- Jadwal praktek DPJP yang bersamaan,
- Komposisi farmasi sudah lengkap (cuti melahirkan sudah masuk bekerja) dengan 5 apoteker rawat jalan, 25 Tenaga Vokasi Farmasi, dan 2 Admin Farmasi.
- Masih terdapat petugas tidak real time klik ambil obat di SIMRS sehingga data tidak akurat.
- Terdapat data waktu tunggu di SIMRS berubah ketika ada revisi resep (pending resep) jadi yang terbaca adalah setelah pending resep.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Evaluasi kebijakan alur penyiapan sampai penyerahan obat ke pasien dan mengulang sosialisasi kebijakan alur penyiapan sampai penyerahan obat ke pasien.
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
4. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
5. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh Tenaga Vokasi Farmasi, resep iter dan PRB oleh apoteker.

1.2.1 Laboratorium

1.2.1.11Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

	TARGET	AGS 25	%	SEP 25	%	OKT 25	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOGI	1950	1817	>0,2%	1628	<10,4%	1752	>7,07%
FAAL HEMOSTASIS	716	779	<6,2%	741	<4,8%	759	>2,3%
HEMATOLOGI LAIN	1	0	0%	0	0%	0	0%
URINALISIS	418	283	>9,5%	267	<5,6%	291	>8,2%
ANALISA FEACES	30	11	<21,4%	9	<18,1%	11	>18,1%
FUNGSI HATI	611	315	<15,5%	306	<2,8%	315	>2,8%
LEMAK DARAH	806	808	<1,3%	787	<2,5%	676	<14,1%
GINJAL HIPERTENSI	1394	1401	<1,2%	1402	>0,07%	1342	<4,2%
GULA DARAH	1187	2115	>7,2%	1876	<11,3	1963	>4,43%
JANTUNG	583	545	<5,5%	497	<8,8%	550	>9,6%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	164	< 30,2%	208	>21,1%	215	>3,2%
IMUNO SEROLOGI	481	425	<9,38%	266	>37,4%	300	>11,2%
REMATIK	6	5	>40%	3	>40%	7	>57%
ENDOKRINOLOGI	60	72	>22,5%	69	<4,1%	63	<9,5%
REPRODUKSI	44	92	>71,7%	86	<6,5%	88	>2,2%
MIKROBIOLOGI	32	46	>6,5%	54	>14,8%	58	>6,8%

Jumlah	8654	8878	>0,3%	8199	<7,6%	8390	>3,22%
--------	------	------	-------	------	-------	------	--------

Analisis :
 Jumlah Pemeriksaan Pada bulan Oktober2025 mengalami Kenaikan sebanyak 3,2 % dari Bulan September, dengan 8390 pemeriksaan Laboratorium Akan tetapi masih dibawah target yang di tetapkan yaitu 8654

Rencana Tindak Lanjut :
 Tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke pada pasien khususnya pasien Laboratorium

1.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan April - Agustus 2025

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
Bulan April 2025					
1.	Abd Rohman	229923	18/04/2025	ICU	Sampel Vena BGA
2.	Aqilla Putri	160607	19/04/2025	IRNA 3C	Sampel Clotting
3.	Rochmad	102166	29/04/2025	IRNA 5C	Sampel Clotting
Bulan Mei 2025					
1.	Andara	224145	01/05/2025	IGD	Sampel Clotting
Bulan Juni 2025					
Tidak ditemukan sampel rusak					
Bulan Juli 2025					
1.	Kuseran	183848	16/07/2025	IGD	DL cloting
2.	Juri	069001	21/07/2025	IGD	DL cloting
Bulan Agustus					
1	Ra'im	125436	12/08/1952	IGD	DL Cloting
2	Budiarjo	155739	15/08/2025	3A	SE Lisis
3	Suyatmi	235823	03/03/1948	ICU	SE Lisis
4	Suyatmi	235823	03/03/1948	7A	SE Lisis
Bulan September					
1	Abdul Rosyid	236733	09/09/2025	IGD	DI Cloting
2	Ngatijam	229509	13/09/2025	6A	Fh Cloting
3	Kasti	073280	13/09/2025	ICU	Se lisis
4	Fadjar Satria	230297	13/09/2025	ICU	BGA Vena
5	Mila	156030	21/09/2025	8A	DI Cloting
Bulan September					
1	M Abid N	188310	01/10/2025	3c	DL Cloting
2	Juma'iyah	207271	02/10/2025	7a	Se Lisis
3	Ichsan	237896	02/10/2025	IGD	DL Cloting
4	Putri W	142022	03/10/2025	6a	FH Cloting
5	Zaini	238306	12/10/2025	7a	FH Cloting
6	Moch Amin	035337	20/10/2025	7a	DL Cloting
7	Riyani	201139	23/10/2025	ICU	SE Lisis

Analisis :
 Di temukan 7 pasien yang sampel darahnya rusak

Rencana Tindak Lanjut :
 Konfirmasi ke Unit pengirim sampel untuk minta sampel ulang

1.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan April - Agustus 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18
Mei 2025	20	27	42	9	98	4	-	-	-	4
Juni 2025	15	29	27	8	79	2	1	-	-	3
Juli 2025	18	14	29	6	67	1	4	-	3	8
Agustus 2025	15	32	30	6	83	6	2	0	2	10

September 2025	21	22	33	3	79	3	4	0	6	13
Oktober										

1.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Maret - Mei 2025

NO	NAMA PASIEN	JUMLAH PASIEN DAN PERMINTAAN LABU DARAH INCOMPATIBLE				TOTAL PERMINTAAN LABU DARAH
		A	AB	O	B	
Bulan April 2025						
Tidak ada						
Bulan Mei 2025						
Tidak ada						
Bulan Juni 2025						
1.	Siti Rahajuningsih				√	2 Labu
Bulan Juli 2025						
Tidak ada						
Bulan Agustus 2025						
Tidak ada						
Bulan September 2025						
Tidak ada						
Bulan Oktober 2025						
Tidak ada						

Analisis :
 Tidak dtemukan pasien Incompatible

Rencana Tindak Lanjut :
 Pertahankan Tetap telili dan berhati hati dalam melakukan crossmatch

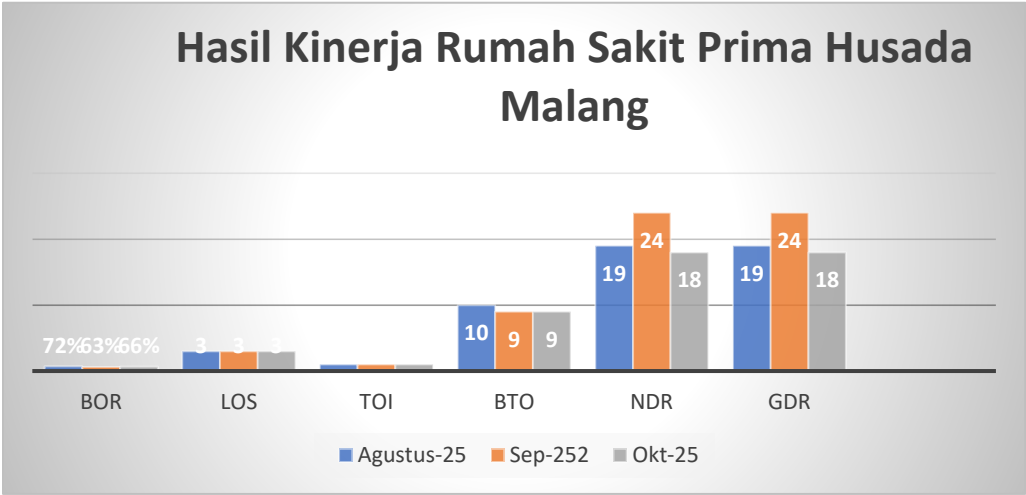
1.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Oktober 2025

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang													
						LT 2C	LT 2A	LT 3A	LT 3 C	LT 4ab	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	Agustus 25	63	26	76	64	91	60	82	81	81	64	12	32	25	72
					September 25	47	30	11	65	79	43	67	66	70	74	30	25	31	63
					Oktober 25	65	49	0	61	84	60	72	67	78	74	3	19	18	66
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	Agustus 25	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3
					September 25	4	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	2	2	3
					Oktober 25	4	3	0	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3
TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	Agustus 25	1	6	1	1	0	2	1	1	1	1	14	2	4	1
					September 25	3	5	9	1	1	3	1	1	1	1	6	3	3	1
					Oktober 25	1	2	0	1	0	2	1	1	1	1	45	5	6	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	Agustus 25	9	4	10	9	12	8	9	9	9	11	2	10	6	10
				(dalam hitungan bulan)	September 25	6	4	3	9	11	5	9	8	8	12	3	7	6	9
					Oktober 25	8	7	0	8	13	8	9	8	9	12	1	6	4	9

NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati} >48\text{jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25‰	Agustus 25	0	22	0	0	7	0	19	9	46	0	0	211	172	19
					September 25	0	0	0	0	0	0	19	32	0	0	100	71	351	24
					Oktober 25	0	0	0	4	7	0	19	0	19	0	0	182	361	18
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Agustus 25	0	0	0	0	7	0	19	9	46	0	0	211	172	19
					September 25	0	0	0	0	0	0	19	32	0	0	100	71	351	24
					Oktober 25	0	0	0	4	7	0	19	0	19	0	0	182	361	18

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Oktober 2025



Analisis :

Indikator	Nilai Oktober 2025	Standar Ideal	Evaluasi Singkat
BOR	66%	60%-85%	Masih dalam standar ideal
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	9 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Update Tren Tahun 2025

Indikator	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Catatan
BOR	81%	75%	72%	68%	69%	73%	72%	63%	66%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	9 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

Masalah :

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

Mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.

2. LOS (Length of Stay)

Indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:

- a) Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
- b) Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
- c) Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.

3. TOI (Turn Over Interval)

Mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.

4. BTO (Bed Turn Over)

Mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Untuk BOR:

Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.

2. Untuk LOS:

- a) Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
- b) Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.

3. Untuk TOI:

Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.

4. Untuk BTO:

- a) Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
- b) Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
- c) Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Oktober 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	355
2.	E11.4	With neurological complications	348
3.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	344
4.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	314
5.	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	299
6.	J47	Bronchiectasis	281
7.	R50.9	Fever, unspecified	208
8.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	196
9.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	191
10.	K04.1	Necrosis of pulp	184

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Oktobe 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever	122
2.	J18.9	Pneumonia	50
3.	E11.6	Dm Type 2 Hiperglikemia	31
4.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	27
5.	J18.0	Bronchopneumonia	23
6.	A09.9	Gastroenteritis Akut	17
7.	D24	Tumor Mammae	16
8.	E14.9	Dm Hyperglikemia	15
9.	N20.1	Batu Ureter	15
10.	I21.4	Nstemi	13

Analisis :

Diagnosa terbanyak pasien rawat inap bulan Oktober 2025 adalah typhoid fever sejumlah 122 Pasien. Diagnosa tersebut diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Oktober 2025

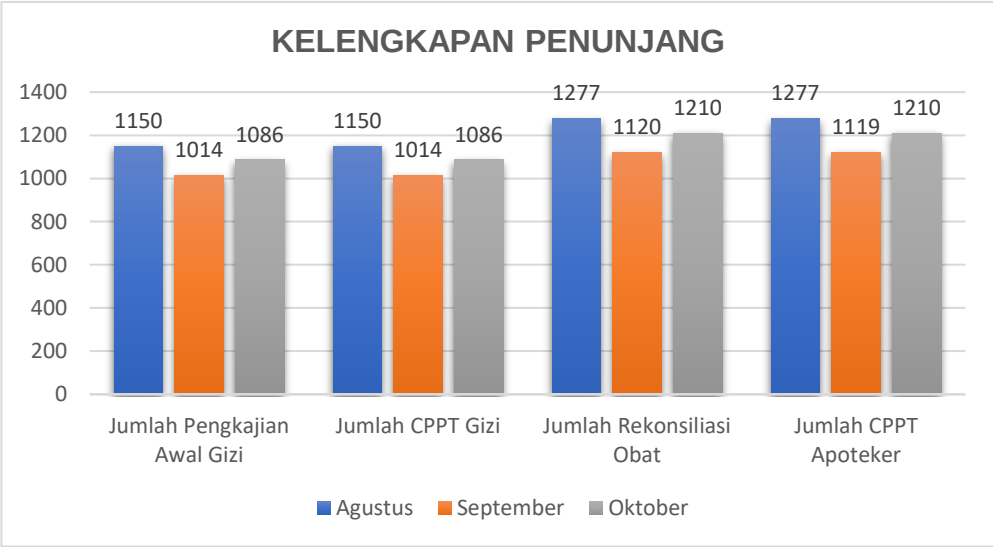
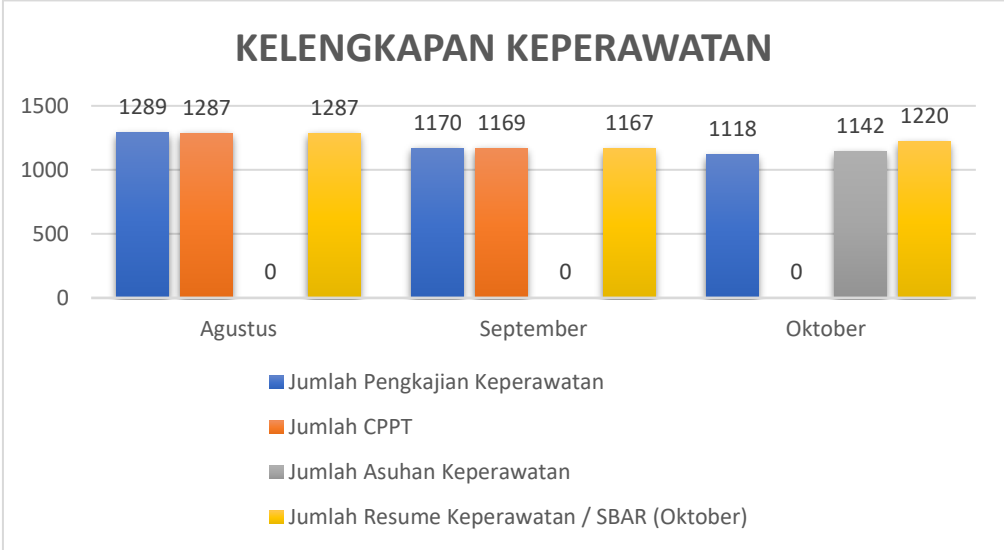
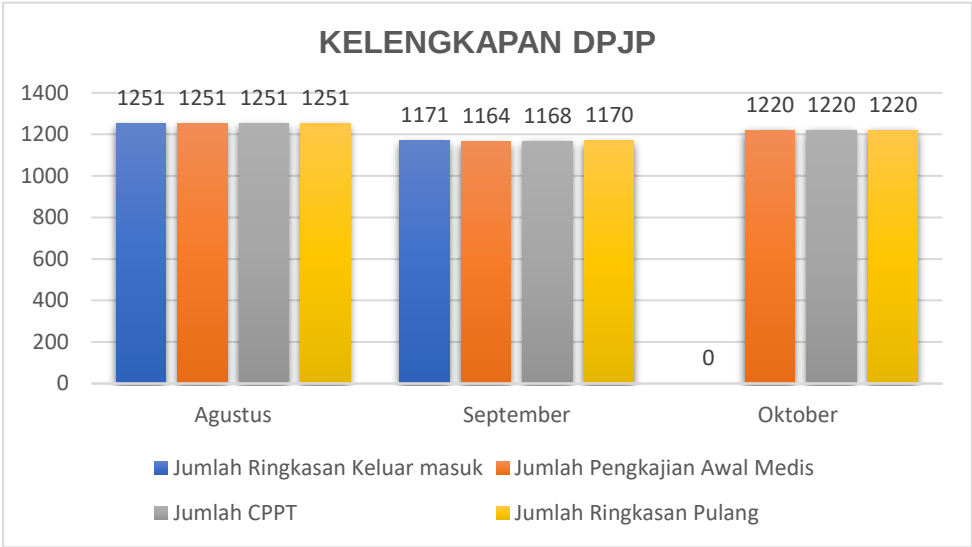
KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0
September	1171	100	0	0	1164	98,14	7	1,86	1168	99,73	4	0,33	1170	99,84	1	0,16
Oktober	-	-	-	-	1219	99,91	1	0,09	1220	100	0	0	1220	100	0	0

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR (Oktober)			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0
Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0
September	1170	99,52	1	0,48	1169	99,33	2	0,67	-	-	-	-	1170	99,52	1	0,48
Oktober	1118	92	112	8	-	-	-	-	1142	94	78	6	1220	100	0	0

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0

Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99.65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33
Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0
September	1014	100	0	0	1014	100	0	0	1120	100	0	0	1119	99,96	1	0,4
Oktober	975	90	111	10	1076	99	10	1	1210	100	0	0	1100	91	110	9

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Oktober 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi terisi lengkap 100% , sebanyak 1210 dokumen
- 2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 92% pada Bulan September 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan September 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

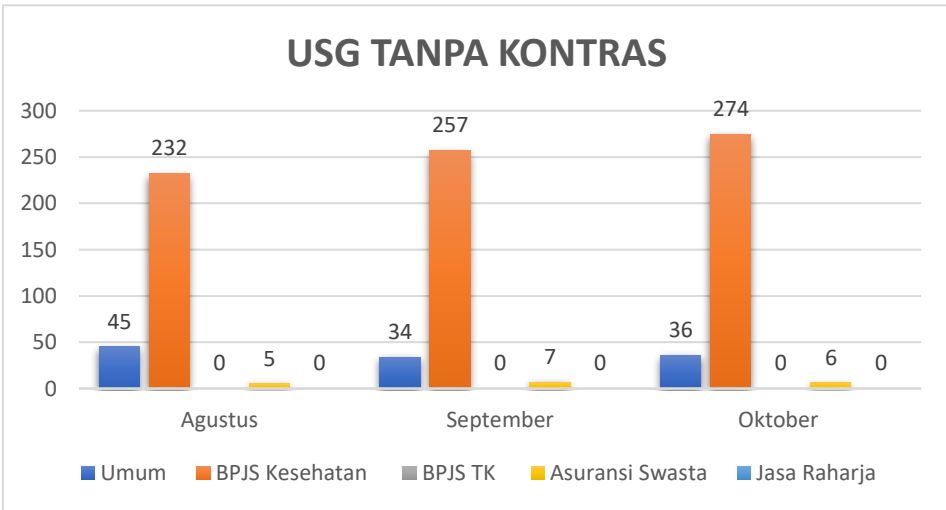
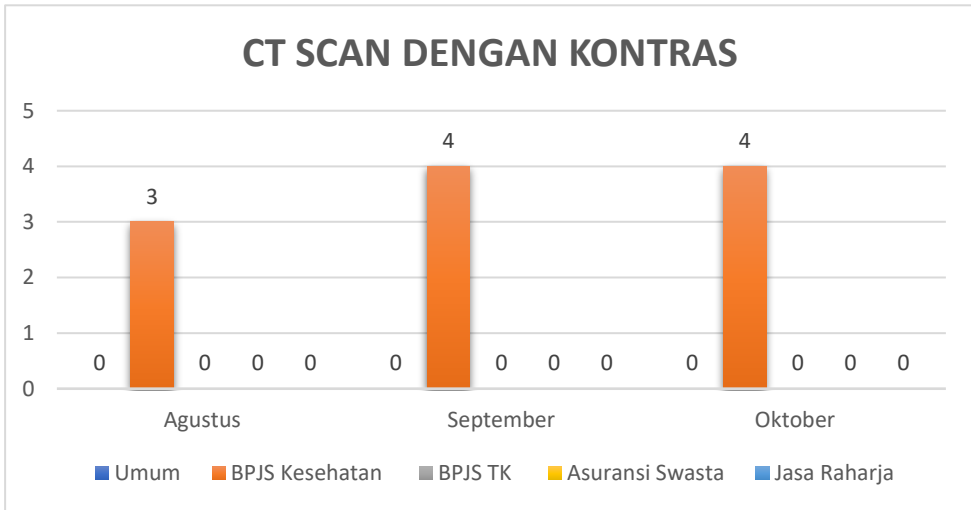
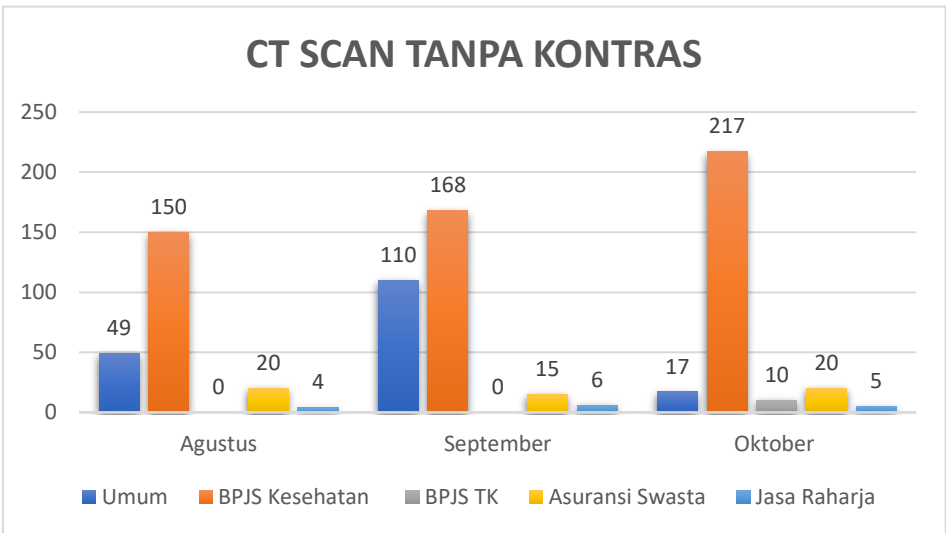
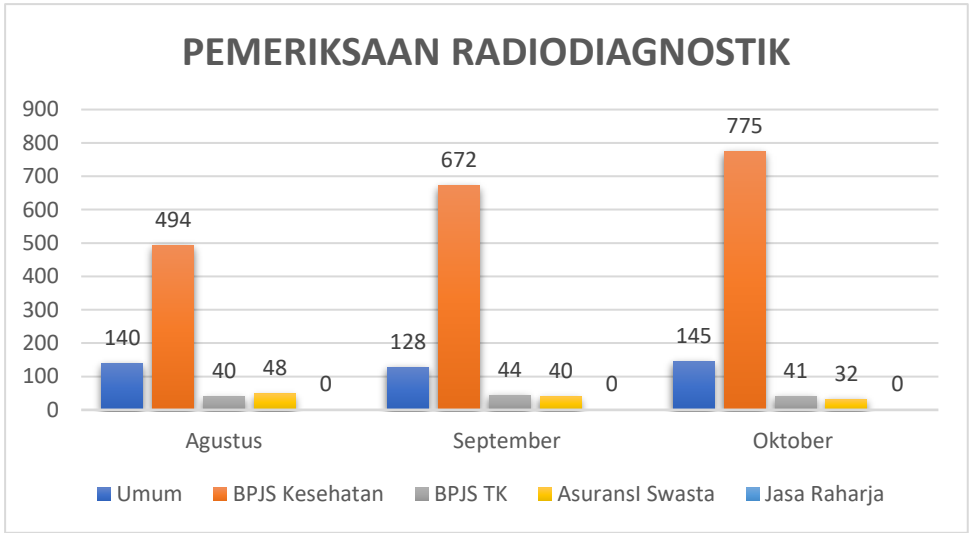
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat raport ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

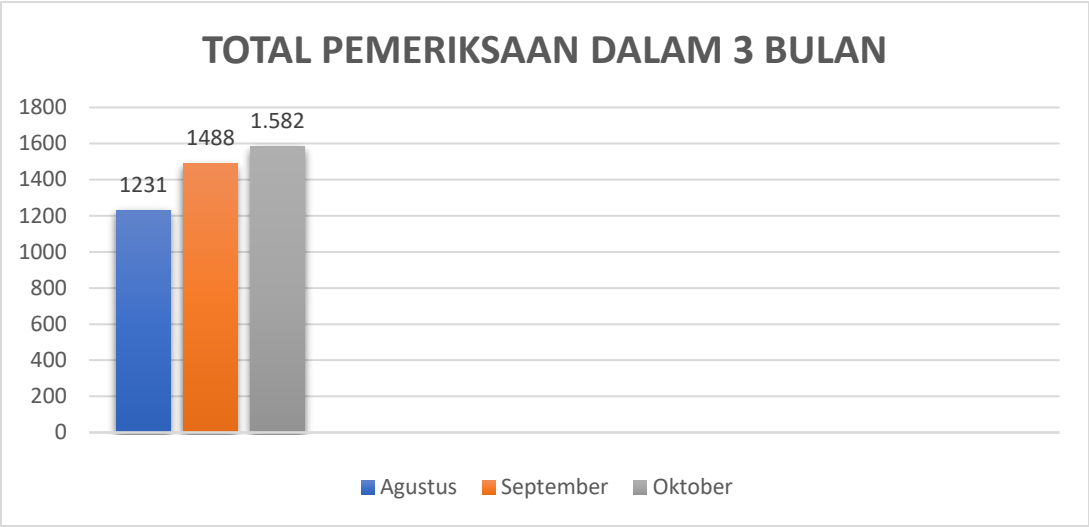
6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Agustus – Oktober 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	140	128	145
		BPJS KESEHATAN	494	672	775
		BPJS TK	40	44	41
		ASURANSI SWASTA	48	40	32
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		722	884	993
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	49	110	17
		BPJS KESEHATAN	150	168	217
		BPJS TK	0	0	10
		ASURANSI SWASTA	20	15	20
		JASARAHARJA	4	6	5
	TOTAL		220	294	269
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	0
		BPJS KESEHATAN	3	4	4
		BPJS TK	0	306	0
		ASURANSI SWASTA	0	306	0
		JASARAHARJA	0		0
	TOTAL		3	666	4
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	45	34	36
		BPJS KESEHATAN	232	257	274
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	5	7	6
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		286	306	316
TOTAL KESELURUHAN			908		

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni - Agustus 2025





Analisis :

- Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Oktober 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada Bulan September 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 993
 - USG Tanpa Kontras : 316
 - CT Scan Tanpa Kontras : 269
- Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Oktober 2025 adalah sebanyak 1582 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
- Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
- Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
2.		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
2.		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Mei 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Sumroti (231733)	Cardiomegali	Cardiomegaly dan Pneumonia	2
2.		Roeskandar	Lung Tumor	Lung Tumor dan Pneumonia	
1.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Rizka Anada	Normal	Fracture Scapulla	1
Bulan Juni 2025					

1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Kiki Nur Ika Sari (232011)	Normal	Tetap Normal	1
Bulan Juli 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	- Eko sutaji (189842) - Sabar (195701)	-Normal -Normal	- Pulmonary hipertension - Pneumonia	2
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	0	0	0	0
Bulan Agustus 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Sabar / 195701	Normal	Pneumonia	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.Rad	Andrianto / 234437	Normal	Ada garis fraktur	1
Bulan September 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	-	-	-	-
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.Rad	ry wahyu /177112	Normal	Fraktur linear costae	1
Bulan Oktober 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	1.Kunaini/239044	Lung edema	Lung edema+pneumonia	2
		2. Tri tungga/ 118125	Normal	Fraktur costae 4	
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-

Analisis :
 Pada Bulan Oktober Tahun 2025 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	00:03:20	00:25:00 (waktu efektif) 00:180:00 (diatas jam 12 malam)	00:03:04	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
2.	Ro Vertebrae	-	-	00:04:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
3.	Ro Abdomen	-	-	00:10:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
4.	Ro Extremitas	-	-	00:02.00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
5.	Ro Skull	-	-	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar

					jam praktek)
6.	USG Abdomen	00:08:00	00:05:00	00:15:00	00:10:00
7.	CT Scan Non Kontras	00:05:00	00:30:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	00:15:00	00:25:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)	-	-
9.	Radiologi CITO	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:25:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:10:00

- Analisa :**
1. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Thorax 3 menit 4 detik dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
 2. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Vertabrae 4 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
 3. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Ekstremitas 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
 4. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Abdomen 10 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
 5. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Skull 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
 6. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi USG 15 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 10 menit. Hal ini disebabkan karna hasil usg langsung dibaca oleh radiolog. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
 7. Semua pemerikaan CT Scan di alihkan ke dokter Agung Setyawan, Sp.Rad berdasarkan kesepakatan antar radiolog.
 8. Terdapat pembacaan CITO selamaselama bulan Agustus 2025 dan hasil ekspertise sesuai target yakni kurang dari 30 menit

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
 2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
 3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
 4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada Oktober 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

- Analisis :**
-
- Rencana Tindak Lanjut :**
- Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

6.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

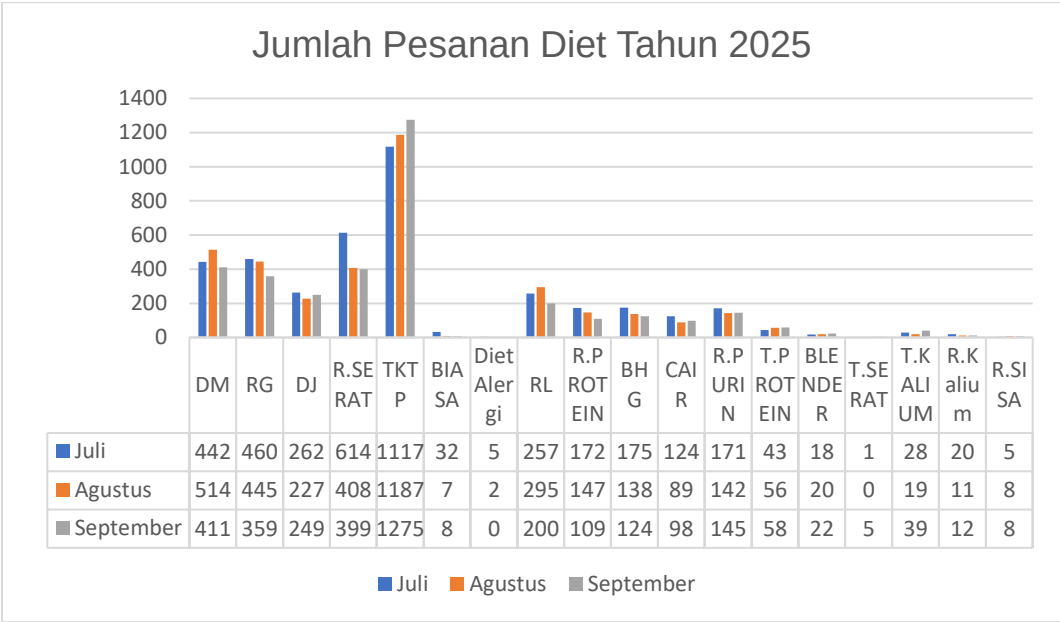
No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Oktober 2025

No.	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Agustus	Bulan September	Bulan Oktober	
1.	Diabetes Mellitus	514	411	492	19,7
2.	Rendah Garam	445	359	564	57,1
3.	Jantung	227	249	287	15,2
4.	Rendah Serat	408	399	358	-10,2
5.	TKTP	1187	1275	1240	-2,7
6.	Makanan Biasa	7	8	23	187
7.	Diet Alergi	2	0	8	100
8.	Rendah Lemak	295	200	284	42
9.	Rendah Protein	147	109	173	58,7
10.	Bubur Halus	138	124	153	23,3
11.	Cair	89	98	107	9,1
12.	Rendah Purin	142	145	175	20,6
13.	Tinggi Protein	56	58	43	-25,8
14.	Blender	20	22	25	13,6
15.	Tinggi Serat	0	5	0	-100
16.	Tinggi Kalium	19	39	42	7,6
17.	Rendah Kalium	11	12	31	158
18.	Rendah Sisa	8	8	12	50
Jumlah		3715	3616	4017	11,1

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Oktober 2025



Analisis :

Jumlah pesanan diet pasien rawat inap meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pasien di rawat inap. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi dan mutu makanan. Pemberian diet rendah purin, rendah kalium meningkat karena banyaknya pasien rawat inap dengan diagnosa CKD disertai hasil lab BUN, Ureum, Kreatinin, dan kalium darah tinggi. Diet rendah garam juga mengalami kenaikan karena banyaknya pasien rawat inap dengan tensi tinggi, diet Biasa meningkat dikarenakan banyaknya pasien usia 6 bulan kebawah sehingga makanan yang disediakan diberikan kepada ibu pasien yang masih menyusui pasien. Diet yang mengalami penurunan adalah diet rendah serat dikarenakan menurunnya pasien anak yang rawat inap dengan diagnosa TF. Pemberian diet TKTP juga menurun dikarenakan pasien yang diberikan diet TKTP adalah pasien post op tanpa komplikasi, pasien post partum dll tanpa komplikasi, sedangkan pasien post op lebih banyak memiliki diagnosa DM sehingga pemberian diet TKTP menurun sedangkan pemberian diet DM meningkat.

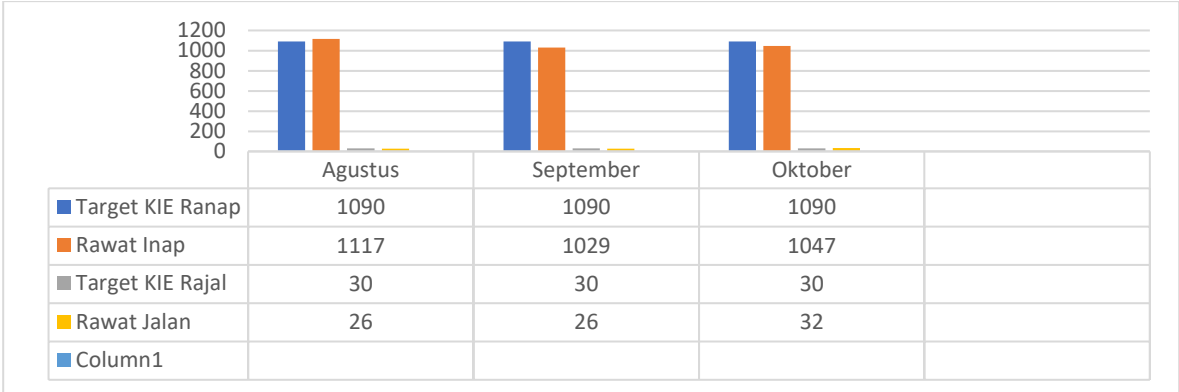
Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi Agustus - Oktober 2025

No.	Indikasi	Jumlah Pasien Agustus	Jumlah Pasien September	Jumlah Pasien Oktober
1.	Konsultasi Rawat Inap	1117	1029	1047
2.	Konsultasi Rawat Jalan	26	26	32

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Bulan Agustus - Oktober 2025



Analisis :
Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada bulan Oktober meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan bulan Oktober mengalami peningkatan dikarenakan DPJP sudah mulai aktif melakukan rujukan konseling gizi rawat jalan. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ardhany SP.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Agustus 2025

NO	JENIS KOMPLAIN	NAMA PASIEN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT	TOTAL
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari 2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Mei 2025					
1.	Keluhan pasien dan OB yang belum mendapatkan makanan	An Abimanyu Putra Herlambang (C3C-8, IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Ayah pasien menyampaikan bahwa jika pasien belum selesai makan maka jangan mengambil makanan pasien terlebih dahulu.	1. Jam pengambilan makan adalah 1 jam setelah pembagian makan. 2. Pasien mengalami penurunan nafsu makan sehingga mengkonsumsi	1. Koordinasi dengan tim penyaji untuk memberikan edukasi terkait jam pengambilan alat makan yaitu 1 jam setelah pembagian makan.	1

			makanan dalam waktu lebih lama.	2. Koordinasi dengan CS pantry untuk cara edukasi yang benar sebelum mengambil alat makan pasien.	
Bulan Juni 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	Ny Nadiah Firliani Komplain melalui google review “makanannya kurang enak”	a. Pasien sakit mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan citarasa b. Antara satu petugas pengolahan dan pengolahan lain memiliki selera rasa yang berbeda sehingga ketika memberi rasa pada makanan disesuaikan dengan selera petugas masing-masing	Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan dalam pembuatan standar resep masakan agar masakan yang dihasilkan sama antara satu petugas dengan petugas lain	1
Bulan Juli 2025					
1	Keluhan adanya benda asing dalam makanan pasien	- Ani Puji Lestari (C3a-6) komplain ada benang wol saat makan siang menu mie bihun, benang dikunyah saat makan oleh pasien. Pasien tidak langsung lapor, tapi mengisi kuesioner saat KRS. - Hana Rizki Anjani (3c anak) komplain sebaiknya pasien sering diberi menu sayur dan buah.	- Ahli gizi kurang teliti dalam melakukan QC makanan pasien - Petugas pengolahan tidak teliti dalam mengolah bihun. Tidak menggunting benang bihun dengan teliti sehingga ada benang yang tertinggal - Pasien anak dengan diagnosa TF diberikan advice DPJP diet rendah serat (tidak boleh mengkonsumsi sayur dan	- Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan, pemorsia, dan ahli gizi dalam menjaga kebersihan makanan dari benda asing - Sosialisasi kepada seluruh ahli gizi jika setelah memberikan penjelasan melakukan konfirmasi terkait informasi yang diberikan.	2

			buah). Ahli gizi sudah menjelaskan diet kepada keluarga pasien. Keluarga pasien yang dijelaskan tidak mengoperkan kepada anggota keluarga yang lain. Ahli gizi tidak konfirmasi terkait informasi yang diberikan.		
Bulan Agustus 2025					
1	Keluhan tentang variasi makanan	- Etik Hariani (2c) komplain jika masakannya tolong bervariasi, - Komplain dari kuisisioner (3 Agustus) Untuk menu makanan bisa bervariasi lagi - Komplain kuisisioner (30 Agustus) Masukan untuk bagian gizi supaya lebih fariatif menu, untuk rasa kurang asin.	Menu makan pasien pada siklus yang berjalan ada yang diulang dalam waktu berdekatan, sehingga jika pasien dirawat dalam waktu 3 hari berisiko masih menemukan menu yang sama dengan hari sebelumnya	- Koordinasi dengan Instalasi gizi RSPHS terkait komplain variasi menu yang muncul - Mengajukan perubahan siklus kepada PT DPM untuk menghindari pengulangan menu dalam waktu dekat (proses pengajuan)	3
Bulan September 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Oktober 2025					
1	Keluhan tentang mutu makanan pasien	- Pasien a/n Ny Sudarti'in dan Ny. Nuktah (25 Oktober 2025) komplain bahwa nasi tim pasien berair seperti sudah basi - Pasien a/n (26 Oktober 2025) Supratiknyo komplain di makanan pasien ada cacing masih hidup	- Nasi tim pasien berair dikarenakan oleh petugas pengolahan (Tyas) nasi tim yang dimasak pagi dicampur dengan nasi tim pana yang baru matang. Sehingga nasi tim mudah berair dan basi. - Ahli gizi (Veni) Saat QC tidak mengetahui jika di makanan pasien ada	- Sosialisasi kepada pengolahan agar tidak mencampur nasi tim yang sudah dingin dengan nasi tim yang masih panas - Edukasi kepada tim pengolahan agar lebih bersih dalam membersihkan sayuran, penyaji lebih teliti saat memorsi	2

			cacing yang masih hidup	makanan dan ahli gizi lebih teliti saat melakukan QC makanan pasien.	
--	--	--	-------------------------	--	--

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) 2025

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	134,5	135,5	105,3	75% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat.
		Nasi Tim	204,5	198,2	145	
	Total		339	333,7	250,3	
2.	Snack	Roti Kukus	0,3	0	0,3	Snack yang memiliki sisa paling banyak adalah bubur sagu
		Setup Pisang	0,8	0,4	0	
		Kacang Hijau	0,4	1,4	0,4	
		Kue Hongkong	0,2	0	0	
		Terang Bulan	1,4	0	0	
	Total		8,8	4,3	2,2	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 12,3 Kg
	Bulan		Okt 2025			
	Pagi	Rolade ayam masak kecap dengan tahu goreng + buncis	5,2			
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Telur mata sapi rebus				
	Siang	Semur daging+wortel+de daunan	5,8			
		Tahu goreng				
	Tambahan VIP	Abon				
	Sore	Semur (ayam fillet, buncis,dedaunan,t omat)	4,4			
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Telur dadar tebal				
	Total		11,9			
2.	Menu 2					
	Bulan		Okt 2025			
	Pagi	Cah sawi putih+wortel, dedaunan, ayam suwir	6,3			
		Rolade ayam				
	Tambahan VIP	Tempe goreng				
	Siang	Bening bayam, oyong	4,8			

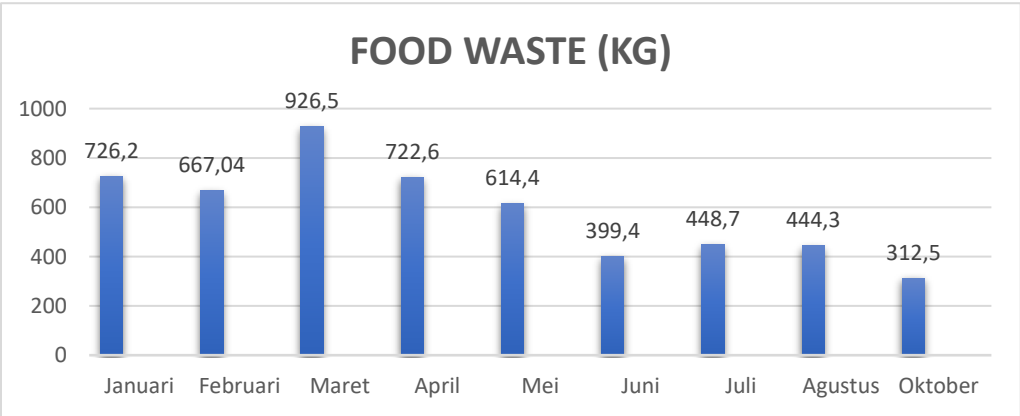
		Bakwan jagung			
	Tambahan VIP	Telur Mata Sapi			
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	3,2		
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar			
	Total		7,2		
3.	Menu 3				
	Bulan		Okt 2025		
	Pagi	Semur (ayam fillet, buncis, daunan, tomat)	4,9		
		Perkedel kentang ayam			
	Tambahan VIP	Telur Dadar tebal			
	Siang	Sup (sawi daging, ayam dadu, wortel)	6		
		Bakwan jagung			
	Tambahan VIP	Lapis daging			
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	4,4		
		Ayam Bombay			
		Tempe Orek			
	Tambahan VIP	Telur Dadar			
	Total		10,9		
4.	Menu 4				
	Bulan		Okt 2025		
	Pagi	Manisa, buncis, bakso masak kuning	7		
		Telur pindang			
	Tambahan VIP	Jamur Goreng			
	Siang	Sup (wortel, polong, bakso, jamur es)	6,1		
		Fillet ayam panggang tabur wijen			
	Tambahan VIP	Perkedel kentang ayam			
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,6		
		Telur Rebus			
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Keripik Kentang			

	Total		14,1			
5.	Menu 5					
	Bulan		Okt 2025			
	Pagi	Tahu +telur+wortel masak kuning	5,7			
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Abon				
	Siang	Bening jagung sisir, bayam, manisah	5,9			
		Ayam wijen				
	Tambahan VIP	Telur ceplok/rebus				
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	2,7	5,2	2,6	
		Tempe Goreng				
		Telur Dadar				
	Total		9,5	12,6	8	
	Total Sisa Menu tanpa KH		109,7	110,6	82,4	
	Total Keseluruhan dengan KH		448,7	444,3	362,4	

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)	Rata-Rata/Hari
1.	Januari 2025	726.2	23,42
2.	Februari 2025	667.04	23,82
3.	Maret 2025	926.5	29,88
4.	April 2025	722.6	24,08
5.	Mei 2025	614,4	19,81
6.	Juni 2025	399,4	13,3
7.	Juli 2025	448,7	14
8.	Agustus	444,3	14
9.	Oktober	312,5	10,9

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Juni Tahun 2025



Analisis :

- 1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
- 2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada penurunansisa makanan pada Bulan Oktober 2025, yaitu sebanyak 312,5 kg, setelah dilakukan tindaklanjut mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian dan memperbaiki dalam segi rasa dan penampilan.
- 3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
- 4. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
- 5. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
- 2. Melakukan plating secara menarik.
- 3. Mengadakan cooking class.
- 4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
- 5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
- 6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
- 7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

2.4.5.7 Lampiran Pemantauan Air Panas di Pencucian Alat Makan

		RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA																																					
		Monitoring Suhu (Suhu Normal = 16° - 26° Celcius)																																					
BULAN : TEMPAT : PENCUCIAN CENTRAL																																							
Ruang	TANGGAL																																						
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18				
	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M			
Batas suhu min (°C)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Batas suhu maks (°C)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
Nilai Suhu (°C)	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3
Inisial Staff	an	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm
Supervisi Haru	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

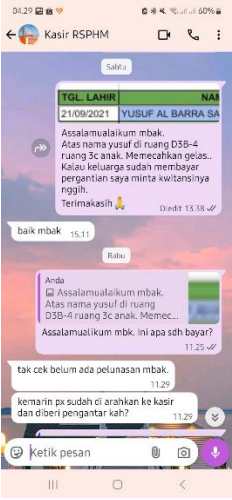
19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M			
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,5	27,3	25,6	26,5	27,3	25,6	26,5	27,3	25,6	26,5	27,3	25,6			
sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	sm	sm	an	sm	sm	an	sm	sm	an	sm	sm	an			
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			

(---) Suhu ruang tidak lebih dari 25°C

(---) Suhu ruang tidak kurang dari 15°C

2.4.5.8 Lampiran Rekap Data Kehilangan Alat Makan

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	RUANGAN	NAMA ALAT	BUKTI KUITANSI	DOKUMENTASI	KETERANGAN
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang

							pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran
Mei 2025							
1.	05/05/2025	Kasiati	D8A-12	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	12/05/2025	Adhibah Mahirah Azizah	C3C-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	28/05/2025	Ika Rodyana	D6A-8	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Juni 2025							
Juli 2025							
1	04/07/2025	Ahmad Subandi	D7A-1	Sendok Makan			Sendok Hilang Px Pulang
2	06/07/2025	Lili Anita	B3C-6	Gelas			Memecahkan Gelas
3	11/07/2025	Eka Maulidia Sari	V3 (VVIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
4	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
5	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Garpu			Garpu Hilang Px Sudah Pulang
6	11/07/2025	Sophia Alya Khairani	B3C-4	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
7	20/07/2025	Arya Raka Pratama	C3C-7	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
Agustus 2025							
1	04/08/2025	Aisyah Bulan Jewel Gandhi	D3C-7	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
2	12/08/2025	Farieza Dayn Za-Zahra	D3B-2	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
3	02/08/2025	Yusuf Al Barra Saputra	D3B-4	Gelas Pasien			Memecahkan Gelas, Pasien Pulang Tanpa Membayar

September 2025							
1	23/09/2025	D7A-2	DENI IRAWAN		-	GELAS PASIEN	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar pergantian ke kasir
Oktober 2025							
1	30/10/2025	C2A-1	ARYTA WULANDARI		-	GELAS PASIEN	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar pergantian ke kasir

Analisis :

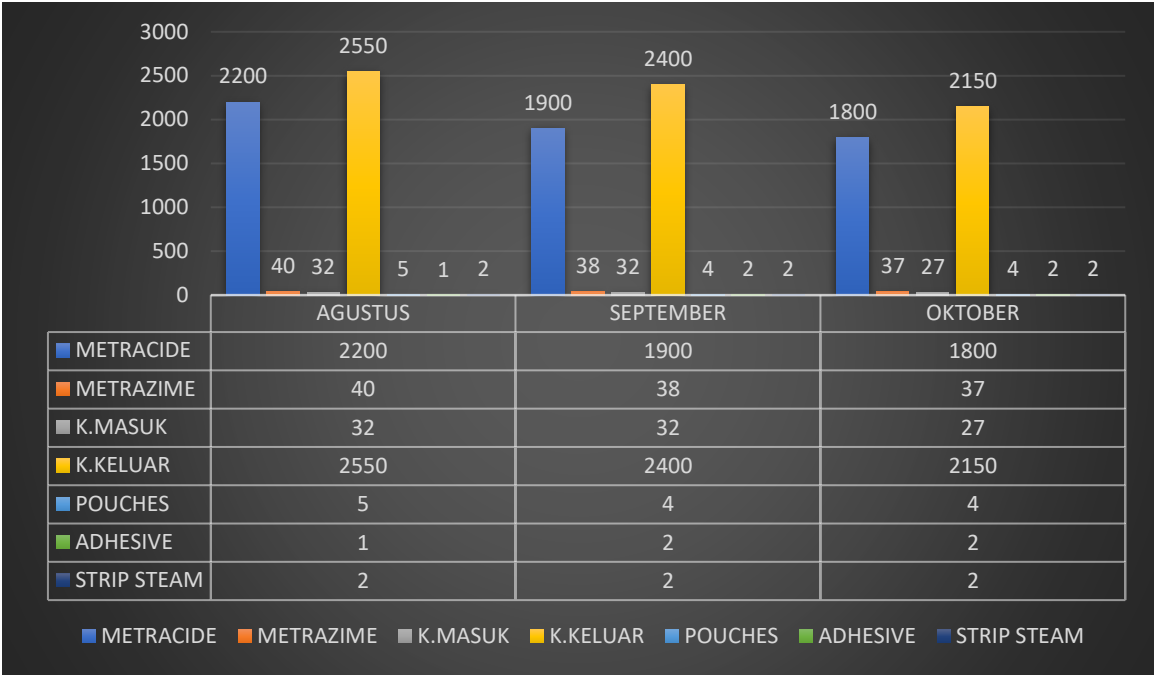
- 1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 kerusakan alat makan pada Bulan Oktober 2025.
- 2. Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

Rencana Tindak Lanjut :

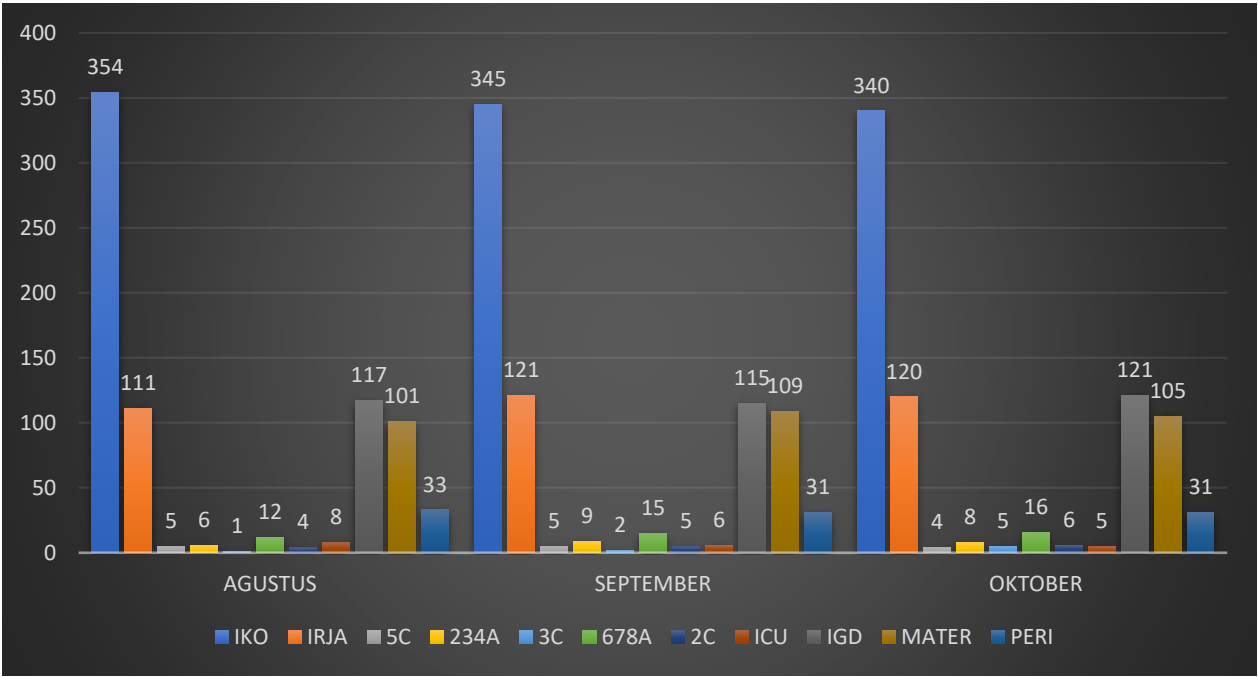
- 1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
- 2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangn , CS Pantry dan Ruangn, dan Kasir.

4.4.7 CSSD – Laundry					
4.4.7.1 CSSD					
4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Agustus - Oktober 2025					
NO	HAL	BULAN TAHUN 2025			
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	
1.	Chemical Alcacide (ml)	2200	1900	1800	
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	40	38	37	
3.	Kassa Masuk (roll)	32	32	27	
4.	Kassa Keluar (pouches)	2550	2400	2150	
5.	BHP Pouces (roll)	5	4	4	
6.	Indikator Adhesive (roll)	1	2	2	
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2	
8.	IKO	354	345	340	
9.	IRJA	111	121	120	
10.	IRNA 5C	5	5	4	
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	6	9	8	
12.	IRNA 3C ANAK	1	2	5	
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	12	15	16	
14.	IRNA 2C VIP	4	5	6	
15.	IRNA ICU	8	6	5	
16.	IGD	117	115	121	
17.	MATERNITAS	101	109	105	
18.	NEONATOLOGI	33	31	31	
Jumlah		742	763	761	

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Agustus - Oktober 2025



Analisis :
Pada bulan Oktober hampir semua bmhp yang mengalami penurunan yaitu : metrazime , metracide, kasa masuk



- Analisis :**
- 1. Pada bulan september jumlah alat yang disetor di CSSD yang mengalami peningkatan yaitu: IGD, 2C, 678A, 3C
 - 2. Sementara Pada bulan september alat yang disetor di CSSD yang mengalami penurunan yaitu IKO, 5C,IRJA,234A,ICU,MATER, NEO

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
- 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
- 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
- 4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan Oktober Tahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breating circuit	-

Analisis :
Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan Agustus 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN							TOTAL
	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	AGT 2025	SEP 2025	OKT 2025	
				Kejadian Instrument Kurang				
IKO	1	4	1	2	-	-	0	8
IGD	0	0	0	0	-	-	0	0
IRNA	0	0	0	0	-	-	0	0
IRJA	0	1	0	0	-	-	0	1
				Kejadian Instrumen Hilang				
IKO	0	0	0	0	-	-	0	0
IGD	2	0	0	0	-	-	0	2
IRNA	0	0	0	0	-	-	0	0
IRJA	0	0	1	0	-	-	0	1

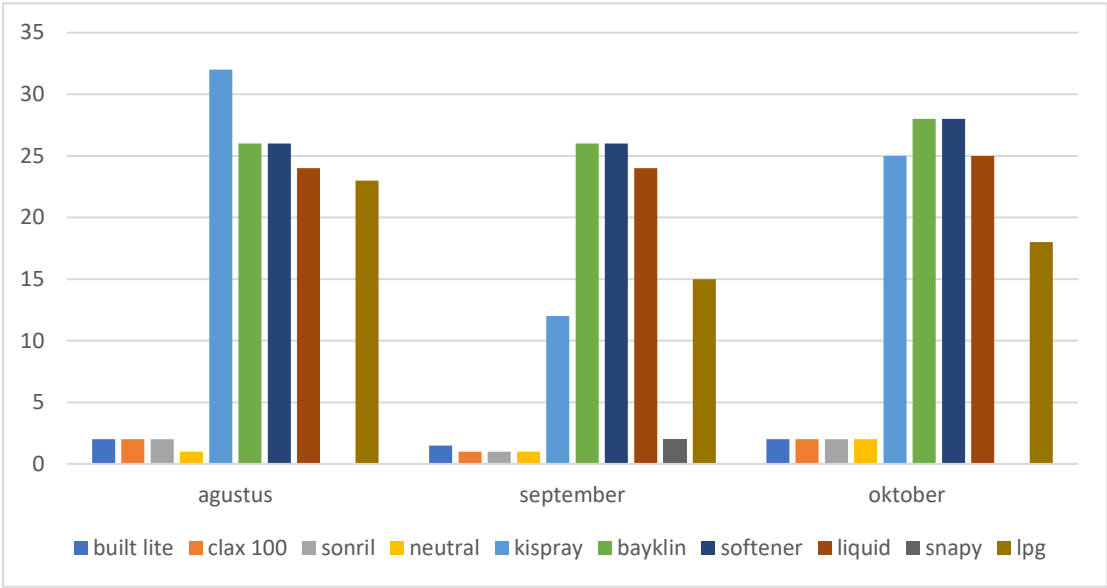
Analisis :
-
Rencana Tindak Lanjut :
-

1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Agustus - Oktober Tahun 2025

NO	HAL	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	1,5	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	2	1,5	2
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	2	1	2
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	2
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	32	12	25
6.	Pemutih Bayclean (liter)	26	26	28
7.	Softener (liter)	26	26	28
8.	Liquid matic (liter)	24	24	25
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	23	15	18
TOTAL		138	108	132
1.	Linen Infeksius	2401	2437	2591
2.	Linen Non Infeksius	2282	2097	2347
3.	IRNA 2,3,4 A	425	361	513
4.	IRNA 6,7,8 A	501	571	553
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	301	375	491
6.	IRNA 3C	399	315	388
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	345	311	382
8.	IRNA 5C	333	267	248
9.	IKO	1883	1865	1867
10.	IRJA	70	67	111
11.	IGD	206	211	231
12.	LABORATORIUM	5	5	8
13.	RADIOLOGI	4	3	6
14.	DAPUR/GIZI	4	5	8
15.	CSSD	9	7	9
16.	Linen MS	73	55	42
17.	Umum	125	117	81
Total		9366	9069	9876

1.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Agustus - Oktober 2025

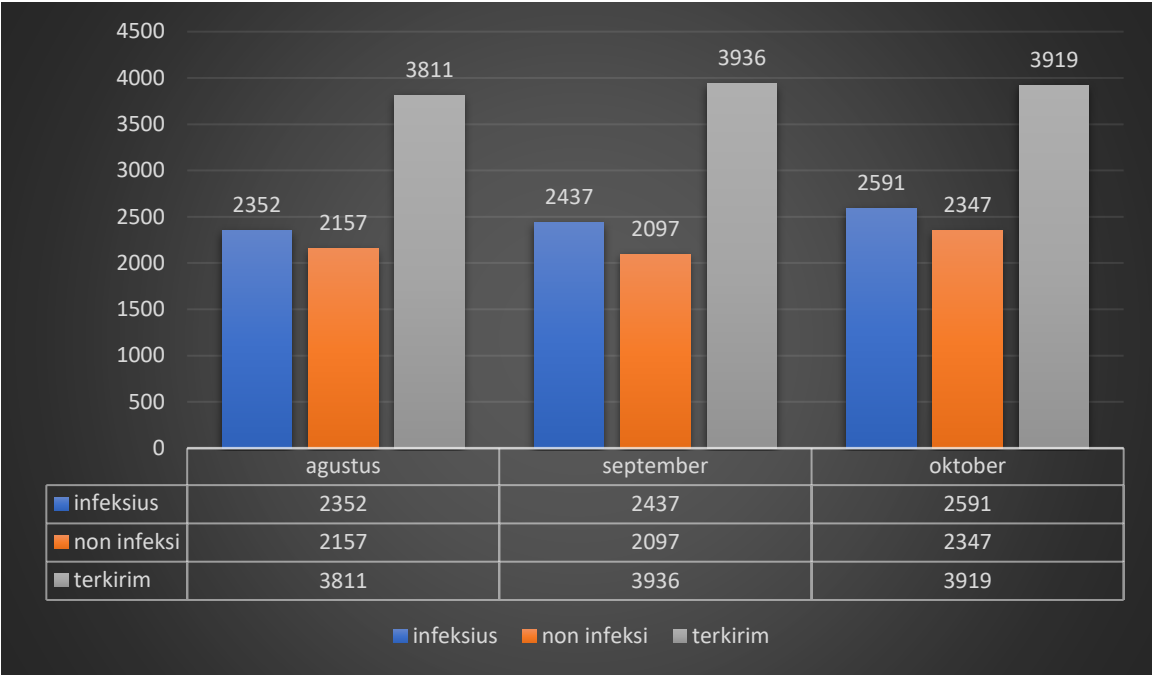


Analisis :

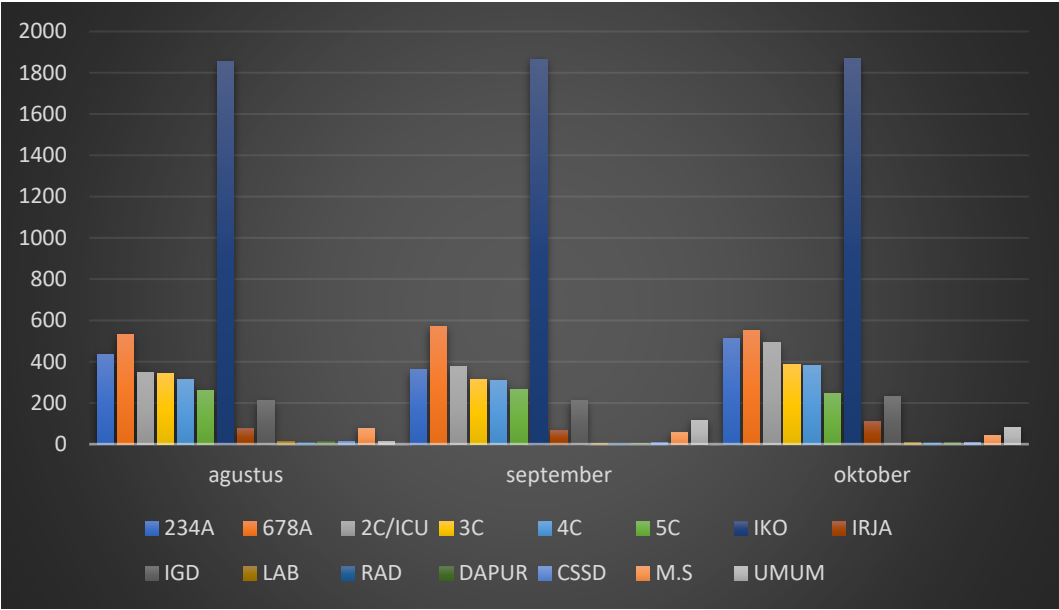
1. Pada bulan Oktober BMHP yang mengalami penurunan pemakaian yaitu : Buit Lite, Clax 100 Ob, Clax Sonril Ultra, Clax Anti Chlor
2. Pada bulan agustus pemakaian chemical yang meningkat yaitu; softener bayklin kispray dan liquid

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.



- Analisis :**
- 1. Terjadi penurunan di linen terkirim dari 3936 ke 3919
 - 2. Untuk linen infeksi dari 2437 ke 2591
 - 3. Untuk linen non infeksi dari 2097 ke 2347



- Analisis :**
- 1. Linen IKO mengalami peningkatann dari 1865 ke 1867
 - 2. Linen IRJA di bulan oktober mengalami peningkatan pemakaian APD dari 67 kg ke 111
 - 3. Linen IRNA di bulan oktober mengalami peningkatan yaitu rantai, 234 A, 2C/ICU, 3C , 4C, sementara rantai 678A menurun
 - 4. Linen kotor IGD meningkat, penggunaan linen selimut di IGD meningkat
 - 5. Terjadi penurunan di cucian umum sebesar 81 kg yaitu korden

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Juli - September 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	Sprei	133	122	115
2.	Sarung bantal	253	241	134
3.	Selimut	164	158	151
4.	Baju tim IKO	110	105	105

5.	Baju ganti pasien	33	28	28
6.	Skort	145	145	145
7.	Perlak	18	15	15
8.	Baju ganti laundry	14	14	14
9.	Duk lubang besar	20	20	20
10.	Duk pembungkus	53	50	50
11.	Duk kecil 1 meter	43	41	41
12.	Duk ortho	14	12	12
13.	Duk lubang kecil	17	16	16
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	19	18	18
16.	Skort IKO	61	58	58
17.	Waslap	55	51	51
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	123	121	121
20.	Baju Pasien	25	21	21

1.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Agustus - Oktober 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	Sprei	11	11	11
2.	Sarung bantal	10	12	12
3.	Selimut	8	6	6
4.	Duk Pembungkus	0	3	3
5.	Duk Lubang Kecil	0	1	1
6.	Celana Tim IKO	1	5	5
7.	Baju Tim IKO	1	5	5
8.	Baju Pasien	2	5	5
9.	Skort	0	1	1
10.	Perlak	4	3	3
11.	Baju Ganti Laundry	1	0	0
12.	Duk Kecil	7	2	2
13.	Waslap	0	4	4
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	2	2	2
16.	Kerudung	2	0	0
17.	Kantung L	0	0	0
18.	Meja Mayo	1	1	1

Analisis :

- 1. Untuk linen rusak bulan agustus yaitu jenis sprei, sarban, selimut, duk kecil, baju pasien, perlak, duk pembungkus dan meja mayo
- 2. Sprei, sarban dan selimut rusak karena terdapat noda yang membandel dan sudah dilakukan spotting berulang

Rencana Tindak Lanjut :
Follow up Pengadaan PT

1.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	Masker IKO	3	2	2
2.	Tissue	2	2	2
3.	Jarum	0	0	0
4.	Bumbu Dapur	0	0	0

5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	0	0	0
7.	Benda lainnya	0	2 (Underpad)	0

- Analisis :**
1. Benda asing yang sering tercampur di bulan oktober yaitu tissue dari IKO, Masker dari IKO dan instrument IKO
 2. Ketidakdisiplinan paling banyak dari Unit IKO.
 3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
 2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.4.7 SDM

3.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	0	0	0	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0

14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	1
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	6	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		11	7	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0

		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	1	1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter	1	1	0	1	0

		Spesialis					
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	s0	1	0
Total			431	431	284	147	1

Keterangan :
 Pada bulan Oktober terdapat 1 staf resign.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	dr. Arianto Prabowo, Sp. OT	Dokter Spesialis	08 Oktober 2025	SIP Perpanjangan Terbit
2	dr. Yeni Octavia	Dokter Umum	01 Oktober 2025	SIP Perpanjangan Terbit
3	Novita Ericdian Anggraeni, Amd.RMIK	Rekam Medik	01 Oktober 2025	SIP Perpanjangan Terbit
4	dr. Resti Lestantini, M. Kes	Dokter Manajemen	06 Oktober 2025	SIP Baru
5	dr. Denny Prasetyo, Sp. An-TI	Dokter Spesialis	21 Oktober 2025	SIP Baru

Keterangan :
 Pada bulan Oktober terdapat 3 SIP perpanjangan dan 2 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Sudah mendapat kandidat dengan drg. Khadijah, Sp. KG. Sedang dalam proses penerbitan STR dan pengurusan SIP
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Terapis Wicara	2	1	1	On proses rekrutmen	On proses rekrutmen
7	Dokter Umum IGD	2	1	1	On proses rekrutmen	On proses rekrutmen

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK
1	Stunting dan Wasting	Internal	28	14	24 Oktober 2025	v	

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	0	6	31	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	3	7	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	4	0	1	3	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	4	1	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	16	0	12	4	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	0	2	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	7	4	1	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	22	0	11	11	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam

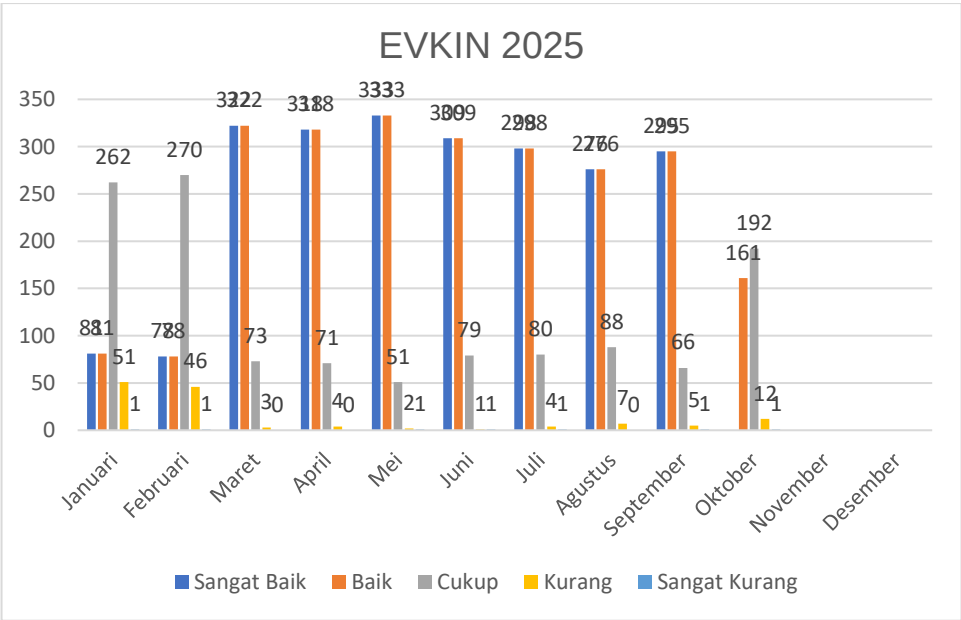
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCN secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSR	Umum	6	0	3	3	0	0	Unit IPSR secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	28	0	17	10	1	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	2	5	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	17	0	8	9	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	13	0	6	7	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	1	8	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	6	11	4	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	11	0	7	3	0	1	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	9	0	3	6	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	9	0	4	5	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	9	0	2	7	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	4	0	2	2	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	3	4	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	15	0	1	12	2	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	0	0	0	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	4	3	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	1	1	1	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	22	18	0	0	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	3	2	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
 Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Oktober 2025.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333	309	298	276	295	161		
Baik	262	270	73	71	51	79	81	88	66	192		
Cukup	51	46	3	4	2	1	4	7	5	12		
Kurang	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1		

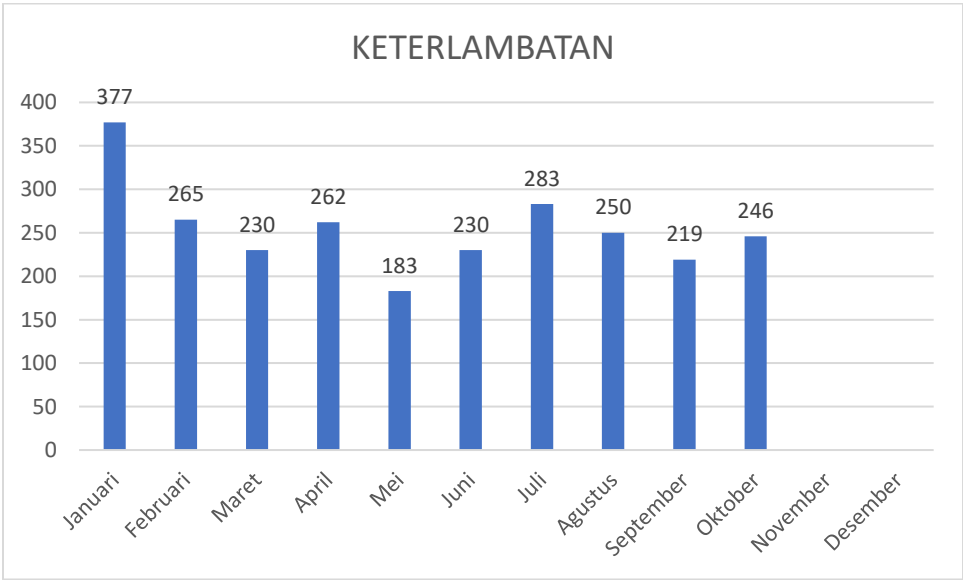
Sangat Kurang	4	4	2	5	4	1	1	2	2	2		
TOTAL	399	399	400	398	391	391	385	373	369	368		

Analisa :
 Secara umum terdapat penurunan kategori sangat baik ke baik akibat tidak adanya diklat seluruh staf di bulan Oktober 2025 dan adanya peningkatan keterlambatan karyawan.

Rencana Tindakanlanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183	230	283	250	219	246		



Analisa :
 Secara umum terdapat penurunan keterlambatan karyawan dari bulan sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	1
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	1

7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	1
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	1
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	1
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	1
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	1
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	1
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	8

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desembe
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%	100%	100%	0%	100%	50%	50%		

Analisaais:
 Dilakukan mandiri ke tiap unit.
 Masih ditemukan staf yang tidak menggunakan nametag (an. Edi – CS, dan Nadhif – Security) karena name tag hilang dan rusak

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Saudah, S. Kep., Ns	IRNA 3C Anak	Neonatologi
2	Neneng Aprilia Pangestuti, Amd. Kep	IRNA 234A	IRNA 2C
3	Safitri Retno kurniawati, Amd. Kep	CSSD	IRNA 3C Anak3
4	Elok Oktaviana, Amd. Keb	IGD	Maternitas

Analisis : pada bulan Oktober 2025 terdapat 3 staf rotasi

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61	66.6	92.3	76,92	89,74	69.2%	82.05%	64.10%	53,8%	84,61%		

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%
Juni	276	165	59.78%
Juli	276	166	60.14%
Agustus	276	194	70%
September	276	77	27,8%
Oktober	276	136	49.27%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26
Juni	15
Juli	25
Agustus	29
September	17
Oktober	17

Analisa :
Pada bulan ini capaian adalah 84,61% untuk ruangan dan 49.27% untuk alat kesehatan

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61
APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI	7	16	2	25
JULI	15	21	12	48
AGUSTUS	3	4	16	23
SEPTEMBER	9	21	20	50
OKTOBER	6	13	10	29
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :
Pemeliharaan AC bulan Oktober turun dibandingkan sebelumnya dikarenakan, banyak kegiatan di luar Rumah Sakit dan perbaikan utilitas yang berat (membutuhkan waktu yang lama).

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
10	Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

Melalui link :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvgSZrNmPuELgYBKbs oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143>

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Ssudah mencapai target
10.	Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	Ssudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWC MAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7 SLF6JsafyAZHxZKoPBLPg dAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497>
4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAYz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwtuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Oktober 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/10/2025	2085	1860	225	MMHG			MMHG
02/10/2025	1860	1596	264	MMHG			MMHG
03/10/2025	1596	1323	273	MMHG			MMHG
04/10/2025	1323	724	599	MMHG			MMHG
05/10/2025	724	3252	0	MMHG	sesudah pengisian	2528	MMHG
06/10/2025	3252	2972	280	MMHG			MMHG
07/10/2025	2972	2613	359	MMHG			MMHG
08/10/2025	2613	2336	277	MMHG			MMHG
09/10/2025	2336	2028	308	MMHG			MMHG
10/10/2025	2028	1705	323	MMHG			MMHG
11/10/2025	1705	1407	298	MMHG			MMHG
12/10/2025	1407	1139	268	MMHG			MMHG
13/10/2025	1139	615	524	MMHG			MMHG
14/10/2025	615	3062	0	MMHG	sesudah pengisian	2447	MMHG
15/10/2025	3062	2875	187	MMHG			MMHG
16/10/2025	2875	2516	359	MMHG			MMHG
17/10/2025	2516	2252	264	MMHG			MMHG
18/10/2025	2252	1981	271	MMHG			MMHG
19/10/2025	1981	1677	304	MMHG			MMHG
20/10/2025	1677	1377	300	MMHG			MMHG
21/10/2025	1377	1098	279	MMHG			MMHG
22/10/2025	1098	613	485	MMHG			MMHG
23/10/2025	613	3251	0	MMHG	sesudah pengisian	2638	MMHG
23/10/2025	3251	3212	39	MMHG			MMHG
24/10/2025	3212	2958	254	MMHG			MMHG
25/10/2025	2958	2727	231	MMHG			MMHG
26/10/2025	2727	2493	234	MMHG			MMHG
27/10/2025	2493	2280	213	MMHG			MMHG
28/10/2025	2280	2033	247	MMHG			MMHG
29/10/2025	2033	1666	367	MMHG			MMHG
30/10/2025	1666	3230	0	MMHG	sesudah pengisian	1564	MMHG
30/10/2025	3230	3111	119	MMHG			MMHG
31/10/2025	3111	2852	259	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8410	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						9177	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			515.3	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3670.8	MMHG

Analisis :
Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcAUU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
---------	----------	----------	------	-----------------------

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPjtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOk6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapian Kegiatan External

BULAN	JUMLAH KEGIATAN (HARI)
Januari	4
Februari	4
Maret	4
April	15
Mei	12
Juni	15
Juli	6
Agustus	12
September	13
Oktober	12

Keterangan :
Perbantuan eksternal ke instansi lain pada bulan ini adalah 12 Hari ke klinik Mutiara Sehat. 5 Kali ke RSDH.

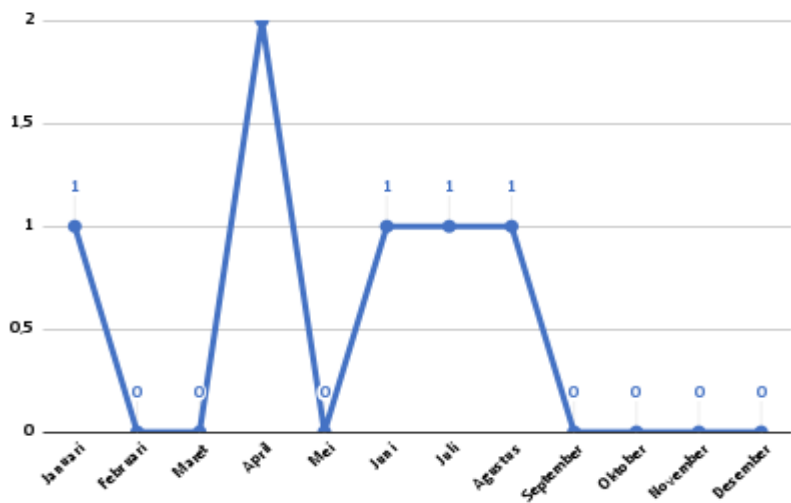
Rekapian link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



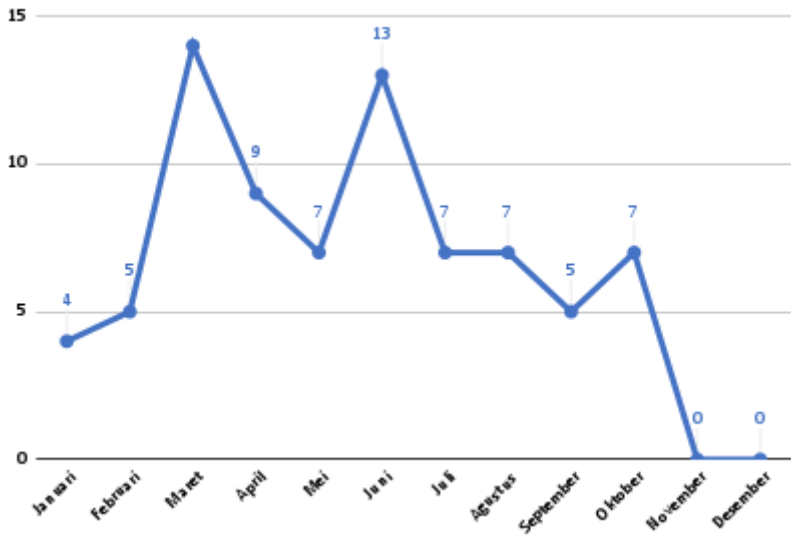
Analisa :
Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7	13	7	7	5	7	

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
03 – 10 – 2025	Telah ditemukan kontak kendaraan milik pasien di area gedung poli spesialis , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
22 – 10 – 2025	Kontak motor milik karyawan tertancap di motor , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik

22 – 10 – 2025	Telah di temukan tas berisi hp milik pasien di depan toilet poli lt 1 depan poli jiwa , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
22 – 10 – 2025	Kontak motor milik karyawan tertancap di motor , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
26 – 10 – 2025	Kontak motor milik keluarga pasien tertancap di motor , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
27 – 10 – 2025	Berkas karyawan ditemukan terjatuh di parkir an karyawan di amankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
29 – 10 – 2025	Telah ditemukan kontak kendaraan milik pasien di area ruang tunggu farmasi , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

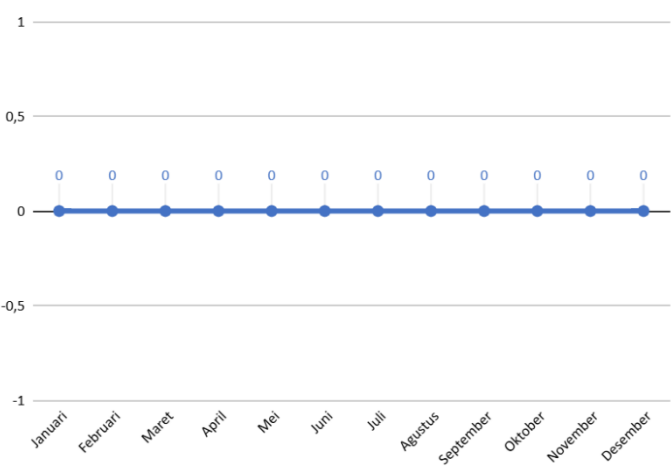
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :

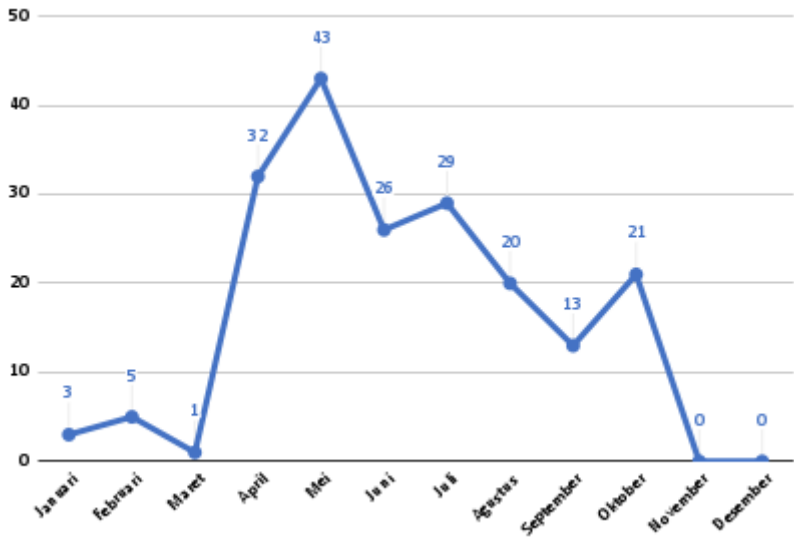
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

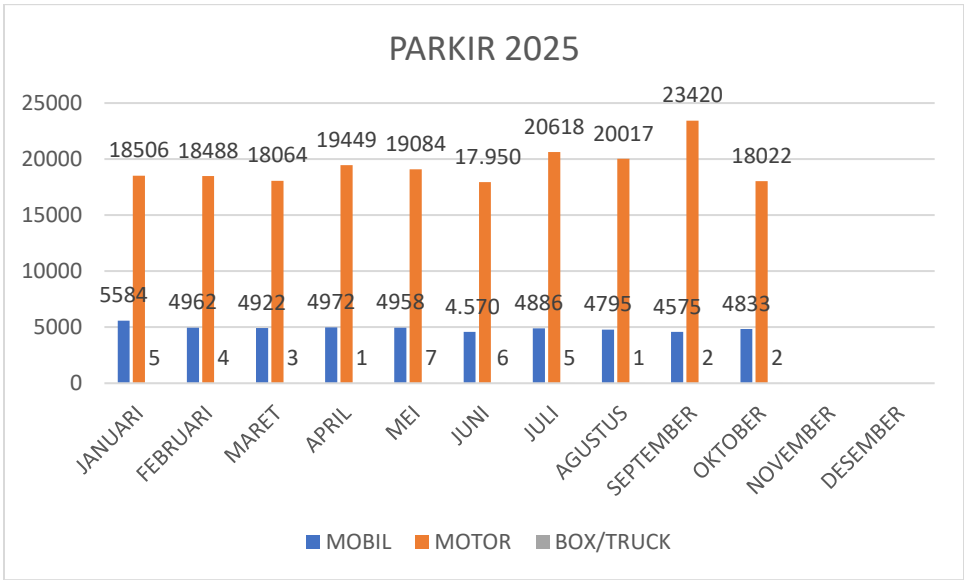
NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	45	26	29	20	13	21		



Analisis :
Angka 21 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x. Dengan temuan yang lebih banyak dari bulan lalu mengindikasikan pencatatan dan pelaporan lebih baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir
3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

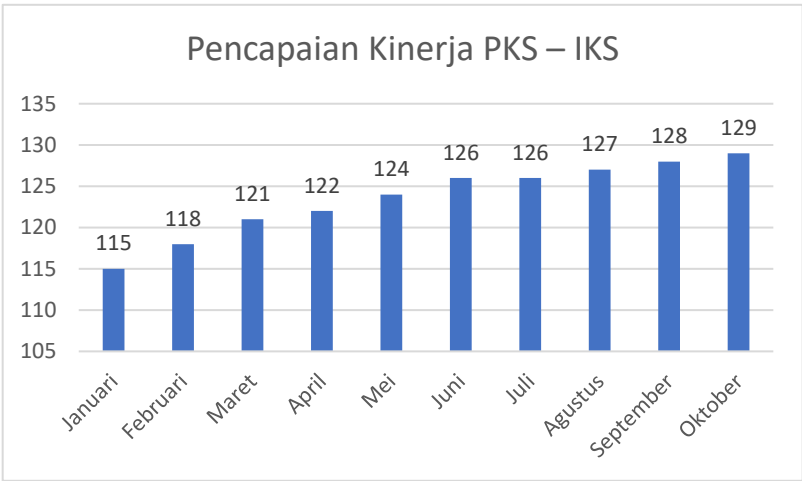
3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah					Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	(review pihak kedua) 1 (105lastic105 evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
6	Juni 2025	2 IKS Baru	126	0	1	1	(2 Proses Review Pihak ke 2)	2
7	Juli 2025	1 IKS Baru	126	1	0	0	1 (Proses Review)	1
8	Agustus 2025	1 IKS	127	1	0	1	1 (Klinik Utama Kedungdoro)	1
9	September 2025	1 IKS	128	1	1	0	1 (Proses Review)	1
10	Oktober	1 IKS	129	0	1	0	1 (Proses Review)	1
Analisis ; 1. Pada bulan Agustus 2025, PKS baru dengan Ambulance Relawan Siaga Utara dalam tahap Review 2. Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Juli 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan

7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April masih menunggu pihak sekda)	Proses pihak Dispenduk
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan
11	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
12	PT Pindad (Persero)	Review	Proses Pihak Kedua
13	RS Panti Nirmala	Review	Proses Review
14	BRI Life	Review	Proses
15	Klinik Utama Kedungdoro	Review	Proses
16	TPA Halodoc	Review	Proses Review
17	Ambulance Relawan Siaga Utara	Review	Proses



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

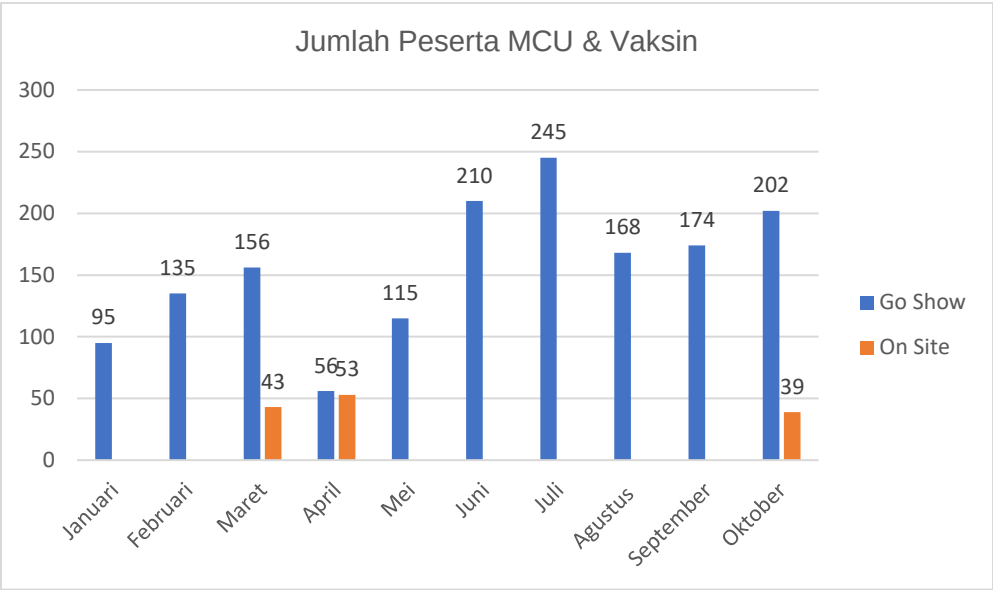
3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Agustus 2025

NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150	115	-
6	JUNI	150	210	-
7	JULI	150	254	
8	AGUSTUS	150	168	
9	SEPTEMBER	150	174	
10	OKTOBER	150	202	39
11	NOVEMBER	150		
12	DESEMBER	150		

Analisis ;
 Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Oktober meningkat sebesar 38,5% dibandingkan bulan sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut :

- Melakukan Promosi rutin melalui Social Media dengan update berkala
- Kunjungan ke SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU



3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
6	Juni	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 7 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 1 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
7	Juli	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Indonesian Marine	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
8	Agustus	PT Arjaya Mukti Santosa	Sudah terlaksana 4 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
9	September	Sjava Travel Indonesia	Sudah terlaksana Vaksin dengan 32 Jamaah di Rumah Sakit
10	Oktober	PT Exel Mandiri Inovasi	Sudah terlaksana 39 Orang Pelaksanaan On Site Perusahaan
		PT Aneka Tuna Indonesia	Sudah terlaksana 2 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Sukanda Djaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2	2	2	17	6	6	10	11	

Analisa :

Kunjungan eksternal disesuaikan dengan permasalahan yang ada, komunikasi sekarang juga dilakukan dengan online pada beberapa target klinik dan mitra. Untuk kegiatan umum seperti pengenalan RS dll sudah dilakukan di akhir Juli FKTP Gathering dan 31 Oktober 2025 (daring)

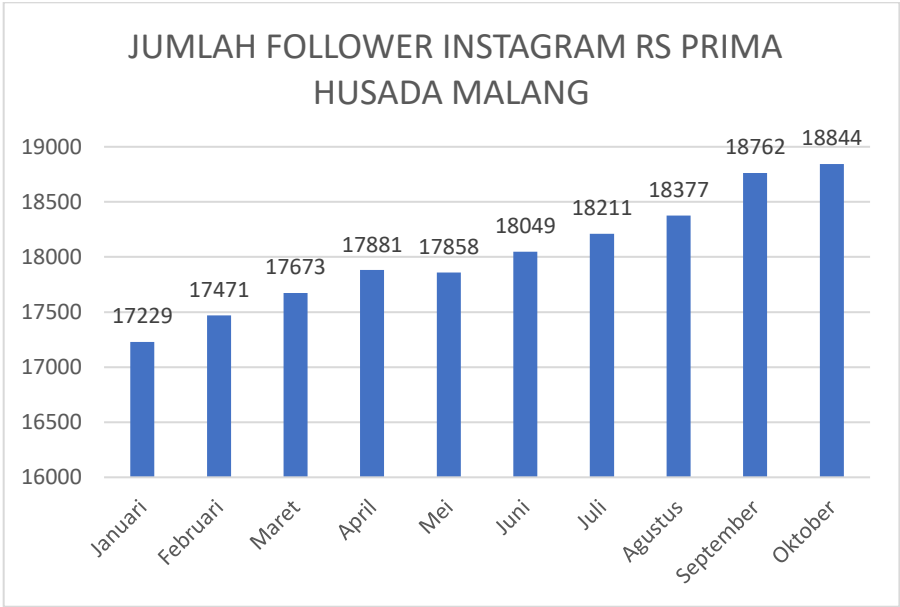
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10	10	9	10	8	6	19		
REELS	5	5	11	5	1	1	6	7	3	4		
STORY	6	10	14	8	12	10	18	11	17	37		
TOTAL	14	22	34	28	23	19	34	26	26	60	0	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19	10	12	14	8	10	24		
FEED VIDEO	0	0	0	0	1	1	6	7	3	4		
REELS	3	4	5	7	1	1	6	7	3	4		
STORY	29	33	28	38	12	29	74	24	51	87		
TOTAL	38	48	49	64	24	20	100	46	67	119	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673	17.881	17850	18049	18.211	18.377	18.762	18.84		
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	374	286	346	283	385	82	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

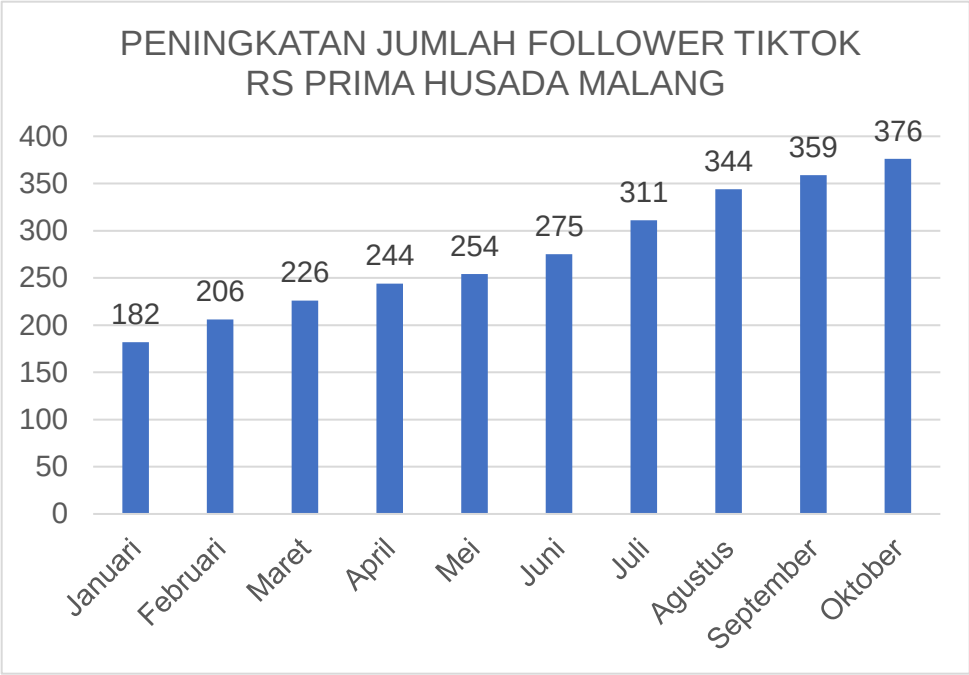


Analisa :
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 0.44%. dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0	2	1	3	3	3	2		
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244	254	275	331	344	359	376		
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	10	21	36	33	15	17	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085	1187	1222	1336	1476	1585	1652		



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 4,74% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

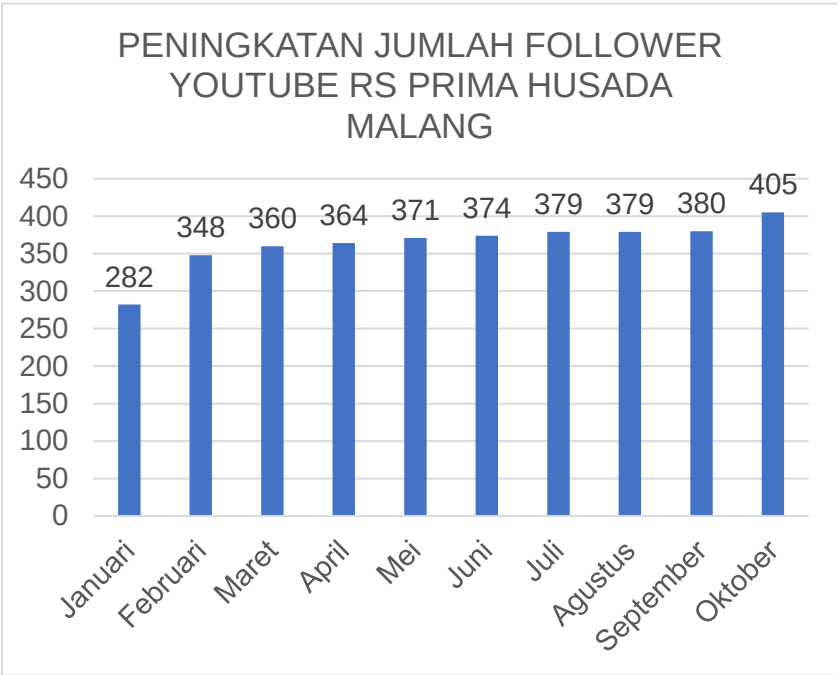
Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1		
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364	371	374	379	379	380	405		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	4	7	3	5	0	1	25	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

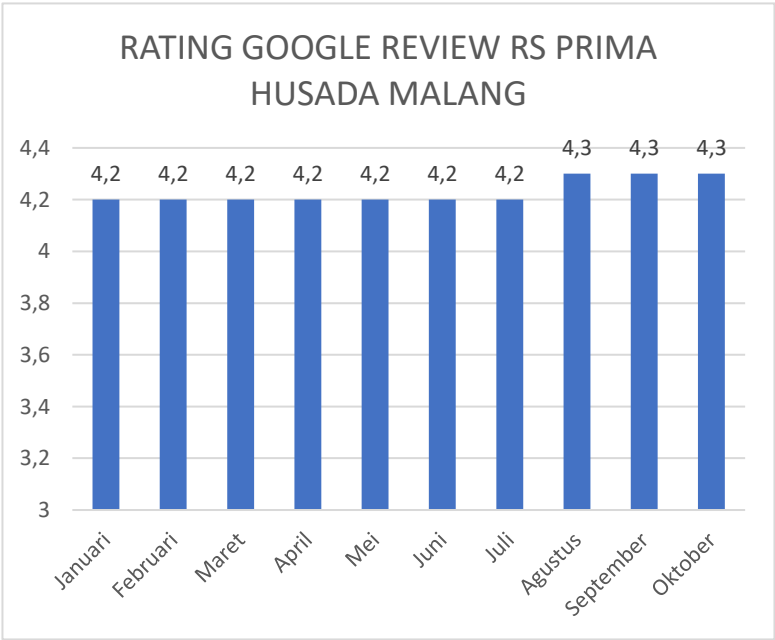


Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan Sebesar 6,58% dari bulan Sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3		



NO	BULAN	KOMENTAR POSITIF	KOMENTAR NEGATIF
1	Jan-25	18	6
2	Feb-25	13	6
3	Mar-25	7	5
4	Apr-25	25	10
5	May-25	15	7
6	Jun-25	19	3
7	Jul-25	60	3
8	Aug-25	44	10
9	Sep-25	104	5
10	Oct-25	173	0
11	Nov-25	0	0
12	Dec-25	0	0

Analisa :
 Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan September. Namun Komentar positif meningkat.

Rencana Tindal Lanjut :
 Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG PERIODE 2025												Y	Z	AA	AB	AC	
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBARA N PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG	
		a	b	c	(a-b-c d)	e	f	g	(e-f-g-h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total	
PERIODE OKTOBER 2025 :																	
1	Acount	367.143.836	263.176.016	3.429.433	100.538.381	259.835.370	73.678.004	1.063.373	104.294.593	284.832.974	247.932.834	4.539.593	19.894.593	9.599.549	2.957.389	284.832.974	
2	Perawatan	707.063.179	386.621.830	-	320.241.349	401.460.787	899.544	-	400.561.244	720.802.533	594.464.814	29.184.259	93.628.814	-	82.521.513	720.802.533	
3	Mandiri kesehatan	93.849.110	44.513.331	1.444.660	47.880.521	31.290.070	-	-	31.290.070	79.180.530	79.180.530	-	-	-	-	79.180.530	
4	Jasa Pakarja	94.241.727	89.851.979	-	4.389.747	141.956.085	-	-	141.956.085	146.345.832	146.345.832	-	-	-	-	146.345.832	
5	BPJS Ketanggakejukan	583.011.196	529.621.890	- 614	53.389.321	649.139.339	-	-	649.139.339	702.529.259	679.495.494	-	-	-	23.924.243	702.529.259	
Total Saldo											1.853.691.248	1.706.159.325	55.126.146	78.925.607	9.599.549	109.485.019	1.933.691.846

Keterangan : Cut off 31 Oktober 2025 sebesar Rp 1.933.691.248

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Pasien dengan igm salmonella positif 4, tidaj terdpaat indikasi dirawat inapkan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Tidak terdpat indikasi ranap, 3 hari los	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Pasien rujuk IGD, tidak ditemukan assesmen dpjp, ditagihkan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Tindakan dengan LA dapat dilakukan di rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Tatalaksana pneumonia sesuai dengan pnpk terapi injeksj antibiotik minimal 72 jam	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

6	Los 1 hari rujuk belum mendapat visitasi langsg dari dokter spesialis, klain diajukan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Readmisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Kunjungan transit, hanya untuk numpang dirujuk RS tipe B/A	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Kunjungan multipoli, konsul internal dijamin poli utama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Kunjungan multipoli, kalau udah post 4x kontrol masih kontrol lagi, kenapa?	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Rehab 6 bulan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	SEP approval rj, indikasi approval, tidak terdapat pernyataan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	IRM jantung, indikasi self referral	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Belum ada sertifikasi kompetensi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Pasien HD obat harusnya diberikan oleh rs HD	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
9	Tidak terdapat indikasi diagnostik USG indikasi upkoding	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

3.5.6 PIPP – MOD – MPP

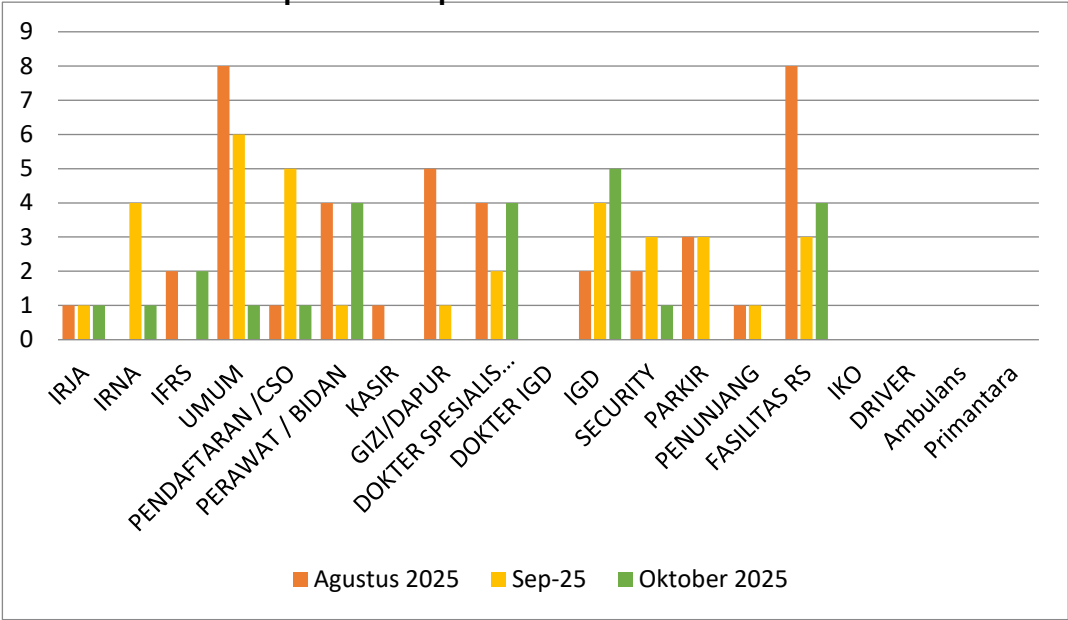
3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Oktober 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	IRJA	1	1	1
2.	IRNA	0	4	1
3.	IFRS	2	0	2
4.	UMUM	8	6	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	5	1
6.	PERAWAT / BIDAN	4	1	4
7.	KASIR	1	0	0
8.	GIZI/DAPUR	5	1	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	4	2	4
10.	DOKTER IGD	0	0	0
11.	IGD	2	4	5
12.	SECURITY	2	3	1
13.	PARKIR	3	3	0
14.	PENUNJANG	1	1	0
15.	FASILITAS RS	8	3	4

16	IKO	0	0	0
17	DRIVER	0	0	0
18	Ambulans	0	0	0
19	Primantara	0	0	0
Total		42	34	24

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Oktober 2025



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Oktober 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Oktober 2025 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan agustus 2025 sebanyak 42 pasien. pada bulan September 2025 sebanyak 34 pasien. Sedangkan pada bulan oktober 2025 sebanyak 24 pasien.
2. Komplain terbanyak pada bulan Oktober 2025 yaitu dari bagian IGD sebanyak 5 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 2 kasus complain dengan rincian :
Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu perlebar ruangan rawat inap karena terlalu sempit

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

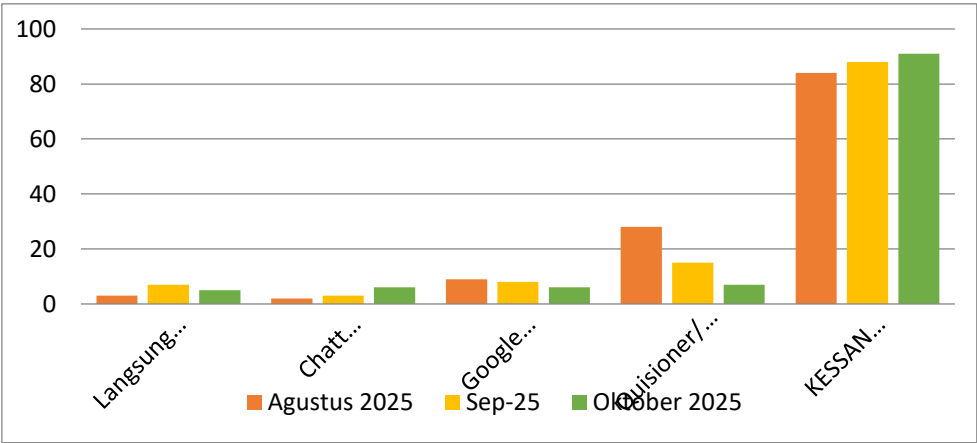
3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan September 2025

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	Langsung tatap muka	3	7	5
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	2	3	6
b	Google reviuw	9	8	6
3.	Quisioner/kolom kritik saran	28	15	7
4	KESSAN	84	88	91

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Oktober 2025



Analisis :

Pada bulan Oktober 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 7 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari Google viuw dan WA sebanyak 6 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Oktober 2025

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplai atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	60%	0	40%
					5		2
5.	KESSAN	100%	100%	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Oktober 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 60% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.
Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 10 kasus complain dengan rincian :
Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu perlebar ruangan rawat inap karena terlalu sempit

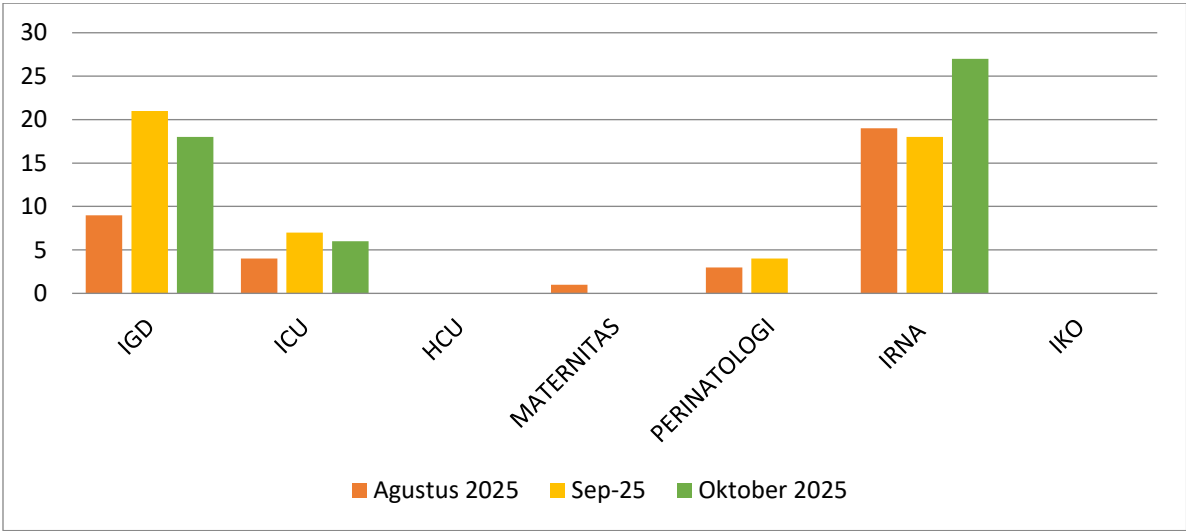
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Oktober 2025

NO	UNIT PERUJUK	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1.	IGD	9	21	18
2.	ICU	4	7	6
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	1	0	0
5.	NEONATOLOGI	3	4	0
6	IRNA	19	18	27
7	IKO	0	0	0
Total		36	50	51

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Oktober 2025



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Oktober 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAYON HABIS
1	Pangeran Aisar Ernestroy	IRNA	Pneumonia	dr. Dicky, Sp. A	RSSA	pro penanganan lebih lanjut + PICU	4	Tidak
2	Ny. Susi	IRNA	tetraparase ec susp GBS	dr. Farid., Sp. N	RSSA	pro MRI dan	2	Tidak

	Nofiyanti		dd IDEM proses			tatalaksana lebih lanjut		
3	Tn. Iwan Yudianto	IRNA	SOP Cerebri	dr. Farid., Sp. N	RS Karsa Husada	pro MRI dengan kontras	4	Tidak
4	Tn Nur Ali	IGD	dyspneu ec ckd gr V+anemia+alo cardiogenik dd pneumonia dd tb paru+adhf	dr Aji, Sp.PD	RSSA	pro hd cito + icu isolasi	2	Tidak
5	Tn Ichsan	IRNA	CKD st 4+Anemia+Hipertensi Emergency+Efusi Pleura Dextra+Pneumonia	dr. Ardhaney., Sp. PD	RSUB	pro HD	3	Tidak
6	Tn Iswanto	IGD	Stemi inferior dan RV infarct+HT emergency+1 st degree AVB	dr. Mira Sp,JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
7	Tn Dedik Endro Cahyono	IGD	Stemi inferoposterior dan RV infarct+ST degee AVB+Riwayat CVA	dr. Mira Sp,JP	RST	Pro PCI	1	Tidak
8	Tn Kasim	ICU	NSTEMI+SYOK KARDIOGENIK+LV FAILURE+ARDS	dr Ira, Sp.JP co dr Elvi, Sp.P+dr Zora, Sp.PD raber dr Heru, Sp.An	RSSA	pro HD back up Ventilator	6	Tidak
9	Tn SUWATIN	IGD	1. Anemia, 2. B20", "Suspek TB Paru", "Obs Febris H7"	dr. Elvi, sp.p	RS LAVALETTE	pro penanganan lebih lanjut / ruang isolasi	1	Tidak
10	Tn royan	IRNA	CVA, DM, CKD	dr Farid Sp N	RS LAVALETTE	pro perawatan lebih lanjut (US)	6	IYA
11	Ny. Sariati	ICU	NSTEMI, Shock Cardiogenik, CF Collum Femur Sinistra	dr Mira SP JP	RS Karsa Husada Batu	Pro ICCU	4	Iya
12	ny suni	IRNA	Bisitopenia (anemia + trombositopenia) + leukositosis susp acute leukemia (hasil HDT terlampir)	dr Zora Sp PD	RSSA	Pro BMP	6	Iya
13	Ny Cariami	IRNA	CA Renal	dr Pradana Sp U	RSSA	pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
14	Tio raflesia armansyah	IGD	OPEN WOUND PEDIS + SUSP RUPTUR TENDON REGIO PEDIS DEXTRA		RSPHS	APS PENANGANAN LEBIH LANJUT	1	Tidak
15	Ichsan	IRNA	ALO ec CKD, HT Emergency, Septic Condition	dr Ardhaney SP PD	RS LAVALETTE	Pro HD Cito	1	Tidak
16	Zainul khuluq	IRNA	Cholangitis	dr Zora Sp PD	RSSA	pro bedah digestif Pro Explore CBD k/p Bypass	3	Tidak
17	Abdul rachman	ICU	NSTEMI, Acut Heart Failure, RF, DM	dr Mira SP JP	RST Soepraoen	Pro PCI	3	tidak
18	Slamet riyanto	IGD	Susp Tetanus gr 1	dr Zaki Sp B	RSSA	Pro Isolasi	2	Tidak
19	Tn. Sjaifudin zuhri	IRNA	CKD, Asid Metabolik, Ensefalopati Uremikum	dr Farid Sp N	RS LAVALETTE	Pro HD	2	tidak
20	Ny. Siti mahmudah	IRNA	CVA ICH PONST	dr. Syahrir sp. s	RSSA	pro Strok unit	2	Tidak
21	Mubarak	ICU	Susp. Difteri	dr Aji, Sp.PD	RSSA	Pro penangan lanjutan ruang isolasi dengan difteri k/p perawatan KPTI	1	Tidak
22	Yunaeni	IGD	Anemia Gravis + CKD + DM + HT	dr. Heri, Sp. PD	RS Lavalate	Pro penanganan HD	1	Tidak
23	Didik ismail	IGD	STEMI inferior Killip I + PVC	dr. Yoga, Sp. JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
24	Darmi trianaingsih	IGD	Combustio Grade I-II 25-30% et Grade IIAB 5-10% (Regio Facial, Thorax, Abdomen, Antebrachii Sinistra, extremitas superior , inferior)	dr. Sigit, Sp. BP	RSSA	Pro penanganan combus lebih lanjut	1	Tidak
25	Seger	IGD	dyspnea ec ckd gr v, susp adhf", "dm hiperglikemi", "ulkus diabetikum pedis s"	dr. Heri Sp,PD	RS Lavalate	Pro HD	2	Tidak
26	Muhammad tsabit kautsar	IRNA	pneumonia, gagal nafas	dr. dicky, Sp.A	RS PERSADA MALANG	PErawatan Lama	1	Tidak

27	Ny. Eni sudaryati	IRNA	pulmo metastase, Fr compressi v lumbal susp metastase, neurogenic bladder, melena.	dr. ARDHI SP. PD	RSSA	Pro perawatan KHOM	4	Tidak
28	Tn. Wijayanto	IRNA	COS ec ICH ec SAH, Trauma Tumpul Thorax	dr. Andi, Sp.B	RS Soepraoen	Pro Bedah Syaraf	2	Tidak
29	Tn. Latifah	IRNA	obs hematoschezia + ACKD + Fatty Liver + SH	dr. Ard hany Sp.PD KGH	RSSA	pertimbangan endoskopi dan perawatan SpPD-KGEH	3	Tidak
30	Ny Agus Sudarmi	IRNA	Hematemesis Melena + Syok Condition	dr. Aji Sp.PD	RSSA	Pertimbangan Endoskopi dan perawatan SpPD-KGEH	2	Tidak
31	Tn. Suparto	IRNA	DM type II Hyperglukemi	dr. Aji, Sp.PD konsul dr. Fahimma Sp. N	RS Lavalette	pro Stroke Unit dan CT - Scan Kepala	2	Tidak
32	Tn. Suwardi	IGD	STEMI Inferior	dr Mira Sp JP	RS UMM	Pro PCI	2	Tidak
33	Tn. Yuliatim	IGD	Hemiparese Dextra dr Stroke infark 2 attack	dr Farid Sp N	RSUD Lawang	Pro Stroke Unit	1	Tidak
34	Ny. Maria santika	IRNA	Susp Autoimun Disease, Fatty Liver, Cholelitis Multiple	dr Ard hany Sp PD	RSSA	Pro perawatan SP.PD-KR & Sp.PD-KGEH	1	Tidak
35	I wayan Muliarta	ICU	CVA Infark+Uremic Encepalophaty dt CKD st.V+Hiperkalemia+DM Hiperglukemia+Leukositosis	dr.Farid.,Sp.N konsul dr.Zoraida.,Sp.PD	RSU Karsa Husada Batu	Pro HD Cito	2	Tidak
36	Tn. Haning susetyo	IRNA	CF Clavicula Sinistra + Multiple Fraktur Costae	DPJP : dr. Zaki Sp.B Konsul : dr. Oka Sp.OT	RSSA	Pro Clipping costae	2	Tidak
37	An. Tio afgan robbani	IGD	Susp torsio testis S	dr. Pradana, Sp. U	RSSA	pro Eksplorasi cito	1	Tidak
38	An. Dewi murti	IGD	Suspek CVA Bleeding	dr. FARID,SP.S	lavalette	pro struk unit	1	Tidak
39	Ny. Nurul aini	IRNA	CKD ST 5	dr. ZORA Sp.PD	RSUB	Pro perawatan SP.PD-KGH (pro HD)	2	Tidak
40	Amanie	IRNA	hematemesis Profus, Anemia, Syok Hipovolemia	dr Ardhi SP PD	RSSA	Pro perbaikan kondisi tranfusi darah masif dan tindakan hemostasis endoskopi jika diperlukan	4	Iya
41	Hamid	IGD	Infected Pacemaker	dr Yoga Sp JP	RSSA	repair Pacemaker	2	tidak
42	Nn putri safitri	IRNA	Bisitopenia dt AML + Volume Depletion	dr Zora Sp PD	RSSA	pro kemothorapi + perawatan Hematologi Onkologi	2	Tidak
43	Tn tauchid wachid	ICU	NSTEMI, Syok Kardiogenik, Gagl nafas perbaikan,, DM	dr Mira SP JP	RSI Aisiyah	Pro PCI Back up HD	3	Tidak
44	Tn. Warno	IRNA	Susp Tetanus	dr Andi Sp B	RSSA	Pro perawatan isolasi tetanus	2	tidak
45	Nn. Khilyatus Saadah	IRNA	Efusi Pleura Bilateral	dr. Andy Sp.P	RS KARSA HUSADA	Pro thoracosintesis back up transfusi albumin prc lanjutan (transfusi tanpa perbaikan)	3	Tidak
46	Siti halimah	IGD	Chest Pain dd UAP dd NSTEMI+Nausea vomiting	dr.Mira , Sp. JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
47	Nilam larasati kemuning	IGD	G2 P0101 AB0 UK 26-28 MNINGGU DG PPRM, HIPERBILIRUBIN	dr HUMAIRA, SP.OG	RSSA	Pro penanganan lebih lanjut bayi kecil	1	Tidak
48	Maisumah	IRNA	Ascites+Sirosis Hepatis	dr. Heri, Sp.PD	RSSA	pro perawatan SpPD-KGEH untuk tranfusi albumin	3	Tidak
49	Anik Rohmaniah	IGD	TRAUMA THORAX dt SUSP HEMATHOTORAX COTUSIO PULMONUM+FRACTURE COSTAE+CF METACARPAL 5 MANUS DEXTRA	dr ANTON, Sp.B	RS Soetomo Surabaya	Pro Chest Tube	1	Tidak

50	Evi Lestari	IRNA	SEIZURE, MENINGOENCHEFALITIS	dr Farid Sp N	RS Soetomo Surabaya	Pro EEG dab CT Scan kepala dengan kontras	3	Iya
51	Tn Bambang Dwi Putro	IRNA	NSTEMI, ADHF dt HHD, susp infective endokarditis	dr Mira SP JP	RSSA	Pro perawatan lebih lanjut untuk infective endokarditis dan pemeriksaan kultur darah	2	tidak

Analisis :

1. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan September 2025. Pada bulan Agustus 2025 sebnayak 36 pasien pada bulan September sebanyak 50 pasien Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 51 pasien.
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - a) Pro PCI
 - b) Pro CVCU
 - c) Pro stroke unit
 - d) Pro HD
 - e) Pro Bedah digestif
 - f) MRI
 - g) Pro bedah saraf lanjutan
 - h) Membutuhkan alat khusus
 - i) Membutuhkan pengobatan ARV
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
 Pada bulan Pada bulan September 2025 terdapat Minus sebanyak Rp.1.287.145 Sedangkan pada bulan Oktober sebanyak : Rp 6.231.130

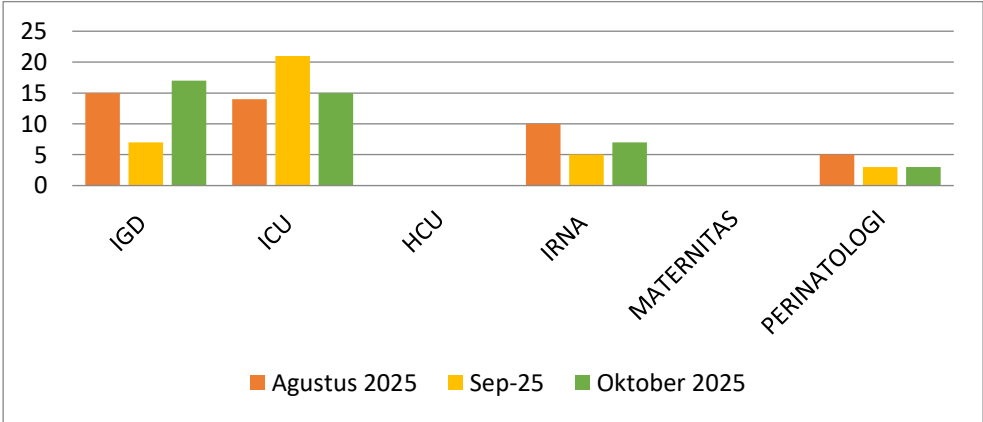
Rencana Tindak Lanjut:

1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Oktober 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	Agustus 2025	September 2025	Oktober 2025
1.	IGD	15	7	17
2.	ICU	14	21	15
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	10	5	7
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	5	3	3
Total		39	36	42

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Oktober 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal Oktober 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	EWS
1	Sudirman	IGD	DOA	dr Endra	√
2	Nurchasanah	IGD	DOA	dr Endra	√
3	By Ny Hartantri	NEO	Abortus Incomplete	dr Humaira, Sp.OG	√
4	Miftahul Jannah	ICU	EFUSI PLEURA MASIF ec TB PARU + TRANSAMINITIS	dr.Elvi Sp.P konsul dr Heru Sp.An konsul dr. Heri Sp.PD	√
5	Ny. Eti Freti Matindas	IGD	DOA	dr Endra	√
6	Agus Sudjono	IGD	Cardiac Arrest	dr Gandha	√
7	NGATIAH	IGD	DOA	dr Endra	√
8	SYAFIRA WULAN SARI	ICU	ARDS+KAD+DM TYPE 1	dr. Aji Sp.Pd raber dr. Robby Sp.An dr.Elvi.,Sp.P Konsul dr.Heru.,Sp.An	√
9	Tn.Yusuf	ICU	ARDS , Pneumoni dd TB, GEA	Konsul dr.Heri.,Sp.PD	√
10	Tn.Mustari	ICU	RHF + RF + POST CARDIAC AREEST + SHOCK Cardiogenik	dr.Miryanti.,Sp.JP raber dr.Heru.,Sp.An Raber dr.Andy.,Sp.P konsul dr.Aji.,Sp.PD konsul dr.Fahimma.,Sp.N	√
11	Tn.Riswanto	ICU	CVA emboli	dr.Syahrir.,Sp.N Konsul dr.Heri.,Sp.PD	√
12	BY NY NURAINIAH	NEO	IUFD	dr Humaira, Sp.OG	√
13	Tn.Suparman	ICU	ARDS, COPD, Pneumonia, Sepsis	dr Andy Sp P	√
14	Tn. TUGAN TARQI AL MAHDY	ICU	DOC Sup CVA, status epileptikus, CKD	dr Syahrir Sp S	√
15	ny CHOIRIJAH	ICU	Krisis Hiperglikemia	dr Zora Sp PD	√
16	Ny Poniti	ICU	Respiratory Failure, DM, AKI	dr Aji Sp PD	√
17	Ny. SHINTA PURWANINGSIH	IGD	Cardiac Arrest	dr Ganda	√
18	ny wenny	ICU	COB, SDH	dr Fachriy Sp BS	√
19	Tn.Hidayat	IGD	DOC Susp CVA	dr Isrotul	√
20	A.n AGAM ARAY EL FATIH	IRNA	kraniopharyngioma hidrosefalus	dr Dicky, Sp.A	√
21	Misdir	IRNA	Colid abdomen susp. ileus post op Laparatomy	dr. Anton Sp.B	√
22	Ny. Heny	IGD	DOC, Hiperglikemia, Susp. Sepsis, AF, Susp. Ileus	dr. Aji, Sp. PD konsul dr. Yoga, Sp. JP konsul dr. Anton, Sp. B	√
23	Tn. Rio Andrianto	IRNA	Colic abdomen, Trombositopenia, ADHF	dr. Ardhi, Sp. PD	√
24	Tn. Daniel Ruru	IGD	Susp. Femur S	dr. Arianto, Sp. ortho	√
25	An. KHOLISATUN NAJWA	IGD	obs konvulsi dd st epileptikus	dr. Dicky, Sp. A	√
26	An. AGHNIA CEISYA SYAFANIA	IRNA	Pjb status epileptikus ec ensefalitis	dr. Dicky, Sp. A	√

27	By. Ny. Ike Yusrini	IRNA	IUFD	dr. Humaira, Sp. OG	√
28	Tn.Moh.Zaini	ICU	ARDS + DOC + Susp.CVA Hemoragic	dr Yoga, Sp.JP	√
29	HAFIZ ZAKI AL GHANI	IGD	DOA	dr.Endra	√
30	FAUZI	ICU	ARDS, PNEUMONIA	dr.Ardhany Sp.Pd. KGH	√
31	SUTIYARI	IRNA	COLIC RENAL, DEHIDRASI SEDANG	dr. Aji, SP.PD	√
32	NY. PAISRI	ICU	CVA ICH PONS	dr.Fahima Sp.N	√
33	NY. DEWI MURTI	ICU	CVA ICH	dr Farid Sp S	√
34	Tn KASURI	IGD	ARSD	dr Ardhi Sp PD	√
35	KUNANI	IGD	Susp Pneumonia, Susp TB Paru, DM	dr Andy Sp P	√
36	SALMA	IGD	COB 111	dr Fachriy Sp BS	√
37	RIYANI	IRNA	DM Hiperglikemia, AKI, Hipernatremia, CVA sequele.	dr. ardhi Sp.PD	√
38	MUCHAMAD	IGD	DOA	dr.fira	√
39	HENI BEKTI PRATIWI	IGD	DOA	dr Endra	√
40	TN. LUKMAN ASNAWI	ICU	DOC susp metastastic, Brain Lession, CKD	dr.Farid Sp.N	√
41	JULIA EKA RAHMANIA	IGD	DOA	dr Anisavira	√
42	MUJIATI	IRNA	DM HIPERGLIKEMIA, DM GASTROPATI	dr Zora Sp PD	√

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Oktober 2025 sebanyak 42 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 17 pasien, ICU : 15 pasien IRNA : 7 pasien Neo : 3 pasien
3. Pada bulan Oktober 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 8 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Habis PKS	14	12	19
2	BPJS status Denda	17	36	41
3	BPJS status Premi	0	0	0
4	BPJS status Denda dan Premi	3	2	1
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	3	1	2
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	4	3	2
7	BPJS status penangguhan pembayaran	3	5	3
8	Rencana pengurusan BPJS	89	91	85
9	BPJS status tidak ditanggung	6	4	5
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	1	0	1
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	0	0	0

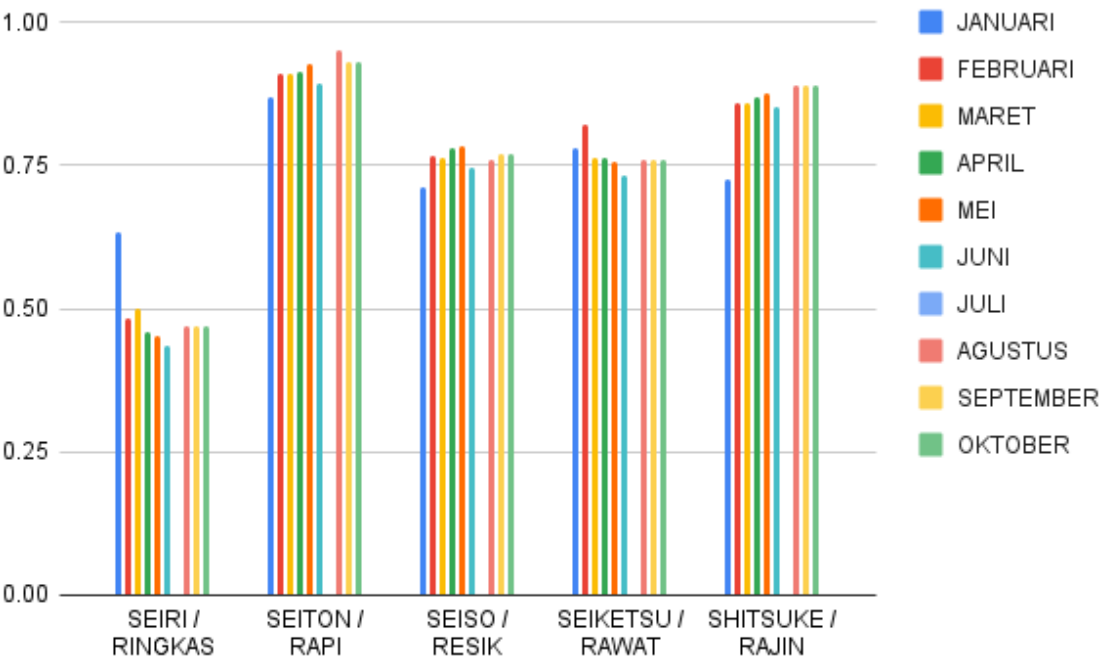
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%	44%		47%	47%	47%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%	89%		95%	93%	93%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%	75%		76%	77%	77%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%	73%		76%	76%	76%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%	85%		89%	89%	89%



Analisa :
Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

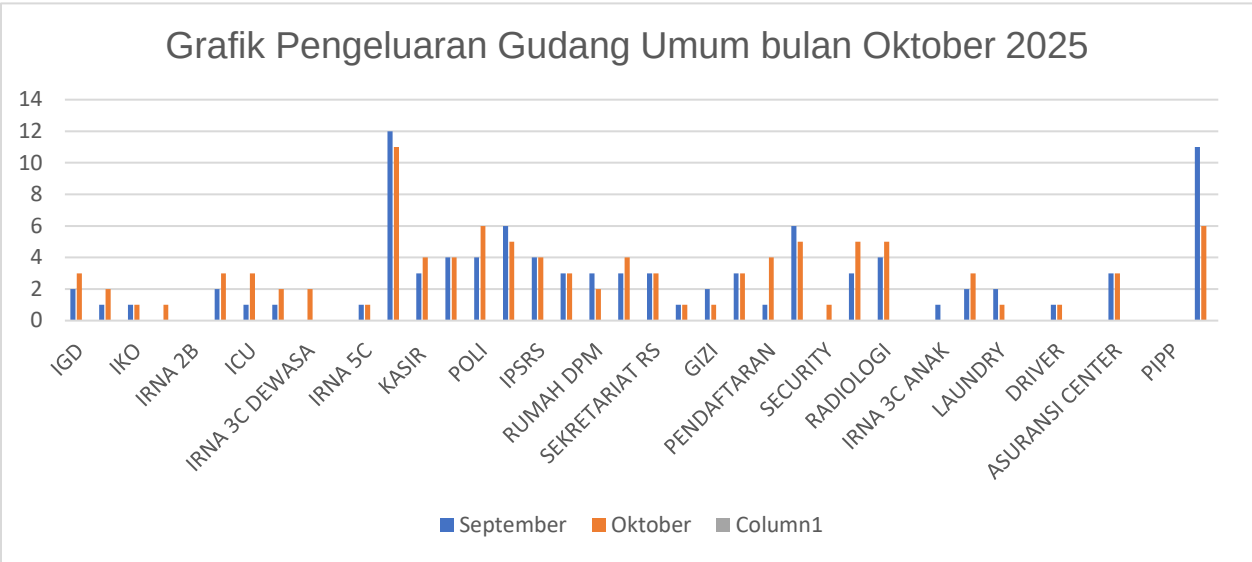
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

No	Unit Asal	Jumlah Barang		Persentase
		September	Oktober	
1	IGD	2	3	↑33,33%
2	MATERNITAS	1	2	↑50%
3	IKO	1	1	↓0%
4	IRNA 2A	0	1	↑100%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	2	3	↑33,33%
7	ICU	1	3	↑66,66%
8	IRNA 3A+4A	1	2	↑50%
9	IRNA 3C DEWASA	0	2	↑100%
10	IRNA 4C	0	0	↓0%
11	IRNA 5C	1	1	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	12	11	↓-9,09%
13	KASIR	3	4	↑25%
14	DAPUR	4	4	↓ 0%
15	POLI	4	6	↑33,33%
16	CLEANING SERVICE	6	5	↓-20%
17	IPSRs	4	4	↓0%
18	GUDANG FARMASI	3	3	↑0%
19	RUMAH DPM	3	2	↓-50%
20	SEKRETARIAT PT	3	4	↑25%
21	SEKRETARIAT RS	3	3	↓0%
22	CSSD	1	1	↓0%
23	GIZI	2	1	↓-100%
24	REKAM MEDIS	3	3	↑0%
25	PENDAFTARAN	1	4	↑75%
26	DEPO FARMASI	6	5	↓-20%
27	SECURITY	0	1	↓100%
28	LABORATORIUM	3	5	↑40%
29	RADIOLOGI	4	5	↑20%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	1	0	↓0%
32	NS NICU	2	3	↑33,33%%
33	LAUNDRY	2	1	↓-100%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	1	1	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	3	↑0%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	11	6	↓0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat dan RSDH

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 - 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 - 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

3.7.8 Capaian Tata Laksana Keluhan

NO	JENIS KELUHAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
1	Keluhan terkait software	19	19	100%
2	Keluhan terkait hardware	77	77	100%

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasis

3.7.9 Rekapitulasi Kejadian Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1	23/10/2025	Tidak terencana	60 menit (09.00-10.00)	Finger pasien dan Frista	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs
2	31/10/2025 s/d 1/11/2025	Terencana	17.00-05.00	Maintenance bulanan server bridging bpjs	Edukasi proses pencarian data peserta secara manual

Analisis

: Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT

Rencana Tindak Lanjut

: Monitoring dan Evaluasi

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	60	46	47	57	35	48	51	36	50	49		
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1		
JEMPUT RUMAH PASIEN	17	13	18	16	11	14	21	15	14	15		
ANTAR RUMAH PASIEN	19	14	11	16	20	13	18	23	9	11		
SAMPEL LAB	19	19	12	14	15	30	30	27	26	18		
SAMPEL SHK	4	2	3	3	3	5	3	5	4	4		
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	5	6	2	7	5	5	2	3	7	6		
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PENGANTARAN JENAZAH	25	29	16	23	44	35	31	36	26	33		
RUJUK CT SCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35		
ANTAR MCU RSPHM	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
LAIN-LAIN	7	11	13	6	12	11	6	10	9	11		
TOTAL	158	140	122	142	145	162	162	156	147	183	0	0

Analisa :

Terdapat kenaikan bulan ini akibat adanya rujuk CT Scan (kerusakan CT Scan PHM).

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

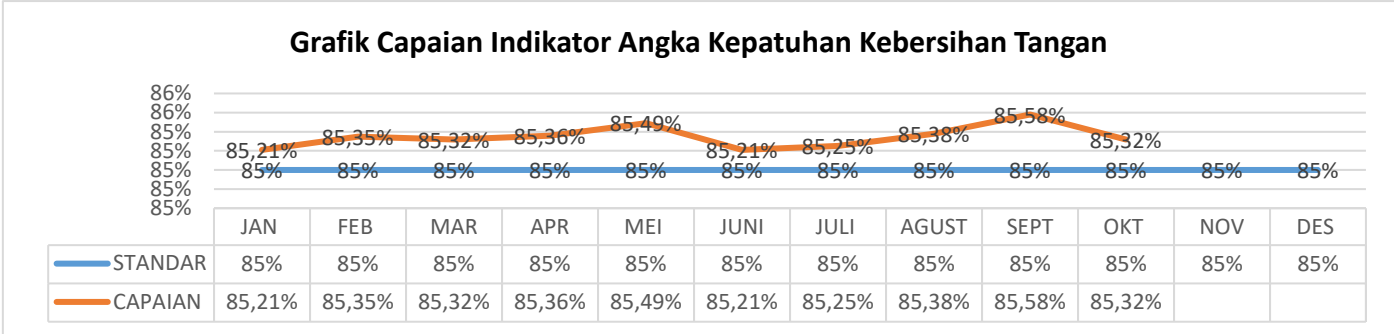
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%			85,34%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%	93,79%	94,3%	94,33%	94,52%			93,92%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%	99,96%			99,3%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%	96,23%	96,60%	96,62%	96,88%			95,7%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%	0%			0,03%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%	66,22%	60,55%	70,4%	62,74%			71,2%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			99,42%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%	96,33%	95,04%	93,45%	89,47%			97,4%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			99,99%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,89%	99,9%			99,52%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



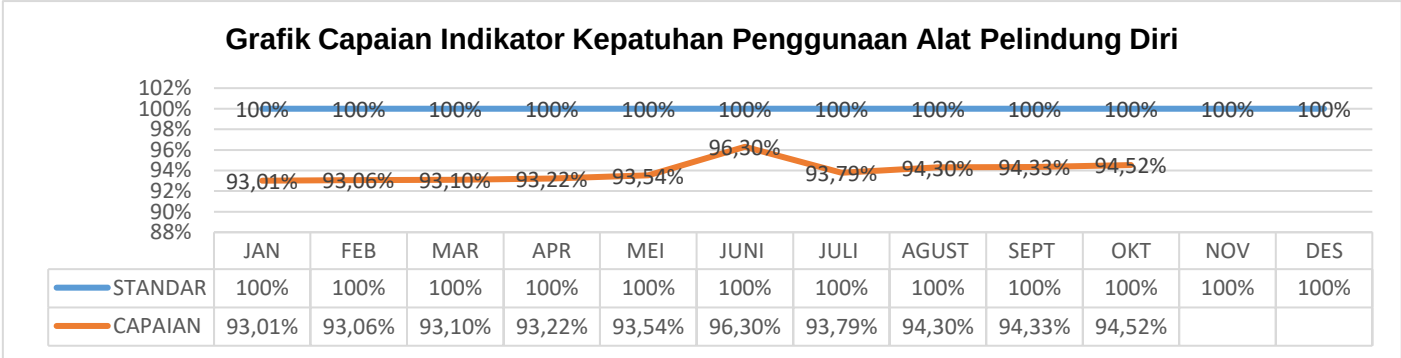
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21, capaian di bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58 dan Oktober 85,32% dengan rata rata bulan Januari hingga Oktober yaitu 85,34%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.					
DO	a) Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. b) Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. c) Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. d) Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. e) Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.					
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21, capaian di bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58 dan Oktober 85,32% dengan rata rata bulan Januari hingga Oktober yaitu 85,34%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.7.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



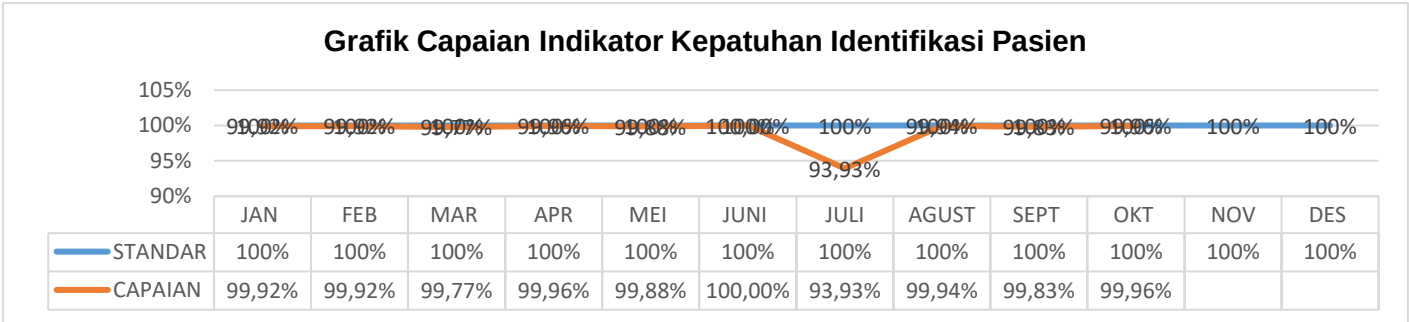
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada bulan Januari hingga September Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.

	6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54%, bulan Juni 96,3% dan bulan Juli 93,79% serta bulan Agustus sebesar 94,3%, bulan September yaitu 94,33% dan bulan Oktober yaitu 94,2% dengan rata-rata 93,85%. Ketidakpatuhan ini berpotensi meningkatkan risiko penularan infeksi silang antar pasien dan tenaga kesehatan. Berdasarkan temuan, masih ada petugas yang dengan sengaja tetap menggunakan handscoon untuk menulis rekam medis.Selain itu masih ada DPJP yang menggunakan satu APD untuk visit ke seluruh pasien. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan disiplin dalam penggunaan APD.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. pentingnya penggunaan APD kepada seluruh tenaga Kesehatan 2. Melakukan audit harian kepatuhan APD dan memberikan Feedback langsung 3. Memberikan apresiasi (reward) bagi tenaga Kesehatan yang patuh	1. Kepala ruangan dan IPCN 2. Kepala ruangan 3. Kepala Bidang	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

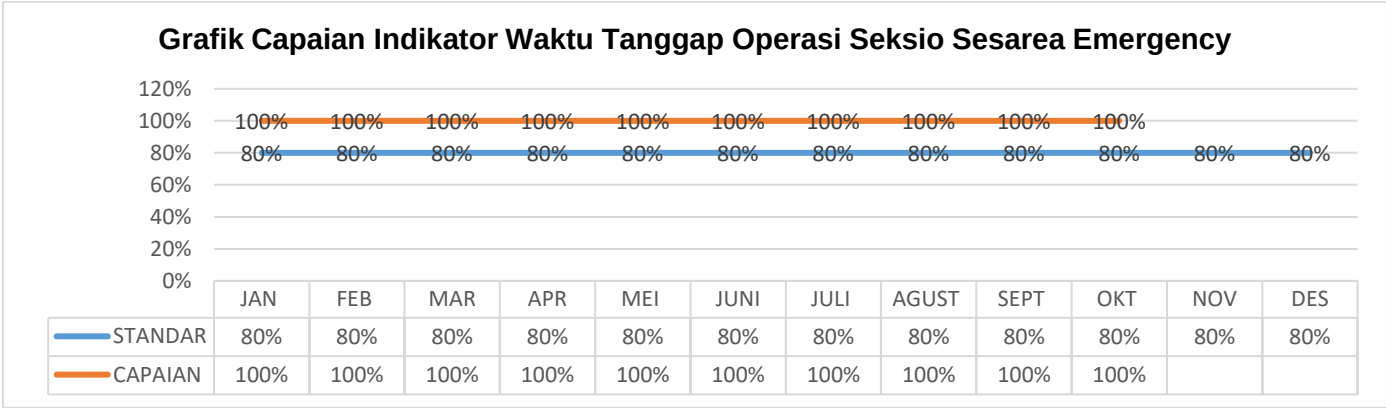
3.7.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83% dan bulan Oktober yaitu 99,96%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan 130lastic130e pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan 130lastic130e dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96%, capaian di bulan Mei 99,88% dan capaian meningkat di bulan Juni menjadi 100%,namun kembali menurun pada bulan Juli yaitu 93,93% serta bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83% dan bulan Oktober yaitu 99,96% dengan rata rata 99,3 %. Dari temuan dilapangan diketahui bahwa DPJP seringkali tidak melakukan identifikasi pasien ketika melakukan visite karena sudah didampingi oleh perawat. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat. 3. Perawat diharapkan bisa membantu melakuakn identiifikasi pasien ulang ketika melakukan visite	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

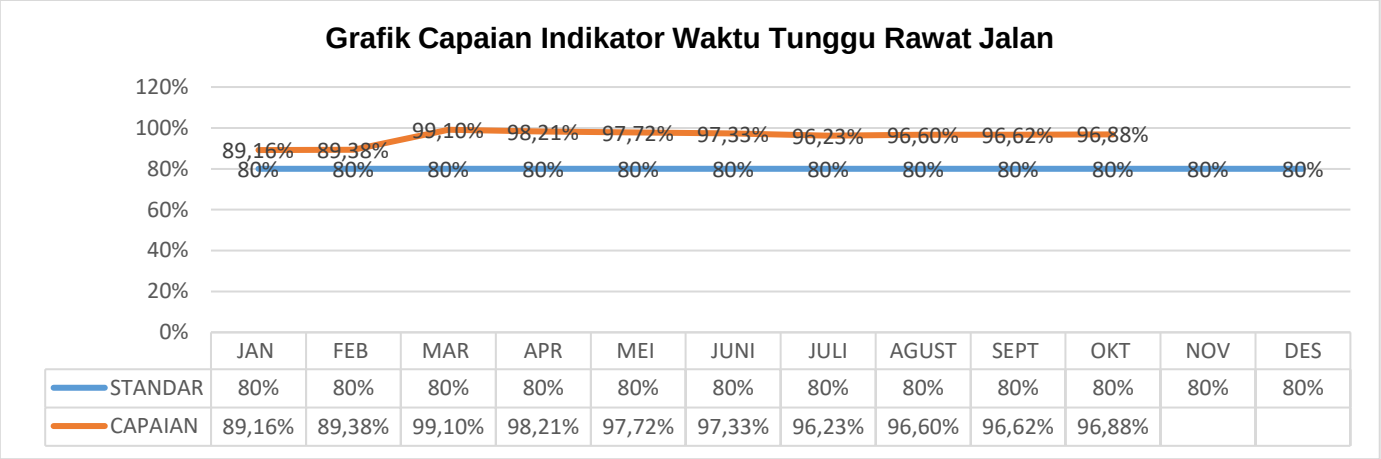


Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat

kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi faktor tercapainya indikator waktu tanggap operasi SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

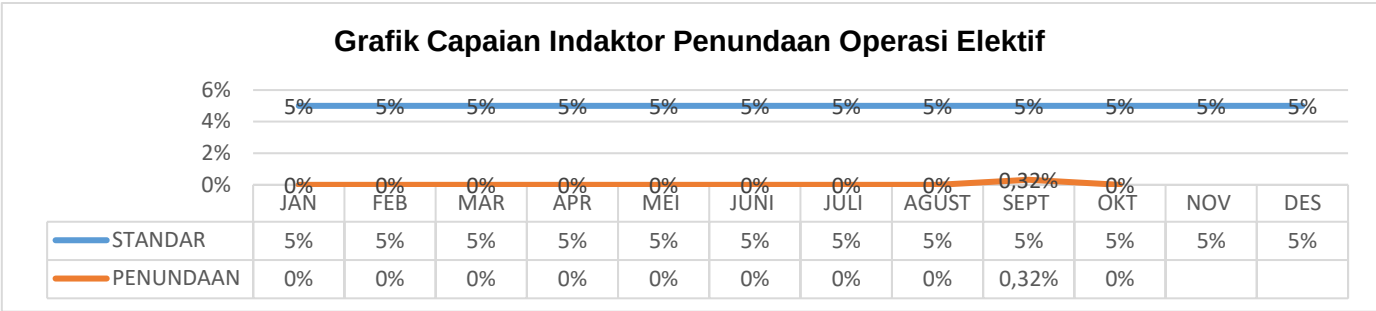
3.7.12 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71%, capaian di bulan Juni adalah 97,33% dan capaian di bulan Juli adalah 96,23%, capaian di bulan Agustus yaitu 96,60%, di bulan September yaitu 96,52% dan capaian di bulan Oktober yaitu 96,88% dengan rata-rata 95,7%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Adanya aturan baru bahwa pasien bisa di daftar 1 jam sebelum jadwal praktek dokter juga sangat membuat waktu tunggu rawat jalan menjadi lebih pendek. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya dengan cara Optimalisasi alur pendaftaran dan koordinasi antar unit.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

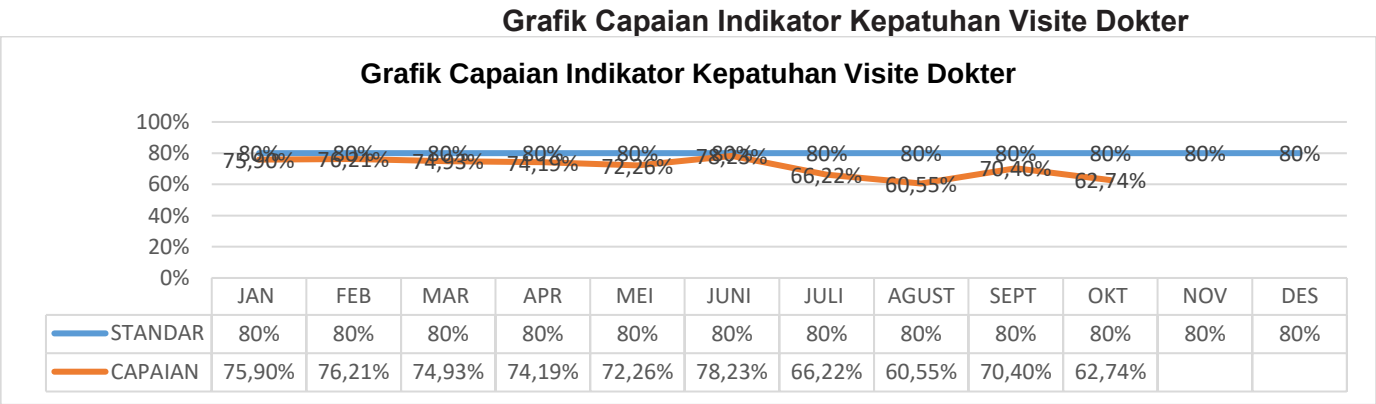
3.7.13 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart dengan rata rata 0,03% hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya melalui ketersediaan alat dan kesiapan tim.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

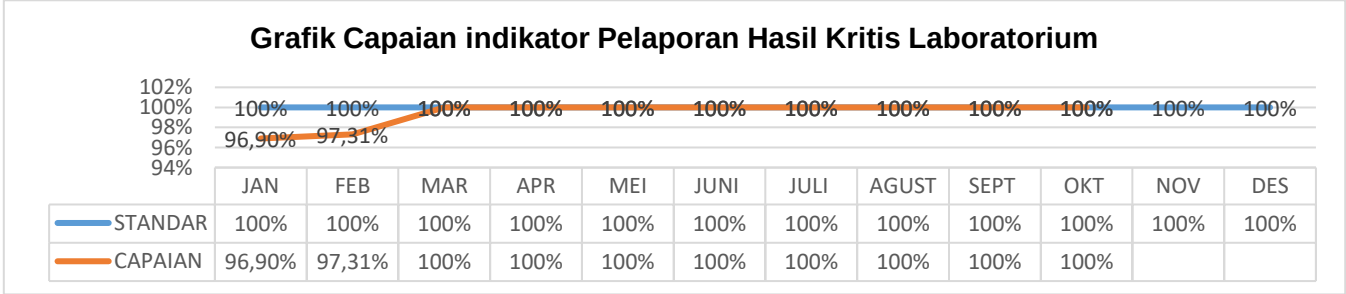


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Oktober Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26%, capaian di bulan Juni yaitu 78,23%, capaian di bulan Juli yaitu 66,22% dan capaian di bulan Agustus yaitu 60,55%, capaian bulan September yaitu 70,4% dan Oktober 62,74% dengan rata-rata 71,2%. Dari hasil supervisi didapatkan Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena dokter seringkali memiliki jadwal yang padat termasuk jadwal praktik klinik dan tugas di rumah sakit lain. Selain itu budaya di rumah sakit yang belum sepenuhnya mengutamakan kepatuhan terhadap indikator mutu nasional, dimana visite di anggap fleksibel atau dapat di sesuaikan di luar jam standart.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	1. Kepala ruangan memantau kehadiran dokter pada waktu visite yang dijadwalkan. 2. Data dikumpulkan dan dibandingkan dengan jadwal resmi. 3. Supervisi secara konsisten .	Manajemen RS	Satu Tahun

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Labororium

3.7.14 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

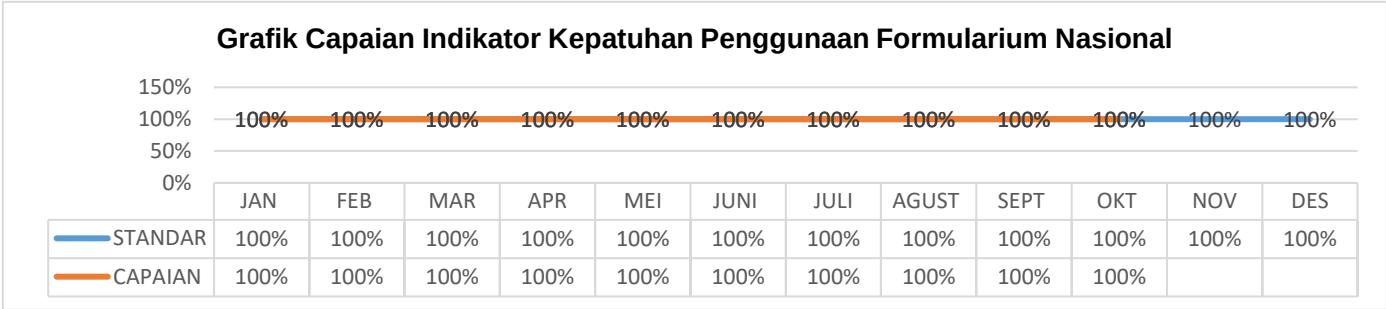


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga September. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Juni yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan 134lastic134e baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Oktober yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap yang membuat indikator tidak tercapai di bulan Januari dan Februari. Perbaikan telah dilakukan dengan cara menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor, memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap, memberikan pemahaman akan pentingnya melaporkan hasil kritis karena melalui hasil kritis dapat mempercepat mengetahui kondisi yang mengancam jiwa pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap. 3. Memberikan pemahaman akan pentingnya melaporkan hasil kritis karena melalui hasil kritis dapat mempercepat mengetahui kondisi yang mengancam jiwa pasien.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

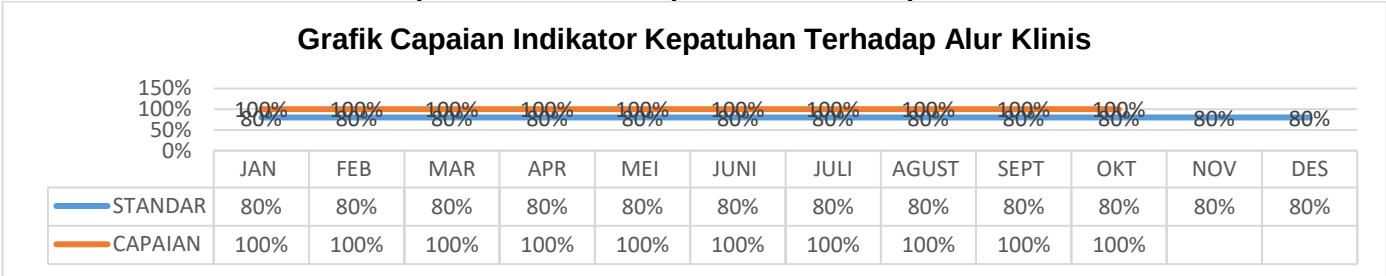
1.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga September tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Adanya payung hukum yang kuat, seperti Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional, memberikan landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan juga menjadi faktor yang membuat rumah sakit wajib mematuhi standart formularium nasional. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.7.15 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



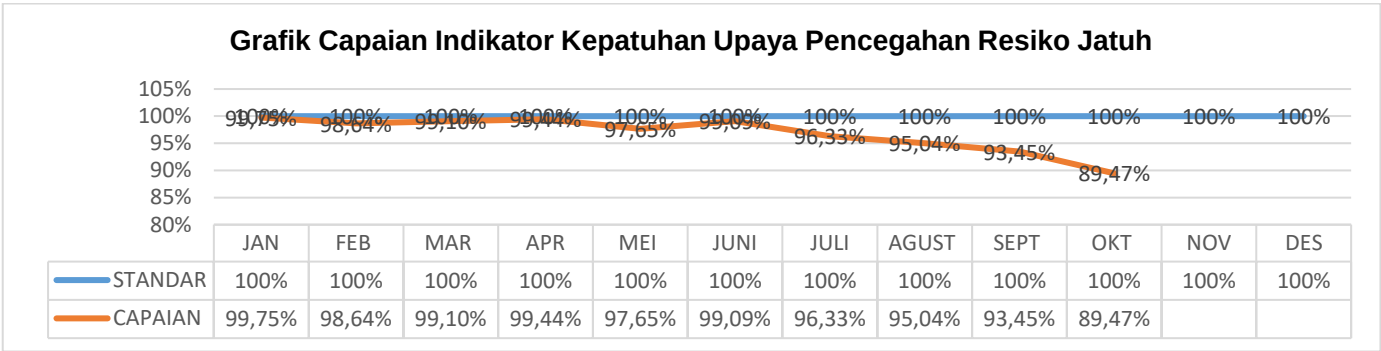
Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga oktober tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, unit yang patuh dalam pengisian CP daalah unit maternitas dengan diagnosa partus normal dan SC. Alur klinis sendiri sebenarnya membantu menstandarisasi perawatan untuk diagnosis tertentu, memastikan konsistensi dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Daftar Clinical Pathway Bulan Oktober 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	71		
Partus Normal	46		
Jumlah	107		

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.7.16 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



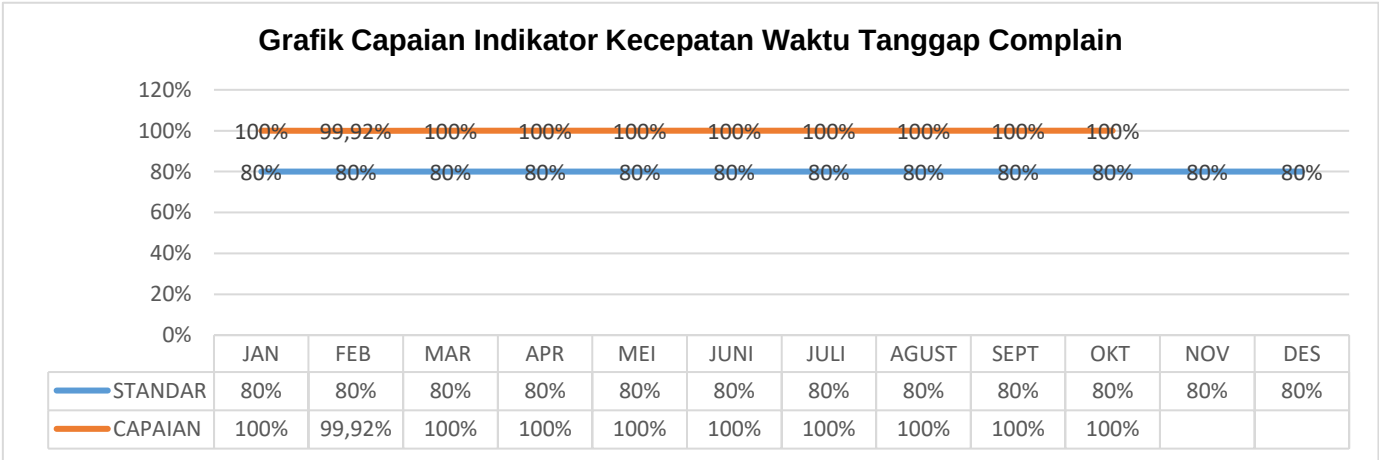
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga OktoberTahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65%, capaian di bulan Juni adalah 99,09%, capaian di bulan Juli adalah 96,33% dan capaian di bulan Agustus yaitu 95,04%, September 93,45% dan Oktober 89,47% dengan rata-rata 97,4%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. Temuan pada unit IGD yaitu kurangnya kepedualian petugas dalam upaya pencegahan risiko jatuh, hal ini diketahahui dari ditemukannya pasien IGD dengan tempat tidur yang tidak terpasang handrel dan tanda risiko jatuh yang tidak diberikan pada tempat tidur pasien. Hal ini menunjukkan bahwa motinasi petugas yang masih rendah dalam menjalankan prosedur keselamatan pasien secara konsisten.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	1. Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

			ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan. 2. Memberikan teguran langsung kepada petugas yang tidak melakukan upaya pencegahan risiko jatuh 3. Meningkatkan pengetahuan perawat mengenai SPO pencegahan risiko jatuh dengan cara melakukan sosialisasi kembali dan pengajuan diklat sasaran keselamatan pasien.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.7 **Kecepatan Waktu Tanggap Komplain**

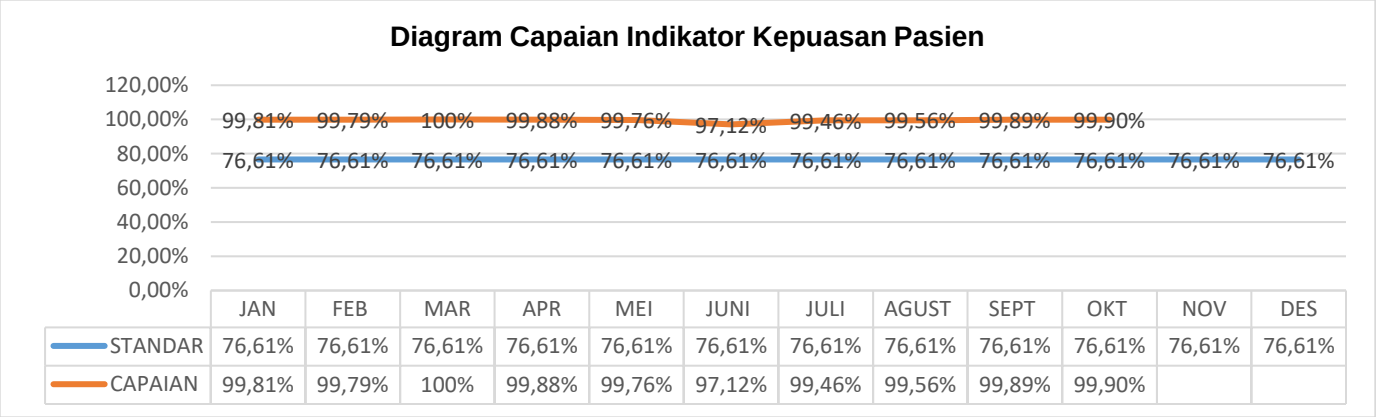
1.6.1.1.12.1 **Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain**



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,99%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui tlp, WA dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

1.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

1.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99,52%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk berfokus pada kualitas pelayanan secara keseluruhan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%	99,96%			99,27%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%	99,93%	99,37%	99,41%	99,46%	99,36%			99,55%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%	100%	100%	100%	100%	98,62%			98,94%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	98,85%	100%	100%	100%	93,22%			98,34%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%

8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%	97,63%	98,22%	98,48%	98,52%	98,62%			98,12%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%	99,31%	99,48%	98,71%	98,79%	99,93%			99,12%
11.	Kepatuhan 140last pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%	98,48%	96,33%	95,04%	95,21%	89,47%			96,7%
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,42%	85,32%			85,34%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,89%	99,9%			99,52%

1.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%	89,35%	86,4%	80%	87,5%	87,9%	88,2%			85,9%

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%	99,48%	98,79%	98,2%	98,32%	99,9%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%	96,03%	95,23%	95,445	95,68%	94,24%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Kepatuhan 141last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2	98,92%	98,45%	98,92%	98,82%	98,84%	98,9%			
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%	5,43%	1,96%	1,72%	1,52%	1,87%			

17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0			

Secara keseluruhan, **capaian indikator mutu Unit IGD menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil sepanjang tahun 2025**. Mayoritas indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan pelayanan gawat darurat yang sudah berjalan sesuai standar keselamatan pasien dan prosedur operasional.

Beberapa poin penting dari hasil capaian tersebut antara lain:

- Indikator pelayanan pasien emergensi dan non-emergensi** (seperti waktu tunggu pasien <5 menit untuk kasus gawat darurat dan <60 menit untuk non-emergensi) menunjukkan capaian **sangat tinggi dan konsisten di kisaran 98–100%**. Hal ini menggambarkan kecepatan serta ketepatan pelayanan tenaga medis IGD dalam menangani pasien.
- Indikator keselamatan pasien dan pencegahan infeksi**, seperti **kepatuhan hand hygiene, penggunaan APD, dan identifikasi pasien**, juga mencapai **hasil optimal** dengan capaian di atas standar minimal. Hanya terdapat sedikit fluktuasi pada bulan Maret dan Juni yang kemungkinan disebabkan oleh beban kerja meningkat atau rotasi tenaga baru.

-
3. **Indikator tanpa kejadian**, seperti **pasien jatuh, KTD, dan sentinel event**, menunjukkan **hasil nol (0%)** sepanjang tahun, menandakan pengawasan terhadap risiko keselamatan pasien berjalan sangat baik.
 4. **Kepatuhan terhadap aspek administrasi dan dokumentasi** (misalnya informed consent, form identifikasi, label obat high alert, dan pemasangan gelang pasien) juga tercapai 100% hampir setiap bulan. Ini menunjukkan komitmen tenaga IGD terhadap tata kelola dan tertib dokumentasi pelayanan

Indikator yang masih perlu perhatian antara lain:

1. **Kebersihan lingkungan IGD**, yang memiliki capaian sangat rendah (1–5%). Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kebersihan area kerja dan sistem audit lingkungan.
2. **Ketepatan pelaporan hasil laboratorium ≤ 2 jam**, yang pada awal tahun sempat berada di bawah standar (sekitar 73%) sebelum akhirnya membaik di bulan-bulan berikutnya.
3. **Kejadian gugus insiden horizontal**, masih muncul beberapa kali (hingga 4 kasus) pada awal pertengahan tahun, menunjukkan adanya potensi masalah komunikasi atau tekanan kerja antarstaf.

Secara umum, **kinerja mutu Unit IGD dapat dikategorikan sangat baik** karena hampir seluruh indikator mencapai standar nasional. Namun, peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan terutama pada aspek **kebersihan lingkungan, ketepatan pelaporan hasil laboratorium, dan hubungan kerja antarstaf** agar mutu pelayanan tetap optimal dan risiko keselamatan pasien bisa terus ditekan.

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-				-	-	-	-	-	-	
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Kepatuhan 144last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Kepatuhan penandaan 145lasti operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.7.17 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%	96,32%	96,88%	95,41%	96,33%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%	97,24%	96,9%	95,26%	95,88%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%	94,58%	72,31%	69,88%	70,22%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 145last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%	100%	100%	100%	100%				

8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%	96,93%	100%	100%	100%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	100%	97,71%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%	100%	100%	95,27%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%	100%	100%	100%	100%				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-	4,52%	1,81%	-	-	-				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-	100%	100%	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 146lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%	100%	100%	100%	100%				
-----	---	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	------	--	--	--	--

3.7.18 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%	90,32%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%	98,24%	97,22%	95,31%	96,42%	95,22%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%	97,32%	96,34%	95,22%	96,41%	96,21%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,86%	100%	100%	95,71%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%	92,93%	95,52%	89,30%	89,22%	95%			
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	Kepatuhan 147last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%	100%	67,38%	100%	100%	98,22%			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%	100%	90,27%	100%	1005	100%			
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,55%	100%	100%	82,73%			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%	41,67%	100%	100%	100%	88,272%			
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%			
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%	100%	100%	95,48%	100%	78,23%			

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%	100%	41,84%	100%	100%	88,1%			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,73%			
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,32%	100%	100%	100%	97,03%			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%	2,3%	-	-	-	-			
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-			
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%	59,7%	100%	100%	100%	100%			
21.	Kepatuhan penandaan 148lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%	58,82%	82,4%	100%	100%	100%			
22.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator mutu di Unit IRNA 4A selama periode pemantauan, secara umum dapat disimpulkan bahwa **kinerja mutu layanan berada dalam kategori baik**. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator yang menunjukkan capaian stabil mendekati atau mencapai angka **100%**, terutama pada indikator yang berkaitan dengan **keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap SOP**, seperti kepatuhan hand hygiene, kepatuhan penggunaan APD, ketepatan identifikasi pasien, pelaksanaan komunikasi SBAR, serta kelengkapan penyerahan pasien antar shift dan antar ruangan. Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien telah berjalan baik dan menjadi kebiasaan kerja di lingkungan IRNA 4A. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan **fluktuasi capaian**, meskipun tidak terlalu signifikan, namun tetap perlu dilakukan perbaikan. Indikator-indikator tersebut antara lain pada **ketepatan waktu pemberian obat, kepatuhan pengisian dokumentasi, serta kelengkapan pelaporan saat transfer pasien**. Turunnya capaian pada indikator tersebut kemungkinan disebabkan oleh **beban kerja yang**

tinggi pada jam-jam tertentu, pergantian shift, serta variasi kedisiplinan pelaksanaan dokumentasi di lapangan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian berupa penguatan sistem monitoring harian dan peningkatan kepatuhan petugas.

Sementara itu, indikator **kepuasan pasien** menunjukkan hasil yang masih berada dalam batas standar, namun cenderung fluktuatif. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas interaksi antara petugas dan pasien, waktu tunggu pelayanan tertentu, serta kenyamanan lingkungan perawatan. Upaya peningkatan komunikasi terapeutik dan pendekatan pelayanan yang lebih humanis perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan beberapa **rencana tindak lanjut** untuk meningkatkan konsistensi mutu pelayanan, antara lain: pelaksanaan audit dan monitoring dokumentasi secara berkala, penguatan briefing antar shift untuk memastikan kelengkapan informasi dan koordinasi, optimalisasi alur distribusi obat, serta peningkatan kualitas hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan dan pasien. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan capaian mutu IRNA 4A dapat terus meningkat, lebih stabil, dan mendukung tercapainya pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

3.7.19 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%	98,79%	97,88%	97,92%	99,36%	98,81%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%	91,23%	93,52%	93,88%	98,8%	99,12%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%	80,95%	74,42%	72,22%	80,15%	79,49%			
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	Kepatuhan 149last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%	86,09%	96,15%	96,42%	94,92%	100%			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%	97,14%	100%	100%	100%	100%			

9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%	100%	100%	100%	100%			
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	53,85%	100%	100%	100%	100%			
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	100%	100%	100%	100%			
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	75%	100%	100%	100%	100%			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Kepatuhan penandaan 150lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	45,45%	100%	100%	100%	100%			
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%	70,83%	90,48%	100%	100%	100%			

Berdasarkan hasil pemantauan capaian indikator mutu di Unit IRNA 2C selama periode Januari hingga Oktober, secara umum diperoleh hasil bahwa sebagian besar indikator mutu **telah mencapai standar yang ditetapkan**. Hal ini terlihat pada indikator-indikator terkait **keselamatan pasien**, seperti kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, ketepatan identifikasi pasien, serta kepatuhan komunikasi SBAR yang menunjukkan capaian stabil mendekati atau mencapai **100%**. Capaian tersebut mencerminkan bahwa penerapan budaya keselamatan pasien **sudah berjalan baik dan konsisten** di lingkungan unit. Selain itu, pelaksanaan dokumentasi keperawatan, kelengkapan lembar observasi, serta pelaksanaan edukasi pasien dan keluarga juga menunjukkan hasil yang baik dan relatif stabil. Hal ini menandakan bahwa petugas telah melaksanakan asuhan keperawatan sesuai prosedur serta mampu mempertahankan mutu pelayanan dalam proses perawatan pasien.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan **fluktuasi capaian** dan pada beberapa bulan masih berada **di bawah standar**, seperti indikator angka kejadian dekubitus, kelengkapan pengisian form transfer pasien, serta kelengkapan dokumentasi asesmen nyeri. Penurunan capaian pada indikator tersebut berpotensi disebabkan oleh **beban kerja perawat yang tinggi**, pergantian shift, serta **kurangnya konsistensi monitoring dokumentasi** di waktu sibuk. Selain itu, adanya variasi tingkat kedisiplinan antar petugas juga dapat memengaruhi konsistensi hasil. Secara keseluruhan, mutu pelayanan IRNA 2C sudah berada dalam kategori **baik**, namun untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan stabil, perlu dilakukan beberapa tindak lanjut berupa: penguatan supervisi dan audit dokumentasi secara berkala, pendampingan kepada perawat dalam penerapan prosedur klinis, optimalisasi briefing antar shift, serta peningkatan kesadaran petugas mengenai pentingnya konsistensi pelaksanaan SOP dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan capaian indikator mutu di IRNA 2C dapat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien.

3.7.20 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%	97,81%	96,22%	96,82%	96,98%	96,42%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%	97,8%	98,24%	98,60%	98,84%	97,4%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-			
7.	Kepatuhan 152last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	97,86%			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%	1,53%	-	100%	-	-			
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-			
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%			

21.	Kepatuhan penandaan 153lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, capaian indikator mutu di Unit IRNA 3C Anak menunjukkan **kinerja yang sangat baik dan konsisten**, dengan sebagian besar indikator mencapai **100%** setiap bulannya. Hal ini menandakan pelaksanaan standar pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan adanya komitmen yang kuat terhadap mutu pelayanan pasien. Beberapa indikator utama seperti **ketepatan waktu pemberian obat, kepatuhan pengisian rekam medis, pelaksanaan asuhan keperawatan (APD), dan penerapan Clinical Pathway** menunjukkan capaian **stabil di atas 97% hingga 100%** sepanjang tahun. Hasil ini menggambarkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan yang tinggi terhadap prosedur pelayanan. Indikator lain seperti **kelengkapan lembar asuhan, lembar persetujuan tindakan (informed consent), dan serah terima pasien (SBAR)** **juga menunjukkan capaian 100% secara konsisten**, menandakan koordinasi antarpetugas yang baik dan dokumentasi yang tertib.

3.7.21 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%	98,92%	97,44%	97,47%	99,92%	99,73%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%	99,71%	99,62%	99,80%	99,68%	99,46%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%	97,96%	99,4%	99,54%	95,65%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%	68,75%	90,71%	72,22%	85,20%	76,98%			
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

7.	Kepatuhan 154last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%	69,57%	96,43%	96,52%	84,78%	100%			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%	91,67%	97,73%	97,6%	97,8%	100%			
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%	100%	91,3%	100%	100%	94,74%			
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%	99,38%	100%			
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%	80,77%	100%	100%	97,57%	100%			
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%	56,25%	100%	100%	100%	100%			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%	100%	99,12%	99,72%	100%	100%			
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%			
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	0%	-	-	-	-	-			
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,01%	99,48%	100%	100%			
21.	Kepatuhan penandaan 154lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 5C menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.22 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,78%	100%	100%%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%	95,92%	99,72%	97,44%	99,72%	98,7%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%	98,88%	99,66%	99,62%	99,66%	98,9%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,65%	99,4%	94,65%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%	65,94%	75%	90,71%	80,60%	64,8%			
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	Kepatuhan 155last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,13%	84,15%	96,43%	97,82%	100%			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,9%	97,73%	97,9%	100%			
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	100%	100%	100%			

11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,3%	100%	100%			
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%			
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,47%	100%	100%	100%			
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,66%	100%	100%	100%	100%			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,12%	100%	100%			
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-			
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%	100%	100%			
21.	Kepatuhan penandaan 156lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 6A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.23 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%	98,27%	96,62%	98,92%	98,80%	99,22%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%	96,71%	97,66%	97,21%	97,60%	98,78%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%	88,42%	98,68%	97,92%	98,21%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%	69,44%	68,1%	52,88%	66,72%	70,21%			
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	Kepatuhan 157last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%	100%	100%	100%	100%	100%			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%	1,32%	-	0%	0%	0%			
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-			
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,67%			
21.	Kepatuhan penandaan 158lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 7A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Capaian indikator kelengkapan edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang mengalami penurunan di bulan Oktober, hal ini disebabkan karena tenaga Kesehatan terkadang kurang teliti atau disiplin dalam mengisi setiap item yang tersedia pada lembar edukasi pasien atau ringkasan pulang, seringkali

terburu-buru. Secara keseluruhan, untuk mencapai standar indikator mutu ini, diperlukan intervensi yang komprehensif mulai dari perbaikan sistem alur kerja, peningkatan disiplin dan kompetensi SDM, serta penguatan pengawasan dan penerapan sanksi.

3.7.24 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%	99,02%	97,2%	98,93%	98,70%	97,2%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%	98,34%	97,22%	97,22%	97,54%	97,4%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	99,01%	100%	97,93%	98,29%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%	66,67%	68,1%	52,90%	68,90%	85,5%			
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	Kepatuhan 159last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%	100%	100%	92,88%	100%	100%			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%			
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-			
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Kepatuhan penandaan 160lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 7A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.25 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%	99,51%	97,22%	98,24%	98,86%	97,68%			

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%	99,72%	98,2%	99,89%	99,84%	98,92%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%	94,32%	74,66%	70,21%	72,28%	100%			
6.	Kepatuhan 161last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,2%			
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,25%			
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%			
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-			
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,11%			
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,56%			
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	1,4%	-	-	-	-	-			
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-			

18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,21%			
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu di ruang ICU menunjukkan hasil yang **sangat baik** dengan sebagian besar indikator mencapai atau mendekati **100%** sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja dan penerapan standar pelayanan yang tinggi di unit ICU. **Rata-rata capaian mutu ruang ICU sangat tinggi (di atas 95%)**, menunjukkan pelayanan yang aman, efektif, dan sesuai standar. **Beberapa indikator teknis (pelabelan obat, hand hygiene tertentu)** masih perlu ditingkatkan melalui **penguatan supervisi, edukasi berulang, dan audit mutu internal**. Indikator yang belum berjalan perlu **diperjelas statusnya** agar tidak menurunkan nilai keseluruhan mutu unit.

3.7.26 HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%	98,22%	85,22%	99,52%	98,54%	98,2%			

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%	98,91%	99,2%	99,57%	99,8%	98,72%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%	97,3%	74,66%	70,22%	70,21%	100%			
6.	Kepatuhan 163last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,66%			
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-			
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-			
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %			
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di HCU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.27 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%	96,32%	95,62%	96,22%%	96,62%	96,4%			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%	97,44%	96,8%	96,92%	97,1%	96,2%			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%	98,72%	97,33%	96,23%	96,66%	96,62%	96,88%			

6.	Kepatuhan 165last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%	81,86%	78,6%	82,44%	85,4%%	85,19%			
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48		15	17	21	34	41	45			
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu di Instalasi Rawat Jalan (IRJA) pada periode **Januari – Oktober 2025** menunjukkan hasil yang **sangat baik dan stabil**. Mayoritas indikator mencapai nilai **≥95%**, yang menandakan bahwa pelayanan di IRJA telah berjalan sesuai standar mutu rumah sakit dan pedoman Kemenkes.

3.7.27 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%	43,75%	62,22%	64,43%	72,22%	63,25%			
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Kepatuhan 166last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Kejadian keterlambatan operasi 166lastic caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2	0	0	3	4	1			
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12	15	11	13	26	17			
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1	3	1	1	4	2			
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1			
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	17,2%	13,6%	7,52%			
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	16,5%	12%	7,52%			
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72	90	98	96	123	123			
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Secara keseluruhan, indikator mutu ruang maternitas menunjukkan kinerja yang baik dan stabil pada sebagian besar aspek pelayanan. Sebagian besar indikator berada pada angka capaian 100%, menandakan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan, terutama pada aspek identifikasi pasien, penggunaan Clinical Pathway, dan pelaksanaan informed consent.

Indikator dengan Capaian Konsisten Baik (100%)

Beberapa indikator menunjukkan capaian sempurna (100%) sepanjang periode:

- 1. Kepatuhan Identifikasi Pasien
- 2. Kepatuhan Tindakan Sesuai SPO
- 3. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
- 4. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan
- 5. Angka Kepatuhan Penggunaan APD
- 6. Kepatuhan Pelaksanaan Informed Consent
- 7. Kepatuhan Hand Hygiene & APD di Proses Persalinan

Hal ini mencerminkan bahwa budaya keselamatan pasien dan kepatuhan prosedur sudah berjalan baik di ruang maternitas.

3.7.28 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1	1	3	0	2	0			
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%	99,98%	99,8%	99,88%	100%	100%			
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%	99,84%	99,67%	99,86%	100%	98,3%			
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%	87,3%	76,2%	62,34%	100%	79,75%			
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%	98,86%	100%	95,54%	100%	100%			

10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,88%	98,88%	100%	100%	100%			
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	94,92%	96,8%	88,47%	89%	89%			
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,92%	100%	100%	100%	100%			
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%			
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (169lastic169)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Secara umum, pencapaian indikator mutu di NICU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

1.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%	98,74%	98,8%	98,92%	99,20%	99,15%			
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%	98,73%	98,78%	99,21%	99,46%	98,34%			
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di PICU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun

3.7.29 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%	0%			
4.	Kepatuhan 172last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan 172lasti operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0			

17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%	21,05%	42,31%	32,6%	100%	100%	100%			
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%	98,22%	100%	100%	100%	100%			
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IKO menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.30 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0			
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%			
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Laboratorium menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.31 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%	7,4%	6,22%	5,2%	4,8%	6,59%	6,69%			
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Radiologi menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

Terdapat satu indikator yang belum mencapai standart yaitu angka kelengkapan permintaan form radiologi yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan petugas dalam mengisi formular secara lengkap dan tepat waktu. Untuk mengatasi masalah ini, perbaikan perlu dilakukan secara komprehensif pada semua faktor penyebab tersebut, misalnya dengan merevisi SOP, memberikan pelatihan berkesinambungan, meningkatkan pengawasan.

3.7.32 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendaptkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,76%			
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	11			
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dam lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21&	99,42%	99,82%	98,92%	99,28%	99,40%	99,48%	98,46%			
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%	99,31%	999,42%	99,53%	99,60%	99,6%			

Berdasarkan data capaian indikator mutu pada unit Gizi periode **Januari hingga Oktober 2025**, secara umum dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan mutu pelayanan di unit Gizi berjalan dengan baik dan stabil**, dengan sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang sangat baik serta memenuhi standar yang ditetapkan. Indikator **kejadian keadaan membahayakan diri** menunjukkan adanya **sedikit peningkatan pada Oktober (11 kasus)** setelah beberapa bulan sebelumnya nihil. Hal ini menunjukkan perlunya **evaluasi terhadap faktor risiko atau kondisi pasien** yang mungkin berkontribusi terhadap timbulnya potensi bahaya, serta peningkatan pengawasan dan pelaporan insiden agar bisa segera dilakukan tindakan pencegahan.

Capaian kepatuhan identifikasi pasien menunjukkan hasil yang **sangat tinggi dan konsisten**, yaitu **100%** pada seluruh bulan, dengan sedikit penurunan pada bulan Oktober menjadi **98,67%**. Hal ini menunjukkan bahwa petugas secara umum **telah menerapkan prosedur identifikasi pasien dengan baik**, meskipun tetap diperlukan **monitoring berkala dan umpan balik langsung** untuk memastikan tidak terjadi kelalaian kecil di lapangan.

3.7.33 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1	0	4	4	4/6	7			
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%	55,10%	48,88%	47,72%	43,08%	19,25%			
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%	31,35%	24,03%	19,97%	15,70%	8,27%			
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	1			
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0			
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3			
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0	0	0	0	0	0			
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42	32	0	0	0	0			
15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%	89,92%	100%	87,72%	87,72%	86,11%			
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Farmasi menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Indikator mutu waktu tunggu obat tidak mencapai standar karena beberapa faktor seperti jam sibuk yang menyebabkan penumpukan resep, kendala administrasi seperti resep tidak lengkap atau data pasien yang tidak sesuai, masalah stok obat yang tidak cocok antara sistem dan stok fisik, serta proses penyiapan obat racikan yang lebih rumit dan memakan waktu. Keterbatasan sumber daya manusia atau petugas farmasi juga sangat mempengaruhi waktu tunggu.

3.7.34 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%	0,45%	0,26%	0,17%	0,18%	0%			
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Berdasarkan data capaian indikator mutu unit pengadaan farmasi dari bulan Januari hingga Oktober 2025, terdapat dua indikator utama yang dievaluasi, yaitu:

Ketepatan stok farmasi : Capaian ketepatan stok farmasi menunjukkan fluktuasi capaian dari bulan ke bulan. Pada awal tahun (Januari–Februari 2025), capaian masih **0%**, yang menunjukkan belum adanya pencapaian terhadap target indikator. Mulai Maret hingga Juli 2025, capaian mulai meningkat bertahap dari **0,24% hingga 0,28%**, dan kemudian sedikit menurun pada Agustus (0,17%) hingga mencapai **0% kembali pada Oktober 2025**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian stok farmasi belum berjalan optimal dan masih memerlukan perbaikan dalam hal perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, serta distribusi agar ketepatan stok dapat terjaga sepanjang tahun.

Angka ketersediaan kebutuhan obat berdasarkan stok : Indikator kedua menunjukkan hasil **yang konsisten dan optimal**, dengan capaian **100% dari Januari hingga Oktober 2025**. Artinya, seluruh kebutuhan obat yang direncanakan dapat tersedia sesuai kebutuhan pelayanan tanpa terjadi kekosongan stok. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan pengendalian ketersediaan obat berjalan baik, serta koordinasi antara unit pengadaan dan unit pelayanan sudah efektif.

3.7.35 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%	0,49%	0,51%	0,25%			
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰			
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰			
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰			
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%	0,61%	0,73%	0,78%	0,42%	0,77%			
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,32%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%			
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%	93,74%	93,79%	94,3%	94,33%	95,1%			
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%	93,74%	93,77%	94,35%	94,35%	95,24%			
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			

3.7.36 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,56%	99,91%			
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%	18,12%	16,32%	14,22%	19,16%	19,16%	16,21%			
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%	99,98%	100%	100%	99,52%	99,52%	100%			
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pasien (PIPP) dari bulan Januari hingga Oktober 2025, secara umum terlihat bahwa kinerja unit menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian mendekati atau mencapai target pada sebagian besar indikator. **Angka Terupdate-nya Display TT dengan Mobile JKN** : Capaian indikator ini menunjukkan konsistensi **100% setiap bulan** dari Januari hingga Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembaruan data tempat tidur melalui sistem Mobile JKN berjalan optimal dan terpantau secara berkala. **Angka Terupdate-nya Data Operasional dengan Mobile JKN** : Sama halnya dengan indikator pertama, capaian indikator kedua juga **stabil di angka 100%** sepanjang tahun. Hal ini menggambarkan keandalan sistem dan kedisiplinan petugas dalam melakukan pembaruan data operasional secara real time. **Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dalam 24 jam** : Capaian indikator ini **konsisten di angka 100%** pada seluruh periode, menunjukkan respon cepat dan efektif dalam menangani setiap keluhan atau komplain yang masuk dari pasien maupun keluarga pasien **Angka Kepuasan Pasien BPJS** : Capaian indikator ini stabil dengan rata-rata di atas **99% setiap bulan**, menunjukkan bahwa pelayanan bagi pasien BPJS telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. **Angka Capaian Discharge Planning** : Capaian indikator discharge planning tercatat **100% secara konsisten** sepanjang periode pengamatan. Ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pulang pasien telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan memastikan kesinambungan pelayanan. Indikator Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan masih menunjukkan nilai yang relatif rendah dan perlu menjadi **prioritas perbaikan**. Diperlukan peningkatan motivasi dan kedisiplinan petugas untuk melakukan komunikasi pada pasien agar berkenan untuk mengisi kuisiонер.

3.7.37 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%	98,66%	99,03%	98,96%	98,54%	98,31%			
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%	2,03%	2,41%	2,23%	1,99%	2,19%			
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu SDM tahun 2025 menunjukkan kinerja **sangat baik**. Seluruh indikator administrasi dan tata kelola SDM mencapai **100%**, menandakan pelaksanaan fungsi manajerial SDM berjalan optimal. Namun demikian, indikator **kehadiran SDM berdasarkan finger print** masih menunjukkan sedikit fluktuasi pada awal tahun, sehingga perlu dilakukan **analisis penyebab ketidakhadiran** dan **strategi peningkatan kedisiplinan** secara berkelanjutan. Selain itu, upaya menjaga konsistensi pencapaian administrasi kepegawaian perlu terus dilakukan agar mutu pelayanan SDM tetap terjaga di seluruh unit.

3.7.38 Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%	50,36%	36,06%	80,93%	78,88%	93,95%	84,41%			
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%	0,23%	0,49%	0,27%	0,19%	0,28%			
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8%%	98,04%	1,57%	7%	6,67%	100%	100%	100%	100%			
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	10,23%	2,05%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%	10,47%	7,54%	7,6%	12%	5,39%			
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%	96,2%	95,94%	100%	100%	100%			

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu rekam medis menunjukkan **kinerja yang cukup baik** dengan beberapa indikator sudah mencapai target 100% secara konsisten, terutama terkait **pengelolaan data di SIMRS dan kelengkapan rekam medis IGD**. Namun, masih terdapat **tantangan signifikan** pada aspek **kelengkapan rekam medis pasien rawat jalan dan ketepatan penyelesaian DRM rawat inap**, yang perlu mendapat perhatian khusus melalui peningkatan supervisi, pelatihan, dan koordinasi antartugas rekam medis dan tenaga kesehatan.

3.7.39 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit K3RS menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

3.7.40 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%	1,19	1,12%	1,32%	1,24%	4,08%			
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%	1,31	1,42%	1,21%	1,32%	1,93%			
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%	98,8%	99,22%	99,425	99,82%	99,1%			
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			

Berdasarkan data capaian indikator mutu Asuransi Center periode **Januari sampai Oktober 2025**, secara umum pelaksanaan kegiatan mutu berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan sebagian besar indikator menunjukkan tren yang stabil dan mendekati target yang ditetapkan.

- Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim** : Selama periode Januari hingga Oktober 2025 tidak ditemukan kejadian dokumen rawat jalan yang tidak layak klaim (0 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan kelengkapan administrasi sudah berjalan baik, serta petugas telah memahami standar kelengkapan berkas klaim.
- Angka pending klaim BPJS** : Capaian indikator ini berfluktuasi setiap bulan dengan kisaran antara **1,46% – 4,08%**, dimana nilai tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2025. Meskipun masih relatif kecil, adanya peningkatan pada bulan Oktober menunjukkan perlunya evaluasi terkait keterlambatan atau kekurangan dokumen pendukung klaim. Penguatan koordinasi antara petugas asuransi, verifikator, dan unit pelayanan menjadi hal penting untuk menekan angka pending klaim.-

3. **Presentase readokasi pasien rawat inap** : Nilai capaian indikator ini relatif stabil antara **0,91% – 2,36%** selama periode pengamatan. Angka yang rendah menunjukkan proses administrasi pasien dan penyesuaian data jaminan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sedikit kasus yang memerlukan readokasi. Perlu dilakukan monitoring terhadap penyebab readokasi untuk mencegah pengulangan.
4. **Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS** : Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan nilai konsisten tinggi di atas **98% hingga 99%** setiap bulannya. Hal ini menandakan kedisiplinan dan ketelitian petugas dalam melengkapi berkas klaim sudah optimal, serta sistem penginputan di SIMRS berjalan efektif.
5. **Kejadian pasien tidak di-SEP** : Tidak ditemukan kejadian pasien yang tidak dibuatkan SEP selama periode Januari hingga Oktober 2025 (0 kasus). Ini menunjukkan kepatuhan petugas dalam melakukan registrasi dan pembuatan SEP sesuai ketentuan BPJS telah berjalan dengan sangat baik.

3.7.41 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%	78%	80%	95%	95%	50%			
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%	97%	95%	95%	95%	45%			

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu IPSRS dari bulan Januari hingga Oktober 2025, secara umum terlihat bahwa kinerja IPSRS menunjukkan **pola peningkatan yang cukup baik di awal hingga pertengahan tahun**, meskipun terdapat **penurunan signifikan pada bulan Oktober 2025**. **Angka ketepatan waktu penanganan perbaikan kerusakan oleh unit terkait ≤ 24 jam (Target: 100%)** Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan dari Januari (46%) hingga mencapai nilai tertinggi pada bulan September (95%). Namun, terjadi penurunan tajam pada bulan Oktober menjadi 50%. Secara umum, capaian rata-rata menunjukkan bahwa **pelaksanaan perbaikan kerusakan dalam waktu 24 jam sudah berjalan cukup baik pada sebagian besar bulan**, terutama pada pertengahan tahun. Penurunan di bulan Oktober kemungkinan disebabkan oleh **peningkatan volume pekerjaan, keterbatasan sumber daya, atau kendala teknis** yang menghambat kecepatan penanganan. **Angka ketepatan waktu respon dan penanganan kerusakan oleh unit terkait ≤ 24 jam (dalam kondisi darurat)** Indikator ini menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan capaian tertinggi mencapai 97% pada bulan Juni, namun juga mengalami penurunan pada bulan Oktober hingga 45%. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan

bahwa **respon terhadap kondisi darurat umumnya cepat dan tepat waktu** pada sebagian besar bulan, meskipun masih perlu ditingkatkan konsistensinya agar dapat mempertahankan capaian tinggi sepanjang tahun.

3.7.42 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4	2	2	3	2	1			
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4	3	7	3	7	3			

Berdasarkan data capaian indikator mutu Gudang Umum dari bulan Januari hingga Oktober 2025, secara keseluruhan menunjukkan bahwa kegiatan penerimaan dan distribusi barang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat **fluktuasi jumlah keterlambatan** pada beberapa bulan tertentu. **Keterlambatan barang datang di gudang (target: 0 keterlambatan)**, selama periode Januari hingga Oktober 2025, tercatat adanya keterlambatan barang dengan jumlah bervariasi antara 1 hingga 8 kejadian per bulan. Jumlah keterlambatan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Maret (masing-masing 8 dan 7 kejadian), sedangkan capaian terbaik terjadi pada bulan Oktober (1 kejadian). Secara umum, terdapat **tren penurunan keterlambatan sejak pertengahan tahun**, yang menunjukkan adanya **peningkatan koordinasi dengan pihak penyedia atau vendor** serta efisiensi dalam proses penerimaan barang. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan agar target “0 keterlambatan” dapat tercapai secara konsisten.

Keterlambatan pendistribusian barang oleh unit (target: 0 keterlambatan), ini juga menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan jumlah keterlambatan berkisar antara 2 hingga 10 kejadian per bulan. Keterlambatan tertinggi tercatat pada bulan Februari (10 kejadian), sedangkan capaian terbaik terjadi pada bulan April (2 kejadian). Meskipun masih terjadi keterlambatan pada beberapa bulan, data menunjukkan adanya **perbaikan dalam kecepatan pendistribusian barang**, terutama pada semester kedua tahun berjalan. Hal ini dapat mencerminkan adanya **perbaikan dalam manajemen stok, jadwal pengiriman, serta koordinasi antarunit** di lingkungan rumah sakit.

3.7.43 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%	35,4%	28,88%	22,35%	20,44%	0%			
2.	Kejadian 186lastic186 Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0			
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%	97,88%	98,21%	98,40%	98,80%	97,92%			
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%	99,02%	99,37%	99,55%	99,58%	99,23%			

Berdasarkan analisa di atas dapat diketahui capaian indikator angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit masih belum stabil tetapi cenderung semakin membaik di bulan Juni hingga Oktober. Faktor yang membuat petugas patuh dalam menggunakan spillkit antara lain : Memberikan pelatihan dan edukasi yang efektif kepada pengguna tentang pentingnya penggunaan spill kit yang benar dan dampaknya terhadap keselamatan dan lingkungan. Serta Memastikan spill kit tersedia di lokasi-lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengguna.

3.7.44 KESEKRETARIATAN

No	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%	47,62%	26,19%	23,8%	28,57%	35,71%		
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%	9,09%	18,18%	34,5%	40%	12,5%		
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%	20%	13,51%	46,7%	20%	40%		

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu kesekretariatan RS sepanjang tahun 2025 menunjukkan **fluktuasi kinerja yang cukup tinggi** dengan kecenderungan penurunan pada pertengahan tahun (Mei–Juli) dan perbaikan kembali pada triwulan ketiga (Agustus–Oktober). Faktor yang mungkin memengaruhi antara lain:

- 1. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan rutin (rapat dan pelaporan).
- 2. Kendala koordinasi antarunit dan keterlambatan proses administrasi.
- 3. Periode beban kerja tinggi pada pertengahan tahun yang memengaruhi capaian indikator.

Untuk meningkatkan capaian, disarankan:

- 1. Membuat **jadwal tetap dan sistem pengingat otomatis** untuk kegiatan rutin seperti meeting dan pelaporan.
- 2. Meningkatkan **monitoring berkala** terhadap proses pemesanan barang agar waktu pemenuhan lebih cepat.
- 3. Mengadakan **evaluasi bulanan** untuk mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.

3.7.45 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%	2,5%	1,15%	1,22%	1,28%	2,11%			
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0			
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%	100%	100%	100%	100%	100%			

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu laundry di atas, dapat diketahui bahwa masih terjadi keterlambatan penyediaan linen di unit unit karena keterlambatan pengiriman karena petugas pengiriman hanya 1 orang tiap pengirimnya, tindak lanjut yang telah dilakukan Adalah mengirim terlebih dahulu unit unit yang stok unitnya tinggal sedikit sehingga tidak sampai kehabisan.

3.7.46 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0			
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0			
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Berdasarkan tabel capaian di atas, dapat diketahui bahwa masih ditemukan kejadian instrument hilang dan instrument kurang di ruang CSSD. Faktor yang menyebabkan masih terjadi instrumen hilang dan tidak lengkap di ruang CSSD antara lain: Kurangnya Sistem Pelacakan, kurangnya sistem pelacakan yang efektif membuat sulit untuk memantau lokasi instrumen. Selain itu Adalah kesalahan manusia, esalahan manusia seperti lupa mengembalikan instrumen, salah penempatan, atau tidak mencatat instrumen yang dipinjam dapat menyebabkan instrumen hilang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan pengelolaan instrumen dan mengurangi kehilangan instrument :

1. Implementasi Sistem Pelacakan: Implementasikan sistem pelacakan yang efektif untuk memantau lokasi dan status instrumen.
2. Pelatihan Staf: Berikan pelatihan yang komprehensif kepada staf CSSD tentang prosedur pengelolaan instrumen, termasuk pengumpulan, pembersihan, sterilisasi, dan penyimpanan.
3. Pengembangan Prosedur Operasional Standar (SOP): Kembangkan SOP yang jelas dan efektif untuk pengelolaan instrumen, termasuk prosedur pengumpulan, pembersihan, sterilisasi, dan penyimpanan.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Lakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan instrumen untuk mengidentifikasi area perbaikan.

3.7.47 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%	86,73%	89,32%	94,52%	99,32%	99,02%			
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%	88,21%	91,7%	91,88%	87,16%	88,91%			
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%	81,44%	75%	78%	74,3%	74,47%			
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%	70,22%	76,22%	100%	92,75%	100%	100%			

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0			
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit IT menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

1.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pencatatan pada buku register	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Kelengkapan APD pada ruang jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit kamar Jenazah menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

3.7.48 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%	82,75%	86,45%	84,75%	88,90%	97,9%			

Unit	Target	Oktober	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	IRNA 2C Meningkat
ICU\HCU	4x/Bulan	100%	ICU/HCU mencapai target
IRNA 3C	4x/Bulan	100%	IRNA 3C mengalami peningkatan
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	MATERNITAS mencapai target
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	PERINATOLOGI mencapai target
IRNA 5C	4x/Bulan	100%	IRNA 5C Meningkat
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	100%	IRNA 2A,3A,4A Meningkat
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	100%	IRNA 6A,7A,8A mencapai target
IGD	4x/Bulan	100%	IGD mengalami peningkatan
FARMASI	4x/Bulan	100%	FARMASI mengalami peningkatan
GIZI	4x/Bulan	75%	Gizi Mengalami penurunan
IRJA	4x/Bulan	100%	IRJA Bagus dipertahankan
Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Oktober Petugas PKRS tiap unit mengalami peningkatan tetapi TIM PROGNAS KBRS, HIV, STUNTING, TB belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal. Tidakan yang dilakukan Adalah menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan berikutnya.			

1.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%	100%	100%	100%	100%	100%			
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit driver menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

1.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, 191lastic rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14	21	13	18	19	16	21			
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0			
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8	9	7	4	5	7			
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu security dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang menunjukkan jumlah kejadian yang signifikan dan fluktuatif yaitu :

1. Kejadian ditemukannya merokok/puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit):
- a) Indikator ini menunjukkan tingkat kejadian yang paling tinggi di antara semua kategori, mencerminkan adanya tantangan serius dalam menegakkan kebijakan larangan merokok di lingkungan rumah sakit.

b) Jumlah kejadian bervariasi dari **6** di Januari hingga puncaknya di Mei (21 kejadian), dan tetap tinggi di bulan-bulan berikutnya (18-21 kejadian)

-
- c) Meskipun sedikit menurun di bulan-bulan tertentu, trennya menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan perlu ditingkatkan secara konsisten untuk mencapai lingkungan rumah sakit yang bebas asap rokok.

2. Kejadian potensial barang hilang:

- a) Jumlah kejadian ini juga cukup tinggi dan menunjukkan fluktuasi bulanan yang cukup besar (antara 4 hingga 13 kejadian).
- b) Puncaknya terjadi pada Maret (13 kejadian).
- c) Angka ini mencerminkan tingginya risiko atau potensi terjadinya kehilangan barang, yang mungkin memerlukan peningkatan pengawasan, edukasi kepada pengunjung/pasien, dan pengamanan aset di area-area rentan. Dua indikator lainnya menunjukkan hasil yang sangat baik, menandakan bahwa area ini terkendali dengan efektif :
 - 1) Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit :
 - a) Tercatat hanya dua kejadian sepanjang periode (Juni dan Juli).
 - b) Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi barang hilang (poin 3) cukup tinggi, kejadian kehilangan yang benar-benar terjadi dan dilaporkan sangat rendah, mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan kerugian dan penanganan insiden.
 - 2) Kejadian Kekerasan di lingkungan RS :
 - a) Tidak ada satu pun kejadian yang tercatat dari Januari hingga Oktober 2025 (0 di setiap bulan)
 - b) Ini adalah capaian mutu yang sangat baik dan menunjukkan bahwa lingkungan rumah sakit relatif aman dari insiden kekerasan.

1.6.2 Komite PPI

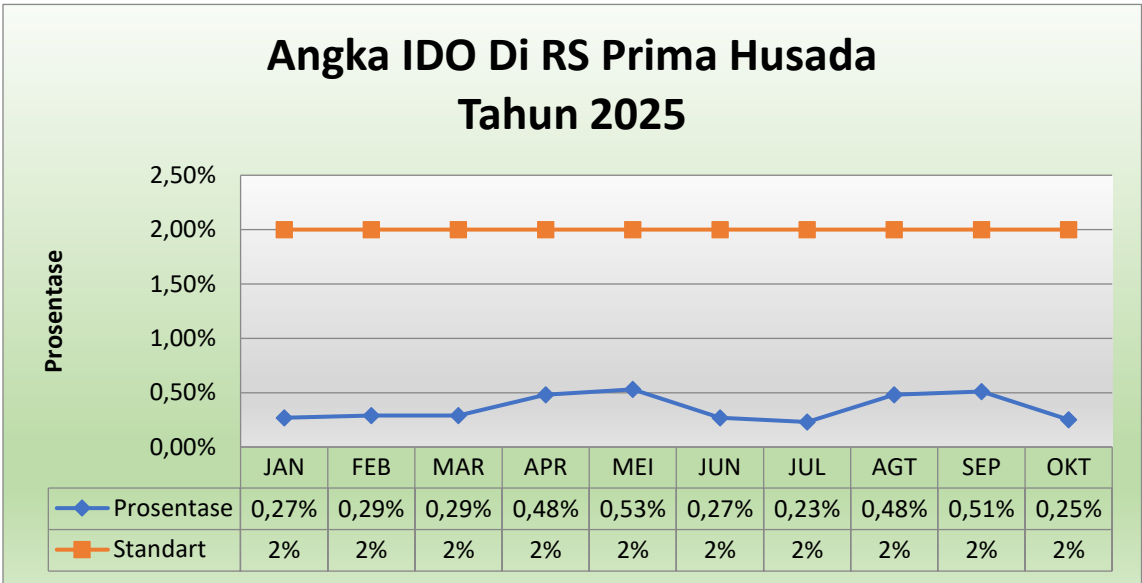
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI (Oktober 2025)		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	71	0%
Seksio Sesaria	1	68	2,53%
Apendiktomi	0	9	0%
Herniotomi	0	11	0%
Katarak	0	36	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	17	0%
Semua Operasi	1	396	0,51%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Berdasarkan grafik, angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) di RS Prima Husada masih memenuhi standar $\leq 2\%$. Meskipun masih di bawah batas standar nasional (2%), terdapat kenaikan tren pada bulan Agustus–September 2025 yang mencapai 0,51–0,59%, menandakan adanya potensi peningkatan risiko kejadian infeksi pasca operasi. Diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 1 orang pasien yang menjalani operasi SC. Secara umum, didapatkan hasil analisa ketidakpatuhan terhadap prosedur pencegahan infeksi dasar seperti mandi pre-op, teknik pencukuran, dan ketepatan kontrol luka. Karena tidak dilakukan mandi dan pencukuran manual menyebabkan peningkatan flora mikroba pada kulit. Selain itu, Faktor tambahan seperti overcrowding/turn over di ruang operasi (7 staf dalam 1 kamar, 12 operasi/hari) meningkatkan kontaminasi udara. Dari segi kendala dokumentasi, tidak adanya hasil kultur pus menghambat penentuan penyebab dan evaluasi antibiotik profilaksis. Manusia: - Banyaknya staf meningkatkan risiko kontaminasi udara dan droplet mikroba. - Kepatuhan hand hygiene & teknik aseptik belum terverifikasi. - Tidak dilakukan kultur menyebabkan terapi antibiotik empiris dan tidak tepat sasaran, infeksi tidak terkontrol. Material: - Secara umum alat dan bahan sudah sesuai standar, namun efektivitas antiseptik tergantung teknik dan waktu kontak. - Jika antiseptik tidak diberikan dengan durasi kontak cukup, bakteri masih bisa bertahan di kulit dan masuk ke luka operasi. Lingkungan: - Kondisi lingkungan memenuhi standar, tetapi mobilitas staf tinggi meningkatkan partikel udara pembawa mikroorganisme. - Risiko infeksi meningkat bila kontrol pergerakan dan kebersihan udara tidak optimal. Metode: - Tidak mandi & pencukuran manual menyebabkan peningkatan flora mikroba kulit dan luka mikro pada kulit → memudahkan kolonisasi bakteri. - Keterlambatan kontrol menyebabkan infeksi tidak segera diidentifikasi. - Turn over terlalu tinggi di ruang operasi. Obat: - Antibiotik profilaksis sudah diberikan. - Tanpa hasil kultur, antibiotik mungkin tidak sesuai dengan jenis bakteri penyebab infeksi. - Infeksi tidak tertangani optimal karena pengobatan empiris. Pasien: - Nutrisi tidak adekuat menurunkan daya tahan tubuh dan memperlambat penyembuhan luka. - Tidak mandi pre-op meningkatkan risiko kolonisasi flora kulit patogen. - Daya tahan tubuh rendah → mudah terinfeksi.
Masalah saat ini	1. Faktor Manusia (Risiko kontaminasi udara meningkat karena crowding; tidak adanya kultur membuat terapi antibiotik empiris, berpotensi tidak sesuai). 2. Faktor Pasien (Nutrisi tidak adekuat menyebabkan daya tahan tubuh rendah memperlambat penyembuhan luka.). 3. Faktor Lingkungan (Jumlah staf yang memang terlalu banyak di dalam OK dan turn over OK yang terlalu cepat sehingga desinfeksi ruangan tidak maksimal). 4. Faktor metode (Peningkatan flora kulit akibat tidak mandi; pencukuran dengan silet menimbulkan luka mikro; kontrol terlambat menyebabkan infeksi teridentifikasi lambat; beban operasi tinggi menurunkan kualitas sterilisasi ruang). 5. Faktor material (Sudah sesuai standar, namun efektivitas antiseptik tergantung durasi kontak dan teknik aplikasi.).
Permasalahan sebelumnya	1. Faktor Manusia (kepatuhan prosedur aseptik kurang optimal, monitoring pasca operasi kurang optimal). 2. Faktor Pasien (imunitas menurun/Hb rendah, kurangnya asupan protein). 3. Faktor Lingkungan (Jumlah staf yang memang terlalu banyak di dalam OK dan turn over OK yang terlalu cepat sehingga desinfeksi ruangan tidak maksimal). 4. Faktor metode (resiko kontaminasi meningkat akibat cukur manual, tidak ada evaluasi AB berdasarkan kultur). 5. Faktor material (kemungkinan sterilisasi tidak optimal karena hanya ada 1 indikator saja).
Tindakan yang dilakukan	1. Monitoring prosedur klinis dengan baik (monitoring perawatan luka pasien post operasi, kontrol proses pencukuran dan perawatan/desinfeksi alat cukur dan penggunaan pisau cukur disposable).

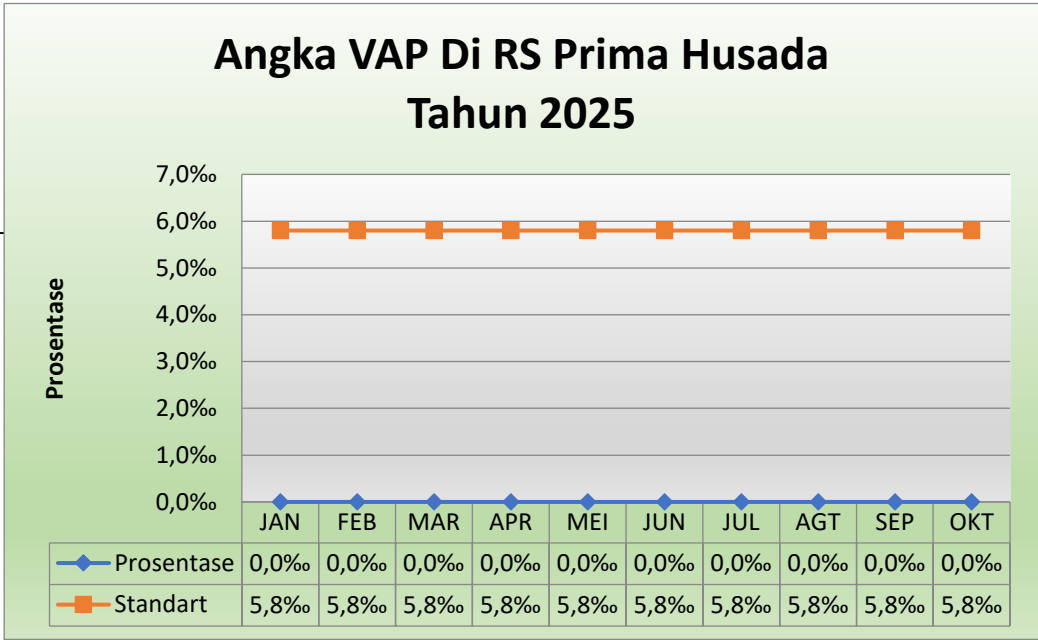
	2. Melakukan edukasi ulang perawat tentang deteksi dini tanda infeksi luka, terutama pasien di poli saat kontrol pertama. 3. Melakukan monitoring kepatuhan aseptik di ruang-ruang perawatan. 4. Mengkonfirmasi pada Karu kamar operasi untuk membantu menjadwalkan operasi dengan jeda minimal 1 jam dari operasi sebelumnya untuk proses desinfeksi ruangan kamar operasi. Termasuk untuk mengurangi padatan jumlah petugas didalam kamar operasi, untuk tim anastesi setelah dilakukan anastesi bisa keluar dari kamar operasi sementara 5. Melakukan koordinasi dengan ahli gizi untuk edukasi terkait kebutuhan nutrisi pasien pasca operasi, terutama pasien dengan operasi saluran cerna.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 2. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) 3. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. 4. Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien pasca operasi	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feed back) 3. Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. 4. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 5. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	20	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.7.49 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 207 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

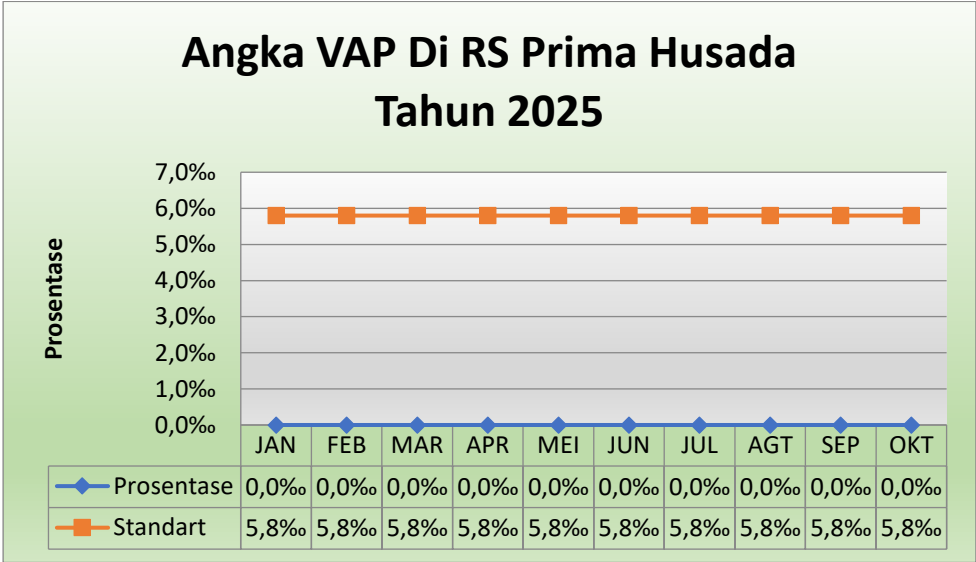
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
--	---	--	--	--	------------

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	206	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	1	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



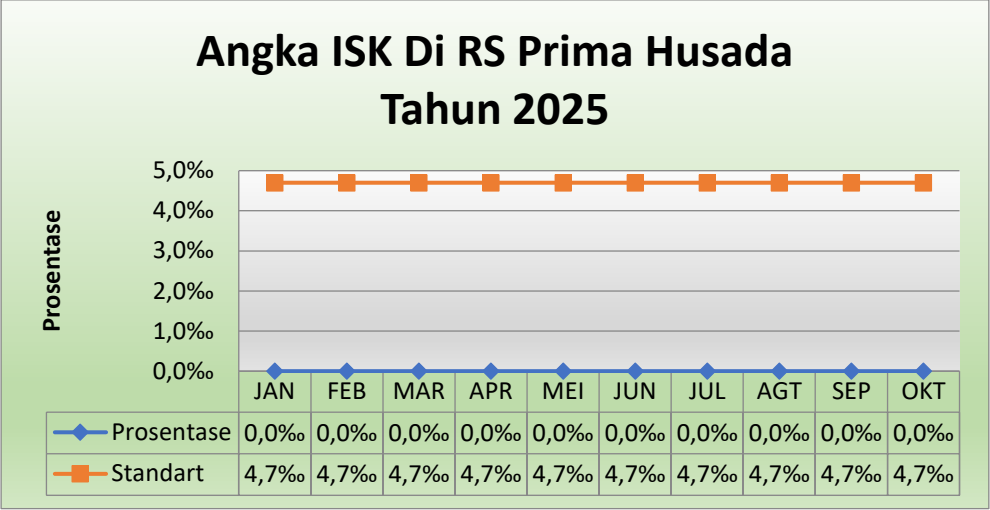
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 106 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan 198lasti / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
((Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	244	0‰
HCU	0	25	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	7	0‰

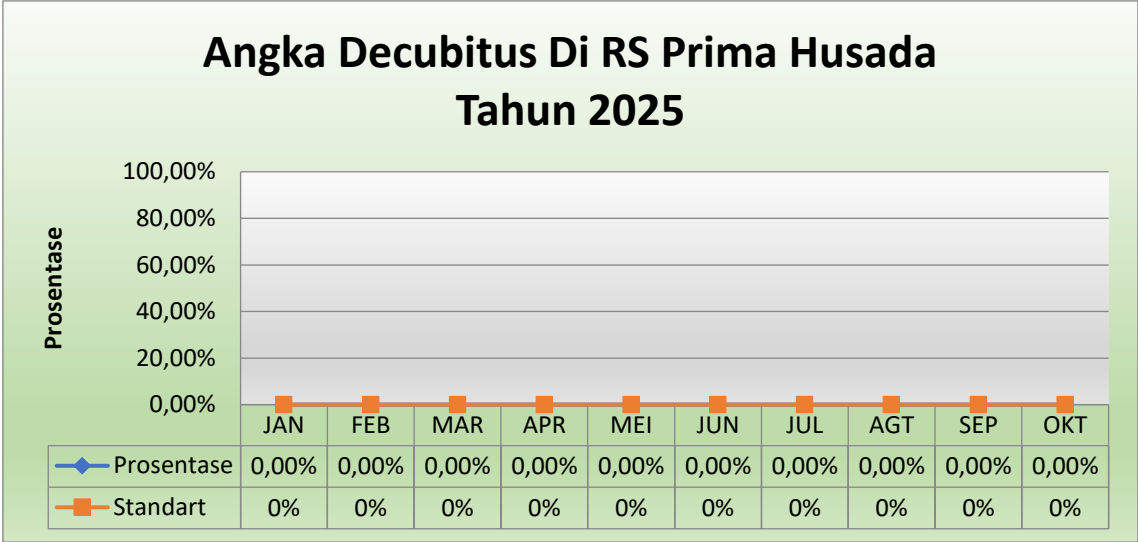
3.7.50 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1151 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

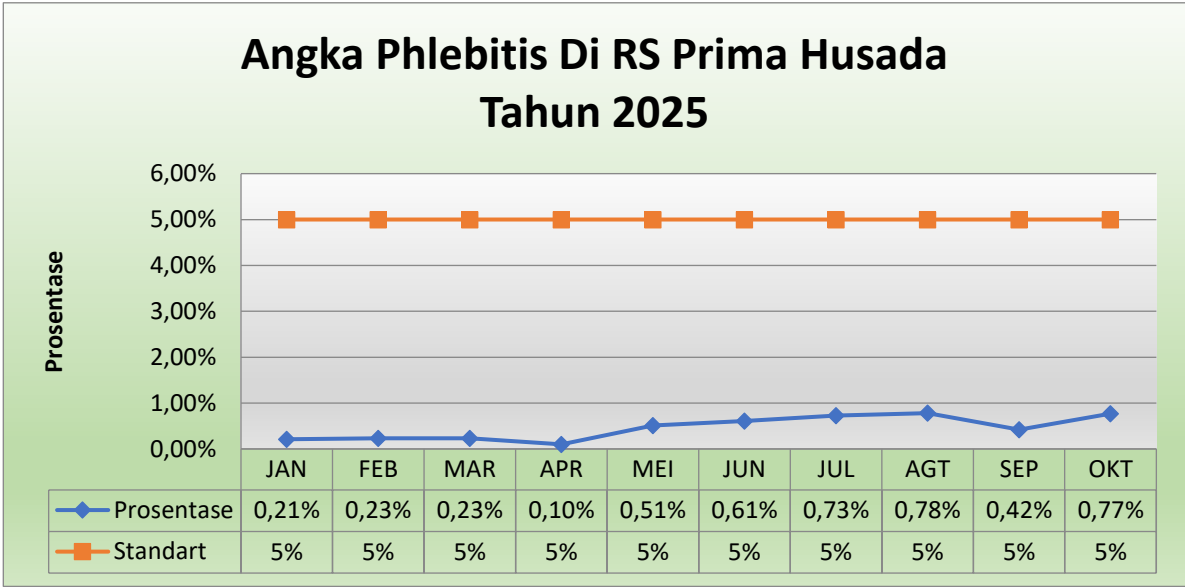
1.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 25 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan 200lastic200e.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan 200 last anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.51 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

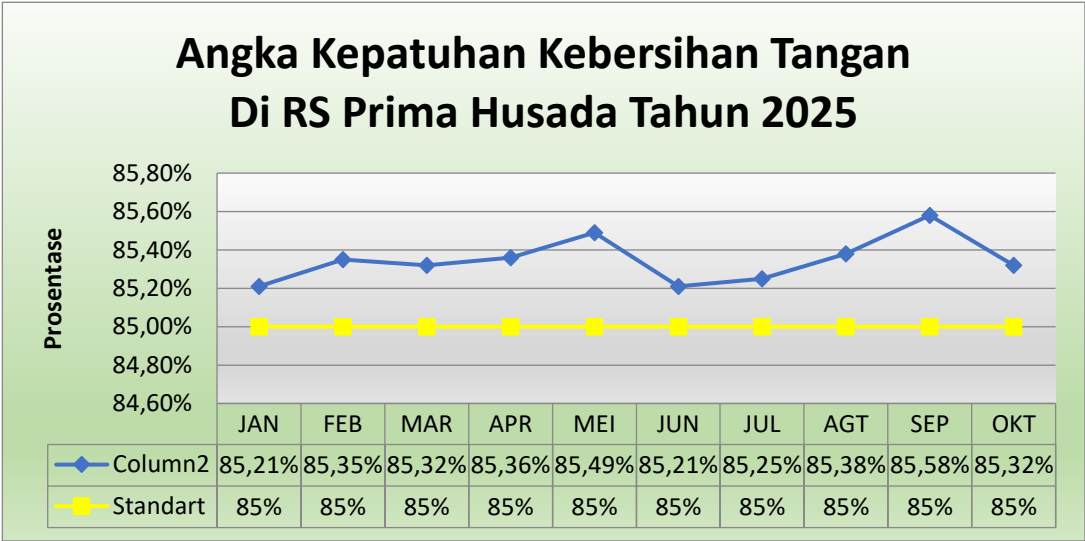


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2731 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,77%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh terdapat 21 pasien yang mengalami phlebitis, 10 diantaranya merupakan pasien berusia >50 tahun, 3 pasien anak-anak dan sisanya pasien dewasa, dimana 62% masuk pada faktor usia beresiko phlebitis. 1 diantara 21 pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat seperti KCL, 1 orang transfusi darah, dan 1 orang mendapat 2 antibiotik meropenem dan levofloxacin. Pasien lainnya tidak mendapatkan cairan pekat hanya mendapat 1 antibiotik dan injeksi pekat seperti metamizole. Dari 15 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. 2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini. 3. Faktor pemilihan lokasi pemasangan infus dan pemilihan pemakaian plester transparan perlu diperhatikan.				
Permasalahan sebelumnya	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga infus pekat dan antibiotik dobel.. 2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini. 3. Faktor pemilihan lokasi pemasangan infus dan pemilihan pemakaian plester transparan perlu diperhatikan.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengkoordinasikan dengan kbid dan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. 2. Mengajukan pada perawat pemasangan infus benar-benar harus menentukan posisi vena yang tepat dan memberikan edukasi setelah melakukan pemasangan infus terutama pada pasien beresiko tinggi. 3. Mengajukan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. 4. Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. 5. Mengajukan perawat untuk menggunakan plester transparan supaya area luka infus dapat lebih mudah dikontrol.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

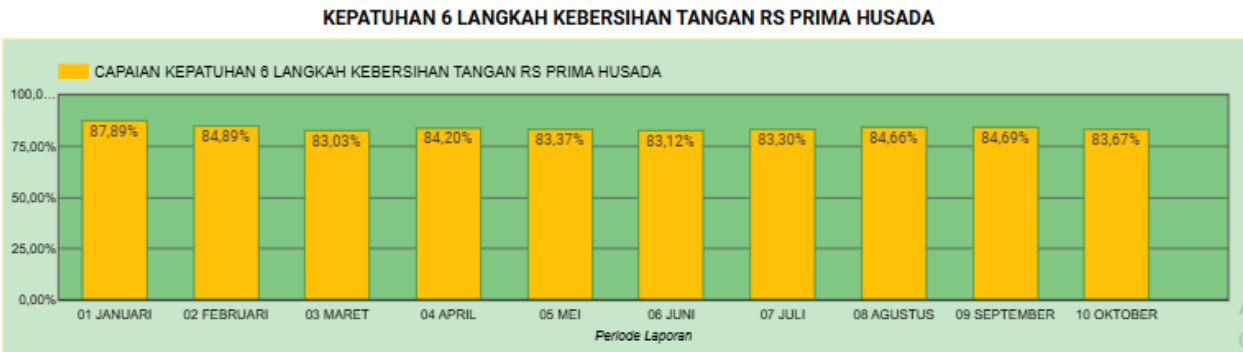
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------------	---	-----------------------------	--	--	------------

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

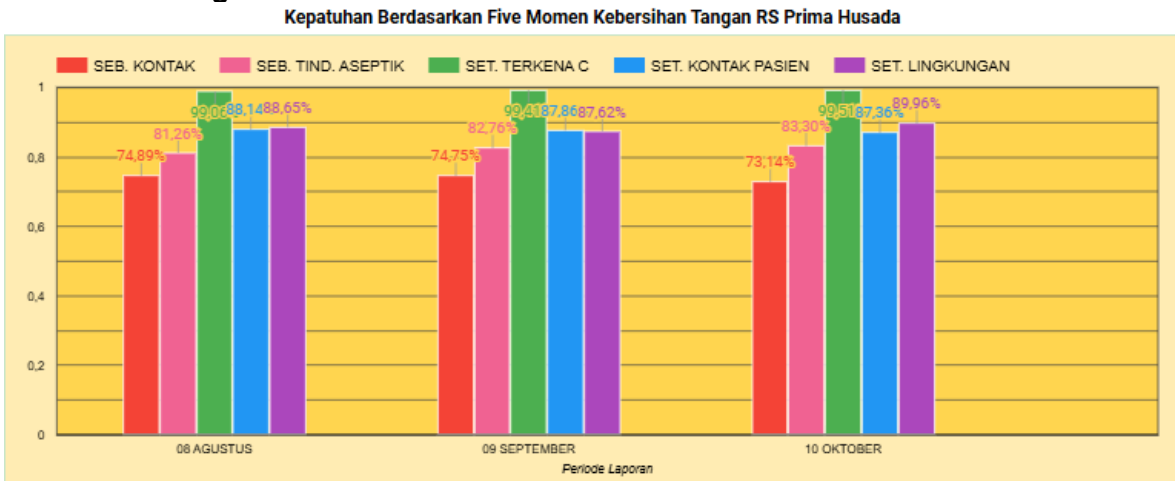
3.7.52 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

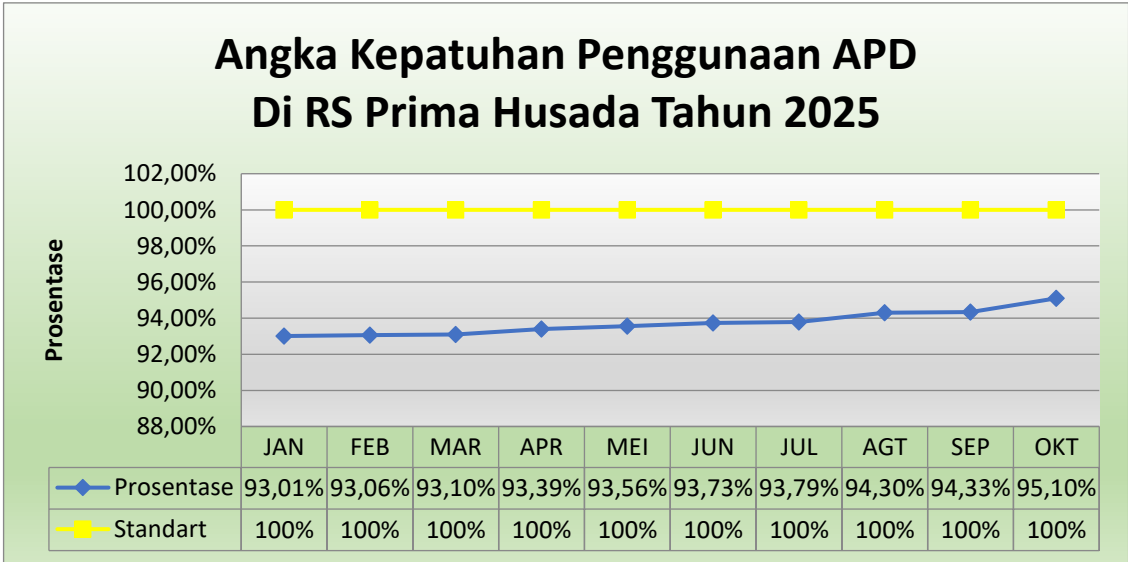


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Oktober 2025 berada sedikit di atas standar (selisih +0,32%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi penurunan dibanding bulan September (85,59%), yang berarti ada sedikit penurunan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan tidak terus menurun menjelang akhir tahun. Nilai kepatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan pada bulan Oktober: 83,67%. Nilai ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya (September: 84,69%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Penurunan ini bisa mencerminkan kelelahan tenaga kerja, kurangnya audit 6 langkah, atau menurunnya perhatian terhadap teknik yang benar, bukan hanya frekuensi mencuci tangan. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan Oktober sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien dan sebelum tindakan aseptik melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Permasalahan sebelumnya	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dibiasakan dalam melakukan tindakan sehari-hari.				
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. - Memberikan contoh cara cuci tangan yang benar saat mengisi diklat KE. - Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. 6. Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

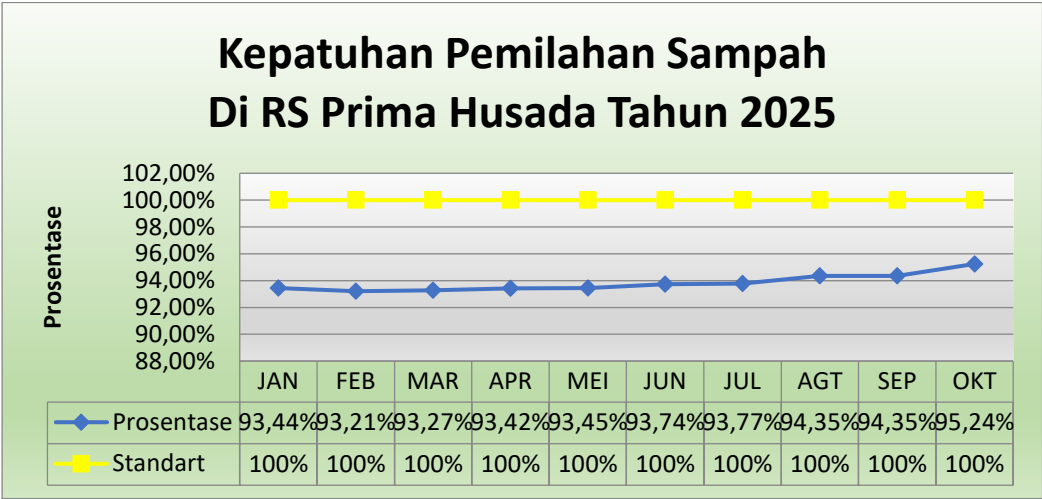
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Nilai kepatuhan penggunaan APD pada bulan ini sebesar 95,10%, mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam penggunaan APD, seperti: Pemakaian sarung tangan berlebihan pada situasi/tindakan yang tidak memerlukan atau tidak ada indikasi pemakaian APD khususnya sarung tangan dan skort. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada kelalaian tidak memakai APD, melainkan ketidaktepatan jenis dan cara penggunaan APD, yang juga berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidaknyamanan kerja, dan hal tersebut juga termasuk dalam ketidakpatuhan pemakaian APD. Peningkatan kepatuhan yang terjadi dibandingkan bulan sebelumnya menandakan bahwa pengawasan
---------	--

	dan pembinaan efektif, namun masih perlu penekanan pada aspek rasionalitas dan efisiensi penggunaan APD. Ketidaktepatan dalam penggunaan APD dapat berdampak pada potensi kontaminasi silang jika APD digunakan secara berlebihan tanpa prosedur yang tepat.				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. 5. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. 2. Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. 3. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 5. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 6. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 7. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

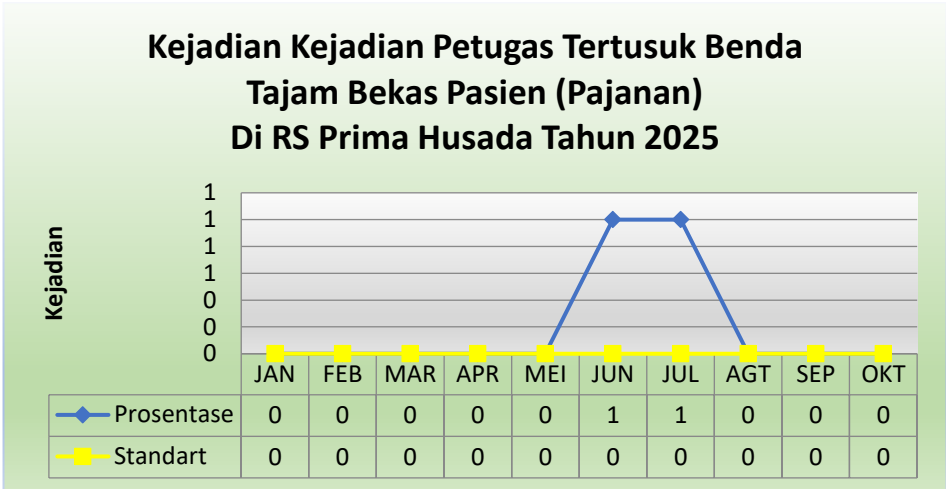
3.6.1.1.9
Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius
3.6.1.1.9.1
Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 95,24%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan dengan permasalahan utama yang sulit dihindari yaitu terkait pembuangan sampah bungkus spuit dan alcohol swab yang sering sekali dimasukkan ke sampah infeksius.				
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius (terutama bungkus alkes).				
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah 2. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 5. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Peletakkan tempat sampah baik infeksius dan non infeksius harus ditata dengan benar. 2. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 3. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 4. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



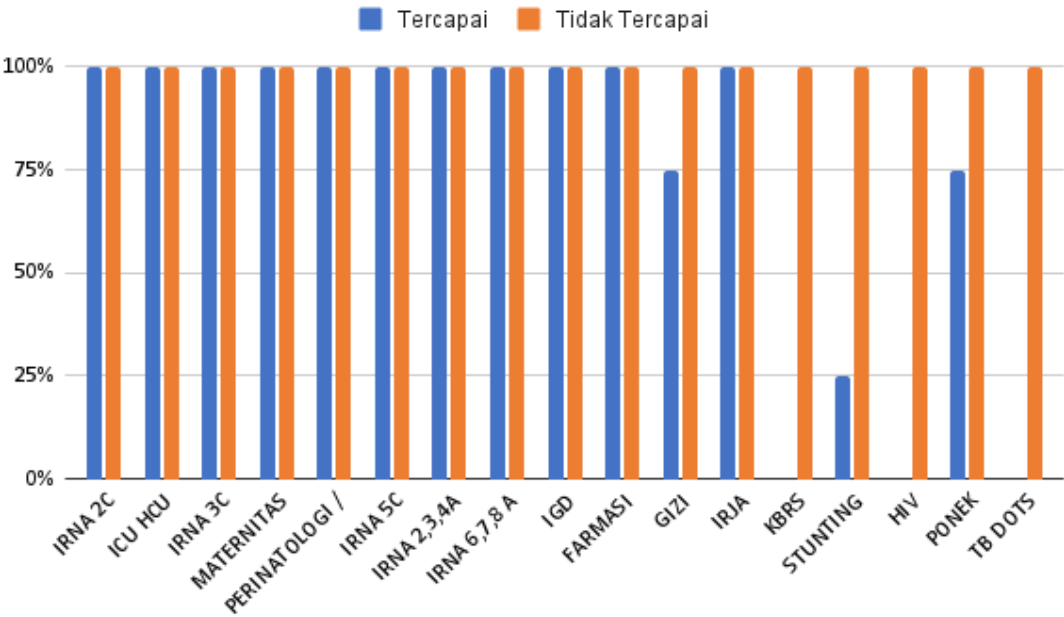
Analisa	Tidak ditemukan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. 2. Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. 3. Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. 4. Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. 5. Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Agt	September	Oktober	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	50%	50%	100%	Tercapai	Meningkat	Lampiran B
ICU\HCU	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tidak Tercapai	Tercapai	Lampiran B
IRNA 3C	4x/Bulan	0%	100%	100%	Tidak Tercapai	Meningkat	Lampiran B
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Tercapai	Lampiran B
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Tercapai	Lampiran B
IRNA 5C	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tidak Tercapai	Meningkat	Lampiran B
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	50%	0%	100%	Meningkat	Meningkat	Lampiran B
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	100%	100%	100%	Meningkat	Tercapai	Lampiran B
IGD	4x/Bulan	0%	100%	100%	Tidak Tercapai	Meningkat	Lampiran B
FARMASI	4x/Bulan	50%	75%	100%	Meningkat	Meningkat	Lampiran B
GIZI	4x/Bulan	100%	75%	75%	Menurun	Menurun	Lampiran B
IRJA	4x/Bulan	100%	75%	100%	Menurun	Tercapai	Lampiran B

Grafik Edukasi Kelompok Unit



- ANALISIS

: Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Oktober Petugas PKRS tiap unit mengalami peningkatan tetapi TIM PROGNAS KBRS, HIV, STUNTING, TB belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal.
- RTL

: Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.1 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	AGT	SEPTEMBER	OKTOBER	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						

		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.2 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

UNIT	TARGET	AGT	SEPTEMBER	OKTOBER	%	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI ATAU KOLABORASI	KET
PONEK	4X/Bulan	25%	100%	75%	Tidak Tercapai	√	terlaksana
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	25%	0%	25%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	25%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan Oktober PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

3.6.4 Tim Prognas

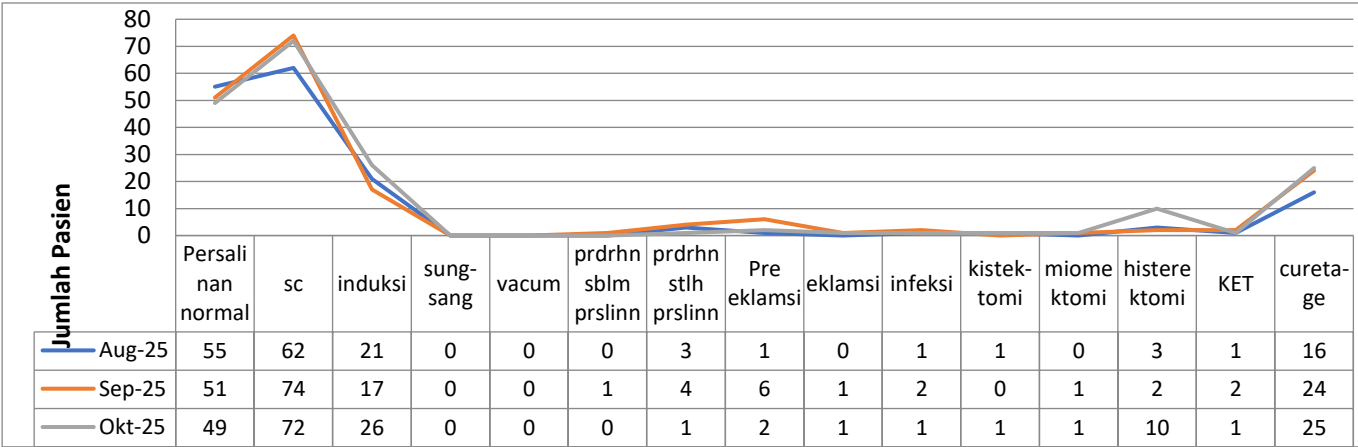
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Oktober 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	55	51	49
	b. SectioCaesaria	62	74	72
2				
	a. Induksi / Drip	21	17	26

	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	1	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	4	1
	c. Pre Eklamsi	1	6	2
	d. Eklamsi	0	1	1
	e. Infeksi	1	2	1
4				
	a. Curretage	16	24	25
	b. Kistektomi	1	0	1
	c. Miomektomi	0	1	1
	d. Histerectomy	3	2	10
	e. KET	1	2	1

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan September 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Oktober 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 72 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Oktober 2025 juga sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 49 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan Oktober sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah pasien INC di maternitas juga sedikit menurun pada bulan Oktober 2025.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Oktober 2025 dan 2 bulan sebelumnya. Dan juga tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Oktober 2025 dan 2 bulan sebelumnya.

4. Induksi Persalinan pada bulan Oktober mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 26 pasien
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien. Dan ada 1 kejadian eklamsi pada bulan Oktober 2025.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan Oktober 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 25 pasien. *Curretage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya

Rencana dan Tindak Lanjut :

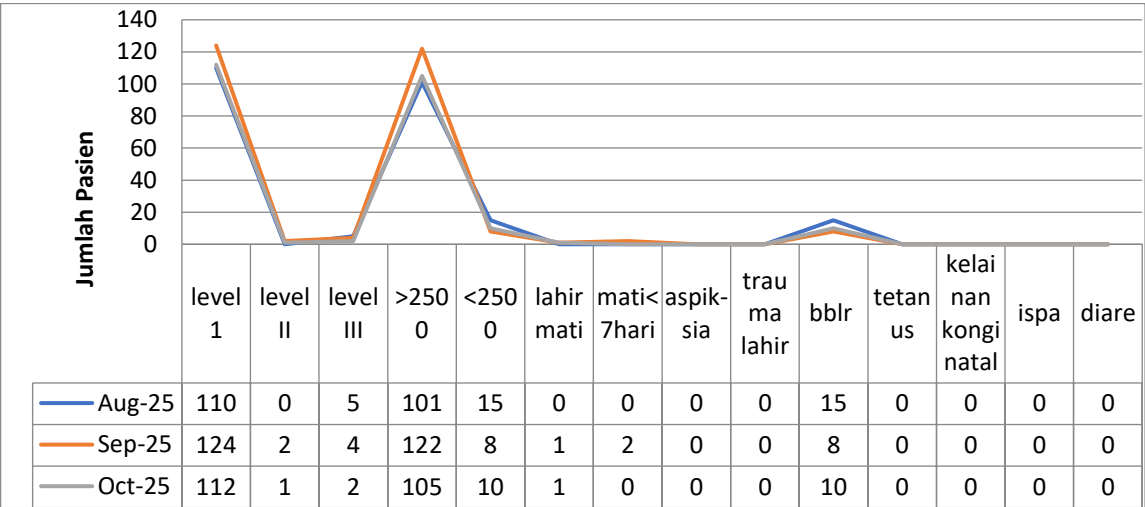
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Oktober 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1				
	a. Level 1	110	124	112
	b. Level II	0	2	1
	c. Level III	5	4	2
2				
	a. ≥ 2500 gram	101	122	105
	b. ≤ 2500 gram	15	8	10
3				
	a. Kelahiran Mati	0	1	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	1	0
4				
	a. Asphyxia	0	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	15	8	10
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Oktober 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 112 bayi. Dan untuk pelayanan level 2 pada bulan September sebanyak 1 bayi, sedangkan pada level 3 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Jumlah bayi bulan Oktober 2025 menurun seiring dengan jumlah persalinan pada bulan Oktober 2025
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 105 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Oktober 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Oktober 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi.
5. Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan September dan Oktober 2025, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada kasus.
6. Tidak ada 2 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September ada 2 kasus, dan Agustus tidak ada kasus.

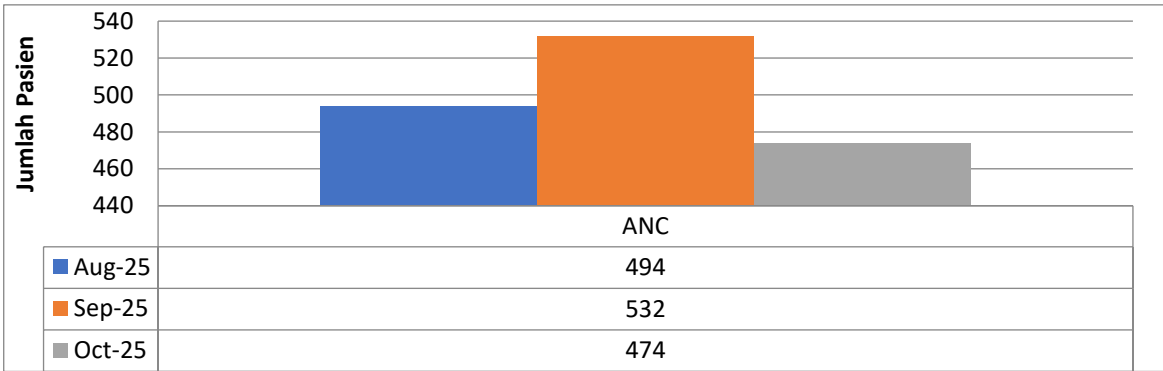
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.53 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek Oktober 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	ANC	494	532	474

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Oktober 2025



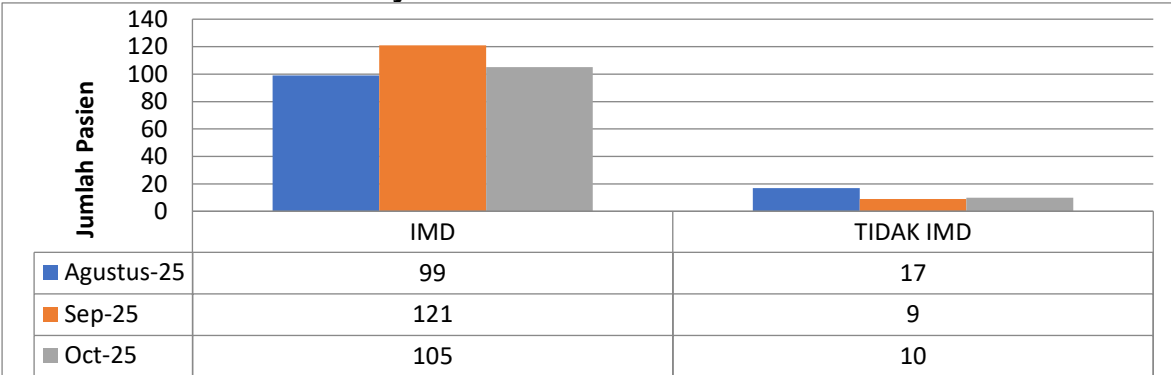
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Oktober 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 474 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.7.54 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Oktober 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	IMD	99	121	105
2	Tidak IMD	17	9	10

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 105 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi, Sedangkan pada bulan September sebanyak 9 bayi, dan Agustus sebanyak 17 bayi.
- 3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Oktober 2025

NO	NAMA BAYI	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Dwi Rahmasari	NCB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Rifka	NCB + BBLR	Cuvis
3	By Ny Salsa	NCB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Ulfi Nur	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Maulidiah	NCB + BBLR	Cuvis
6	By Ny Nurdiana	NKB + BBLR	Cuvis
7	By Ny Anis	NCB + BBLR	Cuvis
8	By Ny Sri Puji	NKB + BBLR	Cuvis
9	By Ny Siti Nabila	NKB + BBLR	CPEP + Inkubator
10	By Ny Juariyah	RDS, BBLR,IUGR	CPEP + Inkubator

Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

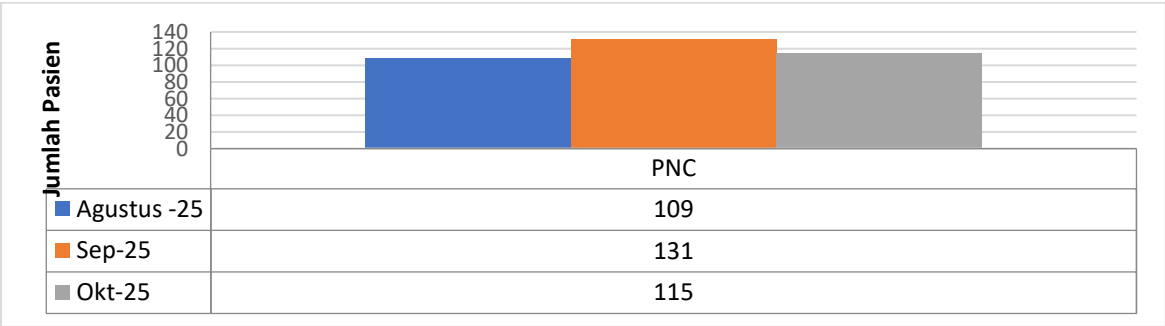
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

3.7.55 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponек Oktober 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	PNC	109	131	115

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan Oktober 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 115 kunjungan..

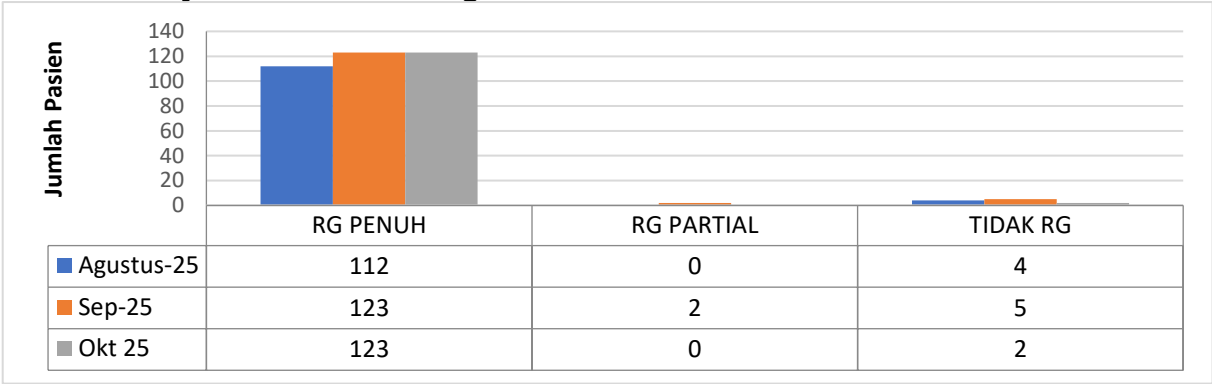
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponек Oktober 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	Rawat gabung penuh	112	123	123
2	Rawat gabung partial	0	2	0
3	Tidak Rawat gabung	4	5	2

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Analisis :

- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan September dan Oktober 2025 sama yaitu sebanyak 123 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Oktober 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi.
- Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Juariyah	NKB + BBLR	CPEP + Inkubator
2	Ny Ny Siti Nabila	NKB + BBLR	CPEP + Inkubator

Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

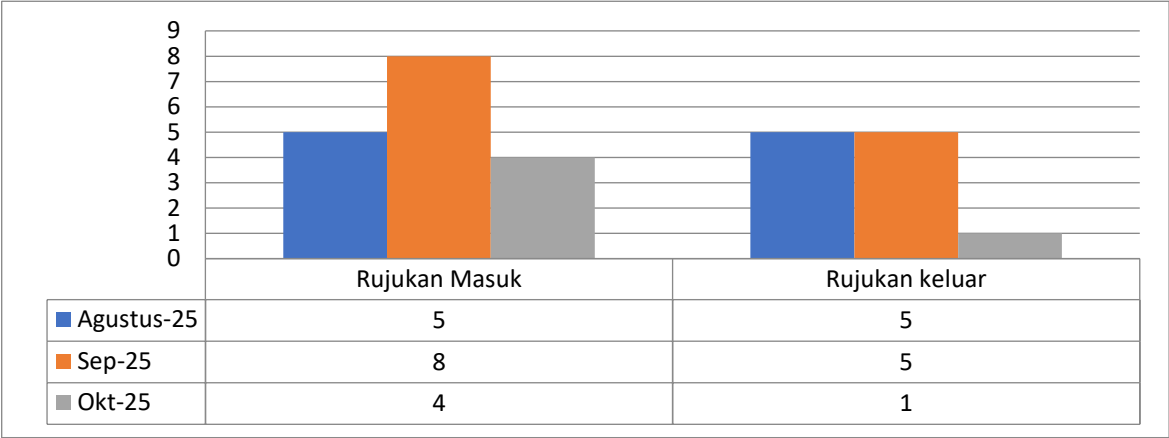
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Oktober 2025

NO	RUJUKAN	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	Rujukan Masuk	5	8	4
2	Rujukan keluar	5	5	1

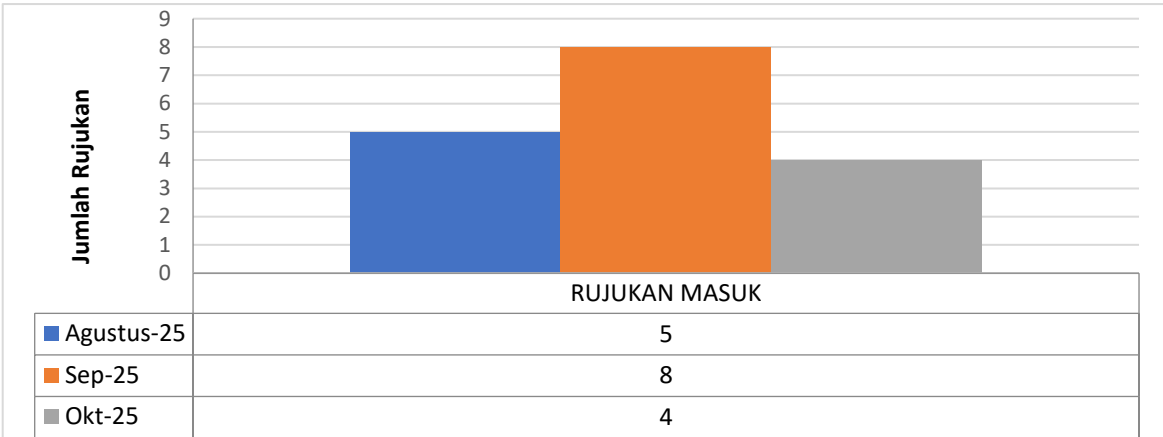
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Oktober 2025

BULAN AGUSTUS 2025			
1	By Ny Nur Fitri	RDS	PMB Tri W
2	Ny. Illa Rodhiyah	G4 P1103 AB100 UK 10-12 Mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Siska A	G1 P0000 AB 0 UK 32-34 MGG dg kala 2	PKM Singosari
4	Ny Siti Nur H	G1P000 AB00 UK 39-40 Mgg dg kala 2	PKM Lawang
5	Ny Widya A	G1 P0000 AB000 UK 32-34 Mgg dg PPR0M	Klinik Mutiara Sehat
BULAN SEPTEMBER 2025			
1	By Ny Sri bawon 1	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
2	By Ny Sri bawon 2	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
3	By By Erwin	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	PKM Singosari
4	By Rayyan Maulana	PNEUMONIA, NEC, BBLSR	RS Sahabat
5	Ny Erwin	P2103 Ab000 dengan post partum + HPP ec sisa plasenta	PKM Singosari
6	Ny Meila	G3 P0010 Ab100 UK 36-37 mgg dg HT+ DM+BOH	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Nur Halimatus	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg KPD	PMB Titik Sunaryati
8	Ny Cholis Ambiyah	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 mgg dengan PEB +KPD	PKM Singosari
BULAN OKTOBER 2025			
1	Ny Riska Rismawati	G2 P1001 Ab000 UK 32-34 minggu dengan hemoroid	RS Graha Medika
2	Ny mAuludiya	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan kala 2 lama	PMB Indah M
3	Ny Rosa Dwi	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Tuminah	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 minggu dengan prolong KIFA +HT+KPD	RKM Ardumulyo

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



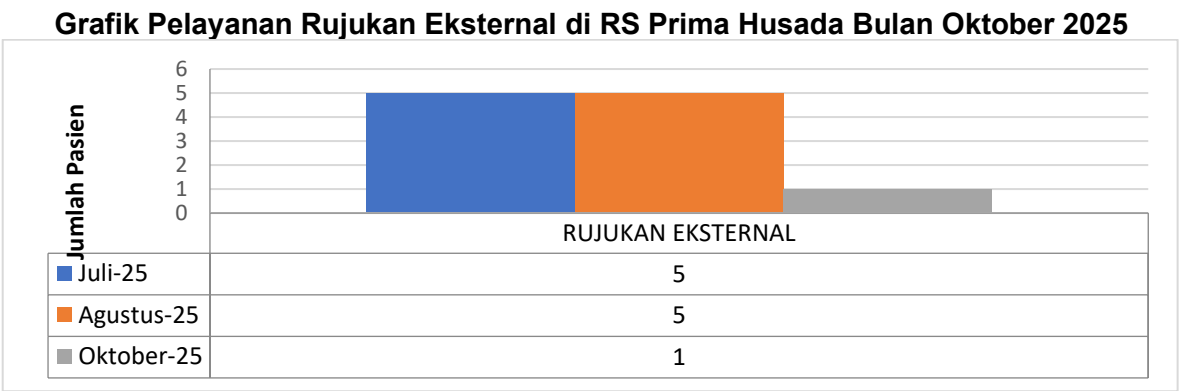
Analisis :
Jumlah rujukan masuk pada Oktober menurun yaitu 4 rujukan, sedangkan pada bulan September sebanyak 8, dan Agustus sebanyak 5 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut
Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponpek Oktober 2025

NO	NAMA	USIA	UNIT	DIAGNOSA	ALASAN RUJUKAN	TUJUAN RUJUKAN
Bulan Agustus 2025						
1	Riyanti	41 Th	Maternitas	P2103 Ab000 dg Post SC+MOW hari ke 2 a/l Impending eklamsi + anuria	Pro Hemodialisa	RS Saiful Anwar
2	Nn Nafisa	17 Th	Irna 5C	Susp Internal bleeding ec KET + trombositopenia + anemia	Pro Laparatomy cito dg backup transfusi TC	RS Saiful Anwar
3	By Ny Wikke	1 hr	NICU	NKB + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Nur Aini	2 hr	NICU	NCB + Pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Nur Fitri	3 hr	NICU	RDS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan September 2025						
1	By Ny Apsah	3 hr	NICU	Bronchopneumonia + Hipoglikemia refrakter	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
2	By Ny Lia	3 hari	NICU	NP-Spt + BBLASR + obs. dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
3	By Ny Erwin	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Soepraoen
4	By Ny Sri bawon 2	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	Ny Lilis	38 th	PONEK	G2 P0000 AB100	Penanganan	RS Saiful

				UK 30-32 mgg dengan Eklamsi + HT emergency + nprimi tua sprimer + riwayat infertile +HSVB	lebih lanjut	Anwar
Bulan Oktober 2025						
1	Nilam larasati	28 th	PONEK	G2 p1001 ab0 uk 26-28 minggu dg pprom, hiperbilirubin	Penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar



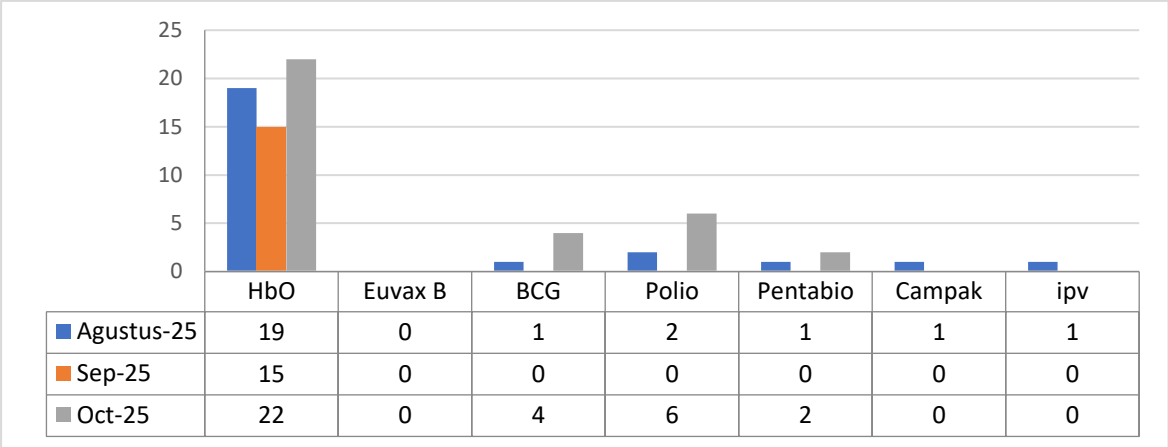
Analisis :
 Jumlah rujukan keluar pada bulan Oktober menurun yaitu 1 rujukan, sedangkan pada bulan September dan Agustus sebanyak 5 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Oktober 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	HbO	19	15	22
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	0	4
3	Polio	2	0	6
4	Pentabio	1	0	2
5	Campak	1	0	0
6	IPV	1	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Oktober 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Oktober sebanyak 22 bayi, sedangkan pada bulan September Sebanyak 15 bayi, dan Agustus sebanyak 19 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Oktober dan September, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi.
4. Ada 4 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September tidak ada, dan Agustus sebanyak 1 bayi.
5. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak pda bulan Oktober dan September, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi.
6. Ada 6 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Oktober, sedangkan bulan September dan agustus tidak ada
7. Ada 2 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September tidak ada, dan pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

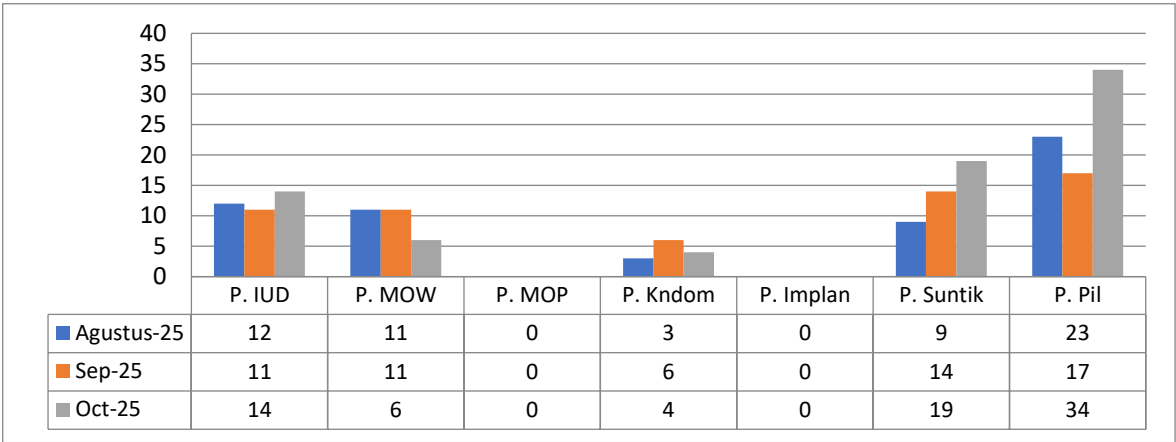
1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Oktober 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	IUD	12	11	14
2	MOW	11	11	6
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	3	6	4
5	Implant	0	0	0

6	Suntikan	9	14	19
7	Pil	23	17	34

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Aanalisis :

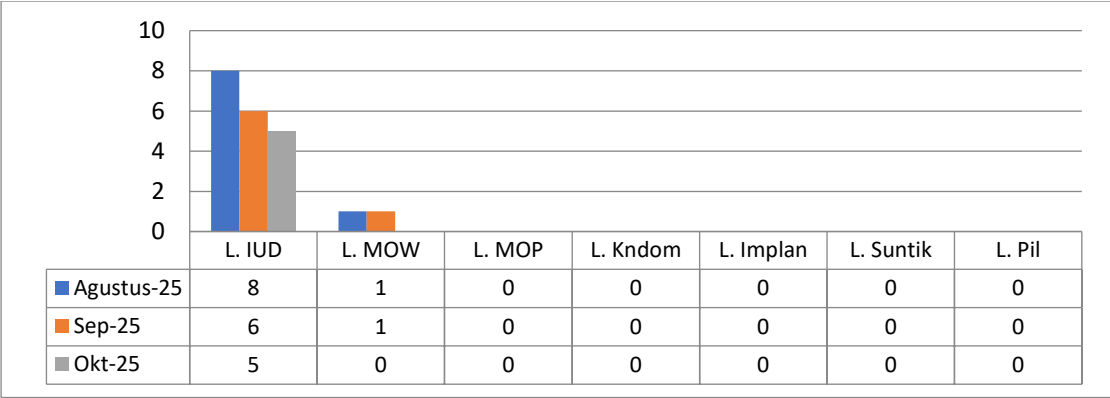
1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Oktober 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 14 akseptor yang terdiri dari 11 akseptor IUD Nova T dan 3 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien, sedangkan pada bulan September dan Agustus sebanyak 11 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Oktober menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu yaitu 4, sedangkan pada bulan September sebanyak 6 pengguna, dan Agustus 3 pengguna.
4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Oktober meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 34 pengguna, sedangkan pada bulan September sebanyak 17 pengguna, dan bulan Agustus sebanyak 23 pengguna.
5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 19 pengguna, sedangkan bulan September sebanyak 14 pengguna, dan bulan Agustus sebanyak 9 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025

NO	JENIS	JUMLAH LEPAS		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	IUD	8	6	5
2	MOW	1	1	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0



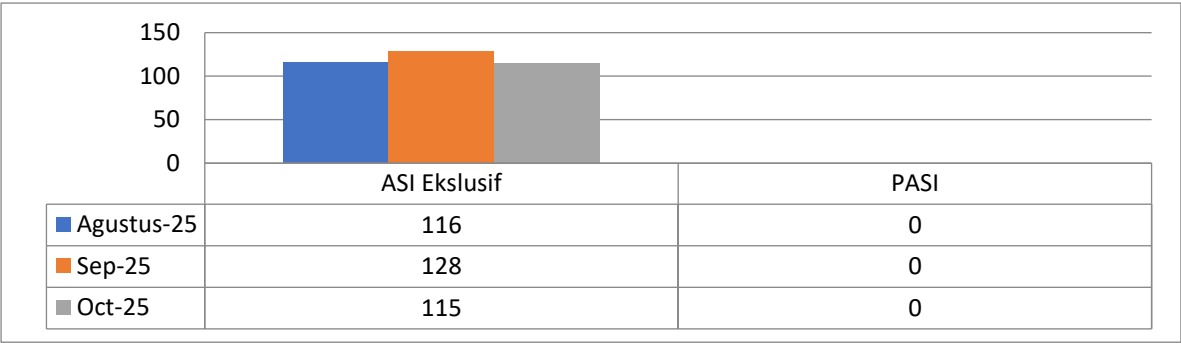
- Analisis :**
1. Pelepasan KB IUD pada bulan Oktober menurun yaitu 5 Akseptor, sedangkan pada bulan September 6 Akseptor , dan Agustus sebanyak 8 akseptor.
 2. Pelepasan KB Implan pada bulan Oktober dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Oktober 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	Asi eksklusif	116	128	115
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025

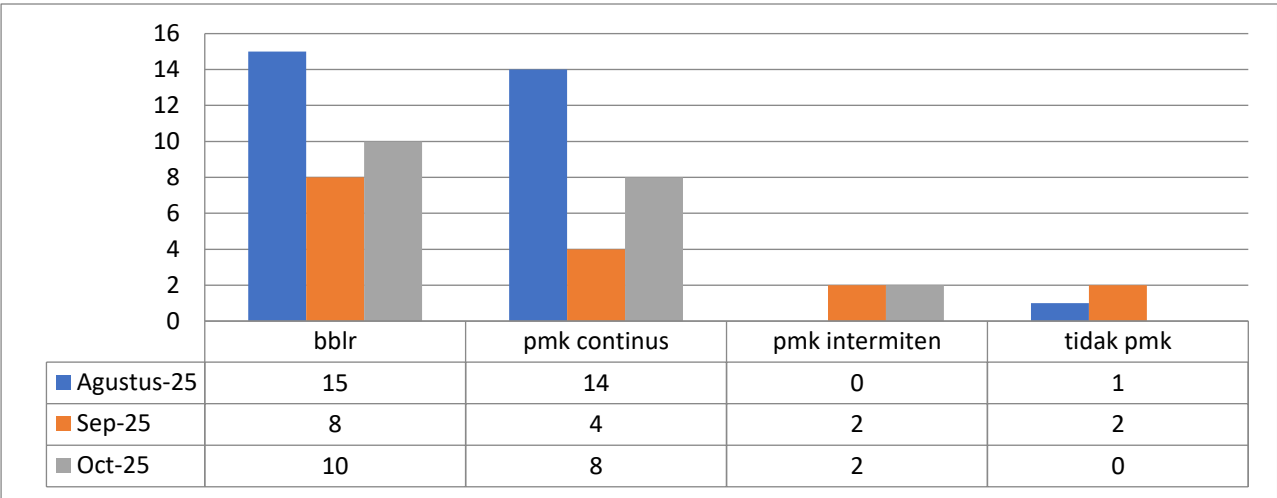


- Analisis :**
1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Oktober menurun yaitu 115 bayi, sedangkan pada bulan September sebanyak 128 bayi, dan pada bulan Agustus sebanyak 116 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan Oktober dan 2 bulan sebelumnya. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Oktober 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	Bayi BBLR	15	8	10
2	PMK continuos	14	4	8
3	PMK Intermiten	0	2	2
4	Tidak PMK	1	2	0



Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Oktober 2025

- Analisis :**
- Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
 - Ada 2 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Oktober dan September, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
 - Sedangkan metode PMK continus pada bulan Oktober meningkat yaitu 8 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil, sedangkan pada bulan September sebanyak 4 bayi, dan Agustur 2025 sebanyak 14 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada.
 - Tidak ada bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September sebanyak 2 bayi, bulan Agustus ada 1 bayi.

Rencana dan Tindak Lanjut
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN			KET
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	0			
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	2			
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	2			

Evaluasi :

- 1. Pada bulan Oktober 2025 terdapat 4 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan November 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Desember 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Bulan Oktober 2025

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	04/10/2025	38th	-	Positif	Positif	-
2	06/10/2025	58th	-	Positif	Positif	-
3	07/10/2025	17th	-	Positif	Positif	-
4	08/10/2025	60th	-	Positif	Positif	-
5	09/10/2025	21th	-	Negatif	Positif	-
6	11/10/2025	10bln	Positif	-	Positif	Positif
7	15/10/2025	41th	-	Positif	Positif	-
8	15/10/2025	52th	-	Positif	Negatif	-
9	18/10/2025	54th	-	Positif	Negatif	-
10	18/10/2025	42th	-	Positif	Positif	-
11	21/10/2025	1th	Positif	-	Positif	Positif
12	22/10/2025	19th	-	Positif	Negatif	-
13						
	Total	12	2	9	9	2

Analisis :

- 1. Pada bulan Oktober 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 40 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 12 pasien dan pasien negatif sejumlah 28 pasien
- 2. Pada bulan November 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien
- 3. Pada bulan Desember 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	UNIT	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Poli Paru	8		
2	Poli Bedah			
3	Poli IPD			
4	Poli Anak			
5	Irna 2C			
6	ICU	1		
7	IGD			
8	Irna 2A			
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			
12	Maternitas 4C			
13	Irna 5C	3		
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			
16	Irna 8A			
	Total			

Analisis :

- 1. Pada bulan Oktober 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 40 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 12 pasien dan pasien negatif sejumlah 28 pasien
- 2. Pada bulan November 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien
- 3. Pada bulan Desember 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN			JUMLAH TOTAL PASIEN TB
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	42			
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	5			
3	Pasien RFT	12			

Analisis:

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan Oktober mencapai 42 pasien, di bulan November 0 pasien, dan di bulan Desember 0 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan Oktober 5 pasien, di bulan November 0 pasien dan di bulan Desember 0 pasien.
- 3. Jumlah keseluruhan kunjungandi poli pasien RFT di bulan Oktober 12 pasien, di bulan November 0 pasien dan di bulan Desember 0 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	12		

Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	4	0	0

Evakuasi :

- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 4 pasien yang diimunisasi pada bulan Oktober
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan November
- 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Desember

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Oktober 2025

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny. R	V		
		Nn. D	V		
		Tn. S	V		
		Tn. B	V		
		Tn. R	V		
		Ny. M	V		
		Nn. H	V		
		Tn. A	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Tn. M	V		Meninggal
		Tn. A	V		
3.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A	An. A	V		
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. A	V		

Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		Oktober	November	Desember
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%		
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%		
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%		

Analisis:
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

No	Penempatan Pasien TB	Jumlah Pasien		
		Oktober	November	Desember
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%		
2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%		
3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%		

Analisis:

Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Oktober 2025

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Okto	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny. M	V	-	1	PKM Ardmulyo	pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak	An. A	V	-	1	PKM Singosari	pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A	Tn. M	V	-	1	PKM Pakis	pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

Analisis :

1. Pada bulan Oktober 2025 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan November 2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit karena pasien dengan
3. Pada bulan Desember 2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP karena.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		Oktober	November	Desember	
1.	OAT Anak	5			12/26
2.	OAT Harian Dewasa	15			10/26
3.	Ethambutol 250 mg	448			02/26
4.	Ethambutol 400 mg	308			05/26
5.	Pirazinamid 500 mg	756			05/27
6.	Isoniazid 300 mg	1190			02/26
7.	Rimfapicin 450 mg	1470			03/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0			0

Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

No	Unit	Jenis TB	Jumlah Pasien					
			Oktober		November		Desember	
			Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
1.		Pasien paru	2	10				
2.		Pasien Ekstra paru	2	0				

- Evaluasi :**
- 1. Pada bulan Oktober 2025 terdapat 2 pasien ekstra paru dan 12 pasien paru
 - 2. Pada bulan November 2025 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru
 - 3. Pada bulan Desember 2025 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru

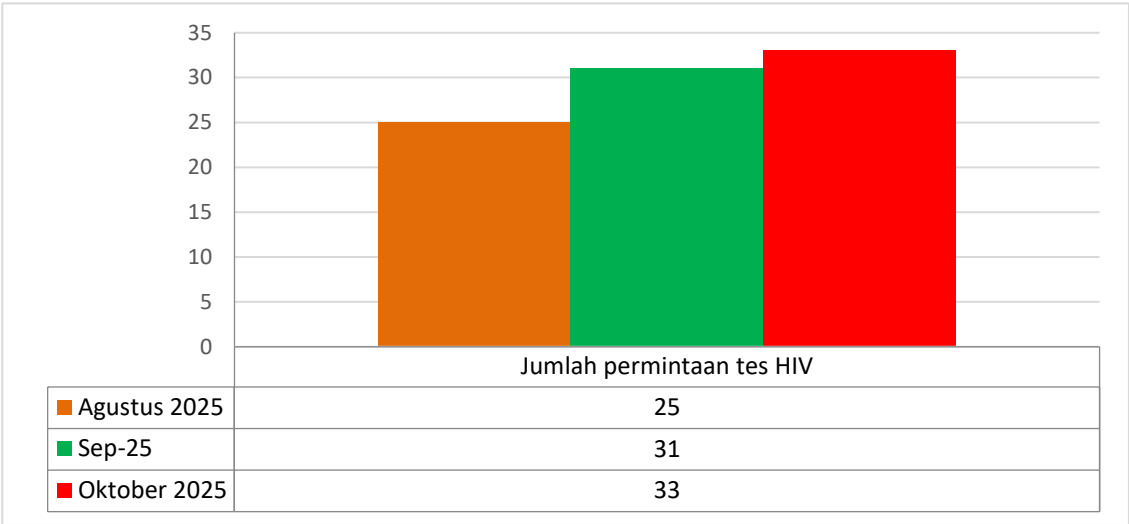
Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Permintaan Test HIV	25	31	33

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2025



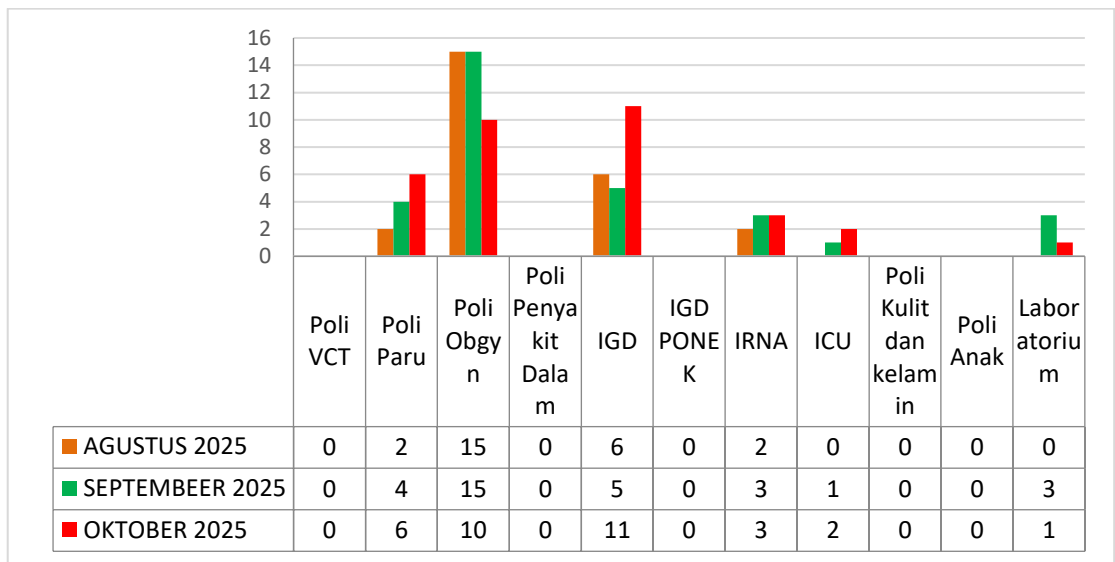
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Agustus 2025 sebanyak 25 pemeriksaan pada bulan September 2025 sebanyak 31 pasien. Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 33 pasien
Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.56 Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	2	4	6
3	Poli Obgyn	15	15	10
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	6	5	11
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	2	3	3
8	ICU	0	1	2
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	0	3	1

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



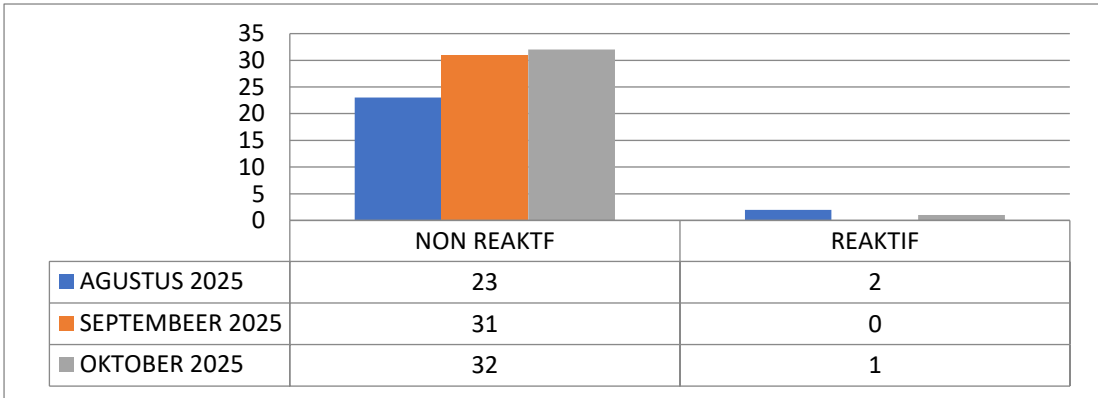
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Agustus 2025 sebanyak 15 pasien pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien. Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 10 pasien.
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Non Reaktif	23	31	32
2	Reaktif	2	0	1

Grafik Status HIV Oktober 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan

pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Agustus 2025 sebanyak 2 pasien dari IGD. pada bulan September 2025 tidak terdapat pasien dengan HIV reaktif Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 1 pasien

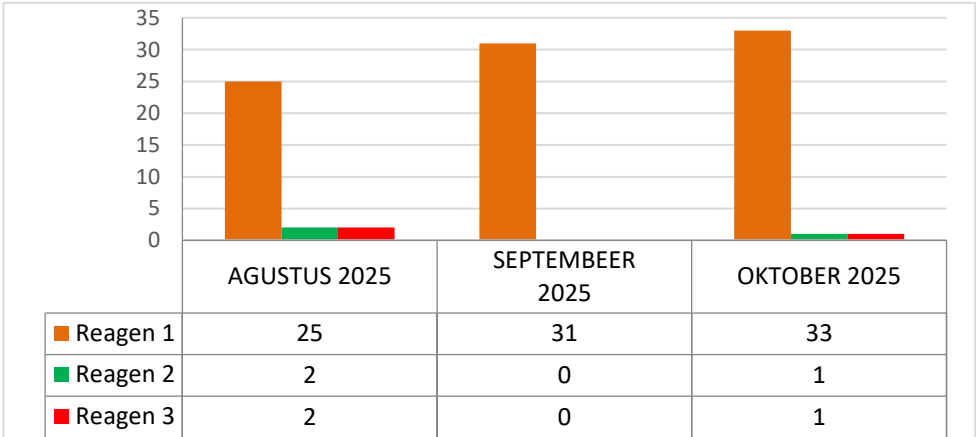
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.57 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Reagen 1	25	31	33
2	Reagen 2	2	0	1
3	Reagen 3	2	0	1

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Oktober 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Agustus 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien. pada bulan September 2025 hanya memakai reagen 1 dengan jumlah 31 pasien Sedangkan Pada bulan Oktober 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

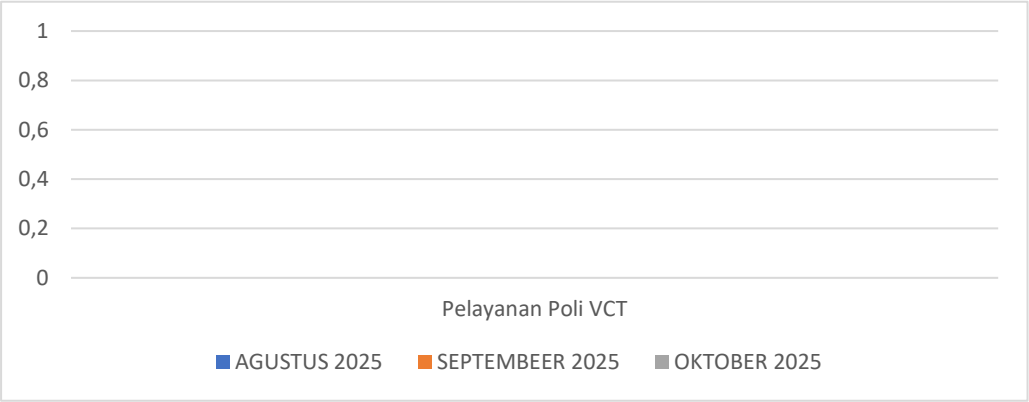
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.58 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Oktober 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

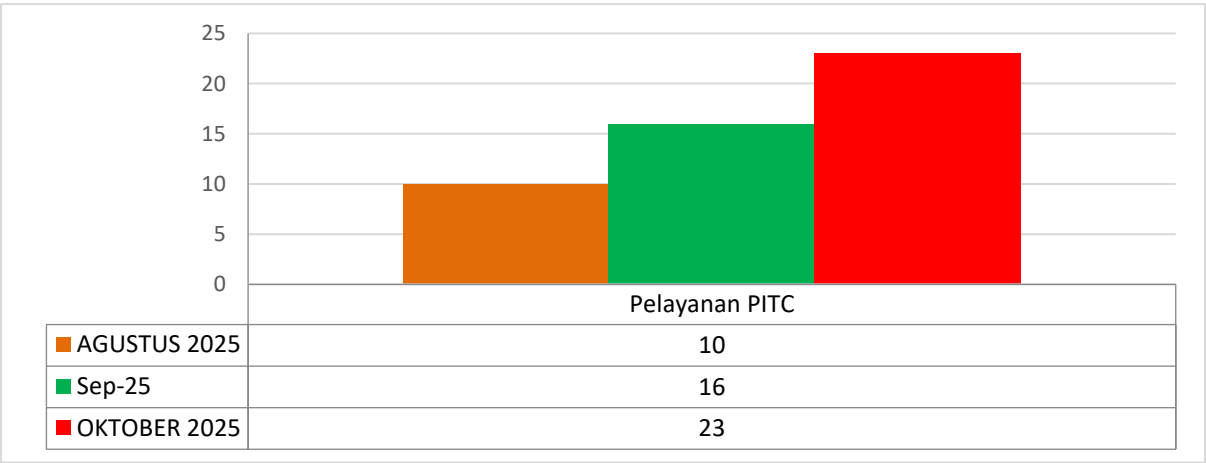
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.59 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Pelayanan PITC	10	16	23

Grafik Pelayanan PITC Oktober 2025



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan Agustus 2025 sebanyak 10 pasien. pada bulan September 2025 sebanyak 16 pasien Sedangkan pada bulan oktober 2025 sebanyak 23 pasien

Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :

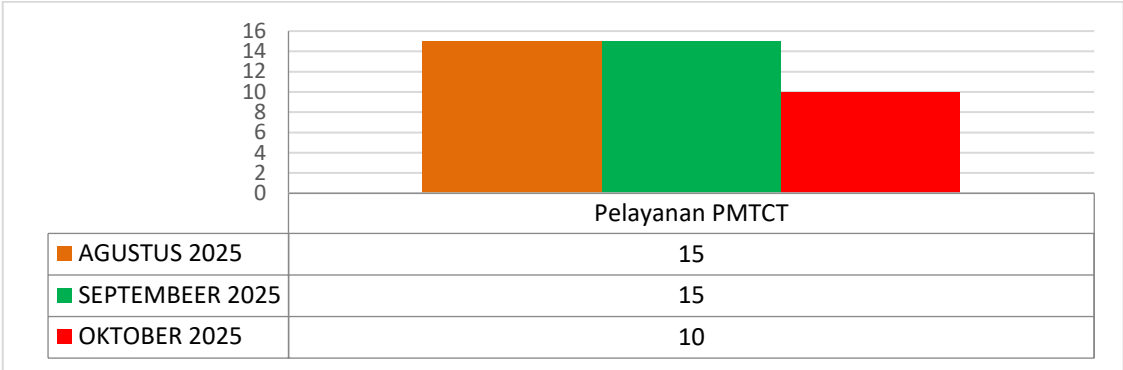
Dilakukan peningkatan terkait penjangran pasien dengan dialkukanya edukasi pasien

tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.60 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Pelayanan PMTCT	15	15	10

Grafik Pelayanan PMTCT Oktober 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan pada bulan agustus 2025 sebanyak 15 pasien. pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien. Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 10 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

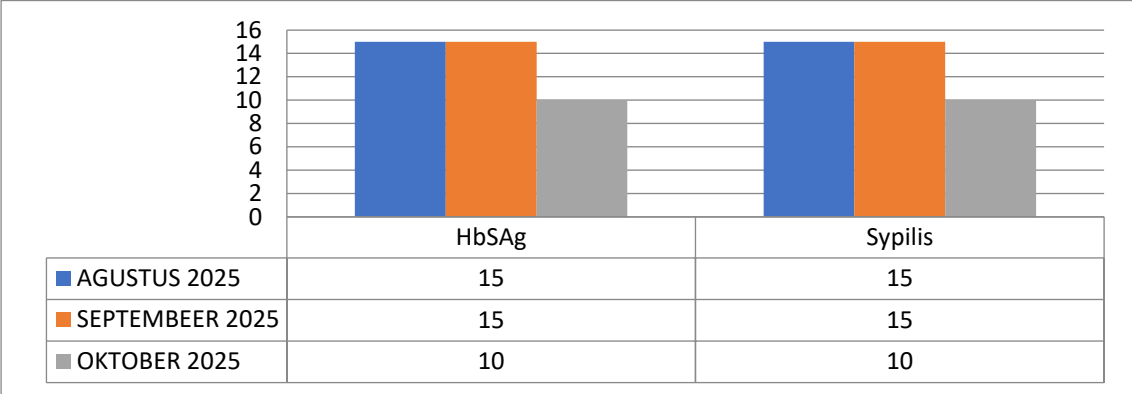
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.61 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	HbSAg	15	15	10
2	Sypilis	15	15	10

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Oktober 2025



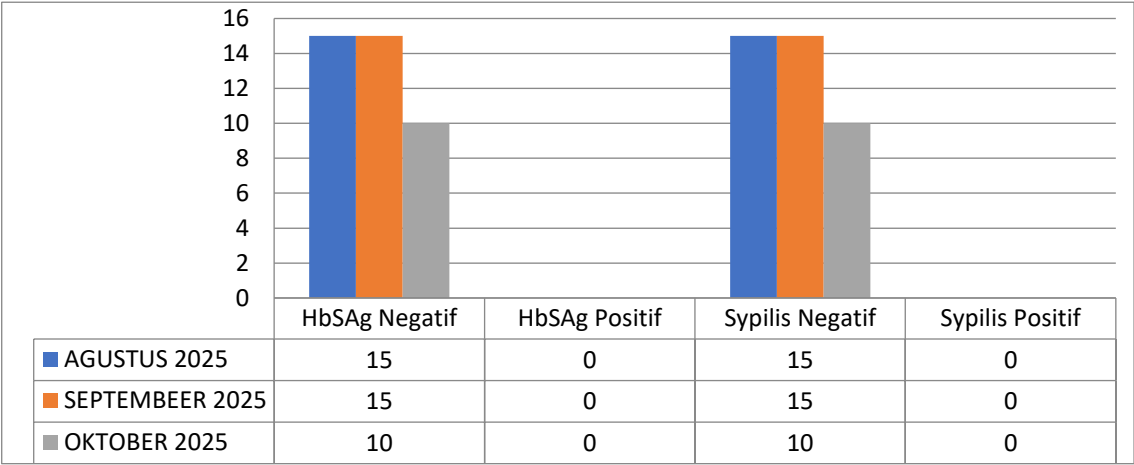
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan agustus sebanyak 15 pasien. pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 10 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.62 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	HbSAg			
	Negatif	15	15	10
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	15	15	10
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Oktober 2025



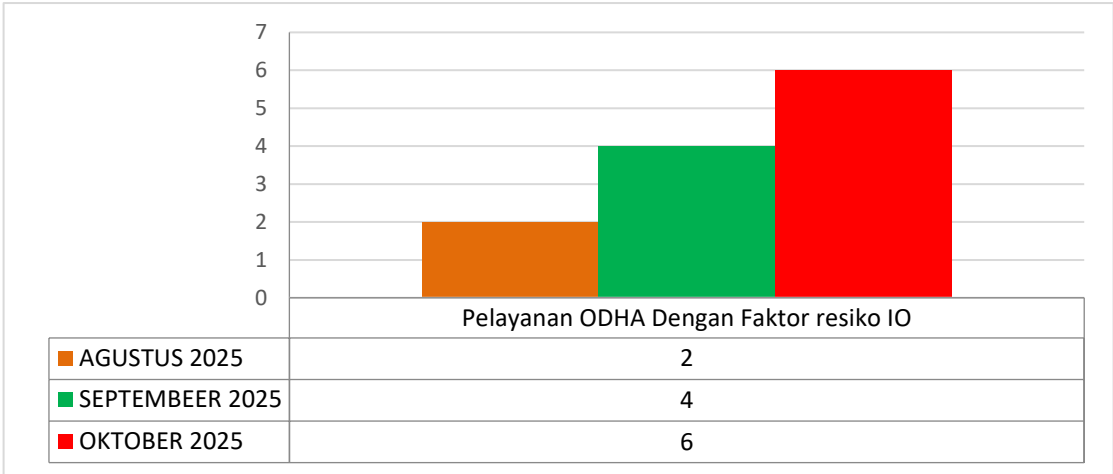
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Agustus, September dan Oktober 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
 2. Pada pasien Sypilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.63 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	2	4	6

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Oktober 2025



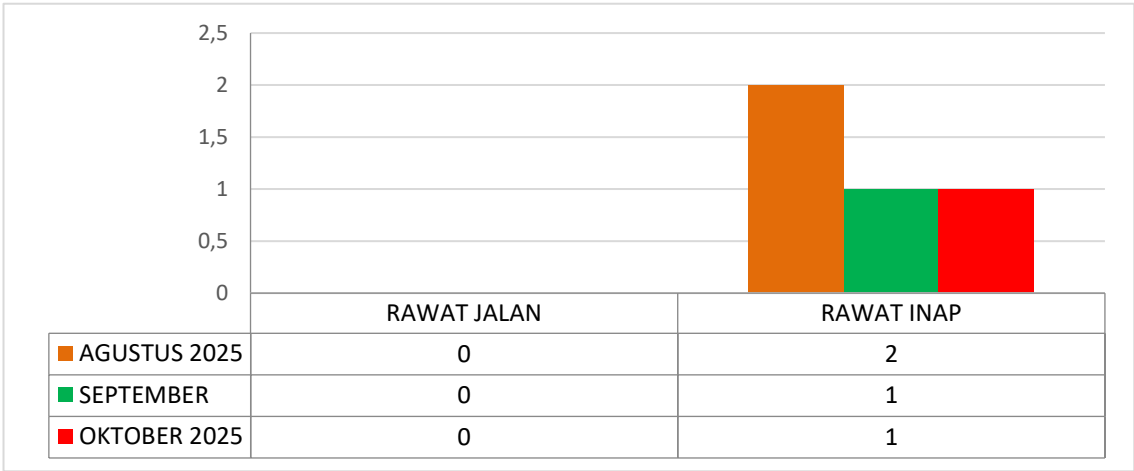
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. pada bulan agustus sebanyak 2 pasien. pada bulan September 2025 sebanyak 4 pasien. Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 6 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.64 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	Rawat Jalan	0	0	0
2	Rawat Inap	2	1	1

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Oktober 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan Agustus 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap. pada bulan September 2025 sebanyak 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap Sedangkan pada bulan oktober 2025 sebanyak 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap

Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting September 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan

		2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
- Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung	1	1	1

	asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat		baru lantai 5			
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberia	Memastik	Pasien anak	IRJA	1	1	1

n Imunisasi	an ketersedia an imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	dan Bayi baru lahir	anak			
Pemberia n vitamin A	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberia n Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberik an PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersdiaa n bahan pangan di lingkunga n	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberia n Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberia n Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

	mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil					
--	---	--	--	--	--	--

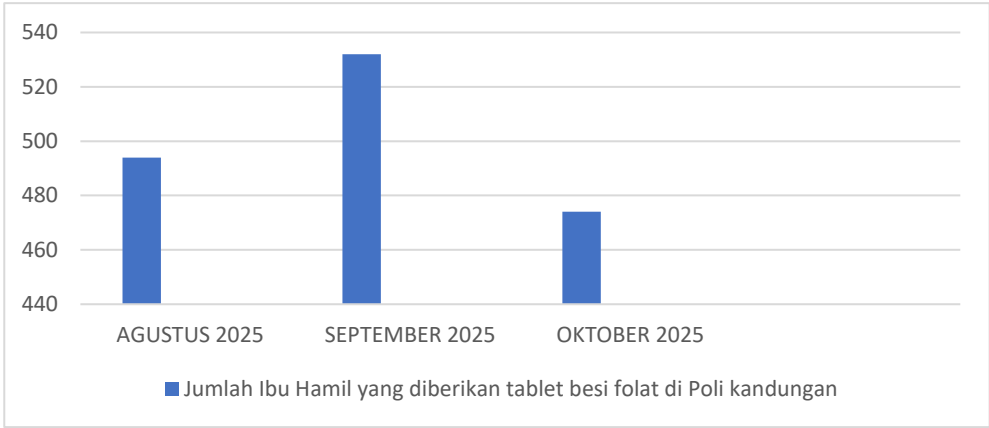
Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	494	532	474

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Oktober 2025



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 555 di bulan Juli menjadi 494 pada bulan Agustus yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

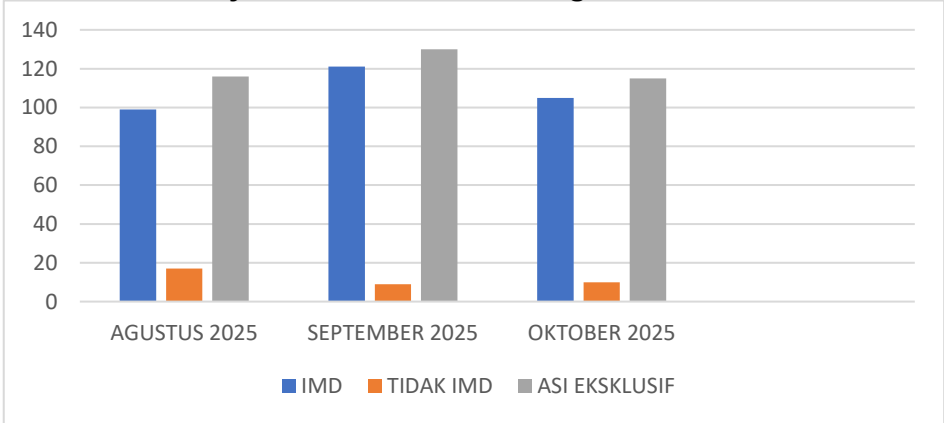
- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	IMD	99	121	105
2	Tidak IMD	17	9	10
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	116	130	115

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif Oktober 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Oktober sebanyak 105 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Oktober 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Oktober 2025 yaitu sebanyak 115 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

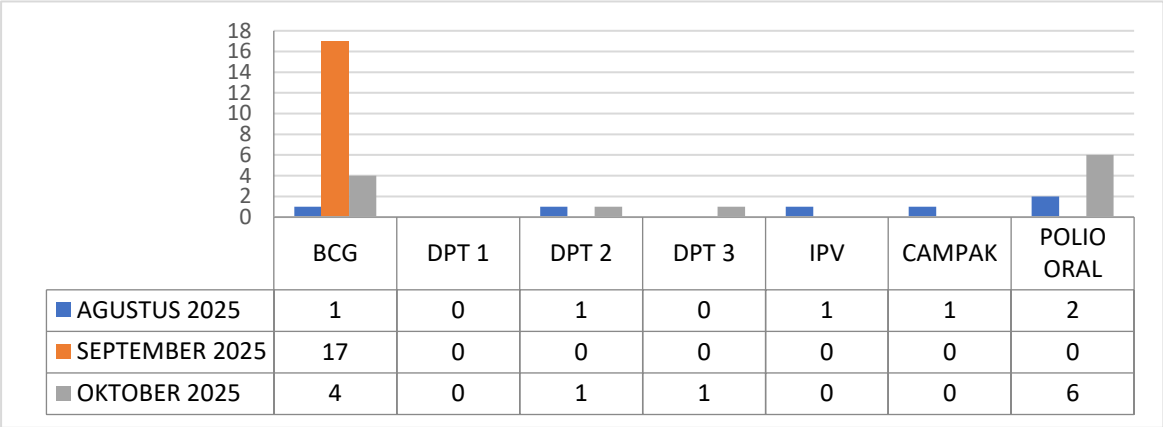
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	BCG	1	17	4
2	DPT 1	0	0	0
3	DPT 2	1	0	1
4	DPT 3	0	0	1
5	DPT 4	0	0	0
5	IPV	1	0	0
6	Campak	1	0	0
7	Polio Oral	2	0	6

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Oktober 2025



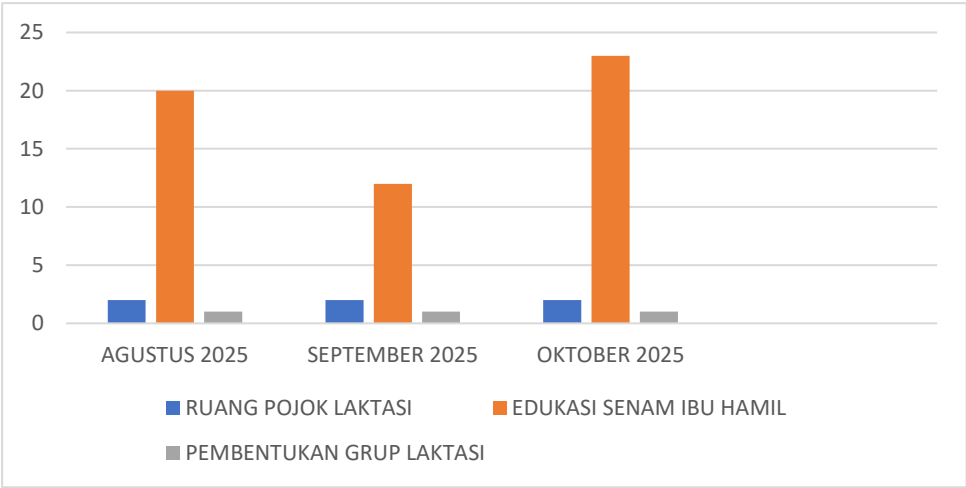
- Analisis:**
- 1. Terdapat 4 balita yang melakukan imunisasi BCG di bulan Oktober 2025.
 - 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi DPT 1, IPV, CAMPAK pada bulan Oktober 2025.
 - 3. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi DPT 2, DPT 3 pada bulan Oktober 2025.
 - 4. Terdapat 6 balita yang melakukan imunisasi polio oral pada bulan Oktober 2025

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	20	12	23
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Oktober 2025



- Analisis :**
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
 - 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.

3. Pada bulan Oktober edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Gizi Seimbang sebanyak 10 peserta penyuluhan dilakukan di poli obgyn. Dan 13 peserta penyuluhan dilakukan di senam ibu hamil

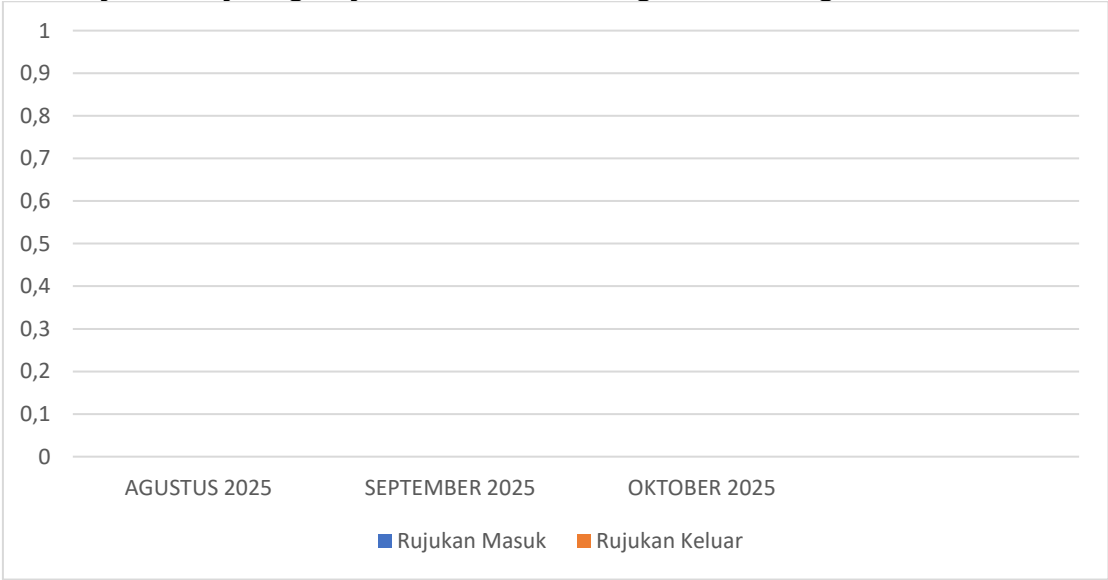
Rencana Tindak Lanjut :

1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Oktober 2025



Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangkau pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
Jumlah Pasien Stunting	1	1	2
Jumlah Pasien Wasting	1	1	3

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
 Pada bulan Oktober 2025 ditemukan 3 pasien (2 stunting dan 3 wasting).

- Balita atas nama Arcelleo Razka Aswandi, BB: 10 kg TB: 80 cm (balita BB kurang dan pendek). Pola makan balita tidak adekuat, kurang beragam. Berat badan lahir kurang, yaitu 2100 gram. Perlu adanya makanan adekuat untuk mengejar tumbuh kembang balita sejak lahir. Balita mendapatkan pendampingan dari puskesmas setempat.
- Balita atas nama Azqilla Hifza Nurfathiya, BB: 11.10 kg TB: 90 cm (BB sangat kurang dan sangat pendek). Pasien memiliki Riwayat anemia defisiensi zat besi. Berat badan lahir rendah, yaitu 1900 gram. Pola makan pasien tidak menentu, jika makanpun hanya mau dengan telur saja tanpa nasi dan sayur. Dilihat dari latar belakang pasien, pasien sudah lahir BBLR, di mana harus mengejar ketinggalan BB. Selain itu, pasien memiliki Riwayat anemia defisiensi zat besi yang di mana pasien tidak suka makan protein jika bukan telur, harus lebih banyak mengenalkan makanan pada anak dengan modifikasi makanan.
- Balita atas nama El Haaziq Gavin Izqian, BB: 8,7 kg TB: 80,3 cm (gizi kurang). Imunisasi balita lengkap, Balita sulit makan, namun aktif bergerak. Berat badan balita sempat naik dan normal. Balita batuk selama 1 bulan ini sehingga berat badan turun. Balita hanya suka makan buah, tidak suka makan makanan yang lain. Perlunya makanan adekuat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan berat badan.

Rencana Tindak Lanjut :

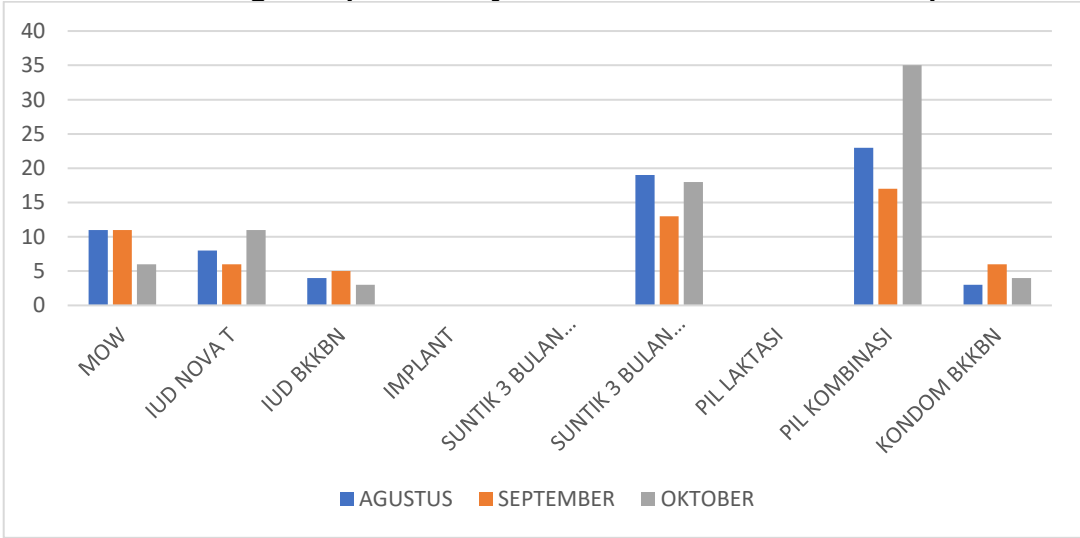
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan

3.1.2.5 KBRS

3.7.65 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025
1	MOW	11	11	6
2	IUD Nova T	8	6	11
3	IUD BKKBN	4	5	3
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	0	1	1
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	19	13	18
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	23	17	35
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	3	6	4

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Agustus (11) September tetap (11) dan turun pada Oktober (6)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Agustus naik (8) September turun (6) Oktober naik (11)
- 3. Peserta IUD BKKBN pada bulan Agustus (4) September naik (5) Oktober turun (3)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Agustus dioperkan ke faskes lain sebanyak 80 vial karena jarang pengguna, September (1) dan Oktober tetap (1)

- 5. Peserta KB suntik progestin pada bulan Agustus dipakai sebanyak (19) dioperkan ke faskes lain(mutiara sehat) sebanyak (10) vial karena faskes lain kehabisan stok September turun (13) dan Oktober naik (18)
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Agustus (23) September turun (17) Oktober naik (35)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan Agustus (3) September naik (6) Oktober turun (4)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

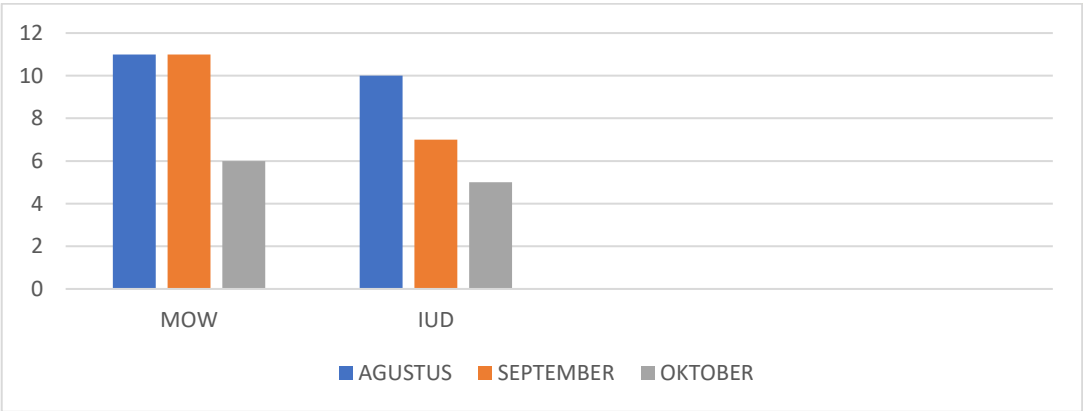
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

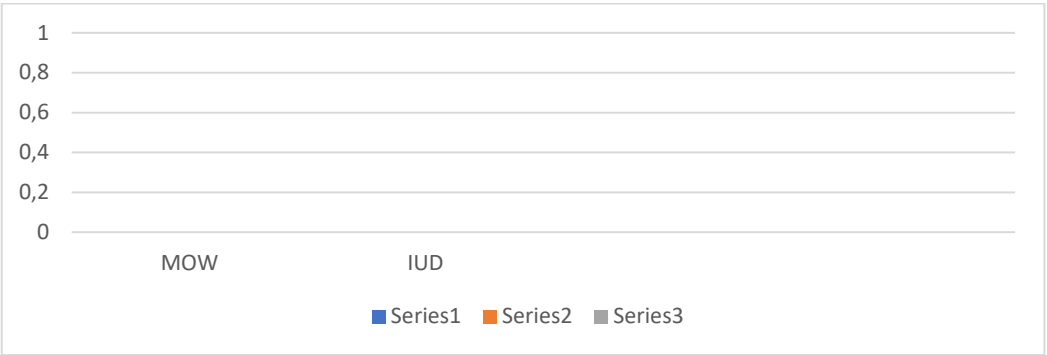
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	MOW	11	11	6
2	IUD	10	7	5

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Agustus-September-Oktober meningkat
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Agustus-September-Oktober menetap.

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Agustus 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Yanti Ningsih	P/26	dr. Aida, Sp.OG	162043	Pre Eklamsia	30/07/2025	01/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Eny Zuhriah	P/63	dr. Anton, Sp.B	160878	Necrotizing facitis	01/08/2025	03/08/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
3	Kusairi	L/58	dr. Ardhanay, Sp.Pd	235268	DM Hiperglikemi	06/08/2025	08/08/2025	3	Levofloxacin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
4	Ra'im	L/73	dr. Catur, Sp. P	125436	COPD	06/08/2025	09/08/2025	4	Meropenem	1	3x1	6	3	2
5	Dasuki	L/65	dr. Andy, Sp.P	186331	COPD	07/08/2025	11/08/2025	5	Azitromycin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
6	Hilda Dwi Vanka	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	171684	Oligohydramnios	08/08/2025	10/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Faradilla S	P/25	dr. Andy, Sp.P	235471	Pneumoni	10/08/2025	13/08/2025	4	Azitromycin	2	1x0.5	0.5	0.3	1.67
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Patrum	L/71	dr. Pradana, Sp. U	234831	BPH	12/08/2025	14/08/2025	3	Ceftizxime	1	1x2	2	4	0.5
9	Lailatur R	P/51	dr. Andi, Sp.B	235567	Hemorrhoids with complication	12/08/2025	15/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Chofifa	P/53	dr. Fachriy, Sp.BS	235247	Necrotizing facitis	13/08/2025	15/08/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
11	Anang Fakhmi	L/35	Dr. Ardhi, Sp. Pd	235486	TF	13/08/2025	16/08/2025	4	Levofloxacin	1	1x1	2.25	0.3	7.5
12	Aan Trinova	L/35	dr. Zaki, Sp.B	166558	Peritonitis akut	21/08/2025	24/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5

13	Soewarsih	P/76	dr. Heri, Sp.Pd	074832	TF + ISK	22/08/2025	25/07/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8	3
14	lin Budi	P/58	dr. Ardhi, Sp.Pd	001240	DM Hiperglikemi + ISK	22/08/2025	26/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,8	0,8	3.5
15	Sulistiani	P/57	dr. Arianto, Sp.OT	172936	CF Distal	23/08/2025	25/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
16	Ririn Wijayanti	P/48	dr. Yoga, Sp.JP	066465	Dyspnea	23/08/2025	26/08/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Ester Ningmawati	P/59	dr. Anton, Sp.B	194608	Necrotizing facitis	25/08/2025	26/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
18	Ony Devita	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	118438	SC	26/08/2025	28/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tohit	L/55	dr. Aji, Sp.Pd	236147	TF + Shock Condition	26/08/2025	29/08/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Cefotaxime		3x1	6	4	2
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0.8	3
20	Rahit German	L/19	dr. Catur E, Sp. P	236262	Cronic fever, Efusi pleura	28/08/2025	31/08/2025	4	Ceftriaxnoe	1	2x1	6	2	3

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan September 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIO TIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Choirul Anam	L/84	dr. Edi, Sp. U	236329	BPH	01/09/2025	03/09/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
2	Samsul Arifin	L/55	dr. Ardhany, Sp. Pd	221994	DM + CKD	01/09/2025	04/09/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2	0,3	6,67
3	Alifah	P/41	dr. Heri, Sp.Pd	200272	DM 2 + ISK	04/09/2025	09/09/2025	6	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
4	Ani Andarwati	P/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	144918	TF	08/09/2025	10/09/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
5	Nimas Noviantika	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	182763	Abortus	09/09/2025	10/09/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilin		3x0,5	1,5	1,5	1
6	Siti Meilina Dwi	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	232752	Oligohidramnion	12/09/2025	14/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Hermanto	L/37	dr. Zaki, Sp.B	237018	Peritonitis akut	14/09/2025	16/09/2025	3	Cefoperazon e	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Didi Supriadi	L/82	dr. Andy, Sp. P	237027	Pneumoni PSI	14/09/2025	17/09/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
9	Irina Kusuma P	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	010721	KPD	16/09/2025	18/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
10	Hafidah	P/68	dr. Aji, Sp.Pd	237124	Cholelithiasis	16/09/2025	21/09/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefotaxime		3x1	10	4	2,5
11	Heru Suryo	L/56	dr. Pradana, Sp.U	123508	Hydrouretronefrosis is osis	17/09/2025	19/09/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
12	Amalia Iffah	P/38	dr. Anton, Sp.B	204588	Appendisitis akut	17/09/2025	20/09/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
13	Bheny Murtopo	L/54		237325	ADHF + Sepsis	20/09/2025	25/08/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4

			dr. Yoga, Sp.JP						Levofloxacin inf		1x0,5	1,5	0,3	5
14	Tatik Suprihatin	P/56	dr. Andy, Sp. P	090921	Pneumoni	21/09/2025	23/09/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
15	Rasit	L/61	dr. Heri, Sp.Pd	237275	Abses Hepar	22/09/2025	25/09/2025	4	Ceftraixone	2	2x1	5	2	2,5
									Metronidazol e inf		2x0,5	2,5	1,5	1,67
16	Melati Mandasari	P/39	dr. Ardhi, Sp.Pd	237445	ISK	23/09/2025	27/09/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Puput Pratiwi	P/18	dr. Aji, Sp. Pd	061672	Colic abdomen	23/09/2025	27/09/2025	5	Goforan (Cefotaxime)	1	2x1	8	4	2
18	Wahyundari	P/47	dr. Zaki, Sp.B	099504	Hernia Umbilical	23/09/2025	25/09/2025	3	Cefoperazon e	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
19	Zainul Bahri	L/53	dr. Anton, Sp.B	156453	Gangrene Necrotic Diabeticum	26/09/2025	28/09/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazol e po		3x0,25	1,5	2	7,5
20	Pudji Rahaju	P/72	dr. Oka, Sp.OT	236404	CF Distal	26/09/2025	28/09/2025	3	Cefoperazon e	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Oktober 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Asri Putri Dwi	P/27	dr. Aida, Sp.OG	068706	KPD	30/09/2025	02/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
2	Rizky Emiliyatus S	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	227436	SC Eracs	02/10/2025	04/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5

3	Rofiatun Nabila	P/21	dr. Humaira, Sp.OG	238031	Blighted ovum	06/10/2025	07/10/2025		Ceftrizxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilin		3x0,5	1,5	1,5	1
4	Mila Dwi Pratiwi	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	225267	Post Partum + Granuloma Vagina	07/10/2025	09/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Apriliani F	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	234430	Oligohidramnion	08/10/2025	11/10/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Rosa Faradianti	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	236389	KPD	10/10/2025	13/10/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
7	Ismi Tri Utari	P/60	dr. Humaira, Sp.OG	151336	Mioma Uteri	15/10/2025	18/10/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Nani Suhartati	P/50	dr. Aida, Sp.OG	237867	Multiple Miomi Uteri	20/10/2025	23/10/2025	4	Cefazoline	3	1x2	2	2	1
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
									Metronidazole po		3x0,5	1,5	2	7,5
9	Inayah Kurniati	P/37	dr. Humaira, Sp.OG	84320	Abortion	22/10/2025	23/10/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1
10	Anis Karunia	P/25	dr. Aida, Sp.OG	95738	SC + MOW	25/10/2025	27/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
11	Imam Hanafi	L/55	dr. Anton, Sp.B	238456	Selulitis dd Necrotizing Fascitis Cruris	12/10/2025	14/10/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
12	Sulastri	P/66	dr. Edi, Sp.B	237272	Retensio urine dd cystitis	13/10/2025	15/10/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		2x1	3	4	0,75
13	Nur Jamil	L/55	dr. Oka, Sp.OT	238642	Osteomyeltis pedis	15/10/2025	17/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
14	Mujiono	L/62	dr. Zaki, Sp.B	238637	Hernia Scrotalis	15/10/2025	17/10/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5

									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Sanali	L/78	dr. Edi, Sp. U	206687	BPH	20/10/2025	22/10/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Supeno Hadi	L/64	dr. Anton, Sp.B	156453	Gangrene Necrotic Diabeticum Manus D	19/10/2025	21/10/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,25	2	0,625
17	Fitroir Arif	L/25	dr. Anton, Sp.B	238909	Hydrocel testis	24/10/2025	26/10/2025	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
18	Warni	P/73	dr. Zaki, Sp.B	237911	Appendicitis akut	02/10/2025	05/10/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
19	Widji Asrini	P/68	dr. Andi, Sp.B	237911	Ulkus decubitus	09/10/2025	12/10/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
20	Sumirah	P/91	dr.Oka, Sp.OT	238408	CF distal radius S	11/10/2025	13/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
21	Djuma'ijah	P/90	dr. Andy, Sp. P	224262	COPD + Pneumoni	05/10/2025	07/10/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1			
22	Hendrik Prasetiawan	L/48	dr. Elvi, Sp.P	238132	Pneumonia, Bronkitis Kronis	06/10/2025	09/10/2025	2	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefoperazone		2x1	3	4	2,5
23	Winarso	L/60	dr. Andy, Sp. P	137124	COPD Ae + Pneumoni Psi	06/10/2025	09/10/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
24	Devan Tri Angga	L/18	Dr. Aji, Sp. Pd	238444	OF, Susp TF	11/10/2025	13/10/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
25	Sumisni	P/59	dr. Zora, Sp. Pd	238597	OF Susp DF + GEA	14/10/2025	16/10/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
26	Kiky Dwi Ratnasari	P/33	Dr. Aji, Sp. Pd	139241	Ruq pain dt cholelelitis	13/10/2025	18/10/2025	6	Ceftizoxime	1	2x1	7	2	3,5
27	Utami	P/66	Dr. Ardhi, Sp. Pd	238607	GEA + Diarrhoea	18/10/2025	19/10/2025	2	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
28	Hery Sampurno	L/73	dr. Zora, Sp. Pd	062693	ISK Colic Abdomen	19/10/2025	22/10/2025	4	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
29	Ruba'inah	P/65	dr. Ardhan, Sp. Pd	238794	DM Hiperkalemi + Edema Paru+ Pneumonia	19/10/2025	22/10/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2	0,3	6,67
30	Agus Handoyo	L/50	Dr. Yoga, Sp. Jp	131012	ADHF	21/10/2025	24/10/2025	4	Ceftrizxone	1	2x1	6	2	3

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

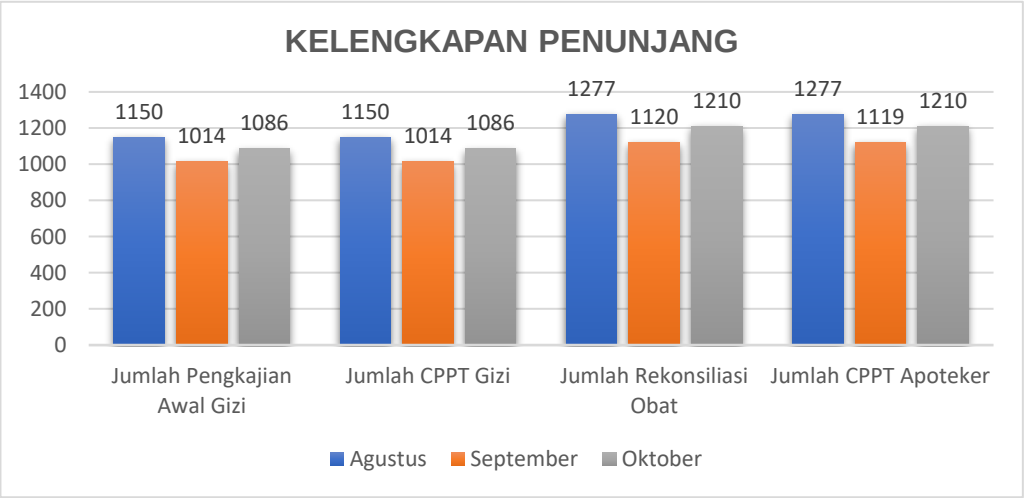
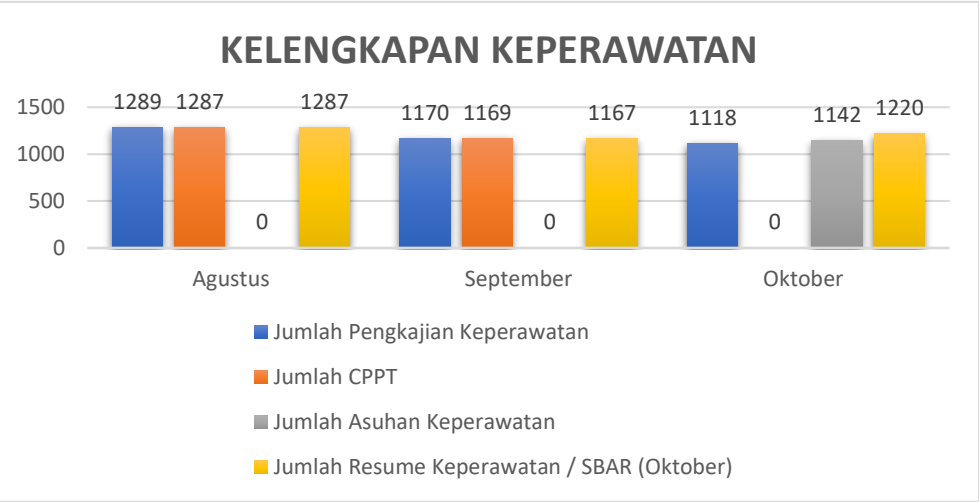
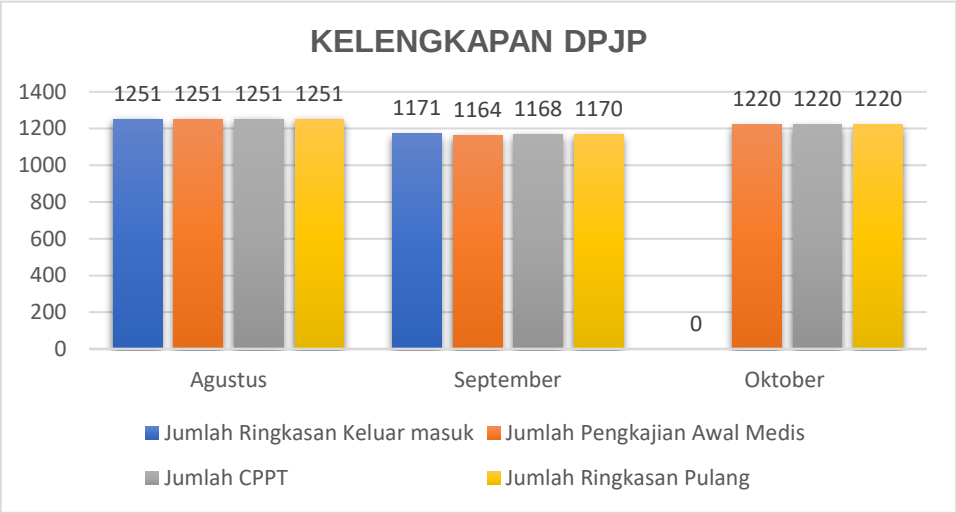
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Oktober Tahun 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0
September	1171	100	0	0	1164	98,14	7	1,86	1168	99,73	4	0,33	1170	99,84	1	0,16
Oktober	-	-	-	-	1219	99,91	1	0,09	1220	100	0	0	1220	100	0	0

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR (Oktober)			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0
Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0
September	1170	99,52	1	0,48	1169	99,33	2	0,67	-	-	-	-	1170	99,52	1	0,48
Oktober	1118	92	112	8	-	-	-	-	1142	94	78	6	1220	100	0	0

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99,65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33
Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0
September	1014	100	0	0	1014	100	0	0	1120	100	0	0	1119	99,96	1	0,4
Oktober	975	90	111	10	1076	99	10	1	1210	100	0	0	1100	91	110	9

3.1.1.7 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Oktober 2025



Analisis :

1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi terisi lengkap 100% , sebanyak 1210 dokumen
2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 92% pada Bulan September 2025.
3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan September 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
2. Melakukan supervise secara berkala.
3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.66 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Implant IKO bedah saraf ada 6 screw hilang	P	Lakukan identifikasi dan kronologi serah terima alat dari unit Gudang farmasi, IKO dan CSSD
		D	Lakukan koordinasi penyebab alat bedah saraf tidak sesuai
		S	Lakukan eksekusi terkait dengan punishment apabila ada SPO yang dilanggar dengan membayar ganti rugi screw yang dihilangkan
		A	Sudah ada form komunikasi yang dihadiri oleh unit CSSD, IKO , Gudang farmasi , Yanmed dan SPI diketahui oleh SDM RS dan Dir RS
2	Alat orthopedi martin (vasgrip) belum datang	P	1. Sudah pengajuan bulan februari 2025 2. Dari PT menunggu penawaran dari vendor 3. Membandingkan harga beberapa vendor 4. Ada vendor martin dan disuruh uji coba kan di IKO 5. Pengajuan evaluasi alat martin ke PT 6. Follow up alat datang karena dokter ortopedi komplain
		D	Follow up ke pengadaan PT, sudah proses P.O estimasi 3-4 bulan
		S	Koordinasi dengan unit dan PT untuk selalu monitor dan follow up
		A	Lakukan follow up berkala sampai barang datang

3.7.67 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Tren kunjungan rawat inap bpjs turun	P	Indikasi medis rawat inap pasien bpjs harus masuk kriteria kegawatdaruratan
		D	Sharing dan sosialisasi kembali untuk refreshing ilmu kegawatan dan kasus-kasus yang masih

			ada kemungkinan dirawat inapkan untuk menaikkan kunjungan rawat inap
		S	Menekankan kembali untuk di IGD, bahwa tidak ada penolakan pasien, melainkan penjelasan terkait penjamin yang digunakan oleh pasien jika tidak sesuai indikasi dirawat dan menggali kembali diagnosa banding yang bisa muncul untuk bisa dirawat inapkan
		A	Dari segi pelayanan, dirutinkan kembali terkait morning report, dari segi marketing, dibantu untuk follow up rujukan dari Perusahaan, klinik, puskesmas dan lain-lain
2	PR ERM SPRI IGD	P	Mengidentifikasi PR ERM dari verifikator terkait kesesuaian SPRI maupun isinya
		D	Ingatkan dan sosialisasikan kembali bagian yang sering di PR kan oleh verifikator diantaranya GCS, Operasi/tidak operasi, nama keluarga yang diberikan edukasi
		S	Pembetulan PR ERM wajib diselesaikan dalam waktu 1x24 jam
		A	Monitoring dan evaluasi kerjasama dengan kains RM untuk mengecek PR ERM saat itu juga, agar bisa dilengkapi dengan segera.
3	Resep manual dari IGD	P	Banyaknya penggunaan resep manual IGD ke farmasi dari dapat menimbulkan ketidaksuaian saat stok opname
		D	Saat ada keadaan emergency atau pasien membutuhkan tindakan cepat dan pasien belum masuk billing, pasien menggunakan resep manual untuk mengambil obat dan bmhp ke farmasi
		S	Koordinasi dengan programmer agar unit IGD bisa menginput resep tanpa harus melalui proses pengisian triase dan pengkajian awal
		A	Sudah berjalan untuk akses langsung input resep di IGD setelah proses pendaftaran dan meminimalisir penggunaan resep manual
5	Waktu tunggu IGD lebih dari 6 jam sehingga menyebabkan penumpukan pasien dan pasien baru tidak masuk	P	Identifikasi penyebab waktu tunggu IGD yang lama
		D	- PJ atau Karu harus mengatur sirkulasi perpindahan pasien di IGD - Plotting perawat belum dibentuk sehingga masing-masing perawat masih belum jelas harus memegang pasien apa saja - Koordinasi dengan dokter IGD dan PIPP, untuk memindah pasien yang stabil ke ruangan
		S	Operan antar shift harus jelas dan terdokumentasi
		A	Pendampingan operan pasien dan penunjukan plotting yang sesuai harus dipatuhi setiap shift

3.7.68 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Orientasi ruangan belum berjalan secara konsisten di unit beserta dokumentasi di ERM	P	Setiap pasien MRS di rawat inap harus dilakukan orientasi ruangan
		D	Setelah orientasi ruangan, di ERM harus didokumentasikan dilengkapi dengan TTD pasien atau keluarga pasien
		S	Implementasi di lapangan kurang konsisten, karena ada 2 kondisi yaitu sudah dilakukan, tetapi tidak terdokumentasi, tidak dilakukan dan tidak terdokumentasi
		A	Kerjasama dengan karu rawat inap untuk mendisiplinkan staf nya dalam pendokumentasian orientasi ruangan rawat inap di ERM
2.	Pendokumentasian pasien meninggal di rawat inap (jam belum sesuai karena sebelumnya tidak ada menu edit)	P	Ditemukan kendala di rawat inap untuk pasien meninggal jam nya tidak sesuai, karena di sistem pencatatan di CPPT real time, sehingga yang terbaca adalah pasien di lakukan tindakan setelah pasien meninggal
		D	Koordinasi dengan programmer untuk menu edit bisa di akses di rawat inap, karena untuk pasien gawat atau penurunan kondisi, perawat ruangan melakukan tindakan dulu, baru melakukan penginputan di billing simrs
		S	Sosialisasi di rawat inap untuk cara penginputan dan edit waktu
		A	Evaluasi dan monitoring pendokumentasian pasien meninggal secara berkala
3.	Pendokumentasian di CPPT belum seragam (terutama untuk pasien nyeri dan observasi)	P	Ditemukan DRM pasien ada keluhan nyeri, di CPPT tidak ada penjabaran PQRST, dan ada pasien observasi di CPPT tidak ada dokumentasi tindakan observasi yang terbaca yang jelas dan rinci.
		D	Sosialisasi kembali untuk penulisan PQRST dan penulisan CPPT untuk pasien observasi
		S	Ada progress setelah ada sosialisasi dengan irna, yaitu lantai 6,7,8 A sudah ada perbaikan penulisan di CPPT, karena beberapa kali juga sudah terpapar lapsus yang diadakan komite keperawatan
		A	Sosialisasi dan monitoring kembali pada ruangan rawat inap yang lain yang masih belum sesuai untuk pendokumentasian di CPPT

3.7.69 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien rawat jalan tidak gawat darurat, semua masuk ke IGD sehingga masuk false emergency	P	Identifikasi pasien indikasi rawat inap tetapi tidak gawat darurat sehingga tidak perlu di MRS kan di IGD
		D	Buat SPO alur masuk pasien rawat inap dari POLI
		S	Implementasi SPO ditemui kendala untuk pasien beda penjamin, SPRI tidak muncul
		A	Koordinasi dengan programmer agar SPRI tetap

			muncul, tanpa pasien harus masuk ke IGD untuk didaftar ulang
2	Pengisian lembar transfer kosong untuk pasien lodingan yang diambil oleh rawat inap	P	Untuk pengisian lembar transfer karena sudah ERM, pengisian dilakuakn oleh perawat rawat inap
		D	Di ERM ditulis staf yang mengambil pasien ke di PDF, dan yang menerima boleh dari PJ atau karu
		S	Meminimalisir kekosongan TTV dan tanda tangan di ERM
		A	Evaluasi kembali kendala yang muncul pada pasien lodingan elektif
3	Masih ditemukan kendala untuk handel pasien ODC umum dan asuransi non bpjs	P	Buat SPO Pasien ODC umum dan asuransi non bpjs dengan kebijakan semua pasien ODC adalah masuk billing rawat jalan
		D	Koordinasi dengan programmer untuk mengakomodir fitur penunjang – laporan operasi dan tim operasi masuk di pasien ODC
		S	Sosialisasi SPO pada unit terkait diantaranya PIPP, Karu IRJA, Karu IGD, Karu IKO, Karu Asce dan Karu RM
		A	Monitoring dan evaluasi secara berkala
4	Kuota pasien terapi wicara full sampai ada waiting list	P	Identifikasi pasien baru waiting list terapi wicara diurutkan berdasarkan yang paling lama menunggu
		D	Identifikasi pasien lama dengan terapi yang bisa di kurangi dari 2x menjadi 1x / minggu
		S	Masukkan slot dari waiting list untuk bisa masuk 1/minggu dulu
		A	1. Minta nomor HP dan edukasi apabila sewaktu-waktu mendapat kuota karena salah satu pasien ada yang tidak bisa isi slot, maka pasien bisa masuk kuota 2. Evaluasi kembali pasien lama yang masih memungkinkan terapi dalam 1x / minggu 3. Identifikasi kembali dan disiplinkan terkait kehadiran pasien selama mengikuti jadwal terapi yang sudah diadvicekan oleh dokternya.

3.7.70 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0
		A	- Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. - Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. - Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih

			terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. - Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. - Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggalan setiap bulan
2.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Agustus 2025 = +1.412.881 September 2025 = -128.673 Oktober 2025 = -30.150	P	Perencanaan scan barcode.
		D	3. Sudah dilakukan pengajuan proposal scan barcode dan pengadaan alat yang menunjang pelayanan. 4. Sudah dilakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Selisih stok opname di gudang farmasi dan depo farmasi
		A	1. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien. 2. Scan barcode menunggu antrian di progamer PT.
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 19,25% dan waktu tunggu obat racikan 8,27%	P	Perencanaan elektronik KPO dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur elektronik KPO di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	3. Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. 4. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	3. Elektronik KPO menunggu antrian di progamer PT. 4. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 155 KPO.
4.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaikan kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	3. Obat tertinggal bulan September mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 4. Farmasi sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	4. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 6. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
5.	Penambahan daftar obat	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.

	near ED	D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	4. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 5. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 6. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
6.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan VVM (Vaksin Vial Monitor) untuk vaksin pemerintah warna segiempat lebih gelap dari warna lingkaran sehingga tidak layak digunakan. (Data vaksin pada Tabel 9.10)	P	Pengadaaan VR (Vaccine Refrigerator) di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	3. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 4. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	4. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 5. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli. 6. Koordinasi dengan PJ Vaksin Pemerintah untuk permintaan vaksin baru ke Puskesmas.
7.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). Agustus 2025 = 19 resep September 2025 = 36 resep Oktober 2025 = 21	P	Koordinasi dengan Karu poli
		D	3. Sosialisasi fitur edit no apol. 4. Koordinasi dengan Karu poli untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	5. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 6. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 7. Farmasi utang input obat di apol. 8. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	3. Alur fitur "Edit No APOL" : g. Input resep IU di apol h. Copy no apol i. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol j. Klik "Edit No APOL" k. Paste no apol l. Klik OK 4. Alur perubahan surat kontrol ; h. Farmasi menemukan IU di apol i. Farmasi konfirmasi ke perawat poli untuk hapus surkon di SIMRS. j. Farmasi konfirmasi ke CSO untuk hapus di V-Claim pada grup whatsapp Pelayanan BPJS Kes jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format: Ganti Surat Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa

			k. Perawat input ulang surkon terbaru di SIMRS dan mengirimkan di grup WA. l. Pendaftaran mengubah di V-Claim m. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. n. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.
8.	Obat Rawat Inap di tandon di Nurse Station	P	Pengecekan obat tandonan di nurse station setelah dilakukan serah terima obat ODD
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi terkait pengecekan obat tandonan di nurse station
		S	Memaksimalkan jobdesk distribusi obat rawat inap oleh Tenaga Vokasi Farmasi dan Apoteker untuk mengecek obat yang ada di nurse station
		A	Pada saat distribusi obat rawat inap Tenaga Vokasi Farmasi wajib mengecek obat-obat yang ada di nurse station. Jika ada tandonan obat, Tenaga Vokasi Farmasi wajib menanyakan ke perawat jam pemberian obatnya. Jika sudah terlewat jam pemberiannya maka Tenaga Vokasi Farmasi wajib cek DPO obat yang ada di nurse station jika sudah lewat waktu pemberian harus di retur saat itu juga, serah terima obat dengan perawat dan perawat juga langsung input retur di simrs. Apoteker rawat inap saat visite pasien juga wajib double check obat yang ada di nurse station. Jika obat signa PRN / kp berkoordinasi dengan apoteker, apakah pasien masih membutuhkan terapi tersebut.
9.	Pelunasan resep non pasien	P	Koordinasi dengan keuangan PT. DPM, kasir dan farmasi
		D	Perbaikan alur pelayanan resep non pasien di SIMRS
		S	PT. DPM menemukan obat karyawan dan pembelian urinal/ pispot yang diinputkan non pasien belum dilunaskan di sistem sehingga banyak tagihan yang belum terbayarkan muncul di keuangan PT.
		A	Pembayaran obat non pasien wajib minta nota yang sudah terstempel LUNAS oleh kasir, setelah itu baru diberikan barangnya. Jika sudah terstempel lunas tetapi di billing belum dilunasi telfon kasir. Jika belum terselesaikan hingga akhir shift wajib ditulis dioperan unit farmasi. Jika pegawai RSPH yang membeli obat : tulis nama/unit
10.	Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan sehingga terjadi pendingan obat kronis.	P	Pengajuan bridging simrs dan apotek online BPJS Kesehatan
		D	1. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi terkait pendingan yang sering terjadi untuk memperbaiki ketelitian inputan obat di apotek online BPJS Kesehatan. 2. Pengecekan inputan obat kronis di apotek online BPJS dan e-resep oleh admin farmasi setiap hari
		S	1. Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan dan muncul di pendingan obat kronis yaitu velpraz tab 250 mg/ valproat 250 SK tab salut 250 mg (salah input valproat 250 SK tab lepas lambat 250 mg), berotec / fenoterol hbr 100 sk inh 100 mcg/puff (salah input fenoterol hbr 0,1 SK btl 50 ml), adalat oros 10 mg / aripriprazol 10 SK tab dispersible 10 mg (salah input aripriprazol 15 SK tab discmelt 15 mg). 2. Kesalahan centangan obat paket dan non paket di SIMRS.
		A	4. Jobdesk admin farmasi yaitu staff non tenaga vokasi farmasi. 5. Jadwal admin farmasi yaitu NS (jam 08.00-16.00). 6. Target admin : tidak ada masalah inputan apotek online dan pendingan.
11.	Rekonstitusi sediaan steril bentuk serbuk injeksi wajib dilakukan di	P	Pelaksanaan rekonstitusi serbuk injeksi semuanya dilakukan di LAF
		D	Pengajuan proposal pelatihan penyiapan obat intravena dan

	LAF		teknik aseptik
		S	Perlu adanya pelaksanaan pengoplosan obat injeksi bentuk serbuk untuk setiap obat yang akan digunakan, sehingga perlunya farmasi untuk mengoplos obat setiap shiftnya di LAF namun terkendala dengan jumlah tenaga yang melakukan pengoplosan injeksi selama ini adalah apoteker.
		A	5. Tenaga vokasi farmasi sesuai regulasi PMK terbaru bisa diberikan kewenangan melakukan rekonstitusi sediaan steril dengan syarat sudah terlatih. 6. Dilakukan pelatihan dispensing sediaan steril. 7. Dilakukan trial dispensing sediaan steril setiap shift. 8. Dilakukan penjadwalan per shift untuk TVF dan Apoteker yang akan mengoplos.
13.	Input permintaan barang dari depo farmasi ke gudang farmasi	P	Pelaksanaan permintaan barang dari depo farmasi ke gudang farmasi dengan ROP (Re Order Point)
		D	Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi terkait ROP (Re Order Point)
		S	1. Permintaan ke gudang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu (tidak merata). 2. Fitur permintaan barang ROP tidak pernah dipakai lagi.
		A	4. Semua petugas harus bisa melakukan pengecekan barang menipis, harus bisa dan mau melakukan permintaan barang ke gudang. 5. Melakukan evaluasi dan melakukan permintaan dengan fitur ROP lagi. 6. Melakukan perbandingan permintaan ROP dan non ROP.

3.7.71 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terkait keterlambatan, tukar jadwal, dan human error	P	Mengajukan konseling yang bersangkutan ke SDM atau KABID
		D	Karu koordinasi dengan KABID dan SDM
		S	Memperhatikan dan mengatur jadwal staff untuk mengurangi tingkat kelelahan sehingga bisa menekan angka keterlambatan
		A	Melakukan konseling ke staff yg bersangkutan dan berkolaborasi dengan KABID dan SDM salah satunya memberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis
2	Ketidaklengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA	P	Mengajukan sosialisasi ke PPA terkait pengisian DRM yang baik dan benar
		D	Karu koordinasi dengan KABID
		S	Mengecek ulang setiap DRM yang akan di setor ke RM dan melengkapi yang kurang sehingga DRM sudah lengkap waktu di setor ke RM
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap
3	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	Pengajuan fitur Rujuk Penuh di SIMRS ke programmer
		D	Karu koordinasi dengan programmer

		S	Surat rujukan penuh tidak lagi manual tetapi bisa langsung terhubung ke VCLAIM sehingga bisa mengurangi waktu tunggu di pendaftaran
		A	1. Follow up ke programmer
			2. Monitoring dan evaluasi SIMRS
4	Form-form yang sudah ERM masih ada yang belum muncul di billing validasi Rekam Medis	P	Mengajukan koordinasi dengan tim SIMRS/programmer untuk menelusuri penyebab form ERM belum terbaca di validasi RM
		D	Karu berkoordinasi dengan KABID dan tim SIMRS/programmer, untuk sinkronisasi data ERM dengan sistem validasi RM.
		S	Melakukan uji coba penginputan ERM dan memastikan semua form muncul di billing serta tervalidasi di Rekam Medis
		A	1. Melakukan evaluasi berkala terhadap integrasi ERM dan billing
			2. Memberikan laporan hasil evaluasi ke KABID dan programmer untuk perbaikan sistem jika masih ditemukan kendala
5.	Whatsapp Web CSO ter banned	P	Mengajukan permintaan aktivasi ulang atau penggantian nomor WhatsApp Web CSO ke bagian IT.
		D	Karu berkoordinasi dengan bagian IT untuk pemulihan akun atau pembuatan akun baru yang dapat digunakan kembali oleh CSO.
		S	Memastikan WhatsApp Web CSO sudah aktif dan bisa digunakan untuk komunikasi serta pelayanan pasien tanpa kendala.
		A	1. Melakukan evaluasi keamanan penggunaan WhatsApp Web agar tidak terulang kembali. 2. Menyusun SOP penggunaan akun WhatsApp CSO termasuk pembatasan akses agar lebih aman.

3.7.72 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Saluran air kotor	P	1) Membuat laporan jika saluran air kotor maka kendala juga ada pada cucian 2) Koodinasi dengan pak yadi tukang dan IPSRS terkait saluran kotor
		D	1) Jika saluran kotor maka pencucian linen di hentikan sementara, sampai air Kembali bersih normal 2) Koordinasi dengan tim IPSRS dan pak tukang
		S	1) Jika loss kontak antara pak tukang ,IPSRS dan laundry terkait air maka kerusakan atau kerugian terjadi pada pencucian saat itu 2) Membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk mencuci ulang jika linen rusak
		A	Jika terjadi pengurusan tandon air, atau perbaikan saluran air maka tim laundry juga harus di beri tahu informasinya

3.7.73 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Tikus di dapur sudah berkurang, akan tetapi masih ada tikus yang berkeliaran dan hanya melewati jebakan yang sudah dipasang oleh vendor	P	Memperbaiki struktur gedung dapur agar tidak ada celah tempat tikus masuk ke dapur
		D	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan tukang RSPHM
		S	Kontaminasi makanan akibat adanya vector yang ada di lingkungan dapur
		A	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan vendor untuk memperbarui jebakan tikus yang diletakkan di dapur
2	Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian	P	Alur penyerahan alat makan harus bebas dari kontaminasi untuk menjamin higiene sanitasi alat makan
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan IPSRS dalam pembuatan alur yang sesuai
		S	Risiko alat makan terkontaminasi makanan mentah sehingga tidak terjaga kebersihannya
		A	Tim gizi dan IPSRS berkolaborasi dalam pembuatan alur yang sesuai untuk penyerahan alat makan bersih ke tempat pemorsian
3	Showcase ruang pengolahan tidak mendinginkan dengan maksimal sehingga ada beberapa bahan makanan setengah matang (perkedel dan daging lapis) basi	P	Alat penyimpanan bahan makanan basah harus memiliki suhu pendingin yang sesuai
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan IPSRS untuk memperbaiki showcase
		S	Risiko makanan setengah matang/ bahan makanan tidak tersimpan dengan baik sesuai suhu sehingga rusak dan mengakibatkan kerugian secara finansial
		A	Tim gizi dan IPSRS berkolaborasi dalam perbaikan showcase dan memberikan freezer semnetara sebagai tempat penyimpanan bahan makanan basah

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	0	0	0	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0

		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	1
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	6	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		11	7	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0

24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	1	1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit	Pendidikan Dokter	5	5	1	4	0

	Dalam	Spesialis					
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	s0	1	0
Total			431	431	284	147	1

Keterangan :
Pada bulan Oktober terdapat 1 staf resign.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan November 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Oktober 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 07 November 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/II/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/II/II/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025